of levofloxacin and ciprofl oxacin against urinary pathogens. J Antimicrob Chemother 48: 37–45, 2001.

File TM Jr, Milkovich G, Tennenberg AM, et al. Clinical implications of 750 mg, 5-day levofl oxacin for the treatment of community-acquired pneumonia. Curr Med Res Opin 20: 1473–81, 2004.

Garcia-Vazquez E, Mensa J, Sarasa M, et al. Penetration of levofloxacin into the anterior chamger (aqueous humour) of the human eye after intravenous administration. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 26: 137–140, 2007.

Glasheen JJ, Prochazka AV. The safety of levofloxacin in patients on warfarin. Am J Med 120: e13, 2007.

Kiser TH, Hoody DW, Obritsch MD, et al. Levofloxacin pharmacokinetics and pharmacodynamics in patients with severe burn injury. Antimicrob Agents Chemother 50: 1937–45, 2006.

Klausner HA, Brown P, Peterson J, et al. Double-blind, randomized comparison of levofl oxacin 750 mg once daily for 5 days versus ciprofl oxin for 10 days in the treatment of acute pyelonephritis. Curr Med Res Opin 23: 2637–2645, 2007.

Kuriyama T, Williams DW, Yanagisawa M, et al. Antimicrobial susceptibility of 800 anaerobic isolates from patients with dentoalveolar infection to 13 oral antibiotics. Oral Microbiol Immunol 22: 285–288, 2007.

Lee CK, Boyle MP, Diener-West M, et al. Levofloxacin pharmacokinetics in adult cystic fibrosis. Chest 131: 796–802, 2007.

Marchetti F, Viale P. Current and future perspectives for levofl oxacin in severe Pseudomonas aeruginosa infections. J Chemotherapy 15: 315–322, 2003.

Maurin M, Raoult D. Bacteriostatic and bactericidal activity of levofl oxacin against Rickettsia rickettsii, Rickettsia conorii, 'Israel spotted fever group rickettsii' and Coxiella burnetii. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 39: 725–30, 1997.

Nightingale CH, Grant EM, Quintiliani R. Pharmacodynamics and pharmacokinetics of levofloxacin. Chemotherapy 46: 6–14, 2000.

Nista EC, Candelli M, Zocco, MA, et al. Levofloxacinbased triple therapy in first-line treatment for Helicobacter pylori eradication. Am J Gastroenterol 101: 1985–90, 2006.

Ogrendik M. Levofloxacin treatment in patients with rheumatoid arthritis receiving methotrexate. South Med J 100: 135–139, 2007.

Pankey GA, Ashcraft DS. In vitro synergistic/additive activity of levofloxacin with meropenem against Stenotrophomonas maltophilia. Diagn Microbiol Infect Dis 67: 297–300, 2010.

Pankuch GA, Seifert H, Appelbaum PC. Activity of doripenem with and without levofloxacin, amikacin, and colistin against Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii. Diagn Microbiol Infect Dis 67: 191–197, 2010.

Pea F, Marioni G, Pavan F, et al. Penetration of levofloxacin into paranasal sinuses mucosa of patients with chronic rhinosinusitis after a single 500 mg oral dose. Pharmacol Res 55: 38–41, 2007.

Poole M, Anon J, Paglia M, et al. A trial of high dose, short-course levofl oxacin for the treatment of acute bacterial sinusitis. Otolaryngol Head Neck Surg 134: 10–17, 2006.

Pugh RJ, Cooke RPD, Dempsey G. Short course antibiotic therapy for Gram-negative hospital-acquired pneumonia in the critically ill. J of Hosp Infect 74: 337–343, 2010.

Tsuruoka S, Yokota N, Hayasaka T, et al. Pharmacokinetics of multiple-dose levofloxacin in hemodialysis patients. Am J Kidney Dis 58: 498–499, 2011.

Website: www.levaquin.com

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Linezolid (Zyvox)

Nhóm thuốc: Oxazolidinon

Liều thường dùng: 600mg (TM/Uống) mỗi 12h/lần.

Phổ tác dụng: (*xem chương Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 332-335*).

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 15-21 µg/mL.

Sinh khả dụng: 100% (đường tĩnh mạch và đường uống).

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 30%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 6,4/7,1 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 31%

Thể tích phân bố (V_d): 0,64 L/kg.

Đường thải trừ chính: Gan/ chất chuyển hóa.

Điều chỉnh liều*

CrCl < 10 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	600 mg (TM/ Uống)
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không có thông tin

Tương tác thuốc: Pseudophedrin, thức ăn chứa tyramin (↑ nguy cơ bị cơn tăng huyết áp); các chất sinh serotonin (serotonergic), ví dụ như thuốc bắt giữ chọn lọc tái hấp thu serotonin, thuốc ức chế MAO, chế phẩm St.John's wort, ritonavir (↑ nguy cơ bị hội chứng serotonin). Hội chứng serotonin: sốt, sảng, tăng huyết áp, run cơ/rung giật rung, tăng phản xạ.

Phản ứng bất lợi: Giảm tiểu cầu nhẹ và hoàn toàn có thể hồi phục, thiếu máu hoặc giảm bạch cầu đa nhân trung tính thường xảy ra sau điều trị ≥ 2 tuần điều trị. Nhiễm toan lactic (hiếm gặp), bệnh lý thần ngoại biên/thần kinh thị giác (> 28 ngày điều trị, song hiếm gặp). Cần theo dõi chức năng thị giác nếu có triệu chứng hoặc dùng thuốc ≥ 2 tuần; theo dõi công thức máu 1 tuần/lần nếu điều trị thuốc > 2 tuần.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: ***Là thuốc lý tưởng để áp dụng phác đồ chuyển từ đường tiêm TM sang đường uống***. Khác với vancomycin, ***sử dụng linezolid không làm tăng tần suất lưu hành cầu khuẩn ruột kháng Vancomycin (VRE)***. Không giống như quinupritin/ dalfopristin, linezolid có hiệu quả trong điều trị *E. faecalis* (Enterococcus nhạy với vancomycin [VSE]). ***Là thuốc điều trị theo đường uống có hiệu quả trong điều trị các tình trạng nhiễm khuẩn do tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA), S.epidermitis kháng methiciline (MRSE) và E.faecium (VRE). Là điều***

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

trị thay thế trong nhiễm khuẩn do Nocardia và Listeria.

Liều cho màng não = liều thường dùng.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: 70%

(Xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 517).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Aeziokoro CO, Cannon JP, Pachucki CT, et al. The effectiveness and safety of oral linezolid for the primary and secondary treatment of osteomyelitis. J Chemother 17: 643–50, 2005.

Bassetti M, Vitale F, Melica G, et al. Linezolid in the treatment of gram-positive prosthetic joint infections. J Antimicrob Chemother 55: 387–390, 2005.

Cannon JP, Pachucki CT, Aneziokoro CO and Lentino JR. The effectiveness and safety of oral linezolid as primary or secondary treatment of bloodstream infections. Infect Dis Clin Pract 14: 221–226, 2006.

Castro P, Soriano A, Escrich C, Villalba G, et al. Linezolid treatment of ventriculoperitoneal shunt infection without implant removal. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 24: 603–06, 2005.

Colli A, Compodonico R, Gherli T. Early switch from vancomycin to oral linezolid for treatment of grampositive heart valve endocarditis. Ann Thorac Surg 84: 87–91, 2007.

Conte JE Jr, Golden JA, Dipps J, et al. Intrapulmonary pharmacokinetics of linezolid. Antimicrob Agents Chemother 46: 1475–80, 2000.

Cunha BA. Antimicrobial therapy of multidrug-resistant Streptococccus pneumoniae, vancomycin-resistant enterococci, and methicillin-resistant Staphlycoccus aureus. Med Clin N Am 90: 1165–82, 2006a.

Cunha BA. Oral antibiotic therapy of serious systemic infections. Med Clin N Am 90: 1197–1222, 2006b.

Estes KS, Derendorf H. Comparison of the pharmacokinetic properties of vancomycin, linezolid, tigecycline, and daptomycin. Eur J. Med Res 15: 533–543, 2010.

Falagas ME, Manta KG, Ntziora F, et al. Linezolid for the treatment of patients with endocarditis: a systematic review of published evidence. J Antimicrob Chemother 58: 273–280, 2006.

Falagas ME, Siempos II, Vardakas KZ. Linezolid versus glycopeptide or B-lactam for treatment of Gram-positive bacterial infections: meta-analysis of randomized controlled trials. Lancet Infect Dis 8: 53–66, 2008.

Hill EE, Herijgers P, Herregods MC, Peetermans WE. Infective endocarditis treated with linezolid: case report and literature review. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 25: 202–4, 2006.

Joson J, Grover C, Downer C, et al. Successful treatment of methicillin-resistant Staphylococcus aureus mitral valve endocarditis with sequential linezolid and telavancin monotherapy following daptomycin failure. J Antimicrob Chemother 66: 2186–2188, 2011.

Johnson JR. Linezolid versus vancomycin for methicillinresistant Staphylococcus aureus infections. Clin Infect Dis 36: 236–7, 2003.

Kaka AS, Rueda AM, Shelburne SA 3rd, Hamill RJ. Bactericidal activity of orally available agents against methicillin-resistant Staphylococcus aureus. J Antimicrob Chemother 58: 680–3, 2006.

Kalil AC, Puumala S, Stoner J. Is linezolid superior to vancomycin for complicated skin and soft tissue infections due to methicillin-resistant Staphylococcus aureus? Antimicrob Agents Chemother 50: 1910–1911, 2006.

Kruse AJ, Peederman SM, Bet PM, Debets-Oseenkopp YJ. Successful treatment with linezolid of meningitis due to methicillin-resistant Staphylococcus epidermidis refractory to vancomycin treatment. Eur J Clin Microb Infect 215: 135–7, 2006.

Kutscha-Lissberg F, Hebler U, Muhr G, et al. Linezolid penetration into bone and joint tissues infected with methicillin-resistant staphylococci. Antimicrob Agents Chemother 47: 3964–6, 2003.

Lawrence KR, Adra M, Gillman PK. Serotonin

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

toxicity associated with the use of linezolid: a review of postmarketing data. Clin Infect Dis 42: 1578–83, 2006.

Leonard SN, Szeto YG, Zolotarev M, et al. Comparative in vitro acitivity of telavancin, vancomycin, and linezolid against heterogeneously vancomycinintermediate Staphycoccus aureus (h VISA). Int J Antimicrob 37: 558–561, 2011.

Lustberg ME, Schlesinger LS, Mangino JE. Concerns about "complicated skin and skin-structure infections and catheter-related bloodstream infections: noninferiority of linezolid in a phase 3 study. Clin Infect Dis 49: 313–314, 2009.

Manfredi R, Sabbatani S, Marinacci G, Salizzoni E, Chiodo F. Listeria monocytogenes meningitis and multiple brain abscesses in an immunocompetent host. favorable response to combination linezolid-meropenem treatment. J Chemother 18: 331–33, 2006.

Moreillon P, Wilson WR, Leclercq R, et al. Singledose oral amoxicillin or linezolid for prophylaxis of experimental endocarditis due to vancomycinsusceptible and vancomycin-resistant Enterococcus faecalis. Antimicrob Agents Chemother 51: 1661–1665, 2007.

Moylett EH, Pacheco SE, Brown-Elliott BA, et al. Clinical experience with linezolid for the treatment of nocardia infection. Clin Infect Dis 36: 313–8, 2003.

Myrianthefs P, Markantonis SL, Vlachos K, et al. Serum and cerebrospinal fl uid concentrations of linezolid in neurosurgical patients. Antimicrob Agents Chemother 50: 3971–76, 2006.

Nasraway SA, Shorr AF, Kuter DJ, et al. Linezolid does not increase the risk of thrombocytopenia in patients with nosocomial pneumonia: comparative analysis of linezolid and vancomycin use. Clin Infect Dis 11: 1609–16, 2003.

Nathani N, Iles P, Elliott TS. Successful treatment of MRSA native valve endocarditis with oral linezolid therapy: a case report. J Infect 51: 213–215, 2005.

Nguyen S, Pasquet A, Legout L, et al. Efficacy and tolerance of rifampin-linezolid compared with rifampin-cotrimoxazole combinations in prolonged oral therapy for bone and joint infections. Clin Microbiol Infect Dis 15: 1163–1169, 2009.

Park IN, Hong SB, Oh YM, Kim MN, et al. Efficacy and tolerability of daily-half dose linezolid in patients with intractable multidrug-resistant tuberculosis. J Antimicrob Chemther 58: 701–4, 2006.

Ravindran V, John J, Kaye GC, et al. Successful use of oral linezolid as a single active agent in endocarditis unresponsive to conventional antibiotic therapy. J Infect 47: 164–6, 2003.

Rao N, Ziran BH, Hall RA, et al. Successful treatment of chronic bone and joint infections with oral linezolid. Clin Orthop 427: 67–71, 2004.

Schecter GF, Scott C, True L, et al. Linezolid in the Treatment of Multidrug-Resistant Tuberculosis. Clin Infect Dis 50: 49–55, 2010.

Siegel RE. Linezolid to decrease length of stay in the hospital for patients with methicillin-resistan Staphylococcus aureus infection. Clin Infect Dis 36: 124–5, 2003.

Souli M, Pontikis K, Chryssouli Z, et al. Successful treatment of right-sided prosthetic valve endocarditis due to methicillin-resistant teicoplaninheteroresistant Staphylococcus aureus with linezolid. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 24: 760–762, 2005.

Stalker DJ, Jungbluth GL. Clinical pharmacokinetics of linezolid, a novel oxazolidinone antibacterial. Clin Pharmacokinet 42: 1129–40, 2003.

Stein GE, Schooley SL, Havlichek DH, et al. Outpatient intravenous antibiotic therapy compared with oral linezolid in patients with skin and soft tissue infections: A Pharmacoeconomic Analysis. Infectious Dis in Clin Practice 16: 235–240, 2008.

Stevens DL, Herr D, Lampiris H, et al. Linezolid versus vancomycin for the treatment of methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections. Clin Infect Dis 34: 1481–90, 2002.

Taylor JJ, Wilson JW, Estes LL. Linezolid and serotonergic Drug Interactions: a retrospective survey. Clin Infect Dis 43: 180–7, 2006.

Website: www.zyvox.com

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Lopinavir + Ritonavir (Kaletra) LPV/RTV

Nhóm thuốc: Dạng bào chế phối hợp thuốc chống retrovirus nhóm ức chế enzyme protease (antiretroviral protease inhibitor combination).

Liều thường dùng: Điều trị *cho đối tượng trước đó chưa từng dùng thuốc (therapy-naive)*: 400/100 mg (2 viên nén hoặc 5 mL dung dịch) mỗi 24 h/lần hoặc 800/200 mg (4 viên nén hoặc 10 mL dung dịch) mỗi 24 h/lần. Điều trị *cho đối tượng đã từng dùng thuốc kháng virus (therapy-experienced)*: 400/100mg mỗi 12h/lần. Dạng bào chế viên nén mới (lopinavir 200 mg + ritonavir 50 mg) để thay thế cho viên nang (lopinavir 133,3 mg + ritonavir 33,3 mg), giúp làm giảm tổng số viên thuốc bệnh nhân phải uống từ 6 viên nang xuống còn 4 viên nén. Ngoài ra thuốc còn có trên thị trường dưới dạng bào chế dung dịch uống (lopinavir 400 mg + ritonavir 100 mg trong mỗi 5 mL).

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 9,6/≤ 1 µg/ mL.

Sinh khả dụng: Không có số liệu

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 3%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 5-6/5-6 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 99%

Thể tích phân bố (V_d) : Không có số liệu/0,44 L/kg.

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều*

CrCl < 10 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Tránh sử dụng

Điều chỉnh liều thuốc chống retrovirus

Fosamprenvir	Tránh sử dụng
Delavirdin	Không có thông tin
Efavirenz	Xem xét dùng lopinavir/ ritonavir 600/150 mg (3 viên) mỗi 12 h/lần
Indinavir	Indinavir 600mg mỗi 12 h/lần
Nelfinavir	Giống như đối với efavirenz
Nevirapin	Giống như đối với efavirenz
Rifabutin	Liều tối đa của rifabutin là 150mg dùng cách nhật hoặc 3 lần/ tuần
Saquinavir	Saquinavir 1000mg mỗi 12h/lần

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tương tác thuốc: Thuốc chống retrovirus, rifabutin, (xem Bảng chỉnh liều ở trên); Rifampin có thể làm giảm có ý nghĩa nồng độ lopinavir, dẫn đến sử dụng thuốc thất bại và nên tránh phối hợp. Nồng độ sidenafil, tadalafil và verdenafil sẽ tăng lên rất nhiều nên phải giảm liều dùng của các thuốc này. Nồng độ các thuốc chống loạn nhịp như amiodaron, bepredil, lidocain và quinidin có thể tăng. Nồng độ tacrolimus, cyclosporin và rapamycin có thể bị thay đổi, dẫn tới độc tính của thuốc tăng lên. Nồng độ methadon có thể bị giảm xuống gây hội chứng cai thuốc. Nồng độ fluticason có thể tăng, gây ra hội chứng giống Cushing. Astemizol, terfenadin, benzodiazepin, cisaprid, ergotamin, flecainid, pimozid, propafenon, rifampin, statin, chế phẩm St.John's wort (bị chống chỉ định); tenofovir (↓ nồng độ lopinavir, ↑ nồng độ tenofovir). ↓ hiệu quả của thuốc viên tránh thai. Còn chưa có đủ dữ liệu về tình trạng tương tác với các thuốc khác được liệt kê chỉ đối với ritonavir. Khi tình trạng tương tác thuốc kết thúc, phối hợp thêm lopinavir / có chứa và có thể gây ra phản ứng disulfram khi thuốc được dùng cùng với metronidazol, clarithromycin (↑ QTc).

Phản ứng bất lợi: Ỉa chảy (rất hay gặp), đau đầu, buồn nôn, nôn, suy nhược, ↑ SGOT/SGPT, gây độc cho gan, đau bụng, viêm tụy, dị cảm, tăng đường huyết (bao gồm làm nặng thêm bệnh đái tháo đường đã có, làm khởi phát đái tháo đường, nhiễm toan centon do đái tháo đường), ↑ cholesterol/ triglycerid (cần đánh giá nguy cơ bệnh mạch vành, viêm tụy), ↑ CPK, ↑ acid uric, tái phân bố mỡ, có thể làm tăng tình trạng chảy máu ở bệnh nhân bị bệnh ưa chảy máu (hemophilia). Dung dịch uống chứa 42,4% rượu. Hội chứng phục hồi miễn dịch (IRS) và tình trạng tái phân bố lại mỡ/tích tụ mỡ trong cơ thể đã được báo cáo ở những bệnh nhân được điều trị bằng liệu pháp phối hợp các thuốc chống retrovirus.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Dạng bào chế viên nén không cần phải bảo quản lạnh và có thể được uống cùng hoặc không cùng với bữa ăn. Với dạng dung dịch uống, nồng độ Lopinavir trong huyết thanh khi thuốc được dùng cùng với bữa ăn có lượng chất béo vừa phải sẽ tăng lên 54%.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Benson CA, Deeks SG, Brun SC, et al. Safety and antiviral activity at 48 weeks of lopinavir/ ritonavir plus nevirapine and 2 nucleoside reverse-transcriptase inhibitors in human immunodefi ciency virus type 1-infected protease inhibitor-experienced patients. J Infect Dis 185: 599–607, 2002.

Decloedt EH, McIlleron H, Smith P, et al. Pharmacokinetics of lopinavir in HIV-infected adults receiving rifampin with adjusted does of lopinavir-ritonavir tablets. Antimicrob Agents Chemother 55: 3195–3200, 2011.

Manfredi R, Calza L, Chiodo F. First-line efavirenz versus lopinavir-ritonavir-based highly active antiretroviral therapy for naive patients. AIDS 18: 2331–2333, 2004.

Thompson MA, Aberg JA, Cahn P, et al. Antiretroviral treatment of adult HIV infection: 2010 recommendations of the international AIDS society – USA panel. JAMA 304: 321–333, 2010.

Website: www.kaletra.com

Loracarbef (Lorabid)

Nhóm thuốc: Cephalosporin dùng đường uống thế hệ 2.

Liều thường dùng: 400mg (uống) mỗi 12h/lần (*xem Bình luận*).

Phổ tác dụng: (*xem Chương Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 328-335*).

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 14 µg/mL.

Sinh khả dụng: 90%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 90%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 1,2/32 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 25%

Thể tích phân bố (V_d) : 0,35 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl 10-50 mL/phút	200mg (uống) mỗi 24h/lần
CrCl < 10 mL/phút	200mg (uống) mỗi 72h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	400 mg (uống)
Liều dùng sau lọc màng bụng	200mg (uống)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	200mg (uống) mỗi 1h/lần
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Không có.

Phản ứng bất lợi: Sốt/nổi ban da do thuốc, Ỉa chảy/viêm đại tràng do *C.difficile*.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Uống thuốc 1 giờ trước hoặc 2 giờ sau bữa ăn. **Liều điều trị viêm phổi mắc phải từ cộng đồng** : 400mg (uống) mỗi 12h/lần. **Liều điều trị viêm xoang/viêm amidan**: 200mg (uống) mỗi 12h/lần.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: < 10%

(*Xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 794*).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bandak SI, Turnak MR, Allen BS, et al. Assessment of the susceptibility of Streptococcus pneumoniae to cefaclor and loracarbef in 13 cases. J Chemother 12: 299–305, 2000.

Gooch WM 3rd, Adelglass J, Kelsey DK, et al. Loracarbef versus clarithromycin in children with acute otitis media with effusion. Clin her 21: 711–22, 1999.

Vogel F, Ochs HR, Wettich K, et al. Effect of step-down therapy of ceftriazone plus loracarbef versus parenteral therapy of ceftriaxone on the intestinal microflora in patients with communityacquired pneumonia. Clin Microbiol Infect 7: 376–9, 2001.

Website: www.pdr.net

Maraviroc (Selzentry) MVC

Nhóm thuốc: Đối kháng thụ thể chemokine 5 của HIV-1.

Liều thường dùng: 150 mg, 300 mg hoặc 600 mg (uống) mỗi 12 h/lần, tùy thuộc vào các thuốc được dùng đồng thời (Xem ở dưới), đối với các chủng HIV-1 được phân lập có ái tính với CCR5 (CCR5-tropic HIV-1 isolates).

Thuốc cũng có trên thị trường dưới dạng bào chế viên nén 150 mg và 300 mg.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 266-618 µg/mL.

Sinh khả dụng: 23-33%

Bài xuất dưới dạng nguyên vẹn: 20% (trong nước tiểu), 76% (trong phân).

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 14-18 giờ/ không được nghiên cứu.

Liên kết với protein huyết tương: 76%

Thể tích phân bố (V_d): 194 L

Đường thải trừ chính: Phân/Thận..

Điều chỉnh liều*

CrCl > 30 mL/phút với thuốc ức chế CYP3A4 mạnh	150mg (uống) mỗi12 h/lần
CrCl > 30 mL/phút với thuốc gây cảm ứng mạnh, nhưng không gây ức chế CYP3A4	600mg (uống) mỗi 12h/lần
CrCl < 30mL/phút với thuốc gây cảm ứng hoặc ức chế CYP3A4 mạnh,	Tránh dùng
CrCl < 30 mL/phút với thuốc không gây cảm ứng hoặc ức chế CYP3A4 mạnh	300mg (uống) mỗi 12h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không có thông tin
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không có thông tin
Suy gan vừa with potent CYP3A4 inhibitor	Sử dụng thận trọng
Suy gan nặng	Không có số liệu

Điều chỉnh liều các thuốc chống retrovirus

Thuốc ức chế protease (ngoại trừ tipranavir/ ritonavir), delavridin, ketoconazol, itraconazol, clarithromycin, nefazodon, telithromycin	150mg (uống) mỗi 12h/lần
Tipranavir/ritonavir, nevirapin, tất cả các thuốc kháng virus nhóm ức chế enzym sao chép ngược loại nucleoside (NRTI) và enfuvirtid	300mg (uống) mỗi 12h/lần
Efavirenz, rifampin, carbamazepin, phenobarbital, phenytoin	600mg (uống) mỗi 12h/lần

Tương tác thuốc: Maraviroc là một cơ chất của CYP3A và P-glycoprotein

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

và nhiều khả năng được điều biến bởi các chất ức chế và chất cảm ứng của các enzyme/chất vận chuyển này.

Phản ứng bất lợi: Độc tính trên gan đã được báo cáo. Phản ứng dị ứng toàn thân (ví dụ: ban da gây ngứa, tăng bạch cầu ưa acid hoặc tăng IgE) trước khi xuất hiện tình trạng gây độc cho gan có thể xảy ra. Các phản ứng bất lợi khác bao gồm: ho, nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, nổi ban da, sốt, chóng mặt, đau bụng, các triệu chứng về cơ xương khớp (đau cơ/khớp). Nhồi máu cơ tim/thiếu máu cục bộ cơ tim được báo cáo với tỷ lệ < 2% trong các thử nghiệm lâm sàng.

Khả năng dị ứng: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Được chỉ định để điều trị: bệnh nhân người lớn đã từng dùng thuốc kháng virus chỉ bị nhiễm các chủng virus HIV-1 có ái tính với CCR5, các đối tượng này có bằng chứng về sự nhân lên của virus và các chủng HIV-1 kháng lại nhiều thuốc điều trị retrovirus. Thuốc được dùng kết hợp với các thuốc chống retrovirus khác. Cần kiểm tra kiểu hình để khẳng định bệnh nhân bị nhiễm chủng HIV-1 có ái tính với CCR5 (cũng còn được biết dưới tên "R5 virus"). Có thể tăng nguy cơ nhiễm khuẩn (nhất là HSV) và phát triển u tân sinh.

Thấm vào dịch não-tủy: Không có số liệu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Brown KC, Patterson KB, Malone SA, et al. Single and multiple dose pharmacokinetics of maraviroc in saliva, semen, and rectal tissue of healthy HIV-negative men. J Infect Dis 203: 1484–1490, 2011.

Cooper DA, Heera J, Goodrich J, et al. Maraviroc versus efavirenz, both in combination with zidovudinelamivudine, for the treatment of antiretroviral-naïve subjects with CCR5-tropic HIV-1 infection. J Infect Dis 201: 803–813, 2010.

Hughes PJ, Cretton-Scott E, Teague A, et al. Protease inhibitors for patients with HIV-1 infection Pharm Ther 36: 332–344, 2011.

Jacobsen T, Sipointis N. Drug interactions and toxicities associated with the antiviral management of cytomegalovirus infection. Am J Health Syst Pharm 67: 1417–1425, 2010.

Lederman MM, Penn-Nicholson A, Cho M, et al. Biology of CCR5 and its role in HIV infection and treatment. JAMA 296: 815–826, 2006.

Website: www.selzentry.com

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Meropenem (Merrem/Meronem)

Nhóm thuốc: Carbapenem.

Liều thường dùng: 1 g (TM) mỗi 8h/lần (*xem Bình luận*).

Phổ tác dụng: (*Xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 332-335*).

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 49 µg/mL.

Sinh khả dụng: không áp dụng.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 70%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 1/7 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 2%

Thể tích phân bố (V_d): 0,35 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều* (dựa vào liều 1 g; với liều 500 mg sử dụng một nửa liều ghi trong bảng)

CrCl 25-50 mL/phút	1 g (TM) mỗi 12 h/lần
CrCl 10-25 mL/phút	500mg (TM) mỗi 12h/lần
CrCl < 10 mL/phút	500mg (TM) mỗi 24h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	500mg (TM)
Liều dùng sau HFHD	500mg (TM)
Liều dùng sau lọc màng bụng	500mg (TM)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	1 g (TM) mỗi 12h/lần
Liều dùng khi lọc máu mỗi 48-72h/lần	2 g (TM) sau mỗi cuộc lọc máu*
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

** Cho vào cuối kỳ thẩm tách máu*

Tương tác thuốc: Probenecid (↑ thời gian bán thải của meropenem thêm 40%), acid valproic (↓ giảm ngưỡng gây co giật).

Phản ứng bất lợi: Hiếm gặp, có thể gây viêm nhẹ tại chỗ truyền thuốc. Không gây co giật. **Không có tính sinh dị ứng chéo với penicillins/β-lactam, sử dụng an toàn cho các bệnh nhân có tiền sử bị phản ứng dị ứng với penicillin.**

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Liều điều trị nhiễm khuẩn do trực khuẩn Gram âm (GNB) đa kháng thuốc (MDR GNBs), bệnh xơ nang (cystic fibrosis)/viêm màng não: 2g (TM) mỗi 8h/lần; **Liều điều trị nhiễm khuẩn da và các cấu trúc của da không biến chứng hoặc nhiễm khuẩn tiết niệu**: 500mg (TM) mỗi 8h/ lần. Ức chế giải phóng nội độc tố của trực khuẩn Gram âm. **Meropenem là carbapenem duy nhất có thể được dùng kiểu tiêm bolus tĩnh mạch trong vòng 3-5 phút.** Hàm lượng Na^+ chứa trong chế phẩm = 3,92 mEq/g.

Liều cho màng não = 2 g (TM) mỗi 8 h/ lần.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Màng não không bị viêm = 10%

Viêm màng não = 40 %

Khả năng thấm vào mật:

Không bị tắc mật = 75%

Tắc mật = 40%

(Xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 789).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Berman SJ, Fogarty CM, Fabian T, et al. Meropenem monotherapy for the treatment of hospital-acquired pneumonia: results of a multicenter trial. J Chemother 16: 362–71, 2004.

Cheng AC, Fisher DA, Anstey NM, et al. Outcomes of patients with melioidosis treated with meropenem. Antimicrob Agents Chemother 48: 1763–5, 2004.

Conte JE Jr, Golden JA, Kelley MG, Zurlinden E. Intrapulmonary pharmacokinetics and pharmacodynamics of meropenem. Int J Antimicrob Agents 26: 449–56, 2005.

Cunha BA. Meropenem: lack of cross reactivity in penicillin allergic patients. Journal of Chemotherapy 20: 233–237, 2008.

Cunha BA. Meropenem: Current uses in critical care. Antibiotics for Clinicians 11: 433–444, 2007.

Cunha BA. Pseudomonas aeruginosa: resistance and therapy. Semin Respir Infect 17: 231–9, 2002.

Cunha BA. The use of meropenem in critical care. Antibiotics for Clinicians 4: 59–66, 2000 .

Cunha BA. The safety of meropenem in elderly and renally impaired patients. Intern J AntimicrobTher 10: 109–117, 1998.

Doh K, Woo H, Hur J, et al. Population pharmacokinetics of meropenem in burn patients. J Antimicrob Chemother 65: 2428–2435, 2010.

Fish DN, Singletary TJ. Meropenem: A new carbapenem antibiotic. Pharmacotherapy 17: 644–69, 1997.

Hellinger WC, Brewer NS. Carbapenems and monobactams: Imipenem, meropenem, and aztreonam. Mayo Clin Proc 74: 420–34, 1999.

Jaruratanasirikul S, Sriwiriyajan S, Punyo J. Comparison of the pharmacodynamics of meropenem in patients with ventilator-associated pneumonia following administration by 3-hour infusion or bolus injection. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 49: 1337–39, 2005.

Kitzes-Cohen R, Farin D, Piva G, et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of meropenem in critically ill patients. Int J Antimicrob Agents 19: 105–10, 2002.

Louie A, Grasso C, Bahniuk N, et al. The combination of meropenem and levofloxacin is synergistic with respect to both Pseudomonas aeruginosa kill rate and resistance suppression. Antimicrob Agents Chemother 54: 2646–2654, 2010.

Manfredi R, Sabbatani S, Marinacci G, et al. Listeria monocytogenes meningitis and multiple brain abscesses in an immunocompetent host. Favorable response to combination linezolid-meropenem treatment. Journal of Chemotherapy 18: 331–33, 2009.

Mattoes HM, Kuti JL, Drusano GL, et al. Optimizing antimicrobial pharmacodynamics: dosage strategies for meropenem. Clin Ther 26: 1187–98, 2004.

Perez-Simon JA, Garcia-Escobar I, Martinez J, et al. Antibiotic prophylaxis with meropenem after allogeneic stem cell transplantation. Bone Marrow Transplant 33: 183–7, 2004.

Pugh RJ, Cooke RPD, Dempsey G. Short course antibiotic therapy for Gram-negative hospital-acquired pneumonia in the critically ill. J of Hosp Infect 74: 337–343, 2010.

Romano A, Viola M, Gueant-Rodriquez R, et al. Tolerability of meropenem in patients with IgEmediated hypersensitivity of penicillins. Ann Intern Med 146: 266–69, 2007.

Sodhi M, Axtell SS, Callahan J, et al. Is it safe to use carbapenems in patients with a history of allergy to penicillin? J Antimicrob Chemother 54: 1155–7, 2004.

Unal S, Garcia-Rodriguez JA. Activity of meropenem and comparators against Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter spp. isolated in the MYSTIC Program, 2002–2004.Diagn Microbiol Infect Dis 53: 265–71, 2006.

Yamada Y, Ikawa K, Nakamura K, et al. Prostatic penetration of meropenem after intravenous administration in patients undergoing transurethral resection fo the prostate. J Chemother 23: 179–180, 2011.

Website: www.MerremV.com

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Methenamine hippurate (Hiprex, Urex) Methenamine mandelate (Mandelamine)

Nhóm thuốc: Thuốc sát trùng đường tiết niệu.

Liều thường dùng: 1 g (uống) mỗi 6 h/lần (hippurat); 1 g (uống) mỗi 6 h/lần (mandelat).

Phổ tác dụng: Tất cả các vi khuẩn Gram dương và Gram âm ở đường tiết niệu.

Nguy cơ bị đề kháng: Không có

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: Không áp dụng.

Sinh khả dụng: 90%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 90%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/bệnh thận giai đoạn cuối): 4 giờ/Không có số liệu.

Liên kết với protein huyết tương: Không áp dụng.

Thể tích phân bố (V_d): Không được áp dụng.

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl 50-80 mL/phút	Tránh sử dụng
CrCl 10-50 mL/phút	Tránh sử dụng
CrCl < 10 mL/phút	Tránh sử dụng
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Tránh sử dụng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Tránh sử dụng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Tránh sử dụng
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Tránh sử dụng

Tương tác thuốc: Acetazolamid, Natri bicarbonat, thuốc lợi niệu nhóm thiazid (↓ tác dụng diệt khuẩn nếu ↑ pH nước tiểu ≥ 5.5).

Phản ứng bất lợi: Rối loạn tiêu hóa.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Uống thuốc vào bữa ăn giúp làm giảm rối loạn tiêu hóa. Hiệu quả của thuốc phụ thuộc vào việc duy trì nước tiểu acid (pH ≤ 5,5) bằng các thuốc có tính acid (ví dụ acid ascorbic). **Chỉ hiệu quả** đối với tình trạng **vi khuẩn niệu liên quan đến catheter (CAB)**, không có hiệu quả điều trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu. **Hình thành formaldehyd trong nước tiểu acid; Tình trạng kháng thuốc không xuất hiện.**

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cunha BA, Comer JB, Pharmacokinetic considerations in the treatment of urinary tract infections. Conn Med 43: 347–53, 1979.

Klinge D, Mannisto P, Mantyla R, et al. Pharmacokinetics of methenamine in healthy volunteers. J Antimicrob Chemother 9: 209–16, 1982.

Musher DM, Griffith DP. Generation of formaldehyde from methenamine: Effect of pH and concentration, and antibacterial effect. Antimicrob Agents Chemother 6: 708–11, 1974.

Musher DM, Griffith DP, Templeton GB, Further observations of the potentiation of the antibacterial effect of methenamine by acetohydroxamic acid. J Infect Dis 133: 564–67, 1976.

Schiotz HA, Guttu K, Value of urinary prophylaxis with methenamine in gynecologic surgery. Acta Obstet Gynecol Scand 81: 743–6, 2002.

Metronidazole (Flagyl)

Nhóm thuốc: Thuốc kháng ký sinh trùng/kháng sinh nhóm nitroimidazol.

Liều thường dùng: 1 g (TM) mỗi 24h/lần; 500mg (TM/Uống) mỗi 6-8h/lần (*xem Bình luận*).

Phổ tác dụng: (*xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 234-327*).

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp (*H. pylori, Gardnerella, Prevotella*)

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 26 (đường tĩnh mạch)/12 (đường uống) µg/mL

Sinh khả dụng: 100%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 20%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/bệnh thận giai đoạn cuối): 8/14 giờ

Liên kết với protein huyết tương: 20%

Thể tích phân bố (V_d): 0,25-0,85 L/kg

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều*:

CrCl 10-50 mL/phút	Không thay đổi
CrCl < 10 mL/phút	500mg (TM) mỗi 24h/lần 250mg (uống) mỗi 12h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	1 g (TM) 500mg (uống)
Liều dùng sau lọc màng bụng	1 g (TM) 500mg (uống)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	500mg (TM/Uống) mỗi 24h/lần

Tương tác thuốc: Rượu (phản ứng giống disulfiram); disulfiram (loạn thần nhiễm độc cấp); warfarin (↑ INR); phenobarbital, phenytoin (↑ chuyển hóa metronidazol).

Phản ứng bất lợi: Bệnh não, miệng có vị kim loại, viêm màng não vô khuẩn, co giật, bệnh lý thần kinh ngoại vi. Với chế

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

phẩm bào chế dùng theo đường uống: có thể gây nôn, buồn nôn, khó chịu trên hệ tiêu hóa. Có thể làm nước tiểu chuyển màu nâu.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B (tránh dùng trong 3 tháng đầu khi có thai)

Bình luận: Dùng để điều trị tình trạng sepsis trong ổ bụng/ tiểu khung **(phối hợp với kháng sinh điều trị trực khuẩn Gram âm ái khí). Cách dùng liều mỗi 24 h/lần được ưa chuộng áp dụng hơn là cách dùng liều mỗi 6 – 8 h/lần vì thuốc có thời gian bán thải dài (t1/2=8 giờ). Liều điều trị ỉa chảy do *C.difficile***: 250mg (uống) mỗi 6 h/lần. **Liều điều trị viêm đại tràng do *C.difficile***: 500mg (TM/ Uống) mỗi 6-8 h/lần hoặc 1 g (TM) mỗi 24 h/lần. Để điều trị **viêm đại tràng nặng do *C.difficile*, phối hợp thêm các kháng sinh có tác dụng bao phủ trực khuẩn Gram âm**, ví dụ: ertapenem hoặc meropenem (đối với thủng tạng/viêm phúc mạng vi thể/đại thể). **Sử dụng thuốc làm tăng tần suất lưu hành cầu khuẩn ruột kháng vancomycin (VRE). Metronidazol không có tác dụng đối với một số vi khuẩn yếm khí như Propionibacteria, Actinobacillus, Eikinella và có hoạt tính hạn chế đối với Actinomyces, Mobiluncus và *Clostridium ramosum***.

Liều cho màng não = liều thường dùng.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Màng não không bị viêm = 30%

Viêm màng não = 100 %

(Xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 790).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bouza E, Burillo A, Munoz P, Antimicrobial therapy of Clostridium difficile-associated diarrhea. Med Clin N Am 90: 1141–63, 2006.

Clay PG, Graham MR, Lindsey CC, et al. Clinical efficacy, tolerability, and cost savings associated with the use of open-label metronidazole plus ceftriaxone once daily compared with ticarcillin/clavulanate every 6 hours as empiric treatment for diabetic lowerextremity infections in older males. Am J Geriatr Pharmacother 2: 181–9, 2004.

Cunha BA. Oral Antibiotic Therapy of Serious Systemic Infections. Med Clin N Am 90: 1197–1222, 2006.

Desai JA, Dobson J, Melanson M, et al. Metronidazoleinduced encephalopathy: case report and review of MRI fi ndings. Can J Neurol Sci 38: 512–513, 2011.

Falagas ME, Gorbach SL. Clindamycin and metronidazole. Med Clin North Am 79: 845–67, 1995.

Freeman CD, Klutman NE. Metronidazole: A therapeutic review and update. Drugs 54: 679–708, 1997.

Freeman CD, Nightingale CH, Nicolau DP, et al. Serum bactericidal activity of ceftriaxone plus metronidazole against common intra-abdominal pathogens. Am J Hosp Pharm 51: 1782–7, 1994.

Garbino J, Villiger P, Caviezel A, et al. A randomized prospective study of cefepime plus metronidazole with imipenem-cilastatin in the treatment of intraabdominal infections. Infection 35: 161–166, 2007.

Ishikawa T, Okamura S, Oshimoto H, et al. Metronidazole plus ciprofl oxacin therapy

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

for active Crohn's disease. Intern Med 42: 318–21, 2003.

Kasten MJ. Clindamycin, metronidazole, and chloramphenicol. Mayo Clin Proc 74: 825–33, 1999.

Metzger R, Swenson BR, Bonatti H, et al. Identification of risk factors for the development of Clostridium difficile-associated diarrhea following treatment of polymicrobial surgical infections. Ann Surg 251: 722–727, 2010.

Musher DM, Aslam S, Logan N, et al. Relatively poor outcome after treatment of Clostridium difficile colitis with metronidazole. Clinical Infectious Disease 40: 1586–90, 2005.

Vasa CV, Glatt AE. Effectiveness and appropriateness of empiric metronidazole for Clostridium difficile diarrhea. Am J Gastroenterol 98: 354–8, 2003.

Wang S, Cunha BA, Hamid NS, et al . Intravenous metronidazole: once daily vs. multiple dosing in intra-abdominal infections. Journal of Chemotherapy 19: 410–416, 2007.

Website: www.pdr.net

Mezlocillin (Mezlin)

Nhóm thuốc: Penicillin kháng Pseudomonas.

Liều thường dùng: 3 g (TM) mỗi 6 h/lần.

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 300 µg/mL.

Sinh khả dụng: Không áp dụng.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 65%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 1,1/4 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 30%

Thể tích phân bố (V_d): 0,18 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl > 30 mL/phút	Không thay đổi
CrCl 10-30 mL/phút	3 g (TM) mỗi 8 h/lần
CrCl < 10 mL/phút	2 g (TM) mỗi 8 h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	3 g (TM)
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	3 g (TM) mỗi 8 h/lần
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	3 g (TM) mỗi 12 h/lần

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tương tác thuốc: Aminoglycosid (gây bất hoạt mezlocillin khi có suy thận), warfarin (↑ INR); thuốc viên tránh thai (↓ hiệu quả của thuốc viên tránh thai); cefoxitin (↓ hiệu quả của mezlocillin).

Phản ứng bất lợi: Sốt/nổi ban da do thuốc, hội chứng Stevens-Johnson/ hồng ban đa dạng, các phản ứng phản vệ (tụt huyết áp, co thắt thanh quản, co thắt phế quản), mày đay, bệnh huyết thanh. **Tình trạng ức chế kết tập tiểu cầu phụ thuộc liều (dose-dependent inhibition of platelet aggregation) rất thấp/không có**

(liều thường dùng thấp hơn so với Carbenicillin).

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Thời gian bán thải ($t_{1/2}$) phụ thuộc liều, hàm lượng Na^+ chứa trong chế phẩm = 1,8 mEq/g.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: < 10%

(Xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 508).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Wright AJ. The penicillins. Mayo Clin Proc 74: 290–307, 1999.

Website: www.pdr.net

Micafungin (Mycamine)

Nhóm thuốc: Thuốc chống nấm nhóm Echinocandin.

Liều thường dùng:

Nhiễm khuẩn huyết do Candida (Candidemia) : 100 mg (TM) mỗi 24 h/ lần.

Nhiễm Candida thực quản: 150 mg (TM) mỗi 24 h/lần.

Dự phòng nhiễm candida trong ghép tế bào gốc: 50 mg (TM) mỗi 24 h/lần.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 5,1 µg/mL (liều dùng 50mg); 11,2 µg/mL (liều dụng 100 mg); 16,4 µg/mL (liều dùng 150mg).

Sinh khả dụng: Không áp dụng.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 11%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 10-15 giờ/ Không thay đổi.

Liên kết với protein huyết tương: > 99%

Thể tích phân bố (V_d): 0,39 L/kg.

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều *

CrCl < 10 mL/min	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan nhẹ đến vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không có số liệu

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tương tác thuốc: Diện tích dưới đường cong (AUC) của sirolimus ↑ khoảng 21% mà không làm thay đổi Cmax (theo dõi độc tính của sirolimus); Diện tích dưới đường cong (AUC) và Cmax của nifedipin ↑ lần lượt khoảng 18% và 42% (theo dõi độc tính của nifedipin).

Phản ứng bất lợi: Buồn nôn, nôn, giảm bạch cầu, thiếu máu, giảm tiểu cầu, ↑ SGOT/SGPT, nổi ban da.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Thuốc được dùng bằng cách truyền tĩnh mạch trong 1 giờ - không được dùng thuốc theo cách tiêm liều bolus do truyền thuốc quá nhanh thường có thể gây các phản ứng trung gian qua histamin. Không được trộn lẫn thuốc hoặc dùng cùng với các thuốc khác; Làm sạch đường truyền tĩnh mạch bằng dung dịch muối đẳng trương 0,9% trước khi truyền thuốc.

Thuốc có hoạt tính cao đối với *Candida albicans* và các nấm họ Candida không phải albicans (↓ nhạy cảm với *C. parasilosis*) và Hansenula. Thuốc có hoạt tính nhất định đối với Aspergillus. Thuốc không có hoạt tính đối với Cryptococcus, Fusarium, Pseudoallescheria/Scedosporium, Trichosporon, Rhodotorula hoặc Mucor.

Đây là thuốc chống nấm dùng theo đường tiêm có hiệu qua/giá thành phù hợp nhất để điều trị theo kinh nghiệm các nhiễm khuẩn toàn thân do *Candida/Aspergillus*.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: < 1%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Andes D, Safdar N. Effi cacy of micafungin for the treatment of candidemia. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 24: 662–664, 2005.

Chandraseka PH, Sobel JD. Micafungin: A New Echinocandin. Clin Infect Dis 42: 1171–78, 2006.

Denning DW, Marr KA, Lau WM, et al. Micafungin (FK463), alone or in combination with other systemic antifungal agents, for the treatment of acute invasive aspergillosis. Journal of Infection 53: 337–349, 2006.

de Wet N, Llanos-Cuentas A, Suleiman J, et al. A randomized, double-blind, parallel-group, dose-response study of micafungin compared with fluconazole for the treatment of esophageal candidiasis in HIV-positive patients. Clin Infect Dis 39: 842–9, 2004.

de Wet N, Bester A, et al. A randomized, double blind, comparative trial of micafungin (FK463) vs. fluconazole for the treatment of oesophageal candidiasis. Aliment Pharmacol Ther 21: 899–907, 2005.

Higashiyama Y, Kohno S. Micafungin: a therapeutic review. Expert Rev Anti Infect Ther 2: 345–55, 2004.

Hirata K, Aoyama T, Matsumoto Y, et al. Pharmacokinetics of antifungal agent micafungin in critically ill patients receiving continuous hemodialysis filtration. Yakugaku Zasshi 127: 897–901, 2007.

Ikeda F, Tanaka S, Ohki H, et al. Role of micafungin in the antifungal armamentarium. Curr Med Chem 14: 1263–1275, 2007.

Isumikawa K, Ohtsu Y, Kawabata M, et al. Clinical efficacy of micafungin for chronic pulmonary aspergillosis. Med Mycol 45: 273–278, 2007.

Joseph JM, Jain R, Danziger LH. Micafungin: a new echinocandin antifungal. Pharmacotherapy 27: 53–67, 2007.

Kofia G, Ruhnke M. Pharmacology and metabolism of anidalafungin, caspofungin, and micafungin in the treatment of invasive candidosis: review of the literature. Eur J Med Res 16: 159–166, 2011.

Kohno S, Izumikawa K, Ogawa K, et al. Intravenous micafungin versus voriconazole for chronic pulmonary aspergillosis. J Infect 61: 410–418, 2011.

Kuse ER, Chetchotisakd P, da Cunha CA, et al. Micafungin versus liposomal amphotericin

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

B for candidaemia andinvasive candidosis: a phase III radomised double-blind trial. Lancet 369: 1519–1527, 2007.

Nakagawa Y, Ichii Y, Saeki Y, et al. Plasma concentration of micafungin in patients with hematologic malignancies. J Infect Chemother 13: 39–45, 2007.

Okugawa S, Ota Y, Tatsuno K, et al. A case of invasive central nervous system aspergillosis treated with micafungin with monitoring of micafungin concentrations in the cerebrospinal fluid. Scand J Infect Dis 39: 344–346, 2007.

Ostrosky-Zeichner L, Kontoyiannis D, Raffalli J, et al. International, open-label, noncomparative, clinical trial of micafungin alone and in combination for treatment of newly diagnosed and refractory candidemia. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 24: 654–661, 2005.

Paderu P, Garcia-Effron G, Balashov S, et al. Serum differentially alters the antifungal properties of echinocandin drugs. Antimicrob Agents Chemother 51: 2253–2256, 2007.

Pappas PG, Rotstein CM, Betts RF, et al. Micafungin versus caspofungin for treatment of candidemia and other forms of invasive candidiasis. Clin Infect Dis 45: 883–893, 2007.

Pawlitz D, Young M, Klepser M. Micafungin. Formulary 38: 354–67, 2003.

Pettengell K, Mynhardt J, et al. Successful treatment of oesophageal candidiasis by micafungin: a novel systemic antifungal agent. Aliment Pharmacol 20: 475–481, 2004.

Toubai T, Tanaka J, Ota S, et al. Effi cacy and safety of micafungin in febrile neutropenic patients treated for hematological malignancies. Intern Med 46: 3–9, 2007.

van Burik JA, Ratanatharathorn V, Stepan DE, et al. National institute of allergy and infectious diseases mycoses study group. Micafungin versus fluconazole for prophylaxis against invasive fungal infections during neutropenia in patients undergoing hematopoietic stem cell trasnsplantation. Clin Infect Dis 39: 1407–16, 2004.

Wiederhold NP, Lewis JS 2nd. The echinocandin micafungin: a review of the pharmacology, spectrumof activity, clinical effi cacy and safety. Expert Opin Pharmacother 8: 1155–1166, 2007.

Wilke M. Treatment and prophylaxis of invasive candidiasis with anidulafungin, caspofungin, and micafungin and its impact on use and costs: review of the literature. Eur J Med Res 16: 180–186, 2011.

Yamaguchi M, Kurokawa T, Ishiyama K, et al. Efficacy and safety of micafungin as an empirical therapy for invasive fungal infections in patients with hematologic disorders. Ann Hematol 90: 1209–1217, 2011.

Website. www.mycamine.com

Minocycline (Minocin)

Nhóm thuốc: Tetracyclin thế hệ 2 dùng đường tĩnh mạch/đường uống.

Liều thường dùng: 100mg (TM/ Uống) mỗi 12h/lần hoặc 200mg (TM/ Uống) mỗi 24 h/lần (*Xem Bình luận*).

Phổ tác dụng: (*Xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 234-327*).

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 4 µg/mL.

Sinh khả dụng: 95%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 10%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 15/18-69 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 75%

Thể tích phân bố (V_d): 1,5 L/kg.

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều*

CrCl < 10 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo/lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	100mg (TM/ Uống) mỗi 24 h/lần

Tương tác thuốc: thuốc trung hòa acid dịch vị chứa Al^{++}, Ca^{++}, Fe^{++}, Mg^{++}, Zn^{++}, multivitamin, sucralfat (↓ hấp thu minocyclin); isotretinoin (tăng áp lực nội sọ vô căn [pseudotumor cerebri]); warfarin (↑ INR).

Phản ứng bất lợi: Buồn nôn, khó chịu trên đường tiêu hóa nếu không uống thuốc vào bữa ăn, tăng sắc tố da khi sử dụng dài ngày, độc tính với tiền đình (chóng mặt), tăng mẫn cảm với ánh sáng (hiếm gặp), bệnh lupus ban đỏ hệ thống do thuốc.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: D

Bình luận: Truyền chậm thuốc trong vòng 1 giờ. Thuốc **cũng có hiệu quả điều trị đối với Nocardia. Là một trong số hai loại kháng sinh duy nhất có hiệu quả điều trị đối với các nhiễm khuẩn toàn thân nặng do tụ cầu vàng nhạy với methicillin (MSSA)/tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA)**, ví dụ: viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn cấp, viêm xương tủy hoặc viêm màng não do tụ cầu vàng nhạy với methicillin/kháng methicillin (MSSA/MRSA) *S.aureus* nhạy/ kháng Methicillin. **Ngay cả nếu các chủng MRSA nhạy cảm với doxycyclin, minocyclin có hiệu quả điều trị hơn doxcyclin về mặt lâm sàng**. Minocyclin có thể được ưa chuộng hơn doxycyclin trong điều trị nhiễm khuẩn thần kinh trung ương do Borrelia.

Liều cho màng não = liều thường dùng

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Màng não không bị viêm = 50%

Viêm màng não = 50%

Khả năng thấm vào mật: 1000%

(Xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 512).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bernadino ALF, Kaushal D, Philipp MT. The antibiotics doxycycline and minocycline inhibit the inflammatory responses to the lyme disease spirochete Borrelia burgdorferi. Journal of Infectious Disease 199: 1379–1388, 2009.

Bouza E. New therapeutic choices for infections caused by methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Clin Microbiol Infect Dis 15: 44–52, 2009.

Copeland KFT, Brooks JI. A Novel use for an old drug: the potential for minocycline as anti-HIV adjuvant therapy. J Infect Dis 201: 1115–1117, 2010.

Cunha BA. Minocycline versus doxycycline for CA-MRSA: in vitro versus in vivo differences. InternationalJournal of Antimicrobial Agents 35: 517–518, 2010.

Cunha BA. Oral antibiotic therapy of serious systemic infections. Med Clin N Am 90: 1197–1222, 2006b.

Cunha BA. New uses for older antibiotics: nitrofurantoin, amikacin, colistin, polymyxin B, doxycycline and minocycline revisited. Med Clin North Am 90: 1089–107, 2006a.

Cunha BA. Minocycline vs. doxycycline for the antimicrobial therapy of lyme neuroborreliosis. Clin Infect Dis 30: 237–238, 2000.

Elkayam O, Yaron M, Caspi D. Minocycline-induced autoimmune syndromes: an overview. Semin Arthritis Rheum 28: 392–397, 1999.

Pabreja K, Due K, Sharma S, et al. Minocycline attenuates the development of diabetic neuropathic pain: possible anti-inflammatory and anti-oxidant mechanisms. Eur J Pharmacol 66: 15–21, 2011.

Schwartz BS, Graber CJ, Diep BA, et al. Doxycycline, not minocycline, induces Its own resistance in multidrugresistant community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus clone USA300. Clin Infect Dis 48: 1483–1484, 2009.

Tsai CC, Lay CJ, Ho YH, et al. Intravenous minocycline versus oral doxycycline for the treatment of noncomplicated scurb typhus. J Microbiol Infect 44: 33–38, 2011.

Website: www.pdr.net

Moxifloxacin (Avelox)

Nhóm thuốc: Fluoroquinolon tác dụng trên đường hô hấp.

Liều thường dùng: 400mg (TM/ Uống) mỗi 24 h/lần (*Xem Bình luận*).

Phổ tác dụng: (*Xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 332-335*).

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 4,4 (đường tĩnh mạch)/4,5 (đường uống) µg/mL.

Sinh khả dụng: 90%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 20%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 12/12 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 50%

Thể tích phân bố (V_d): 2,2 L/kg.

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều *

CrCl < 10 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tương tác thuốc: Thuốc trung hòa acid dịch vị chứa Al^{++}, Fe^{++}, Mg^{++}, Zn^{++}, acid citrat/citrat, các sản phẩm từ sữa (↓ hấp thu fluoroquinolon chỉ khi được uống kèm); amiodaron, procainamid, sotalon (có thể làm ↑ khoảng QT_c, xoắn đỉnh)

Phản ứng bất lợi: Ỉa chảy/viêm đại tràng do C.difficile. Có thể làm ↑ thời gian khoảng QT_c > 3 mili giây ; tránh uống cùng với các thuốc có thế kéo dài khoảng QT_c (ví dụ amiodaron) và ở những bệnh nhân có loạn nhịp/block tim. Không gây ra co giật. Sử dụng fluoroquinolon làm tăng nguy cơ viêm gân/đứt gân. Nguy cơ cao nhất ở người cao tuổi, người sử dụng steroid và những người ghép tim, phổi, thận.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Moxifloxacin là quinolon duy nhất có hoạt tính đối với *B. fragilis*. Fluoroquinolon với hoạt tính cao nhất đối với *S.pneumoniae*, cầu khuẩn ruột nhạy với Vancomycin (VSE) và tụ cầu vàng nhạy với methicillin (MSSA). Thuốc được chuyển hóa thành dạng liên hợp glucuronid (M1)/sulfat (M2) không có hoạt tính với vi sinh vật. Uống 4 giờ trước hoặc 8 giờ sau khi sử dụng thuốc trung hòa acid dịch vị chứa canxi hoặc magiê hoặc didanosin. Không có tương tác với thuốc viên hạ đường huyết. Nhóm C8-methoxy làm tăng hoạt tính và giảm khả năng đề kháng thuốc. **Liều điều trị lao** (thuốc thay thế trong phác đồ điều trị lao đa kháng thuốc): 400mg (uống) mỗi 24h/lần.

↓ tần suất mắc Ia chảy/viêm đại tràng do *C. difficile* khi phối hợp với thuốc ức chế bơm proton (đối với bệnh nhân đang dùng thuốc ức chế bơm proton trong khi điều trị bằng fluoroquinolon, ngừng dùng thuốc ức chế bơm proton hoặc chuyển sang thuốc ức chế H2 trong quá trình điều trị bằng fluoroquinolon).

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: < 10%

(Xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 516).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Al-Nawas B, Walter C, Morbach T. Clinical and microbiological efficacy of moxifloxacin versus amoxicillin/clavulanic acid in severe odontogenic abscesses: a pilot study. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 28: 75–82, 2009.

Arrieta JR, Galgano AS, Sakano E, et al. Moxifloxacin vs. amoxicillin/clavulanate in the treatment of acute sinusitis. Am J Otolaryngol 28: 78–82, 2007.

Balfour JA, Wiseman LR. Moxifloxacin. Drugs 57: 363–73, 1999.

Bassetti M, Rosso R, Tosi C, et al. Moxifloxacin in the treatment of hospitalized community acquired pneumonia in HIV-infected subjects. J Chemother 19: 104–105, 2007.

Caeiro JP, Iannini PB. Moxifl oxacin (Avelox): a novel fluoroquinolone with a broad spectrum of activity. Expert Rev Anti Infect Ther 1: 363–70, 2004.

Cheadle W, Lee JT, Napolitano LM, et al. Clinical update on the use of moxifloxacin in the treatment of community-acquired complicated intra-abdominal infections. Surg Infect 11: 487–494, 2010.

Cheon JH, Kim N, Lee DH, et al. Efficacy of moxifloxacin based triple therapy as second-line treatment for Helicobacter pylori infection. Helicobacter 11: 46–51, 2006.

Cox H, Ford N, Keshavjee S, et al. Rational use of moxifloxacin for tuberculosis treatment. Lancet Infect Dis 11: 259–260, 2011.

Cunha BA. Oral antibiotic therapy of serious systemic infections. Med Clin N Am 90: 1197–1222, 2006.

Drummond MF, Becker DL, Hux M, et al. An economic evaluation of sequential i.v./po moxifloxacin therapy compared to i.v./po co-amoxiclav with or without clarithromycin in the treatment of communityacquired pneumonia Chest 124: 526–35, 2003.

Ewig S, Hecker H, Suttorp N, et al. Moxifloxacin monotherapy versus B-lactam mono or combination therapy in hospitalized patients with community acquired pneumonia. J Infect 62: 218–225, 2011.

Fouad M, Gallagher JC. Moxifloxacin as an alternative or additive therapy for treatment of pulmonary tuberculosis. Ann Pharmacother, 45: 1439–1444, 2011.

Giordano P, Song J, Pertel P, et al. Sequential intravenous/oral moxifloxacin versus intravenous piperacillin-tazobactam followed by oral amoxicillin/clavulanate for the treatment of complicated skin and skin structure infection. Int J Antimicrob Agents 26: 357–65, 2005.

Gillespie SH, Gosling RD, Uison L, et al. Early bactericidal activity of a moxifloxacin and isoniazid combination in smear-positive pulmonary tuberculosis. J Antimicrob Chemother 56: 1169–71, 2005.

Goldstein EJ, Citron DM, Warren YA, et al. In vitro activity of moxifloxacin against 923 anaerobes isolated from human intra-abdominal infections. Antimicrob Agents Chemother 50: 148–55, 2006.

Haggerty CL, Ness RB. Newest approaches to treatment of pelvic inflammatory disease: a review of recent randomized clinical trials. Clin Infect Dis 44: 953–960, 2007.

Hariprasad SM, Shah GK, Mieler WF, Feiner L, Blinder KJ, et al. Vitreous and aqueous penetration of orally administered moxifloxacin in humans. Arch Opthamol 124: 178–82, 2006.

Hart D, Weinstein MP. Cross-over assessment of serum bactericidal activity of moxifl oxacin and levofloxacin versus penicillin-susceptible and penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae in healthy volunteers. Diagn Microbiol Infect Dis 58: 375–378, 2007.

Hoeffken G, Talan D, Larsen LS, et al. Efficacy and safety of sequential moxifl oxacin for treatment of community-acquired pneumonia associated withatypical pathogens. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 23: 772–5, 2004.

Katz E, Larsen LS, Fogarty CM, et al. Safety and efficacy of sequential I.V. to P.O. moxifloxacin versus conventional combination therapies the treatment of community-acquired pneumonia in patients requiring initial I.V. therapy. J Emerg Med 27: 554–9, 2004.

Klutman NE, Culley CM, Lacy ME, et al. Moxifloxacin. Antibiotics for Clinicians 5: 17–27, 2001.

Lode H, Grossman C, Choudhri S, et al. Sequential IV/PO moxifloxacin treatment of patients with severe community-acquired pneumonia. Respir Med 97: 1134–42, 2003.

Lobera T, Audicana MT, Alarcon E, et al. Allergy to quinolones: low cross-reactivity to levofloxacin. J Investig Allergol Clin Immunol 20: 607–611, 2010.

Malincarne L, Ghebtegzabher M, Moretti MV, et al. Penetration of moxifloxacin into bone in patients undergoing total knee arthroplasty. J Antimicrob Chemother 57: 950–4, 2006.

Malingoni MA, Song J, Herrington J, et al. Randomized controlled trial of moxifloxacin compared with piperacillin-tazobactam and amoxicillin-clavulanate for the treatment of complicated intra-abdominal infections. Ann Surg 244: 204–11, 2006.

Metlay JP, Fishman NO, Joffe MM, et al. Macrolide resistance in adults with bacteremic pneumococcal pneumonia. Emerging Infect Dis 12: 1223–30, 2006.

Miravitlles M, Llor C. Determining factors in the prescription of moxifl oxacin in exacerbations of chronic bronchitis in the primary-care setting. Clin Drug Investig 27: 95–104, 2007.

Nguyen HA, Grellet J, Dubois V, et al. Factors compromising the activity of moxifloxacin

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

against intracellular Staphylococcus aureus. J Antimicrob Chemother 59: 755–758, 2007.

Nijland HM, Ruslami R, Suroto AJ, et al. Rifampicin reduces plasma concentrations of moxifloxacin in patients with tuberculosis. Clin Infect Dis 45: 1001–1007, 2007.

Pranger AD, Van Altena R, Aarnoutse RE, et al. Evaluation of moxifloxacin for the treatment of tuberculosis: 3 years of experience. Eur Respir J. 38: 884–894, 2011.

Rijnders BJ. Moxifloxacin for community-acquired pneumonia. Antimicrob Agents Chemother 47: 444–445, 2003.

Saravolatz LD, Leggett J. Gatifloxacin, gemifloxacin, and moxifloxacin: the role of 3 newer fluoroquinolones. Clin Infect Dis 37: 1210–5, 2003.

Schentag JJ. Pharmacokinetic and pharmacodynamic predictors of antimicrobial efficacy: moxifloxacin and Streptococcus pneumoniae. J Chemother 14 (Suppl 2): 13–21, 2002.

Schlossberg D. Treatment of multi-drug resistant tuberculosis. Antibiotics for Clinicians 9: 317–321, 2005.

Schulze MH, Keller C, Müller A, et al. Rickettsia typhi infection with interstitial pneumonia in a traveler treated with moxifloxacin. J Clin Microb 49: 741–743, 2011.

Solnick, JV. Treatment with moxifloxacin versus standard therapy for community-acquired pneumonia. 10 Clinics 41: 1697–1705, 2005.

Stass, H, Rink AD, Delesen H, et al. Pharmacokinetics and peritoneal penetration of moxifloxacin in peritonitis. J Antimicrob Chemother 58: 693–6, 2006. Stein GE, Goldstein EJC. Fluoroquinolones and Anaerobes. Clin Infect Dis 42: 1598–607, 2006.

Torres A, Muir JF, Corris P, et al. Effectiveness of oral moxifloxacin in standard first-line therapy in community-acquired pneumonia. Eur Respir J 21: 135–43, 2003.

Walter S, Kuchenbecker J, Banditt P, et al. Concentration of moxifloxacin in serum and human aqueous humor following a single 400 mg oral dose. J Cataract Refract Surg 33: 553–555, 2007.

Welte T, Petermann W, Schurmann D, et al. Treatment with sequential intravenous or oral moxifloxacin was associated with faster clinical improvement that the standard therapy for hospitalized patients with community-acquired pneumonia who received initial parenteral therapy. Clin Infect Dis 41: 1697–705, 2005.

Yoshida K, Okimoto N, Kishimoto M, et al. Efficacy and safety of moxifloxacin for community acquired bacterial pneumonia based on pharmacokinetic analysis. J Infect Chemother 17: 678–685, 2011.

Zervos M, Martinez FJ, Amsden GW, et al. Efficacy and safety of 3-day azithromycin versus 5-day moxifloxacin for the treatment of acute bacterial exacerbations of chronic bronchitis. Int J Antimicrob Agents 29: 56–61, 2007.

Website: www.avelox.com

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nafcillin (Unipen)

Nhóm thuốc: Penicillin chống tụ cầu

Liều thường dùng: 2 g (TM) mỗi 4 h/lần.

Phổ tác dụng: (*Xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 234-327*).

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 80 µg/mL.

Sinh khả dụng: Không được áp dụng

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 10-30%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 0,5/4 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 90%

Thể tích phân bố (V_d): 0,24 L/kg

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều *

CrCl < 10 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo /lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan vừa hoặc nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Cyclosporin (↓ nồng độ cyclosporin); nifedipin, warfarin (↓ tác dụng của thuốc tương tác).

Phản ứng bất lợi: Không có độc tính đối với gan. Sốt/ nổi ban da do thuốc, giảm bạch cầu, viêm thận kẽ.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Cao

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: **Tránh dùng dạng bào chế sử dụng qua** đường uống (khả năng hấp thu thuốc không tốt/ nồng độ thuốc trong huyết thanh khó dự đoán).

Liều cho màng não = liều thường dùng

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Màng não không bị viêm = 1%

Viêm màng não = 20%

Khả năng thấm vào mật: 100% (*Xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 793*).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Donowitz GR, Mandell GL. Beta-lactam antibiotics. N Engl J Med 318: 419–26 490–500, 1993.

Wright AJ. The penicillins. Mayo Clin Proc 74: 290–307, 1999.

Website: www.pdr.net

Nelfinavir (Viracept) NFV

Nhóm thuốc: Thuốc chống retrovirus nhóm ức chế protease (Antiretroviral protease inhibitor [PI]).

Liều thường dùng: 1250mg (uống) mỗi 12h/lần (2 viên 625mg mỗi lần) uống trong bữa ăn hoặc 5 viên 250mg hoặc 750mg (3 viên 250mg) (uống) mỗi 8h/lần.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 35 µg/mL.

Sinh khả dụng: 20-80%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 1-2%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 4 giờ/không có số liệu.

Liên kết với protein huyết tương: 98%

Thể tích phân bố (V_d): 5 L/kg.

Đường thải trừ chính: Gan

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Điều chỉnh liều*

CrCl < 10 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan vừa	Không có thông tin
Suy gan nặng	Không có thông tin – thận trọng khi dùng

Điều chỉnh liều thuốc chống retrovirus

Delavirdin	Không có thông tin (theo dõi giảm bạch cầu trung tính)
Efavirenz	Không thay đổi
Indinavir	Dữ liệu còn hạn chế đối với nelfinavir 1250 mg mỗi 24 h/lần + indinavir 1200 mg mỗi 12 h/lần.
Lopinavir/ ritonavir	Nelfinavir 1000 mg mỗi 12 h/lần hoặc lopinavir/ritonavir 600/150 mg mỗi 12 h/lần
Nevirapin	Không có thông tin
Ritonavir	Không có thông tin
Saquinavir	Saquinavir 1200 mỗi 12 h/lần
Rifampin	Tránh dùng phối hợp
Rifabutin	Nelfinavir 1250 mg mỗi 12 h/lần; rifabutin 150mg mỗi 24 giờ hoặc 300mg x 2-3/ tuần

Tương tác thuốc: Thuốc chống retrovirus, rifabutin, rifampin (xem Bảng điều chỉnh liều ở trên); amiodaron, quinidin, astemizol, terfenadin, benzodiazepin, cisaprid, alkaloids của ergot, statin, thảo dược St. John (tránh dùng nếu có thể được); carbamazepin, phenytoin, phenobarbital (↓ nồng độ nelfinavir, ↑ nồng độ thuốc chống động kinh; cần theo dõi); caspofulgin (↓ nồng độ caspofungin, có thể ↓ tác dụng của caspofulgin); clarithromycin, erythromycin, telithromycin (↑ nồng độ nelfinavir và macrolid); didanosin (xung đột về liều khi uống cùng thức ăn; cần uống nelfanavir trong bữa ăn song cách trước 2 giờ hoặc 1 giờ sau khi uống didanosin); itraconazol, voriconazol, ketoconazol (↑ nồng độ nelfinavir), lamivudin (↑ nồng độ lamivudin); methadon (có thể cần phải ↑ liều methadon); thuốc viên tránh thai, zidovudin (↓ nồng độ zidovudin), sildenafil (↑ hoặc ↓ nồng độ sildenafil; không dùng quá 25 mg trong vòng 48 giờ), tadalafil (liều tối đa là 10mg/72 giờ), vardenafil (liều tối đa là 2,5 mg/72 giờ)

Phản ứng bất lợi: Suy giảm khả năng tập trung, buồn nôn, đau bụng, ỉa chảy xuất tiết, ↑ SGOT/SGPT, nổi ban da, ↑ cholesterol/ triglycerid (cần đánh giá nguy cơ mạch vành/viêm tụy), tái phân bố mỡ trong cơ thể, tăng đường huyết (bao gồm làm nặng hơn bệnh đái tháo đường, khởi phát bệnh đái tháo đường, nhiễm toan centon do đái tháo đường), có thể làm tăng chảy máu trong bệnh ưa chảy máu.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Uống thuốc trong bữa ăn (↑ hấp thu thêm 300%). Có trên thị trường các viên nén hàm lượng 625 mg

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: Không phát hiện được.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Albrecht MA, Bosch RJ, Hammer SM, et al. Nelfinavir, efavirenz, or both after the failure of nucleoside treatment of HIV infection. N Engl J Med 345: 398–407, 2001.

DiCenzo R, Forrest A, Fischl MA, et al. Pharmacokinetics of indinavir and nelfi navir in treatment-naive, human immunodefi ciency virus-infected subjects. Antimicrob Agents Chemother 48: 918–23, 2004.

Go J, Cunha BA. Nelfi navir: a review. Antibiotics for Clinicians 4: 17–23, 2000.

Hughes PJ, Cretton-Scott E, Teague A, et al. Protease inhibitors for patients with HIV-1 infection. Pharm Ther 36: 332–344, 2011.

Perry CM, Benfield P. Nelfinavir. Drugs 54: 81–7, 1997.

Simpson KN, Luo MP, Chumney E, et al. Cost-effective of lopinavir/ritonavir versus nelfi navir as the first-line highly active antiretroviral therapy regimen for HIV infection. HIV Clin Trials 5: 294–304, 2004.

Thompson MA, Aberg JA, Cahn P, et al. Antiretroviral treatment of adult HIV infection: 2010 recommendations of the international AIDS society – USA panel. JAMA 304: 321–333, 2010.

Walmsley S, Bernstein B, King M, et al. Lopinavirritonavir versus nelfi navir for the initial treatment of HIV infection. N Engl J Med 346: 2039–46, 2002.

Website: www.viracept.com

Nevirapine (Viramune) NVP

Nhóm thuốc: Thuốc chống retrovirus nhóm ức chế enzym sao chép ngược không phải là nucleoside (Antiretroviral NNRTI [non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor]).

Liều thường dùng: 200 mg (uống) mỗi 24 h/lần x 2 tuần, sau đó 200 mg (uống) mỗi 12 h/lần.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 0,9 – 3,6 µg/mL.

Sinh khả dụng: 90%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 5%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 40 giờ/Không có số liệu.

Liên kết với protein huyết tương: 60%

Thể tích phân bố (V_d): 1,4 L/kg.

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều*

CrCl 10-50 mL/phút	Không thay đổi
CrCl < 20 mL/phút	Không thay đổi; thận trọng khi sử dụng
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	200 mg (uống)
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng

Dr Huy Dũng GROUP DỮ LIỆU Y HỌC 0978.336.075

Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan vừa	Thận trọng khi sử dụng
Suy gan nặng	Tránh sử dụng

Điều chỉnh liều thuốc chống retrovirus

Delavirdin	Không có thông tin
Efavirenz	Không có thông tin
Indinavir	Indinavir 1000 mg mỗi 8 h/lần
Lopinavir/Ritonavir (l/r)	Cân nhắc l/r 600/150 mg mỗi 12 h/lần ở các bệnh nhân đã có kinh nghiệm dùng thuốc ức chế protease
Nelfinavir	Không có thông tin
Ritonavir	Không thay đổi
Saquinavir	Không có thông tin
Rifampin	Không được khuyến cáo
Rifabutin	Thận trọng khi sử dụng

Tương tác thuốc: Thuốc chống retrovirus, rifabutin, rifampin (xem bảng điều chỉnh liều ở trên); carbamazepin, phenobarbital, phenytoin (theo dõi nồng độ thuốc chống co giật); caspofungin (↓ nồng độ caspofungin, có thể làm ↓ hiệu quả của caspofungin); ethinyl estradiol (↓ nồng độ ethinyl estradiol; sử dụng các biện pháp tránh thai bổ sung/thay thế); ketoconazol (tránh dùng); voriconazol (↑ nồng độ nevirapin); methadon (↓ nồng độ methadon; cần điều chỉnh liều methadon tới khi đạt hiệu quả); tacrolimus (↓ nồng độ tacrolimus).

Phản ứng bất lợi: *Nặng, có nguy cơ đe dọa tính mạng và trong một số trường hợp tử vong do độc tính trên gan nhất là trong vòng 18 tuần đầu đã được báo cáo ở những bệnh nhân được điều trị bằng nevirapin. Trong một số trường hợp, bệnh nhân có biểu hiện những dấu hiệu hoặc triệu chứng báo hiệu không đặc hiệu của viêm gan và tiến triển thành suy gan. Các biến cố trên thường được kết hợp với nổi ban da. Giới nữ và số lượng bạch cầu CD4 cao hơn lúc bắt đầu điều trị tăng nguy cơ xảy ra độc tính trên gan; Bệnh nhân nữ có số lượng bạch cầu CD4> 250 tế bào/mm3, kể cả các phụ nữ có thai sử dụng nevirapin phối hợp với các thuốc chống retrovirus khác để điều trị nhiễm HIV, thuộc đối tượng có nguy cơ cao nhất. Tuy nhiên, độc tính trên gan liên quan với sử dụng nevirapin có thể xảy ra ở cả 2 giới, với bất kì số lượng bạch cầu CD4 là bao nhiêu và ở bất kì thời gian nào trong quá trình điều trị. Các phản ứng da nghiêm trọng, có nguy cơ gây tử vong (kể cả các trường hợp tử vong) đã xảy ra ở những bệnh nhân được điều trị bằng nevirapin. Các trường hợp này bao gồm hội chứng Stevens-Johnson, hoại tử biểu bì nhiễm độc (toxic epidermal necrosis) và các phản ứng quá mẫn được đặc trưng bằng tình trạng nổi ban da, các dấu hiệu toàn trạng (constitutional finding)* và rối loạn chức

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

năng tạng. Cần đặc biệt để cao cảnh giác trong 6 tuần điều trị đầu tiên, vì đây là giai đoạn có nguy cơ cao nhất bị các sự cố kể trên. Không được sử dụng lại nevirapin sau khi bị các phản ứng nghiêm trọng ở gan, da hoặc có biểu hiện phản ứng quá mẫn.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Cao

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Thức ăn không gây tác động đến hấp thu thuốc. Không được sử dụng thuốc để điều trị dự phòng sau phơi nhiễm do nguy cơ tiềm tàng gây viêm gan dẫn đến tử vong.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: 45%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

D'Aquila RT, Hughes MD, Johnson VA, et al. Nevirapine, zidovudine, and didanosine compared with zidovudine and didanosine in patients with HIV-1 infection. Ann Intern Med 124: 1019–30, 1996.

Herzmann C, Karcher H. Nevirapine plus zidovudine to prevent mother-to-child transmission of HIV. N Engl J Med 351: 2013–5, 2004.

Johnson S, Chan J, Bennett CL. Hepatotoxicity after prophylaxis with a nevirapine-containing antiretroviral regimen. Ann Intern Med 137: 146–7, 2002.

Milinkovic A, Martinez E. Nevirapine in the treatment of HIV. Expert Rev Anti Infect Ther 2: 367–73, 2004.

Negredo E, Ribalta J, Paredes R, et al. Reversal of atherogenic lipoprotein profi le in HIV-1 infected patients with lipodystrophy after replacing protease inhibitors by nevirapine. AIDS 16: 1383–9, 2002.

Schafer JJ, Ravi S, Rowland EV, et al. The expanding class of non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors for the treatment of HIV-1 infection. Pharm Ther 36: 46–364, 2011.

Thompson MA, Aberg JA, Cahn P, et al. Antiretroviral treatment of adult HIV infection: 2010 recommendations of the international AIDS society – USA panel. JAMA 304: 321–333, 2010.

Website: www.viramune.com

Nitazoxanide (Alinia)

Nhóm thuốc: Chống động vật nguyên sinh; kháng sinh điều trị *C. difficle.*

Liều thường dùng: 500 mg (uống) mỗi 12 h/lần.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 9,1 – 10,6 µg/mL; tizoxanil/ tizoxanil glucuronid (chất chuyển hóa).

Sinh khả dụng: Không có số liệu.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: < 10%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): Không có số liệu.

Liên kết với protein huyết tương: 99%

Thể tích phân bố (V_d): Không có số liệu.

Đường thải trừ chính: Gan (66%), thận (34%).

Điều chỉnh liều*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

CrCl 50-80mL/phút	Không thay đổi
CrCl 10-50 mL/phút	Không thay đổi
CrCl < 10 mL/phút	Thận trọng khi sử dụng
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan nhẹ	Không thay đổi
Suy gan vừa hoặc nặng	Thận trọng khi sử dụng

Tương tác thuốc: Tránh dùng cho bệnh nhân bị quá mẫn với salicylat.

Phản ứng bất lợi: Chóng mặt, đau đầu, buồn nôn/nôn, đau bụng, hội chứng giả cúm, nhuộm sắc tố vàng ở củng mạc/nước tiểu.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Nitazoxanid tập trung trong đường tiêu hóa song không xuất hiện trong huyết thanh. Cần uống thuốc trong bữa ăn; hấp thu tốt hơn nhiều với thức ăn (↑ nồng độ các chất chuyển hóa trong huyết tương ~ 50%). Thuốc chứa 1,4 g sucrose/5 mL hỗn dịch hoàn nguyên (reconstituted suspension). **Được ưu tiên chọn để điều trị đối với nhiễm Cryptosporidia và giardiasis. Thuốc cũng có hiệu quả điều trị đối với Cyclospora và Iospora. Có hiệu quả trong điều trị ỉa chảy/viêm đại tràng nặng do *C.difficile* (bao gồm các trường hợp điều trị bằng metronidazol hoặc vancomycin bị thất bại). Thuốc cũng hữu ích trong điều trị ỉa chảy do *H. pylori* hoặc *B. hominis* và *Norovirus diarrliea*.**

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Aslam S, Hamill RJ, Musher DM. Treatment of Clostridium difficile-associated disease: old therapies and new strategies. Lancet Infect Dis 5: 549–57, 2005.

Bouza E, Burillo A, Munoz P. Antimicrobial therapy of Clostridium difficile-associated diarrhea. Med Clin N Am 90: 1141–63, 2006.

Freeman J, Baines SD, Todhunter SL, et al. Nitazoxanide is active against Clostridium diffi cile strains with reduced susceptibility to metronidazole. J Antimicrob Chemother 66: 1407–1408, 2011.

Gilles HM, et al. Treatment of intestinal parasitic infections: a review of nitazoxanide. Trends in Parasitology 18: 95–7, 2002.

Gurgen J, Hogan D, Grace E, et al. Nitazoxanide in the treatment of chronic cutaneous leishmaniasis resistant to traditional sodium stidogluconate. J Am Acad Dermatol 64: 202–203, 2011.

Jung KS, Park JJ, Chon YE, et al. Risk factors for treatment failure and recurrence after metronidazole treatmet for Clostridium diffi cile-associated diarrhea. Gut Liver 4: 332–337, 2011.

Musher DM, Logan N, Hamill RJ, et al. Nitazoxanidefor the treatment of Clostridium difficile colitis. Clin Infect. Dis 43: 421–30, 2006.

Rossignol JF, et al. Treatment of diarrhea caused by Cryptosporidium parvum: a prospective randomized, double-blind, placebo-controlled study of nitazoxanide. J Infect Dis 184: 103, 2001.

Web site: www.romark.com

Dr Huy Dũng GROUP DỮ LIỆU Y HỌC 0978.336.075

Nitrofurantoin (Macrodantin, Macrobid)

Nhóm thuốc: Thuốc sát khuẩn đường tiết niệu.

Liều thường dùng: 100 mg (uống) mỗi 12 h/lần.

Phổ tác dụng: (*Xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 332-335*).

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 1µg/mL.

Sinh khả dụng: 80%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 25%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 0,5/1 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 40%

Thể tích phân bố (V_d): 0,8 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl 50-80 mL/phút	100 mg (uống) mỗi 12 h/lần
CrCl 30-50 mL/phút	100 mg (uống) mỗi 24 h/lần
CrCl < 30 mL/phút	Tránh dùng
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Tránh dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Tránh dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Tránh dùng
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Thuốc trung hòa acid dịch vị, magiê (↓ hấp thu nitrofurantoin); probenecid (↑ nồng độ nitrofurantoin).

Phản ứng bất lợi: *Phản ứng quá mẫn cấp (có thể phục hồi)*: viêm phổi.

Phản ứng quá mẫn mạn (không phục hồi): viêm gan mạn, bệnh thần kinh ngoại biên, xơ hóa mô kẽ (interstitial fibrosis).

Nguy cơ dị ứng thuốc: Trung bình

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Chỉ dùng để điều trị CAB/ nhiễm khuẩn đường tiết niệu thấp, song không dùng cho nhiễm khuẩn toàn thân. Khó chịu trên đường tiêu hóa ít nhất khi dùng chế phẩm được bào chế dưới dạng vi tinh thể. **Thuốc có hiệu quả điều trị vi khuẩn niệu không triệu chứng ở phụ nữ có thai**; Thuốc không qua được rau thai. Độc tính mạn tính có liên quan với sử dụng thuốc kéo dài/ người bị suy thận; hiệu quả tối ưu nếu CrCl > 60 mL/phút. **Thuốc có hoạt tính đối với hầu hết các trực khuẩn Gram âm ái khí gây bệnh đường tiết niệu, ngoại trừ *P.aeruginosa* và *Proteus sp*. Có hiệu quả trong điều trị vi khuẩn niệu liên**

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

quan đến catheter/nhiễm khuẩn tiết niệu dưới do cầu khuẩn ruột nhạy với vancomycin (VSE)/cầu khuẩn ruột kháng vancomycin (VRE) *(Xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 516).*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Auer S, Wojna A, Hell M. Oral treatment options for ambulatory patients with urinary tract infections caused by extended-spectrum-beta-lactamase producing Escherichia coli. Antimicrob Agents Chemother 54: 4006–4008, 2010.

Cunha BA. Prophylaxis for Recurrent Urinary Tract Infections (UTIs): Nitrofurantoin, Not TMP-SMX or Cranberry Juice. Archives of Internal Medicine 172: 82, 2012.

Cunha BA. Nitrofurantoin: Preferred Empiric Therapy for Community Acquired and Nosocomial Lower Urinary Tract Infections (UTIs). Mayo Clinic Proceedings 86: 1243–1244, 2011.

Cunha BA. New uses for older antibiotics: nitrofurantoin, amikacin, colistin, polymyxin B, doxycycline, and minocycline revisited. Med Clin North Am 90: 1089–107, 2006.

Cunha BA. Nitrofurantoin: An update. OB/GYN 44: 399–406, 1989.

McKinnell JA, Stollenwerk NS, Jung CW, et al. Nitrofurantoin compares favorably to recommended agents as empirical treatment of uncomplicatedurinary tract infections in a decision and cost analysis. Mayo Clin Proc 86:480–488, 2011.

Mendez JL, Nadrous HF, Hartman TE, et al. Chronic nitrofurantoin–induced lung disease. Mayo Clin Proc 80: 1298–1302, 2005.

Mendoza-Valdes A, Rosete A, Rios Bueno E, Frentzel A, et al. Antimicrobial and clinical effi cacy of nitrofurantoin in the treatment of acute lower urinary tract infections in adults. Med Klin 105: 698–704, 2010.

Ofloxacin (Oflox)

Nhóm thuốc: Fluoroquinolon

Liều thường dùng: 400 mg (TM/ Uống) mỗi 12 h/lần *(Xem Bình luận)*

Phổ tác dụng: *(Xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 332-335).*

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 5,5 – 7,2 µg/mL.

Sinh khả dụng: 95%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 90%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 6/40 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 32%

Thể tích phân bố (V_d): 2 L/kg

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl 20-50 mL/phút	400 mg (TM/ Uống) mỗi 24 h/lần
CrCl < 20 mL/phút	200 mg (TM/Uống) mỗi 24 h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	200 mg (TM /Uống)
Liều dùng sau lọc màng bụng	200 mg (TM/ Uống)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	300 mg (TM/Uống) mỗi 24 h/lần
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	400 mg (TM/Uống) mỗi 24 h/lần

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tương tác thuốc: Thuốc trung hòa acid dịch vị chứa Al^{++}, Ca^{++}, Fe^{++}, Mg^{++}, Zn^{++}, citrat/acid citric, các sản phẩm từ sữa (↓ hấp thu ofloxacin chỉ khi uống cùng với nhau); cimetidin (↑ nồng độ ofloxacin); cyclosporin (↑ nồng độ cyclosporin); Thuốc chống viêm không steroid (kích thích TKTW); probenecid (↑ nồng độ ofloxacin); warfarin (↑ INR).

Phản ứng bất lợi: Sốt/nổi ban da do thuốc, các triệu chứng kích thích thần kinh nhẹ, la chảy/viêm đại tràng do *C. difficile*. Sử dụng flouroquinolon làm tăng nguy cơ viêm gân/đứt gân. Nguy cơ cao nhất xảy ra ở người cao tuổi, người sử dụng steroid và những người ghép tim, phổi, thận.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Thuốc đối kháng thụ thể H2 làm tăng thời gian bán thải khoảng 30%. Levofloxacin được cải thiện đặc tính dược động học/dược lực học và có hoạt tính kháng khuẩn lớn hơn. Uống ofloxacin 2 giờ trước và sau khi dùng thuốc trung hòa acid dịch vị chứa Canxi/Magiê. **Liều điều trị lậu cầu sinh Penicillinase**): 400 mg (uống) x 1 liều. **Liều điều trị viêm niệu đạo không do lậu cầu / viêm cổ tử cung**: 300 mg (uống) mỗi 12 h/lần x 1 tuần.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: < 10%

Khả năng thấm vào mật: 1500% (*Xem thêm Antibiotics Pearls & Pitfalls trang 516*).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Absalon J, Domenico PD, Ortega AM, Cunha, BA. The antibacterial activity of ofl oxacin versus ciprofloxacin against Pseudomonas aeruginosa in human urine. Adv Ther 13: 191–4, 1996.

Fuhrmann V, Schenk P, Thalhammer F. Ofloxacin clearance during continuous hemofiltration. Am J Kidney Dis 42: 1327–8, 2003.

Hooper DC, Wolfson JS. Fluoroquinolone antimicrobial agents. N Engl J Med 324: 384–94, 1991.

Monk JP, Campoli-Richards DM. Ofloxacin: A review of its antibacterial activity, pharmacokinetics properties, and therapeutic use. Drugs 33: 345–91, 1987.

Walker RC, Wright AJ, The fluoroquinolones. Mayo Clin Proc 66: 1249–59, 1991.

Website: www.pdr.net

Oseltemavir (Tamiflu)

Nhóm thuốc: Thuốc ức chế neuraminidase.

Liều thường dùng: **Liều điều trị**: 75 mg (uống) mỗi 12 h/lần x 5 ngày; **Liều dự phòng**: 75 mg (uống) mỗi 12 h/lần x 10 ngày.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 65,2 µg/L.

Sinh khả dụng: 75%

Bài xuất dưới dạng nguyên vẹn: 1%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 1-3 giờ/ Không có số liệu.

Liên kết với protein huyết tương: 42%

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Thể tích phân bố (V_d): 23-26 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận (oseltamivir carboxylat).

Điều chỉnh liều *

CrCl~30-49 mL/ phút	Không điều chỉnh
CrCl~10-29 mL/ phút	Điều trị: 75 mg (uống) mỗi 24 h/lần **Dự phòng**: 75 mg (uống) mỗi 48 h/lần hoặc 30 mg (uống) mỗi 24 h/lần
CrCl < 10 ml/phút	Không có số liệu
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	30 mg (uống)
Liều dùng sau lọc màng bụng	30 mg (uống) mỗi tuần
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không có số liệu
Suy gan vừa hoặc nặng	Không có số liệu

Tương tác thuốc: tiêm vaccin sống giảm độc lực phòng cúm 2 tuần trước hoặc 2 ngày sau khi sử dụng oseltemavir.

Phản ứng bất lợi: Buồn nôn, nôn, phản ứng da nghiêm trọng, nhìn đôi, rối loạn thị giác, đánh trống ngực, rung nhĩ, nhịp nhanh thất/trên thất, các biến cố về tâm-thần kinh.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: **Bắt đầu điều trị dự phòng trong vòng 3 ngày** sau phơi nhiễm. **Liều điều trị cho trẻ em**: ≤ 15 kg = 30 mg (uống) mỗi 12 h/lần, 16-23 kg = 45 mg (uống) mỗi 12 h/lần, 24-40 kg = 60 mg (uống) mỗi 12 h/lần, > 40 kg = 75 mg (uống) mỗi 12 h/lần. **Liều dự phòng cho trẻ em**: ≤ 15 kg = 30 mg (uống) mỗi 24 h/lần, 16-23 kg = 45 mg (uống) mỗi 24 h/lần, 24-40 kg = 60 mg (uống) mỗi 24 h/lần, > 40 kg = 75 mg (uống) mỗi 24 h/lần. Có trên thị trường các viên nang với hàm lượng 30, 45 và 75 mg và dạng hỗn dịch uống 300 mg.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Agrawal R, Rewatkar PV, Kokil GR, et al. Oseltamivir: a first line defense against swine fl u. Med Chem 6: 247–251, 2010.

Chen H, Cheung CL, Tai H, et al. Oseltamivir-Resistant Influenza A Pandemic (H1N1) 2009 Virus, Hong Kong, China. Emerg Infect Dis 15: 1970–1972, 2009.

Cho D, Hossain M, Liew P, et al. Side effects of oseltamivir in end-stage renal failure patients. Nephrol Dial Transplant 26: 2339–2344, 2011.

Couch RB, Davis BR. Has oseltamivir been shown to be effective for treatment of H5N1 infl uenza? J Infect Dis 202: 1149–1151, 2010.

Jackson RJ, Cooper KL, Tappenden P, et al. Oseltamivir, zanamivir and amantadine in the prevention of influenza: A systematic review. J Infect 62: 14–25, 2011.

Lee VJ, Yap J, Maurer-Stroh S, et al. Investigation causes of oseltamivir chemoprophylaxis failures during influenza A (HINI-2009) outbreaks. J Clin Virology 50: 104–108, 2011.

Sophia NG, Cowling BJ, Fang VJ, et al. Effects of oseltamivir treatment on duration of clinical illness and viral shedding and household transmission of influenza virus. Clin Infect Dis 50: 707–714, 2010.

Sotos JG. Emergence of Oseltamivir-Resistant Pandemic H1N1 Virus during Prophylaxis. N Engl J Med 361: 2296–2298, 2009.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Oxacillin (Prostaphlin)

Nhóm thuốc: Penicillin kháng tụ cầu

Liều thường dùng: 1-2 g (TM) mỗi 4 h/lần.

Phổ tác dụng: *(Xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 234-327).*

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 43 µg/mL.

Sinh khả dụng: Không áp dụng

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 39-66%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 0,5/1 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 94%

Thể tích phân bố (V_d): 0,2 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*
(trên cơ sở liều dùng 2 g mỗi 4 h/lần)

CrCl 10-80 mL/phút	Không thay đổi
CrCl < 10 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Cyclosporin (↓ nồng độ cyclosporin); nifedipin, warfarin (↓ hiệu quả thuốc tương tác).

Phản ứng bất lợi: Sốt/nổi ban da do thuốc, giảm tiểu cầu, ↑ SGOT/SGPT, viêm gan.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Cao

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: **Tránh sử dụng dạng bào chế dùng** đường uống (thuốc không được hấp thu tốt/ nồng độ thuốc trong huyết thanh khó được dự kiến).

Liều cho màng não = 2 g (TM) mỗi 4 h/ lần.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Màng não không bị viêm = 1%

Viêm màng não = 10%

Khả năng thấm vào mật: 25% (Xem thêm Chương *Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 793).*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Al-Homaidhi H, Abdel-Haq NM, El-Baba M, et al. Severe hepatitis associated with oxacillin therapy. South Med J 95: 650–2, 2002.

Donowitz GR, Mandell GL. Beta-lactam antibiotics. N Engl J Med 318: 419–26 and 318: 490–500, 1993.

Wright AJ. The penicillins. Mayo Clin Proc 74: 290–307, 1999.

Website: www.pdr.net

Pegylated Interferon alfa-2a (Pegasys + Ribavirin

Nhóm thuốc: Interferon/thuốc kháng virus

Liều thường dùng: Pegasys: 180 µg (tiêm dưới da) 1 lần/tuần x 48 tuần; ribavirin: 500 mg (cho bệnh nhân < 75 kg) hoặc 800 mg (cho bệnh nhân > 75 kg) (uống) mỗi 12 h/lần x 48 tuần (*Xem Bình luận*).

Các thông số dược động học:

Nồng độ đáy: 16 ng/mL.

Sinh khả dụng: Không có số liệu.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: Không có số liệu.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 80/100-120 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: Không có số liệu.

Thể tích phân bố (V_d): 8-12 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl 10-50 mL/ phút	Tránh dùng ribavirin
CrCl < 10 mL/ phút	Pegasys: 135 µg (tiêm dưới da) 1 lần/ tuần; tránh dùng ribavirin
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Pegasys: 135 µg (tiêm dưới da) 1 lần/tuần; tránh dùng ribavirin
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không có thông tin
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không có thông tin
Suy gan vừa	135 µg nếu ↑ ALT; Tránh dùng ribavirin
Suy gan nặng	Tránh sử dụng
Trầm cảm mức độ vừa	↓ Pegasys xuống 135 µg (90 µg trong một số trường hợp); đánh giá bệnh nhân hàng tuần
Trầm cảm mức độ nặng	Ngừng dùng Pegasys; hội chẩn ý kiến bác sỹ chuyên khoa tâm thần ngay

Điều chỉnh liều Pegasys gây độc tính trên huyết học

Số lượng tuyệt đối bạch cầu đa nhân trung tính < 750/ mm^3	↓ liều Pegasys xuống còn 135 µg
Số lượng tuyệt đối bạch cầu đa nhân trung tính < 500/ mm^3	Ngừng sử dụng Pegasys tới khi số lượng bạch cầu đa nhân trung tính > 1000/mm^3 Dùng lại thuốc với liều 90 µg và theo dõi số lượng bạch cầu đa nhân trung tính
Tiểu cầu < 50000/ mm^3	↓ liều Pegasys xuống còn 90 µg
Tiểu cầu < 25000/ mm^3	Ngừng sử dụng Pegasys

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Điều chỉnh liều Ribaviringây độc tính trên huyết học

Hgb < 10 g/dL và không có bệnh tim	↓ ribavirin xuống còn 600 mg/ngày
Hgb < 8,5 g/dL và không có bệnh tim	Ngừng dùng ribavirin
Hgb ≥ 2g/dL ↓ trong giai đoạn điều trị 4 tuần và bệnh tim ổn định	↓ ribavirin xuống còn 600 mg/ngày*
Hgb < 12g/dL mặc dù đã giảm liều trong giai đoạn điều trị 4 tuần và bệnh tim ổn định	Ngừng dùng ribavirin

* 1 viên 200 mg vào buổi sáng và 2 viên 200 mg vào buổi chiều.

Tương tác thuốc: Ức chế CYP IA2. Có thể ↑ nồng độ theophyllin.

Phản ứng bất lợi: Các triệu chứng giống cúm, rối loạn thần kinh-tâm thần, độc tính với tủy xương, buồn nôn/nôn/ỉa chảy, rụng tóc, suy giáp, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: Pegasys: C (ribavirin: X; cũng tránh sử dụng cho bạn tình của những phụ nữ có thai).

Bình luận: Liều ribavirin với Pegasys để điều trị virus viêm gan C (genotyp 2,3) là 800 mg/ngày. Liều ribavirin tối ưu để điều trị virus viêm gan C (genotyp 1) còn chưa được xác định song liều khoảng 800-1400 mg/ngày đã được sử dụng. Điều trị phối hợp có hiệu quả hơn dùng điều trị bằng một thuốc. Tránh sử dụng trong viêm gan tự miễn và đợt xơ gan mất bù. Kiểm tra công thức máu hàng tuần. Đối với các genotyp 2 và 3, thời gian điều trị là 24 tuần và liều ribavirin là 400 mg (uống) x 2 lần/ngày. Nên uống ribavirin trong bữa sáng và bữa tối để làm ↑ sinh khả dụng/↓ buồn nôn. Uống ribavirin sau bữa tối có thể gây mất ngủ. Thời gian bán thải trong huyết thanh của ribavirin dài cho phép dùng liều mỗi 24 h/lần nhưng làm ↑ buồn nôn.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: Không có số liệu.

Khả năng thấm vào mật: Không có số liệu.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Davis GL. Combination treatment with interferon and ribavirin for chronic hepatitis C. Clin Liver Dis 1: 811–26, 1999.

Ferenci P. Peginterferon alfa-2a (40KD) (Pegasys) for the treatment of patients with chronic hepatitis C. Int J Clin Pract 57: 610–5, 2003.

Fried MN, et al. Peg-interferon alfa-2a plus ribavirin for chronic hepatitis C virus infection. N Engl J Med 347: 975–82, 2002.

Kamal SM, et al. Peg-interferon alone or with ribavirin enhances HCV-specific CD4 T-helper responses in patients with chronic hepatitis C. Gastroenterology 123: 1070–83, 2002.

Liu C-H, Liang C-C, Liu C-J, et al. Pegylated interferon alfa-2a monotherapy for hemodialysis patients with acute hepatitis c. Clin Infect Dis 51: 541–549, 2010.

Plosker GL, Keating GM. Peginterferon-alpha-2a (40kD) plus ribavirin: a review of its use in hepatitis C virus and HIV co-infection. Drugs 64: 2823–43, 2004.

Website: www.pegasys.com

Pegylated Interferon alfa-2b (Peg-Intron) + Ribavirin

Nhóm thuốc: Interferon/thuốc kháng virus.

Liều thường dùng: Xem trang 174

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 30 IU/mL/3680 ng/mL.

Sinh khả dụng: Không có số liệu/64%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: Không có số liệu/17%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): [40 giờ/không có số liệu] / [298 giờ/không có số liệu].

Liên kết với protein huyết tương: Không có số liệu.

Thể tích phân bố (V_d): 0,99 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận/Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl 30-50 mL/ phút	Cho 75% liều Peg-Intron; Tránh dùng ribavirin
CrCl < 30 mL/ phút	Cho 50% liều Peg-Intron; Tránh dùng ribavirin
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không có thông tin
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không có thông tin
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không có thông tin
Suy gan vừa	Không cần
Suy gan nặng	Tránh dùng
Trầm cảm mức độ vừa	↓ 50% liều Peg-Intron; Đánh giá 1 lần/tuần
Trầm cảm mức độ nặng	Ngừng dùng cả hai thuốc; hội chẩn ý kiến bác sỹ chuyên khoa tâm thần ngay

Điều chỉnh liều gây độc tính trên huyết học

Hgb < 10 g/dL	↓ liều ribavirin xuống 200 mg/ngày
Hgb < 8,5 g/dL	Ngừng sử dụng vĩnh viễn cả 2 thuốc
Số lượng bạch cầu < 1,5 x 10^9/L	↓ liều Peg-Intron khoảng 50%
Số lượng bạch cầu < 1,0 x 10^9/L	Ngừng sử dụng vĩnh viễn cả 2 thuốc
Số lượng tuyệt đối bạch cầu đa nhân trung tính < 0,75 x 10^9/L	↓ liều Peg-Intron khoảng 50%
Số lượng tuyệt đối bạch cầu đa nhân trung tính < 0,5 x 10^9/L	Ngừng sử dụng vĩnh viễn cả 2 thuốc
Số lượng tiểu cầu < 80 x 109/L	↓ liều Peg-Intron khoảng 50%
Số lượng tiểu cầu < 50 x 10^9/L	Ngừng sử dụng vĩnh viễn cả 2 thuốc
↓ Hgb ≥ 2 g/dL- trong giai đoạn điều trị 4 tuần và có bệnh tim ổn định	↓ liều Peg-Intron khoảng 50% và liều ribavirin xuống 200 mg/ngày
Hgb < 12 g/dL mặc dù giảm liều ribavirin	Ngừng sử dụng vĩnh viễn cả 2 thuốc

GROUP DỮ LIỆU Y HỌC Dr Huy Dũng 0978.336.075

Tương tác thuốc: Thuốc tương tự nucleoside (Nucleoside analogs): nhiễm toan lactic gây tử vong/không tử vong. Có thể làm ↑ nồng độ theophylin. Độc tính chồng lấp với các chất gây ức chế tủy xương khác.

Phản ứng bất lợi: Thiếu máu tan máu, các tác động trên tâm thần, giảm các dòng tế bào máu, triệu chứng hô hấp, viêm tụy, phản ứng quá mẫn, ↑ triglycerid, triệu chứng giống cúm, buồn nôn/nôn, rụng lông tóc, nổi ban da, suy giáp.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: Peg-Intron: C (ribavirin: X; tránh sử dụng cho bạn tình của phụ nữ mang thai).

Bình luận: Tránh dùng cho bệnh nhân bị viêm gan tự miễn. Kiểm tra công thức máu trước điều trị và ở thời điểm 2 và 4 tuần sau khi điều trị (phải chỉnh liều khi có ↓ bạch cầu, ↓ bạch cầu đa nhân trung tính, ↓ tiểu cầu, ↓ hemoglobin). Kém được dung nạp ở bệnh nhân bị xơ gan mất bù hoặc viêm gan C tái phát sau ghép gan. Cần cảnh giác đối với tình trạng trầm cảm nặng/những thay đổi về tâm thần.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: Không có số liệu.

Khả năng thấm vào mật: Không có số liệu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Alfaleh FZ, Hadad Q, Khuroo MS, et al. Peginterferon alpha-2b plus ribavirin compared with interferon alpha-2b plus ribavirin for initial treatment of chronic hepatitis C in Saudi patients commonly infected with genotype 4. Liver Int 24: 568–74, 2004.

Fried MN. Side effects of therapy of hepatitis C and their management. Hepatology 36: S237–44, 2002.

Jaeckel E, Cornberg M, Wedemeyer H, et al. Treatment of acute hepatitis C with interferon alfa-2b. N Engl J Med 345: 1452–7, 2001.

Wright TL. Treatment of patients with hepatitis C and cirrhosis. Hepatology 36: S185–91, 2002.

Website: www.pegintron.com

Penicillin G

Nhóm thuốc: Penicillin tự nhiên.

Liều thường dùng: 2-4 triệu đơn vị (TM) mỗi 4 h/lần (*Xem Bình luận*).

Phổ tác dụng: (*Xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 324-335*).

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 20-40 µg/mL.

Sinh khả dụng: Không áp dụng.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 80%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 0,5/5,1 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 60%

Thể tích phân bố (V_d): 0,3 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Điều chỉnh liều*

CrCl 50-80 mL/phút	2-4 triệu đơn vị (TM) mỗi 4 h/lần
CrCl 10-50 mL/phút	1-2 triệu đơn vị (TM) mỗi 4 h/lần
CrCl < 10 mL/phút	1 triệu đơn vị (TM) mỗi 6 h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	2 triệu đơn vị (TM)
Liều dùng sau lọc màng bụng	0,5 triệu đơn vị (TM)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	2 triệu đơn vị (TM) mỗi 6 h/lần
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Probenecid (↑ nồng độ penicillin G).

Phản ứng bất lợi: Sốt/nổi ban da do thuốc, hội chứng hồng ban đa dạng/ hội chứng Stevens-Johnson; phản ứng phản vệ (tụt HA, co thắt thanh quản, co thắt phế quản), mày đay, bệnh huyết thanh.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Cao

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Không tương hợp trong các dung dịch có chứa erythromycin, aminoglycoside, bicarbonat canxi hoặc heparin.

Penicillin G (potassium): nồng độ K^+ = 1,7 mEq/g; Na^+ = 0,3 mEq/g.

Penicillin G (sodium): nồng độ Na^+ = 2 mEq/g.

Liều điều trị bệnh giang mai giai đoạn 1, 2 và **giang mai giai đoạn tiềm tàng sớm**: Benzathin Penicillin 2,4 triệu đơn vị (tiêm bắp) x 1 liều. **Liều điều trị bệnh giang mai giai đoạn tiềm tàng muộn** : Benzathin Penicillin 2,4 triệu đơn vị (tiêm bắp) mỗi 8 h/lần x 1 lần/tuần x 3. **Liều điều trị giang mai thần kinh**: Penicillin G 4 triệu đơn vị (TM) mỗi 4 h/lần x 2 tuần.

Liều cho màng não = 4 triệu đơn vị (TM) mỗi 4 h/lần.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Màng não không bị viêm ≤ 1%

Viêm màng não = 5%

Khả năng thấm vào mật: 500% *(Xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 508).*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Falco V, Almirante B, Jordano Q, et al. Influence of penicillin resistance of outcome in adult patients with invasive pneumococcal pneumonia. Is penicillin useful against intermediately resistant strains? J Antimicrob Chemother 54: 481–8, 2004.

Giachetto G, Pirez MC, Nanni L, et al. Ampicillin and penicillin concentration in serum and pleural fluid of hospitalized children with community-acquired pneumonia. Pediatr Infect Dis J 7: 625–9, 2004.

Steininger C, Allerberger F, Gnaiger E. Clinical significance of inhibition kinetics for Streptococcus pyogenes in response to penicillin. J Antimicrob Chemother 50: 517–23, 2002.

Wendel Jr GD, Sheffield JS, Hollier LM, et al. Treatment of syphilis in pregnancy and prevention of congenital syphilis. Clin Infect Dis 35(Suppl2): S200–9, 2002.

Wright AJ. The penicillins. Mayo Clin Proc 74: 290–307, 1999.

Penicillin V

Nhóm thuốc: Penicillin tự nhiên

Liều thường dùng: 500 mg (uống) mỗi 6h/lần. (không uống thuốc vào bữa ăn).

Phổ tác dụng: *(Xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 324-335).*

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 5 µg/mL.

Sinh khả dụng: 60%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 80%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 0,5/8 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 70%

Thể tích phân bố (V_d): 0,5 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl 10-50 mL/phút	Không thay đổi
CrCl < 10 mL/phút	250-500 mg (uống) mỗi 8 h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	250 mg (uống)
Liều dùng sau lọc màng bụng	250 mg (uống)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	500 mg (uống) mỗi 6 h/lần
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Probenecid (↑ nồng độ penicillin V).

Phản ứng bất lợi: Sốt/nổi ban da do thuốc, hội chứng hồng ban đa dạng/ Stevens-Johnson; phản ứng phản vệ (tụt HA, co thắt thanh quản, co thắt phế quản), mày đay, bệnh huyết thanh, ỉa chảy/viêm đại tràng do *C.dificile.*

Nguy cơ dị ứng thuốc: Cao

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Phản ứng Jarisch-Herxheimer trong khi đang điều trị nhiễm khuẩn do xoắn khuẩn, ví dụ: bệnh Lyme, giang mai, mụn cóc.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: < 10% *(Xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 508).*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bisno AL, Gerber MA, Swaltney JM, et al. Practice guidelines for the diagnosis and management ofgroup A streptococcal pharyngitis. Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 35: 113–25, 2002.

Chiou CC, Does penicillin remain the drug of choice for pneumococcal pneumonia in view of emerging in vitro resistance? Clin Infect Dis 42: 234–7, 2006.

Donowitz GR, Mandell GL. Beta-lactam antibiotics. N Engl J Med 318: 419–26 and 490–500, 1993.

Klugman KP, Yu VL. No Impact of Penicillin Resistance on Mortality. Clin Infect Dis 43: 261, 2006.

Peterson LR. Penicillin for treatment of pneumococcal pneumonia: does in vitro resistance really matter? Clin Infect Dis 42: 224–33, 2006.

Pentamidine (Pentam 300, NebuPent)

Nhóm thuốc: Thuốc chống ký sinh trùng.

Liều thường dùng: 4 mg/kg (TM) mỗi 24 h/lần (*xem Bình luận*).

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 0,6-1,5 µg/mL.

Sinh khả dụng: Không được áp dụng.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 50%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 6,4/90 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 69%

Thể tích phân bố (V_d): 5 L/kg.

Đường thải trừ chính: Được chuyển hóa.

Điều chỉnh liều*

CrCl < 10 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan vừa hoặc nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Rượu, acid valproic, didanosin (↑ nguy cơ viêm tụy); foscarnet (tình trạng giảm nồng độ canxi máu nghiêm trọng đã được báo cáo, không được dùng phối hợp); amphotericin B, các aminoglycosid, capreomycin, cis-platinum, colistin, methoxy-fluran, polymyxin B, vancomycin, các thuốc độc với thận khác (↑ độc tính trên thận).

Phản ứng bất lợi: Tụt huyết áp nặng, giảm nồng độ canxi máu, hạ đường huyết, tăng nồng độ creatinin, viêm tụy, giảm bạch cầu đa nhân trung tính nặng, giảm tiểu cầu, thiếu máu nặng. Có thể làm kéo dài khoảng QT khi dùng đường tĩnh mạch và gây nhịp nhanh thất. Có thể gây các cơn hạ đường huyết nặng ở bệnh nhân đái tháo đường giai đoạn sau. Tình trạng thuốc thoát khỏi lòng mạch khi truyền tĩnh mạch có thể gây hoại tử da nặng nề và dùng thuốc đường đường tiêm bắp có thể rất đau và nên tránh nếu có thể được. Các xét nghiệm sau cần được thực hiện định kỳ: xét nghiệm hàng ngày nồng độ urê và creatinin máu, đường huyết, số lượng hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu cũng như cần xét nghiệm cách ngày bilirubin, phosphatase kiềm, AST (SGOT), ALT (SGPT). Nên ghi điện tim đều đặn để tính khoảng QT_c. Nếu nồng độ creatinin máu tăng lên cần giảm liều xuống 3 hoặc 2 mg/kg. Cần dừng thuốc nếu xảy ra hạ đường huyết hoặc khoảng QT_c kéo dài.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Cao

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: **Thuốc được hấp thu tốt khi tiêm bắp nhưng gây đau**. Truyền

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

tĩnh mạch chậm trong vòng một giờ với dịch glucose 5%, không được pha thuốc trong dung dịch nước muối sinh lý/ thuốc có thể được sử dụng với liều 300 mg theo đường khí dung mỗi tháng/lần để dự phòng. Cần thận trọng với pentamidin dạng hít, nhất là gần đó các nhân viên phục vụ đang mang thai do dược phẩm này có thể gây sảy thai tự nhiên cho đối tượng phơi nhiễm. Cần đặc biệt chú ý để bảo đảm thuốc được tạo thành dạng khí dung thích hợp để có thể phân phối thuốc đồng đều trong toàn bộ hai phổi. Các phản ứng bất lợi khi dùng pentamidin dạng khí dung bao gồm đau ngực, rối loạn nhịp tim, chóng mặt, thở khò khè, ho, khó thở, đau đầu, chán ăn, buồn nôn, ỉa chảy, nổi ban da, viêm họng.

Nếu bệnh nhân bị viêm phổi do *Pneumocystis* carinii đồng thời bị lao phổi, điều trị pentamidin dạng khí dung có thể khiến nhân viên y tế phục vụ cho bệnh nhân bị phơi nhiễm với lao do hít phải các hạt nhỏ. Liều khí dung: Hít pentamidin isethionat (NebuPent) 300 mg hàng tháng qua máy khí dung Respirgard II có thể được sử dụng để phòng ngừa viêm phổi do Pneumocystis carinii. **Khí dung Pentamidin có hiệu quả kém hơn dùng pentamidin đường tĩnh mạch/tiêm bắp và không hiệu quả đối với nhiễm khuẩn do *Pneumocystis carinii* ngoài đường hô hấp.** Thận trọng khi dùng thuốc ở bệnh nhân bị bệnh thận. Các thay đổi nồng độ creatinin máu không dễ phát hiện có thể liên quan tới độc tính nghiêm trọng khi dùng thuốc.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: < 10%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chan C, Montaner J, LeFebvre BA, et al. Atovaquone suspension compared with aerosolized pentamidine for prevention of Pneumocystis carinii pneumonia in human immunodeficiency virus infected subsets intolerant of trimethoprim or sulfamethoxazole. J Infect Dis 180: 369–376, 1999.

Goa KL, Campoli-Richards DM. Pentamidine isethionate: A review of its antiprotozoal activity, pharmacokinetic properties and therapeutic use in Pneumocystis carinii pneumonia. Drugs 33: 242–58, 1987.

Guerin PJ, Alar P, Sundar S, et al. Visceral leishmaniasis: current status of control, diagnosis, and treatment, and a proposed research and development agenda. Lancet Infect Dis 2: 494–501, 2002.

Lionakis MS, Lewis RE, Samonis G, et al. Pentamidine is active in vitro against Fusarium species. Antimicrob Agents Chemother 47: 3252–9, 2003.

Monk JP, Benfield P. Inhaled pentamidine: An overview of its pharmacological properties and a review of its therapeutic use in Pneumocystis carinii pneumonia. Drugs 39: 741–56, 1990.

Rodriquez M, Fishman JA. Prevention of infection due to Pneumocystis spp. in human immunodeficiency virus-negative immunocompromised patients. Clin Microbiol Rev 17: 770–82, 2004.

Sattler FR, Cowam R. Nielsen DM, et al. Trimethoprimsulfamethoxazole compared with pentamidine for treatment of Pneumocystis carinii pneumonia in the acquired immunodeficiency syndrome. Ann Intern Med 109: 280–7, 1988.

Website: www.pdr.net

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Peramivir

Nhóm thuốc: Thuốc ức chế neuroaminidase.

Liều thường dùng: 400 mg (TM) mỗi 24 h/lần hoặc 10 mg/kg (TM) mỗi 24 h/lần, liều tối đa 600 mg/ngày (TM) trong vòng 30 phút.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 17-44 µg/mL/13 µg/mL.

Sinh khả dụng: Không được áp dụng.

Bài xuất dưới dạng nguyên vẹn: Không có số liệu.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 7-20 giờ/ không có số liệu.

Liên kết với protein huyết tương: Không có số liệu

Thể tích phân bố (V_d): Không có số liệu.

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl > 49 mL/phút	600 mg (TM) mỗi 24 h/lần
CrCl 31-49 mL/phút	150 mg (TM) mỗi 24 h/lần
CrCl 10-30 mL/phút	100 mg (TM) mỗi 24 h/lần
CrCl < 10 mL/phút	15 mg (TM) mỗi 24 h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	15 mg (TM) mỗi 24 h/lần
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không có số liệu
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không có số liệu
Suy gan vừa hoặc nặng	Không cần điều chỉnh liều

Tương tác thuốc: Không có số liệu

Phản ứng bất lợi: Ỉa chảy, buồn nôn, nôn, sốt do giảm bạch cầu đa nhân trung tính, nguyên nhân hiếm gặp của shock phản vệ.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp- không được dùng nếu bệnh nhân bị dị ứng nặng với các thuốc ức chế neuroaminidase khác.

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: Không có số liệu.

Bình luận: Peramivir tiêm TM đã được cho phép sử dụng thử nghiệm trong trường hợp cấp cứu ở một số đối tượng bệnh nhân người lớn và trẻ em nhất định đã được chẩn đoán xác định hoặc nghi ngờ nhiễm cúm H1N1 nhập viện điều trị. **Peramivir dùng đường tĩnh mạch được sử dụng cho các bệnh nhân người lớn hoặc trẻ em đã được nhập viện và được chỉ định điều trị bằng một thuốc dùng đường tĩnh mạch cho thấy sự phù hợp về phương diện lâm sàng được dựa trên một hoặc nhiều lý do sau đây: 1. Bệnh nhân không đáp ứng với điều trị kháng virus theo đường uống hoặc đường khí dung hoặc**

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

2. Khi thuốc được phân phối bằng một con đường khác ngoài đường tĩnh mạch- tức là đường ruột (thuốc được hấp thu qua ruột) hoặc 3. Đối với bệnh nhân người lớn chỉ khi thấy thuốc lâm sàng xác nhận điều trị theo đường tĩnh mạch là thích hợp do các lý do khác. Để có được biệt dược peramivir, truy cập địa chỉ web: *www.cdc.gov/h1niflu/eua*. Chỉ nên sử dụng thuốc trong vòng 72 giờ từ khi bắt đầu khởi phát triệu chứng. **Không dùng khi oseltamivir bị kháng**. Không được truyền thuốc tốc độ vượt quá 40 mg/phút. **Thuốc có hoạt tính cao đối với nhiễm cúm lợn (H_1N_1).**

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: Không có số liệu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Arya V, Carter WW, Robertson SM. The role of clinical pharmacology in supporting the emergency use authorization of an unapproved anti-influenza drug, peramivir. Clin Pharmacol Ther 88: 587–589, 2010.

Bazan JA, Bauer KA, Hollister AS, et al. Peramivir pharmacokinetics in two critically ill adults with 2009 H1N1 influenza A concurrently receiving continuous renal replacement therapy. Pharacotherapy 30: 1016–1020, 2010.

Castillo R, Holland LE, Bolz DA. Peramivir and its use in H1N1 influenza. Drugs Today (Barc) 46: 399–408 2010.

Hernandez JE, Adiga R, Armstrong R, et al. Clinical experience in adults and children treated with intravenous peramivir for 2009 influenza A (H1N1) under an emergency IND program in the United States. Clin Infect Dis 52: 695–706, 2011.

Kohno S, Kida H, Mizuguchi M, et al. Efficacy and safety of Intravenous peramivir for treatment ofseasonal infl uenza virus infection. Antimicrob Agents Chemother 54: 4568–4574, 2010.

Kohno S, Kida H, Mizuguchi M, et al. Intravenous peramivir for treatment of influenza A and B virus infection in high-risk patients. Antimicrob Agents Chemother 55: 2803–2812, 2011.

Mancuso CE, Gabay MP, Steinke LM, et al. Peramivir: an intravenous neuraminidase inhibitor for the treatment of 2009 H1N1 infl uenza. Ann Pharmacother 44: 1240–1249, 2010.

Moss RB, Davey RT, Steigbigel RT, et al. Targeting pandemic influenza: a primer on influenza antivirals and drug resistance. J Antimicrob Chemother 65: 1086–1093, 2010.

Nasu T, Ogawa D, Wada J, et al. Peramivir for severe influenza infection in a patient with diabetic nephropathy. Am J Respir Crit Care Med 182: 1209–1210, 2010.

Nguyen HTm, Sheu TG, Mishin VP, et al. Assessment of pandemic and seasonal infl uenza A (H1N1) virus suspectibility to neuraminidase inhibitors in three enzyme activity inhibition assays. Antimicrob Agents Chemother 54: 3671–3677, 2010.

Thomas B, Hollister AS, Muczynski KA. Peramivir clearance in continuous renal replacement therapy. Hemodial Int 14: 339–340, 2010.

Website: www.cdc.gov

Website: www.fda.gov

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Piperacillin (Pipracil)

Nhóm thuốc: Penicillin kháng Pseudomonas.

Liều thường dùng: 3 g (TM) mỗi 4 đến 6 h/lần (*Xem Bình luận*).

Phổ tác dụng: (*Xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 324-335*).

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 412 µg/mL.

Sinh khả dụng: Không được áp dụng.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 50-70%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 1/3 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 16%

Thể tích phân bố (V_d): 0,24 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều* (dựa trên liều dùng 4g mỗi 8 h/lần).

CrCl 20-50 mL/phút	3 g (TM) mỗi 8 h/ lần
CrCl < 20 mL/phút	3 g (TM) mỗi 12 h/ lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	1 g (TM)
Liều dùng sau lọc màng bụng	2 g (TM)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	3 g (TM) mỗi 8 h/ lần
Suy gan vừa hoặc nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Các aminoglycosid (bất hoạt piperacillin khi có suy thận); warfarin (↑ INR); các thuốc viên tránh thai (↓ hiệu quả của thuốc tránh thai dùng đường uống), cefoxitin (↓ tác dụng của piperacillin).

Phản ứng bất lợi: Sốt/nổi ban da do thuốc, các phản ứng phản vệ (tụt huyết áp, co thắt thanh quản, co thắt phế quản), nổi mày đay, bệnh huyết thanh, giảm bạch cầu, thiếu máu tan máu, ỉa chảy/viêm đại tràng do *C. difficile*.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Cao

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Khi tiêm bắp 75% liều thuốc được hấp thu. Không được trộn lẫn/ dùng thuốc chung với các aminoglycosid. **Là penicillin kháng Pseudomonas có hoạt tính mạnh nhất đối với *P. aeruginosa*. Liều điều trị nhiễm khuẩn *P. aeruginosa*/viêm phổi mắc phải trong bệnh viện**: 3 g (TM) mỗi 4 h/lần.

Liều cho màng não = liều thường dùng.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Màng não không viêm = 1%

Viêm màng não = 30%

Khả năng thấm vào mật: 1000% (*Xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 793*).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Donowitz GR, Mandell GL. Beta-lactam antibiotics. N Engl J Med 318: 419–26 and 318: 490–500, 1993.

Kim MK, Capitano B, Mattoes HM, et al. Pharmacokinetic and pharmacodynamic

evaluation of two dosing regimens for piperacillin-susceptible organisms. Pharmacotherapy 22: 569–77, 2002.

Peacock JE, Herrington DA, Wade JC, et al. Ciprofloxacin plus piperacillin compared with tobramycin plus piperacillin as empirical therapy in febrile neutropenic patients. A randomized, doubleblind trial. Ann Intern Med 137: 120, 2002.

Tan JS, File TM, Jr. Antipseudomonal penicillins. Med Clin North Am 79: 679–93, 1995.

Website: www.pdr.net

Piperacillin/tazobactam (Zosyn, Tazocin)

Nhóm thuốc: Penicillin kháng Pseudomonas/ chất ức chế β-lactamase.

Liều thường dùng: 3,375 g (TM) mỗi 6 h/lần (*Xem Bình luận*).

Phổ tác dụng: (*Xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 324-335*).

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 298/34 µg/mL.

Sinh khả dụng: Không được áp dụng

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 60/80%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/bệnh thận giai đoạn cuối): [1,5/8] / [1/7] giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 30/30%

Thể tích phân bố (V_d): 0,3/0,21 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*
(xem thêm *Bình luận*)

CrCl 20–40 mL/phút	2,25 g (TM) mỗi 6 h/lần 3,375 g (TM) mỗi 6 h/lần đối với viêm phổi bệnh viện
CrCl < 20 mL/phút	2,25 g (TM) mỗi 8 h/lần 2,25 g (TM) mỗi 6 h/lần đối với viêm phổi bệnh viện
CrCl < 10 mL/phút	2,25 g (TM) mỗi 8 h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	0,75 g (TM)
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	3,375 g (TM) mỗi 6 h/lần
Suy gan vừa hoặc nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Các aminoglycosid (↓ nồng độ aminoglycosid); vecuronium (↑ tác dụng của vecuronium); probenecid (↑ nồng độ piperacillin/tazobactam); methotrexat (↑ nồng độ methotrexat).

Phản ứng bất lợi: Sốt/nổi ban da do thuốc, tăng bạch cầu ưa acid, ↑/↓ tiểu cầu, giảm bạch cầu (khi dùng kéo dài > 21 ngày), ↑ PT/PTT, ↑ SGOT/SGPT nhẹ thoáng qua, mất ngủ, buồn nôn, đau đầu, táo bón, tăng huyết áp, thiếu máu tan máu, Ỉa chảy/ viêm đại tràng do *C. difficile*.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nguy cơ dị ứng thuốc: Cao

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Liều điều trị nhiễm khuẩn do *P. aeruginosa*/viêm phổi mắc phải tại bệnh viện (khi CrCl bình thường) dùng 4,5 g (TM) mỗi 6 giờ phối hợp với amikacin 1 g (TM) mỗi 24 h/lần.

Liều điều trị nhiễm khuẩn do *P. aeruginosa*/ viêm phổi bệnh viện (khi có ↓ CrCl):

CrCl > 40 mL/phút: 4,5 g (TM) mỗi 6 h/lần.

CrCl 20-40 mL/phút: 3,375 g (TM) mỗi 6 h/lần. CrCl < 20 mL/phút: 2,25g (TM) mỗi 6 h/lần.

Liều dùng khi chạy thận nhân tạo (Hemodialysis): 2,25 g (TM) mỗi 8 h/lần; Cho 0,75 g (TM) sau khi lọc máu vào ngày lọc máu.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Màng não không bị viêm = 1%

Viêm màng não = 30%

Khả năng thấm vào mật: 6000% (*Xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 793*).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bow EJ, Rotstein C, Noskin GA, et al. A randomized, open-label, multicenter comparative study of the efficacy and safety of piperacillin-tazobactam and cefepime for the empirical treatment of febrileneutropenic episodes in patients with hematologic malignancies. Clin Infect Dis 43: 447–59, 2006 .

Frei CR, Hampton SL, Burgess DS. Infl uence of culture site-specific MIC distributions on the pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of piperacillin/tazobactam and piperacillin: a data analysis. Clin Ther 28: 1035–40, 2006.

Gin A, Dilay L, Karlowsky JA, et al. Piperacillin-tazobactam: a beta-lactam/beta-lactamase inhibitor combination. Expert Rev Anti Infect Ther 5: 365–383, 2007.

Hayashi Y, Roberts JA, Paterson DL, et al. Pharmacokinetic evaluation of piperacillin-tazobactam. Expert Opin Drug Metab Toxicol 6: 1017–1031, 2010.

Jones RN, Stilwell MG, Rhomberg PR, et al. Antipseudomonal activity of piperacillin/ tazobactam: more than a decade of experience from the SENTRY Antimicrobial Surveillance Program (1997–2007). Diagn Microbiol Infect Dis 65: 331–334, 2009.

Lau WK, Mercer D, Itani KM, et al. Randomized, openlabel, comparative study of piperacillin-tazobactam administered by continuous infusion versus intermittent infusion for treatment of hospitalized patients with complicated intra-abdominal infection. Antimicrob Agents and Chemother 50: 3556–61, 2006.

Lodise TP Jr, Lomaestro B, Drusano GL. Piperacillintazobactam for Pseudomonas aeruginosa infection: clinical implications of an extended-infusion dosing strategy. Clin Infect Dis 44: 357–363, 2007.

Mattoes HM, Capitano B, Kim MK, et al. Comparative pharmacokinetic and pharmacodynamic profile of piperacillin/ tazobactam 3.375 G Q4H and 4.5 G Q6H. Chemotherapy 458: 59–63, 2002.

Minnaganti VR, Cunha BA. Piperacillin/ tazobactam. Antibiotics for Clinicians 3: 101–8, 1999.

Saltoglu N, Dalkiran A, Tetiker T, et al. Piperacillin/ tazobactamversus imipenem/cilastatin for severe diabetic foot infections: a prospective, randomized clinical trial in a university hospital. Clin Microbiol Infect 16: 1252–1257, 2010.

Sanders WE Jr, Sanders CC. Piperacillin/ tazobactam: A critical review of the evolving clinical literature. Clin Infect Dis 22: 107–23, 1996.

Schoonover LL, Occhipinti DJ, Rodvold KA, et al. Piperacillin/tazobactam: A new beta-lactam/betalactamase inhibitor combination. Ann Pharmacother 29: 501–14, 1995.

Scheetz MH, McKoy JM, Parada JP, et al. Systematic review of piperacillin-induced neutropenia. Drug Saf 30: 295–306, 2007.

Winston LG, Charlebois ED, Pang S, et al. Impact of a formulary switch from ticarcillin-clavulanate to piperacillin-tazobactam on colonization with vancomycin-resistant enterococci. Am J Infect Control 32: 462–9, 2004.

Website: www.zosyn.com

Polymyxin B

Nhóm thuốc: Thuốc kháng sinh làm biến đổi màng tế bào.

Liều thường dùng: 1- 1,25 mg/kg (TM) mỗi 12 h/lần (1 mg=10.000 đơn vị) (*Xem Bình luận*).

Phổ tác dụng: (*Xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn*).

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 8 µg/mL.

Sinh khả dụng: Không được áp dụng.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 60%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 6/48 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: <10%

Thể tích phân bố (V_d): Không có dữ liệu .

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl 20-50 mL/ phút	1 mg/kg (TM) mỗi 12 h/lần
CrCl 5- 20 mL/ phút	0,5 mg/kg (TM) mỗi 12 h/lần
CrCl < 5 mL/phút	0,2 g/kg (TM) mỗi 12 h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo/lọc màng bụng	Không có thông tin
Liều dùng khi CVVH /CVVHD/ CVVHDF	0,5 mg/kg (TM) mỗi 12 h/lần
Suy gan vừa đến nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Amphotericin B, amikacin, gentamicin, tobramycin, vancomycin (↑ độc tính đối với thận).

Phản ứng bất lợi: Suy thận. Độc tính trên thần kinh có liên quan với nồng độ thuốc trong huyết thanh cao/dùng rất dài ngày; Nguy cơ tiềm tàng gây block thần kinh cơ khi có suy thận/rối loạn thần kinh cơ.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Thuốc ức chế giải phóng nội độc tố từ các trực khuẩn Gram âm. Tránh truyền thuốc vào khoang phúc mạc do nguy cơ gây tình trạng block thần kinh-cơ. Gia tăng nguy cơ bị suy thận thể còn nước tiểu có thể hồi phục (hoại tử ống thận cấp [ANT]) khi được sử dụng với các thuốc gây độc với thận khác. Không có khả năng gây độc đối

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

với tai. Thuốc có thể được dùng theo đường tiêm bắp cùng với procain, song rất đau. **Liều khí dung để điều trị nhiễm khuẩn do *P. aeruginosa* đa kháng thuốc ở bệnh nhân bị xơ hóa nang/giãn phế quản là**: 80 mg pha trong dịch muối sinh lý dùng qua đường khí dung mỗi 8 h/lần (đối với nhiễm khuẩn tái phát dùng liều 160 mg). **Liều polymycin B dùng đường nội tủy sống (IT)**: 5 mg (50.000 đơn vị) mỗi 24 h/lần ×3 ngày, sau đó mỗi 48 h/lần × 2 tuần. Hòa loãng 50 mg (500.000 đơn vị) vào 10 mL để tiêm đường nội tủy sống.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: <10% (*Xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 520*).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bratu S, Quale J, Cebular S, et al. Multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa in Brooklyn, New York: molecular epidemiology and in vitro activity of polymyxin B. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 24: 196–201, 2005.

Cruz DN, Antonelli M, Fumagalli R, et al. Early use of Polymyxin B Hemoperfusion in Abdominal Septic Shock. The EUPHAD Randomized Controlled Trial. JAMA 301: 2445–2452, 2009.

Cunha BA. New uses for older antibiotics: nitrofurantoin, amikacin, colistin, polymyxin B, doxycycline, and minocycline revisited. Med Clin North Am 90: 1089–107, 2006.

Evans ME, Feola DJ, Rapp RP. Polymyxin B sulfate and colistin: Old antibiotics for emerging multiresistant gram-negative bacteria. Ann Pharmacother 33: 960–7, 1999.

Falagas ME, Kasiakou SK. Colistin: the revival of polymyxins for the management of multidrugresistant gram-negative bacterial infections. Clin Infect Dis 40: 1333–41, 2005.

Kunin CM. The Pharmacokinetics of Polymyxin B are Dependent on Binding and Release from DeepTissue Compartments. Clin Infect Dis 48: 842–844, 2009.

Li J, Nation RL. Old Polymyxins are Back: Is Resistance Close? Clin Infect Disease 43: 663–64, 2006.

Menzies D, Minnaganti VR, Cunha BA. Polymyxin B. Antibiotics for Clinicians 4: 33–40, 2000.

Parchuri S, Mohan S, Young S, Cunha BA. Chronic ambulatory peritoneal dialysis associated peritonitis ESBL producing Klebsiella pneumoniae successfully treated with polymyxin B. Heart & Lung 34: 360, 2005.

Segal-Maurer S, Mariano N, Qavi A, et al. Successful treatment of ceftazidime-resistant Klebsiella pneumoniae ventriculitis with intravenous meropenem and intraventricular polymyxin B: Case report and review. Clin Infect Dis 28: 1134–8, 1999.

Wareham DW, Bean DC. In vitro activities of polymyxin B, imipenem and rifampin against multidrug-resistant Acinetobacter baumannii. Antimicrob Agents Chemother 50: 825–26, 2006.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Posaconazole (Noxafil)

Nhóm thuốc: Thuốc chống nấm (nhóm triazol).

Liều thường dùng: *Dự phòng các nhiễm khuẩn xâm lấn do Aspergillus và Candida ở bệnh nhân nguy cơ cao* (bệnh lý thải ghép , giảm bạch cầu kéo dài do hóa trị)†: 200 mg (uống) mỗi 8 h/lần. *Điều trị nhiễm Candida hầu họng*:100 mg (uống) mỗi 12 h/lần x 1 ngày, sau đó dùng 100 mg (uống) mỗi 24 h/lần x 13 ngày; đối với các chủng nấm kháng fluconazol và/hoặc itraconazol, dùng liều 400 mg (uống) mỗi 12 h/lần với thời gian điều trị được dựa trên tình trạng bệnh lý nền

của bệnh nhân và đáp ứng lâm sàng.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 3 µg/mL.

Sinh khả dụng: Hấp thu thuốc ↑ gấp 2-6 lần khi dùng cùng với thức ăn.

Bài xuất dưới dạng nguyên vẹn (qua nước tiểu): < 1%

Bài xuất dưới dạng nguyên vẹn(qua phân): 66%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 35/35 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 98,2%

Thể tích phân bố (V_d): 1774 L/kg.

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều*

CrCl < 10 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không cần dùng
Suy gan vừa hoặc nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Posaconazol được chuyển hóa qua quá trình liên hợp với acid glucuronic tại gan. Các chất gây cảm ứng (ví dụ, rifampin, phenytoin) có thể làm biến đổi chuyển hóa thuốc. Amiodaron, rifabutin, phenytoin, phenytoin, cimetidin (làm ↓ 50% nồng độ posaconazol). Posaconazol ức chế enzym CYP3A4 của gan và có thể làm tăng nồng độ các thuốc được chuyển hóa qua enzyme này. Các thuốc gây kéo dài khoảng QT như terfenadin, astemizol, cisaprid, pimozid, halofantrin, quinidin (↑ nồng độ thuốc tương tác, ↑ nguy cơ bị loạn nhịp tim); các ergot (↑ nồng độ ergot); các dẫn xuất của statin (↑ nồng độ statin và nguy cơ gây tiêu cơ vân); các alkaloid của cây dừa cạn (↑ nồng độ alkaloid của cây dừa cạn và nguy cơ gây độc trên thần kinh); cyclosporin, tacrolimus, sirolimus, midazolam và các benzodiazepin khác được chuyển hóa qua bởi CYP3A4, các thuốc chẹn kênh canxi được chuyển hóa bởi CYP3A4 (diltiazem, verapamil, nifedipin, nisoldipin); digoxin, các dẫn xuất sulfonylurea, ritonavir, indinavir (↑ nồng độ thuốc tương tác).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Phản ứng bất lợi: Buồn nôn, nôn, ỉa chảy, đau đầu, ↑ SGOT/SGPT; kéo dài khoảng QTc.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Có trên thị trường biệt dược hàm lượng 40 mg/mL dạng hỗn dịch uống. Uống thuốc trong bữa ăn hoặc với 240 mL chất bổ sung dinh dưỡng. **Thuốc có hoạt tính cao đối với *Candida albicans*, hầu hết các chủng nấm Candida không phải albicans, Aspergillus, Cryptococcus, nhiễm nấm Histoplasmosma, Blastomycosis, Sporotrichosis, Paracoccidioidomycosis. Thuốc**

có hoạt tính nhất định đối với Coccidiomycosis, Fusarium và *C. glabrata*. Không có hoạt tính đối với Pseudallescheria/Scedosporium hoặc Mucor. Nồng độ thuốc trong máu không tăng lên khi tăng liều dùng.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: Không có số liệu

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Alffenaar JWC, van Assen S, van der Werf TS. Omeprazole signifi cantly reduces poconazole serum through level. Clin Infect Dis 48: 839–840, 2009.

Bruggemann RJM, Alffenaar JWC, Blijlevens NMA, et al. Clinical relevance of the pharmoacokinetic interactions of azole antifungal drugs with coadministered agents. Clin Infect Dis 48: 1441–1458, 2009.

Chen A, Sobel JD. Emerging azole antifungals. Expert Opin Emerg Drugs 10: 21–33, 2005.

Cornely OA, Maertens J, Winston DJ, et al. Posaconazole vs. fl uconazole or itraconazole prophylaxis in patients with neutropenia. N Engl J Med 356: 348–59, 2007.

Courtney R, Pai S, Laughlin M, et al. Pharmacokinetics, safety, and tolerability of oral posaconazole in single and multiple doses in healthy adults. Antimicrob Agents Chemother 47: 2788–2795, 2003.

Courtney R, Sansone A, Smith W, et al. Posaconazole pharmacokinetics, safety, and tolerability in subjects with varying degrees of chronic renal disease. J Clin Pharmacol 45: 185–192, 2005.

Dodds Ashley ES, Alexander BD. Posaconazole. Drugs Today 41: 393–400, 2005.

E zet F, Wexler D, Courtney R, et al. Oral bioavailability of posaconazole in fasted healthy subjectscomparison between three regimens and basis forclinical dosage recommendations. Clin Pharmacokinet 44: 211–220, 2005.

Felton TW, Baxter C, Moore CB, et al. Efficacy and safety of posaconazole for chronic pulmonary aspergillosis. Clin Infect Dis 51: 1383–1391, 2010.

Green MR, Woolery JE. Optimising absorption of posaconazole. Mycoses 54: 775–779, 2011.

Greenberg RN, Mullane K, van Burik JA, et al. Posaconazole as salvage therapy for zygomycosis. Antimicrob Agents Chemother 50: 126–33, 2006.

Gubbins PO, Krishna G, Sansone-Parsons A, et al. Pharmacokinetics and safety of oral posaconazole in neutropenic stem cell transplant recipients. Antimicrob Agents Chemother 50: 1993–9, 2006.

Herbrecht R, Nivoix Y, Fohrer C, et al. Management of systemic fungal infections: alternatives to itraconazole. J Antimicrob Chemother 56: 139–148, 2005.

Hohmann C, Kang EM, Jancel T: Rifampin and posaconazole coadministration leads to decreased serum posaconazole concentrations. Clin Infect Dis 50: 939–940, 2010.

Howard SJ, Lestner JM, Sharp A, et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of posaconazole for invasive pulmonary aspergillosis: clinical implications for antifungal therapy. J Infect Dis 203: 1324–1332, 2011.

Karthaus M. Prophylaxis and treatment of invasive aspergillosis and voriconazole, posaconazole, and caspofungin: review of the literature. Eur J Med Res 16: 145–152, 2011.

Keating GM, Posaconazole. Drugs 65: 1553–69, 2005.

Kontoyiannis DP, Lewis RE. Posaconazole prophylaxis in hematologic cancer. N Engl J Med 24: 2214–2215, 2007.

Lipp HP. Posaconazole: clinical pharmacokinetics and drug interactions. Mycoses 54: 32–38, 2011.

Miceli MH, Diaz JA, Lee SA. Emerging opportunistic yeast infections. Lancet Infectious Diseases 11: 142–151, 2011.

Mehta AK, Langston AA. Use of posaconazole in the treatment of invasive fungal infections. Expert Rec Hematol 2: 619–630, 2009.

Mullane K, Toor AA, Kalnicky C, et al.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Posaconazole salvage therapy allows successful allogeneichematopoietic stem cell transplantation in patients with refractory invasive mold infections. Transpl Infect Dis 9: 89–96, 2007.

Pound MW, Townsend ML, Dimondi V, et al. Overview of treatment options for invasive fungal infections. Med Mycol 49: 561–580, 2011.

Raad II, Graybill JR, Bustamante AB, et al. Safety of long-term oral posaconazole use in the treatment of refractory invasive fungal infections. Clin Infect Dis 42: 1726–34, 2006.

Raad II, Hachem RY, Herbrecht R, et al. Posaconazole as salvage treatment for invasive fusariosis in patients with underlying hematologic malignancy and other conditions. Clin Infect Dis 42: 1398–403, 2006.

Restrepo A, Tobon A, Clark B, et al. Salvage treatment of histoplasmosis with posaconazole. Salvage treatment of histoplasmosis with posaconazole. J Infect 54: 319–327, 2007.

Ullmann AJ, Cornely OA, Burchardt A, et al. Pharmacokinetics, safety, and efficacy of posaconazole in patients with persistent febrile neutropenia or refractory invasive fungal infection. Antimicrob Agents Chemother 50: 658–66, 2006.

Ullmann AJ, Lipton JH, Vesole DH, et al. Posaconazole or fluconazole for prophylaxis in severe graft-versushost disease. N Engl J Med 356: 335–47, 2007.

Vazquez JA, Skiest DJ, Nieto L, et al. A multicenter randomized trial evaluating posaconazole versus fluconazole for the treatment of oropharyngeal candidiasis in subjects with HIV. Clin Infect Dis 42: 1179–86, 2006.

Walsh TJ, Raad I, Patterson TF, et al. Treatment of invasive Aspergillosis with posaconazole in patients who are refractory to or intolerant of conventional therapy: an externally controlled trial. Clin Infect Dis 44: 2–12, 2007.

Website: www.noxafil.com

Primaquine

Nhóm thuốc: Thuốc điều trị sốt rét/ thuốc điều trị viêm phổi do Pneumocystis carinii.

Liều thường dùng: Liều điều trị sốt rét: 15 mg (26,3 mg dạng bazơ) (uống) mỗi 24 h/lần. **Liều điều trị viêm phổi do Pneumocystis carinii**: 15-30 mg (uống) phối hợp với clindamycin 600 mg (TM) hoặc 300 mg (uống) mỗi 6 h/lần.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 30-100 µg/mL.

Sinh khả dụng: 90%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 3,6%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/bệnh thận giai đoạn cuối): 3,7-9,6/3.7-9,6 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 75%

Thể tích phân bố (V_d): Không có số liệu.

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều*

CrCl < 80 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo /lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Tránh dùng cho bệnh nhân đang sử dụng các thuốc ức

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

chế tủy xương (↑ nguy cơ bị mất bạch cầu hạt), rượu (↑ tác dụng phụ trên đường tiêu hóa), quinacrin (↑ nồng độ/độc tính của primaquin).

Phản ứng bất lợi: Buồn nôn/nôn, đau đầu, đau bụng, giảm bạch cầu (phụ thuộc vào liều), mất bạch cầu hạt, ngứa. Thiếu máu tan máu ở người thiếu enzym G6PD; Gây methemoglobin ở người thiếu NADH reductase.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: D

Bình luận: Uống thuốc vào bữa ăn làm giảm tác dụng phụ trên đường tiêu hóa. Thận trọng khi sử dụng cho người bị thiếu hụt enzym G6PD. Thận trọng khi sử dụng cho các đối tượng bị thiếu hụt NADH reductase.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: Không có số liệu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Baird JK. Effectiveness of antimalarial drugs. N Engl J Med 352: 1565–77, 2005.

Chen LH, Keystone JS. New strategies for the prevention of malaria in travelers. Infect Dis Clin North Am 19: 185–210, 2005.

Korraa H, Saadeh C. Options in the management of pneumonia caused by Pneumocystis carinii in patients with acquired immune defi ciency syndrome and intolerance to trimethoprim/sulfamethoxazole. South Med J 89: 272–7, 1996.

Safrin S, Finkelstein DM, Feinberg J, et al. Comparison of three regimens for treatment of mild to moderate Pneumocystis carinii pneumonia in patients with AIDS. A double-blind randomized trial of oral TMP–SMX, dapsone-TMP & clinda-primaquine. Ann Intern Med 124: 792–802, 1996.

Pyrazinamide (PZA)

Nhóm thuốc: Thuốc chống lao.

Liều thường dùng: 25 mg/kg (uống) mỗi 24 h/lần (tối đa 2 g) *(Xem Bình luận)*.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 30-50 µg/mL.

Sinh khả dụng: 90%.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 10%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/bệnh thận giai đoạn cuối): 9/26 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 10%

Thể tích phân bố (V_d): 0,9 L/kg

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều*

CrCl < 30 mL/phút	25 mg/kg (uống) x 3 lần/tuần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	25 mg/kg (uống) hoặc 1g (uống)
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không thay đổi
Liều dùng khi CVVH /CVVHD/ CVVHDF	Không có thông tin
Suy gan vừa	Không có thông tin
Suy gan nặng	Tránh dùng

Tương tác thuốc: INH, rifabutin, rifampin (↑ độc tính trên gan).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Phản ứng bất lợi: Sốt/nổi ban da do thuốc, khó ỉa, buồn nôn, nôn, chán ăn, ↑ SGOT/SGPT, ↑ acid uric, thiếu máu nguyên bào sắt.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Tránh dùng cho bệnh nhân bị gout (có thể thúc đẩy các đợt gout cấp). **Liều điều trị TB D.O.T:** 4 g (uống) x 2 lần/tuần hoặc 3 g (uống) x 3 lần/tuần.

Liều cho màng não = liều thường dùng.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: 100%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Ahn C, Oh KH, Kim K, et al. Effect of peritoneal dialysis on plasma and peritoneal fluid concentrations of isoniazid, pyrazinamide, and rifampin. Perit Dial Int 23: 362–7, 2003.

Davidson PT, Le HQ. Drug treatment of tuberculosis 1992. Drugs 43: 651–73, 1992.

[No authors listed.] Drugs for tuberculosis. Med Lett Drugs Ther 35: 99–101, 1993.

Furin J, Nardell EA. Multidrug-resistant tuberculosis: An update on the best regimens. J Respir Dis 27: 172–82, 2006.

Iseman MD. Treatment of multidrug-resistant tuberculosis. N Engl J Med 329: 784–91, 1993.

McIlleron H, Wash P, Burger A, et al. Determinants of rifampin, isoniazid, pyrazinamide and ethambutol pharmacokinetics in a cohort of tuberculosis patients. Antimicrob Agents Chemother 50: 1170–77, 2006.

Schlossberg D: An approach to drug-induced liver injury during tuberculosis therapy. Infect Dis Clin Pract 18: 107–108, 2010.

Van Scoy RE, Wilkowske CJ. Antituberculous agents. Mayo Clin Proc 67: 179–87, 1992.

Pyrimethamine (Daraprim)

Nhóm thuốc: Thuốc điều trị ký sinh trùng.

Liều thường dùng: 75 mg (uống) mỗi 24 h/lần (*Xem Bình luận*).

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 0,4 µg/mL.

Sinh khả dụng: 90%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 25 %.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 96/96 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 87%

Thể tích phân bố (V_d): 2,5L/Kg.

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều*

CrCl < 10 mL/phút	Không thay đổi; thận trọng khi dùng
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	25 mg (uống)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi; thận trọng khi dùng

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tương tác thuốc: acid folic (↓ tác dụng của pyrimethamin); lorazepam (↑ nguy cơ gây độc cho gan); sulfamethoxazol, trimethoprim, TMP-SMX (↑ nguy cơ giảm tiểu cầu, thiếu máu, giảm bạch cầu).

Phản ứng bất lợi: Thiếu máu nguyên hồng cầu khổng lồ, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu, mất điều vận, run cơ, co giật.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Thuốc trung hòa acid dịch vị làm giảm hấp thu thuốc. **Liều điều trị nhiễm *Toxoplasma gonndii***: 200 mg (uống) x 1 liều, sau đó 50-75 mg/kg (uống) mỗi 24 h/lần (với acid folinic 20 mg đường uống phối hợp với hoặc sulfadiazin hoặc clindamycin).

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: 10-25%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lemnge MM, Ali AS, Malecela EK, et al. Therapeutic efficacy of sulfadoxine pyrimethamine and amodiaquine among children with uncomplicated Plasmodium falciparum malaria in Zanzibar, Tanzania. Am. J. Trop. Med Hyg 73: 681–5, 2005.

Podzamczer D, Salazar A, Jiminez J, et al. Intermittent trimethoprim-sulfamethoxazole compared with dapsone-pyrimethamine for the simultaneous primary prophylaxis of Pneumocystis pneumonia and toxoplasmosis in patients infected with HIV. Ann Intern Med 122: 755–61, 1995.

Porter SB, Sande MA. Toxoplasmosis of the central nervous system in the acquired-immunodeficiency syndrome. N Engl J Med 327: 1643–8, 1992.

Website: www.pdr.net

Quinine sulfate

Nhóm thuốc: Thuốc điều trị sốt rét.

Liều thường dùng: 650 mg (uống) mỗi 8 h/lần (*Xem Bình luận*).

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 3,8 µg/mL.

Sinh khả dụng: 80%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 5%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/bệnh thận giai đoạn cuối): 7/14 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 95%

Thể tích phân bố (V_d): 3 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận/gan

Điều chỉnh liều*

CrCl 10-50 mL/phút	650 mg (uống) mỗi 12 h/lần
CrCl < 10 mL/phút	650 mg (uống) mỗi 12 h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	650 mg (uống)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	650 mg (uống) mỗi 12 h/lần
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	325 mg (uống) mỗi 12 h/lần; thận trọng khi dùng thuốc

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tương tác thuốc: Amiodaron, các thuốc trung hòa acid dịch vị chứa muối nhôm (↓ hấp thu quinidin); astemizol, cisaprid, terfenadin (↑ nồng độ thuốc tương tác, xoắn đỉnh; tránh dùng); cimetidin, ritonavir (↑ độc tính của quinidin: đau đầu, điếc, mù, nhịp tim nhanh); cyclosporin dofetilid, flecainid (rối loạn nhịp tim); mefloquin (co giật, có thể ↑ khoảng QT, xoắn đỉnh, ngừng tim, ↓ hiệu quả của mefloquin); metformin (↑ nguy cơ nhiễm toan lactic); pancuronium, succinylcholin, tubocurarin (gây block tỏa dẫn truyền thần kinh-cơ); warfarin (↑ INR).

Phản ứng bất lợi: Sốt/ nổi ban da do thuốc, ↑ khoảng QTc, loạn nhịp tim, bệnh lupus ban đỏ hệ thống do thuốc, hoa mắt choáng váng, ỉa chảy, đau bụng, buồn nôn, nôn, hội chứng canhkina (cinchonism) nếu dùng thuốc dài ngày. Tránh dùng thuốc cho bệnh nhân bị thiếu hụt men G6PD.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Cao

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: **Liều đường uống điều trị sốt rét**: 650 mg (uống) mỗi 8 h/lần (*phối hợp với doxycyclin* 100 mg đường uống mỗi 12 h/lần) x 3-7 ngày). **Liều đường tĩnh mạch điều trị sốt rét**: Quinin hydrochlorid 600 mg (TM) mỗi 8 h/lần x 3-7 ngày hoặc quinidin gluconate 10 mg/kg (TM) x 1 liều (truyền trong vòng 1-2 giờ) sau đó dùng liều 0,02 mg/kg/phút (TM) x 72 giờ hoặc đến khi mật độ ký sinh trùng trong máu < 1%.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: 2-5%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Corpelet C, Vacher P, Coudor F, et al. Role of quinine in life-threatening Babesia divergens infection successfully treated with clindamycin. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 24: 74–75, 2005.

Croft AM, Herxheimer A. Tolerability of antimalaria drugs. Clin Infect Dis 34: 1278; discussion 1278–9, 2002. Drugs for Parasitic Infections. Med Letter. March, 2000.

Panisko DM, Keystone JS. Treatment of malaria. Drugs 39: 160–89, 1990.

Wyler DJ, Malaria: Overview and update. Clin Infect Dis 16: 449–56, 1993.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Quinupristin/dalfopristin (Synercid)

Nhóm thuốc: Streptogramin

Liều thường dùng: 7,5 mg/kg (TM) mỗi 8 h/lần.

Phổ tác dụng: (*Xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 332-335*).

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 3,2/8 µg/mL.

Sinh khả dụng: không được áp dụng.

Thải trừ dưới dạng *nguyên vẹn*: 20% (qua nước tiểu), 80% (qua phân).

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/bệnh thận giai đoạn cuối): [3,1/1]/[3,1/1] giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 55/15%

Thể tích phân bố (V_d): 0,45/0,24 L/kg.

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều*

CrCl < 10 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không có thông tin

Tương tác thuốc: Amiodaron, amlodipin (↑ độc tính của amlodipin); astemizol, cisaprid (có thể làm ↑ khoảng QT, xoắn đỉnh); carbamazepin (↑ độc tính của carbamazepin: mất điều vận, rung giật nhãn cầu, nhìn đôi, đau đầu, co giật); cyclosporin, delavirdin, indinavir, nevirapin (↑ nồng độ thuốc tương tác); diazepam, diltiazem, felodipin, isradipin (↑ độc tính của thuốc tương tác: chóng mặt, tụt huyết áp, đau đầu, đỏ bừng mặt); disopyramid (↑ độc tính của disopyramid: rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp, ngất); docetaxel (↑ độc tính của thuốc tương tác: giảm bạch cầu trung tính, loạn nhịp tim, co giật); methylprednisolon (↑ độc tính của methylprednisolon: các bệnh về cơ, đái tháo đường, hội chứng Cushing); nicardipin, nifedipin, nimodipin (↑ độc tính của thuốc tương tác: chóng mặt, tụt huyết áp, đỏ bừng mặt, đau đầu); statins (↑ nguy cơ bị tiêu cơ vân).

Phản ứng bất lợi: Đau, viêm và sưng tại vị trí truyền thuốc tĩnh mạch (phụ thuộc vào liều), đau cơ nặng/kéo dài, tăng bilirubin máu, suy gan làm tăng nồng độ (AUC) của các chất chuyển hóa lên 180%/ 50%.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Pha thuốc trong dung dịch glucose 5% hoặc nước cất vô trùng, không pha trong dung dịch muối đẳng trương. Cần có đường truyền tĩnh mạch trung tâm để truyền thuốc. **Thuốc không có hiệu quả đối với *E. faecalis* (cầu khuẩn ruột nhạy với vancomycin [VSE]). Có thể hữu ích đối với các nhiễm khuẩn tụ cầu vàng kháng methicilin (MRSA)/ tụ cầu vàng nhạy với methicillin (MSSA) song kháng với daptomycin.**

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: < 10%

(Xem Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 518).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Blondeau JM, Sanche Se. Quinupristin/ dalfopristin. Expert Opin Pharmacother 3: 1341–64, 2002.

Bouza E. New therapeutic choices for infections caused by methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Clin Microbiol Infect Dis 15: 44–52, 2009.

Bryson HM, Spencer CM. Quinupristin/ dalfopristin. Drugs 52: 406–15, 1996.

Chant C, Ryback MH. Quinupristin/dalfopristin (RP 59500): A new streptogramin antibiotic. Ann Pharmacother 29: 1022–7, 1995.

Goff DA, Sierawski SJ. Clinical experience of quinupristin-dalfopristin for the treatment of antimicrobial-resistant gram-positive infections. Pharmacotherapy 22: 748–58, 2002.

Griswold MW, Lomaestro BM, Briceland LL. Quinupristin-dalfopristin (RP 59500): An injectable streptogramin combination. Am J Health Syst Pharm 53: 2045–53, 1996.

Kim MK, Nicolau DP, Nightingale CH, et al. Quinupristin/dalfopristin: A treatment option for vancomycin-resistant enterococci. Conn Med 64: 209–12, 2000.

Klastersky J. Role of quinupristin/dalfopristin in the treatment of Gram-positive nosocomial infections in haematological or oncological patients. Cancer Treat Rev 29: 431–40, 2003.

Nadler H, Dowzicky MJ, Feger C, et al. Quinupristin/dalfopristin: A novel selective-spectrum antibiotic for the treatment of multi-resistant and other gram-positive pathogens. Clin Microbiol Newslett 21: 103–12, 1999.

Nailor MD, Sobel JD. Antibiotics for gram-positive bacterial infection: vancomycin, teicoplanin, quinupristin/dalfopristin, oxazolidinones, daptomycin, telavancin, and ceftaroline fosamil. Med Clin North Am 95: 723–742, 2011.

Scotton PG, Rigoli R, Vaglia A. Combination of quinupristin/dalfopristin and glycopeptide in severe methicillinresistant staphylococcal infections failing previous glycopeptide regimen. Infection 30: 161–3, 2002.

Website: www.synercid.com

Raltegravir (Isentress) RAL

Nhóm thuốc: Thuốc ức chế integrase của HIV-1

Liều thường dùng: 400 mg (uống) mỗi 12 h/lần.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 6,5 µg/mL.

Sinh khả dụng: ~ 32% (20-43%).

Thải nguyên vẹn: 51% (qua phân); 9% (qua nước tiểu).

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 9-12 giờ/ không có số liệu.

Liên kết với protein huyết tương: 83%

Thể tích phân bố (V_d): không được nghiên cứu.

Đường thải trừ chính: Phân/ thận.

Điều chỉnh liều*

CrCl < 10 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không cần dùng
Suy gan nhẹ/trung bình	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không có thông tin

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Điều chỉnh liều thuốc chống retrovirus

Atazanavir	Không thay đổi
Atazanavir/ritonavir	Không thay đổi
Efavirenz	Không thay đổi
Rifampin	Tránh dùng
Ritonavir	Không thay đổi
Tenofovir	Không thay đổi
Tipranavir/ritonavir	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Rifampin (↓ nồng độ raltegravir, thận trọng khi dùng thuốc). Trên thực nghiệm, raltegravir không ức chế CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 hoặc CYP3A và không gây cảm ứng đối với CYP3A4. Ngoài ra, raltegravir không ức chế quá trình vận chuyển qua trung gian glycoprotein P. Do đó, thuốc không được dự kiến là sẽ có tác động tới dược động học của các thuốc là cơ chất của những enzyme này hoặc của glycoprotein P (ví dụ: thuốc chống retrovirus nhóm ức chế protease [PI], thuốc chống retrovirus nhóm ức chế enzym sao chép ngược không phải nucleoside [NNRTIs], methadon, thuốc giảm đau gây nghiện nhóm opioid, statin, thuốc chống nấm nhóm azole, thuốc ức chế bơm proton, thuốc viên tránh thai, chất điều trị rối loạn cương dương).

Phản ứng bất lợi: Buồn nôn, đau đầu, ỉa chảy, sốt.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Có thể uống thuốc kèm với hoặc không kèm thức ăn. Tăng CPK, bệnh về cơ và tiêu cơ đã được báo cáo – cần sử dụng thuốc một cách thận trọng ở các bệnh nhân có nguy cơ cao bị các bệnh cơ hoặc tiêu cơ vân, như các bệnh nhân sử dụng đồng thời thuốc có khả năng gây ra những bất thường này (ví dụ: stastin). Raltegravir được chỉ định để điều trị cho những bệnh nhân người lớn đã từng dùng thuốc kháng virus và là đối tượng có bằng chứng nhân lên của virus và nhiễm các chủng HIV-1 kháng với nhiều thuốc chống retrovirus. Gia tăng nhẹ nguy cơ bị ung thư ở các đối tượng bị suy giảm miễn dịch nặng.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: Không có số liệu.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Grinsztejn B, Nguyen BY, Katlama C, et al. Safety and efficacy of the HIV-1 integrase inhibitor raltegravir (MK-0518) in treatment-experienced patients with multidrug-resistant virus: a phase II randomised controlled trial. Lancet 369: 1261–1269, 2007.

Hicks C, Gulick RM. Raltegravir: The First HIV Type 1 Integrase Inhibitor. Clin Infect Dis 48: 931–940, 2009.

Iwamoto M, Wenning LA, Petry AS, et al. Safety, tolerability, and pharmacokinetics of raltegravir after single and multiple doses in healthy subjects. Clin Pharmacol Ther 83: 293–299, 2008.

Kassahun K, McIntosh I, Cui D, et al. Metabolism and disposition in humans of raltegravir (MK-0518), an anti-AIDS drug targeting the HIV-1 integrase enzyme. Drug Metab Dispos 35: 1657–1663, 2007.

Markowitz M, Morales-Ramirez JO, Nguyen BY, et al. Antiretroviral activity, pharmacokinetics, and tolerability of MK-0518, a novel inhibitor of HIV-1 integrase, dosed as monotherapy for 10 days in treatment-naive HIV-1–infected

individuals. J Acquir Immune Defic Syndr 43: 509–515, 2006.

Palmisano L, Role of integrase inhibitors in the treatment of HIV disease. Expert Rev Anti Infect Ther 5: 67–75, 2007.

Thompson MA, Aberg JA, Cahn P, et al. Antiretroviral treatment of adult HIV infection: 2010. recommendations of the international AIDS society – USA panel. JAMA 304: 321–333, 2010.

Website: www.isentress.com

Ribavirin (Rebetol) (Copegus)

Nhóm thuốc: Thuốc kháng virus hợp bào hô hấp (RSV), thuốc điều trị virus viêm gan C (*Xem Bình luận*).

Liều thường dùng: 600 mg (uống) mỗi 12 h/lần (*Xem Bình luận*).

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 0,07-0,28 µg/mL.

Sinh khả dụng: 64%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 40%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 120 giờ/ không có số liệu.

Liên kết với protein huyết tương: 0%

Thể tích phân bố (V_d): 10 L/kg.

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều*

CrCl 50-80 mL/phút	Không thay đổi
CrCl 10-50 mL/phút	Tránh dùng
CrCl < 10 mL/phút	Tránh dùng
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Tránh dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Tránh dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Tránh dùng
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Tránh dùng

Tương tác thuốc: Ribavirin có thể đối kháng hoạt tính kháng virus trên in vitro của stavudin và zidovudin trong điều trị nhiễm HIV. Pegylated interferon (Pegasys) ở bệnh nhân nhiễm HIV (↓ số lượng tế bào CD4).

Phản ứng bất lợi: Thiếu máu tan máu. Thiếu máu liên quan đến điều trị bằng ribavirin có thể làm nặng thêm bệnh tim và tình trạng này có thể dẫn tới nhồi máu cơ tim gây tử vong hoặc không tử vong. Bệnh nhân có tiền sử bị bệnh tim có ý nghĩa không nên được điều trị bằng ribavirin. Nếu nồng độ hemoglobin < 10 g/dL cần giảm liều ribavirin xuống còn 600 mg dùng hằng ngày. Nếu nồng độ hemoglobin < 8,5 g/dL, ngừng dùng ribavirin. Khi được dùng kết hợp với interferon, các phản ứng bất lợi có thể gặp bao gồm: tình trạng trầm cảm nặng và ý định tự tử, ức chế tủy xương, các bệnh lý nhiễm khuẩn/bệnh tự miễn, rối loạn chức năng hô hấp, viêm tụy và đái tháo

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

đường. Sốt/nổi ban da do thuốc, buồn nôn, nôn, khó chịu trên đường tiêu hóa, giảm bạch cầu, tăng bilirubin máu, thiếu máu tan máu, ↑ acid uric.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: X (tránh mang thai trong khi điều trị và sau khi đã kết thúc điều trị 6 tháng ở cả bệnh nhân nữ và bạn tình nam của người dùng ribavirin)

Bình luận: Liều dùng dạng khí dung để điều trị virus hợp bào hô hấp (RSV): 20 mg/mL đường khí dung trong vòng 12 giờ mỗi ngày x 3-7 ngày. Thuốc cũng có hoạt tính đối với sốt Lassa (Lassa fever) và hội chứng phổi do Hatavirus (Hantavirus Pulmonary Syndrome).

Liều cho bệnh nhân ghép tạng: *Liều nạp*: 30 mg/kg (TM) (không vượt quá 2 g), sau đó dùng liều 16 mg/kg (TM) mỗi 6 h/lần x 4 ngày (không vượt quá 1g); *Liều duy trì*: 8 mg/kg (TM) (không vượt quá 500 mg) x 3-6 ngày.

Thuốc có hoạt tính cao đối với virus viêm gan C (HCV) và virus hợp bào đường hô hấp (RSV). Thuốc có hoạt tính nhất định đối với HEV, adenovirus và sốt xuất huyết do arbovirus Thuốc không có hoạt tính đối với EBV, CMV, HBV, HDV. Đối với sốt xuất huyết Crimean-Congo sử dụng ribavirin ban đầu với *Liều nạp*: 30 mg/kg (uống) x 1 , sau đó dùng *Liều duy trì*: 15 mg/kg (uống) mỗi 6 h/lần x 4 ngày, sau đó dùng liều 7,5 mg (uống) mỗi 8 h/lần x 6 ngày điều trị.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: 70%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Ilyas JA, Vierling JM. An overview of emerging therapies for the treatment of chronic hepatitis C. Clin Liver Dis 15: 515–536, 2011.

Khalid O, Bacon BR. Management of the treatmentexperienced patient infected with Hepatitis C virus genotype 1: options and considerations. Clin Liver Dis 15: 573–583, 2011.

Razonable RR. Antiviral drugs for viruses other than human immunodefi ciency virus. Mayo Clin Proc 86: 1009–1026, 2011.

Website: www.rocheusa.com/products/

Rifabutin (Mycobutin)

Nhóm thuốc: Thuốc điều trị Mycobacterium avium nội tế bào (MAI).

Liều thường dùng: 5 mg/kg hoặc 300 mg (uống) mỗi 24 h/lần (*Xem Bình luận*).

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 0,38 µg/mL

Sinh khả dụng: 20-50%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 10%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 45/45 giờ

Liên kết với protein huyết tương: 85%

Thể tích phân bố (V_d): 9,3 L/kg

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều:

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

CrCl < 30 mL/min	150 µg (uống) mỗi 24 h/lần
CrCl < 10 mL/min	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không cần dùng
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Atovaquone, amprenavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, clarithromycin, erythromycin, telithromycin, fluconazol, itraconazol, ketoconazol (↓ nồng độ thuốc tương tác, ↑ nồng độ rifabutin); thuốc chẹn giao cảm, clofibrat, cyclosporin, enalapril, thuốc viên tránh thai, quinidin, sulfonylurea, tocainid, warfarin (↓ tác động thuốc tương tác); corticosteroid (↑ nhu cầu corticosteroid); delavirdin (↓ nồng độ delavirdin, ↑ nồng độ rifabutin; tránh sử dụng); digoxin, phenytonin, propafenon, theophyllin, zidovudin (↓ nồng độ thuốc tương tác); methadon (↓ nồng độ của methadon, hội chứng cai thuốc); mexiletin (↑ độ thanh thải mexiletin); thuốc ức chế men protease (↓ nồng độ thuốc ức chế protease, ↑ nồng độ rifabulin; cần thận trọng)

Phản ứng bất lợi: Đau đầu, buồn nôn, nôn. ↑ SGOT/SPGT, giảm bạch cầu, thiếu máu, giảm tiểu cầu, sốt/nổi ban da do thuốc. Dịch cơ thể có màu nâu/ da cam.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Cao

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Tránh dùng cho bệnh nhân bị giảm bạch cầu (với số lượng bạch cầu ≤ 1000 tế bào/mm^3). Luôn sử dụng như một phần của phác đồ điều trị kết hợp nhiều thuốc, không bao giờ được dùng một thuốc duy nhất.

Liều rifabutin khi dùng phối hợp với thuốc chống retrovirus: 450 mg (uống) mỗi 24 h/lần với điều trị kết hợp EFV; 150 mg (uống) mỗi 24 h/lần với điều trị kết hợp AVP, IDV, NFV, FPN; 150 mg (uống) mỗi 48 h/lần với điều trị kết hợp RTV/LPV.

Liều cho màng nào = Liều thường dùng.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: 50-70%

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Benson CA, Williams PL, Cohn DL, and the ACTG 196/CPCRA 009 Study Team. Clarithromycin or rifabutin alone or in combination for primary prophylaxis of Mycobacterium avium complexdisease in patients with AIDS: A randomized, double-blinded, placebo-controlled trial. J Infect Dis 181: 1289–97, 2000.

Centers for Disease Control and Prevention. Notice to readers: Updated guidelines for the use of rifabutin or rifampin for the treatment and prevention of tuberculosis among HIV-infected patients taking protease inhibitors or nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors. MMWR 49: 183–189, 2000.

[No authors listed.] Drugs for AIDS and associated infections. Med Lett Drug Ther 35: 79–86, 1993.

Finch CK, Chrisman CR, Baciewicz AM, et al. Rifampin and rifabutin drug Interactions: an update. Arch Intern Med 162: 985–92, 2002.

Hoy J, Mijch A, Sandland M, et al. Quadruple-drug therapy for Mycobacterium avium-intracellulare bacteremia in AIDS patients. J Infect Dis 161: 801–5, 1990.

Nightingale SD, Cameron DW, Gordin FM, et al. Two controlled trials of rifabutin prophylaxis against Mycobacterium avium complex infection in AIDS. N Engl J Med 329: 828–33, 1993.

Sax PE, Cohen CJ, Kuritzkes DR. HIV Essentials, 5th edition, Jones & Bartlett, Sudbury, MA, 2011. pp. 123–125.

Website: www.pdr.net

Rifampin (Rifadin, Rimactane)

Nhóm thuốc: Kháng sinh/thuốc điều trị lao.

Liều thường dùng: 600 mg (uống) mỗi 24 h/lần (*Xem Bình luận*)

Phổ tác dụng: (Xem *Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn* trang 324-335).

Nguy cơ bị đề kháng: Cao (vi khuẩn Gram âm ái khí khi đơn trị liệu với vi khuẩn không phải lao).

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 7 µg/mL.

Sinh khả dụng: 95%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 15%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 3,5/11 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 80%

Thể tích phân bố (V_d): 0,93 L/kg.

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều*

CrCl < 10 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan vừa	Không thay đổi; thận trọng khi dùng
Suy gan nặng	Tránh dùng

Tương tác thuốc: Amprenavir, indinavir, nelfinavir (↑ tác dụng của rifampin); thuốc chẹn β giao cảm, clofibrat, cyclosporin, thuốc viên tránh thai, quinidin, sulfonylurea, tocainamid, warfarin (↓ tác dụng thuốc tương tác); caspofungin (↓ nồng độ của caspofungin, có thể làm ↓ tác dụng của caspofungin); clarithromycin, ketoconazol (↑ nồng độ của rifampin, ↓ nồng độ của thuốc tương tác); corticosteroid (↑ nhu cầu corticosteroid); delavirdin (↑ nồng độ của rifampin, ↓ nồng độ của delavirdin; tránh dùng); disopyramid, itraconazol, phenytoin, propafenon, theophyllin, methadon, nelfinavir, ritonavir, tacrolimus, những thuốc có chuyển hóa được rifampin cảm ứng, ví dụ: thuốc ức chế men chuyển angiotensin, dapson, diazepam, digoxin, diltiazem, doxycyclin, fluconazol, fluvastatin, haloperidol, nifedipin, progestin, triazolam, các tricyclic,

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

zidovudin (↓ nồng độ của thuốc tương tác); fluconazol, trimethoprim-sulfamethoxazol (TMP -SMX) (↑ nồng độ của rifampin); INH (INH được chuyển đổi thành hydrazin gây độc); mexiletin (↑ độ thanh thải của mexiletin); nevirapin (↓ nồng độ của nevirapin; tránh dùng).

Phản ứng bất lợi: Chóng mặt, những triệu chứng giả cúm, ↑ SGOT/SGPT, sốt/nổi ban da do thuốc, giảm tiểu cầu, các chất tiết của cơ thể chuyển màu đỏ/cam.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Vừa

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Chất cảm ứng CYP 3A4 mạnh. Bị chống chỉ định ở bệnh nhân nhiễm HIV. Để điều trị/dự phòng lao, cần theo dõi độc tính tiềm tàng trên gan bằng cách xét nghiệm hàng tuần SGOT/SGPT trong vòng 3 tuần, sau đó xét nghiệm hàng tháng x 3 tháng. Uống thuốc trước ăn 1 giờ hoặc sau ăn 2 giờ. **Liều TB D.O.T**: 10 mg/kg hoặc 600 mg (uống) x 2-3 lần/tuần. **Không sử dụng như một điều trị đơn độc đối với tụ cầu vàng. Không lợi ích làm sàng nào được chứng minh khi kết hợp với một kháng sinh điều trị MSSA/MRSA. Liều dùng với một thuốc điều trị cầu khuẩn khác**: 300 mg (uống) mỗi 12 h/lần. **Liều để điều trị người mang vi khuẩn khu trú tại mũi (Nasal carriage dose)**: 600 mg (uống) mỗi 12 h/lần x 72 giờ.

Liều cho màng não= liều thường dùng.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Màng não không bị viêm = 50%

Viêm màng não = 50 %

Khả năng thấm vào mật: 7000%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cascio A, Scarlata F, Giordano S, et al. Treatment of human brucellosis with rifampin plus minocycline. J Chemother 15: 248–52, 2003.

Castahneira D, Rifampin. Antibiotics for Clinicians 6: 89–100, 2001.

Curry SR, Marsh JW, Shutt KA, et al. High frequency of rifampin resistance identifi ed in an epidemic clostridium diffi cile clone from a large teaching hospital. Clin Infect Dis 48: 425–430, 2009.

Davidson PT, Le HQ. Drug treatment of tuberculosis 1992. Drugs 43: 651–73, 1992.

Ena J, Valls V. Short-course therapy with rifampin plus isoniazid compared with standard therapy with isoniazid, for latent tuberculosis infection: a meta-analysis. Clin Infect Dis 40: 670–6, 2005.

Euga G, Murillo O, Fernandez-Sabe N, et al. Treatment of chronic staphylococcal osteomyelitis: intravenous or oral? how long? Antimicrob Agents Chemother 53: 2672–2676, 2009.

Giamarellos-Bourboulis EJ, Sambatakou H, Galani I, et al. In vitro interaction of colistin and rifampin on multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa. J Chemother 15: 235–8, 2003.

Gomez J, Canovas E, Banos V, et al. Linezolid plus rifampin as a salvage therapy in prosthetic joint infections treated without removing the implant. Antimicrob Agents Chemother 55: 4308–4310, 2011.

Hohmann C, Kang EM, Jancel T: Rifampin and posaconazole coadministration leads to decreased serum posaconazole concentrations. Clin Infect Dis 50: 939–940, 2010.

Ijaz K, Jereb JA, Lambert LA, et al. Severe or fatal injury in 50 Patients in the United States taking rifampin and pyrazinamide for latent tuberculosis infection. Clin Infect Dis 42: 346–56, 2006.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Ijaz K, McElroy PD, Navin TR. Short course rifampin and pyrazinamide compared with isoniazid for latent tuberculosis infection: a cost-effectiveness analysis based on a multicenter clinical trial Clin Infect Dis 39: 289, 2004.

Johnson JR. Rifampin and methicillin-resistant Staphylococcus aureus bone and joint infections. Clin Infect Dis 53: 98–99, 2011.

Krause PJ, Corrow CL, Bakken JS. Successful treatment of human granulocytic ehrlichiosis in children using rifampin. Pediatrics. 112: e252–3, 2003.

Lundstrom TS, Sobel JD. Vancomycin, trimethoprim - sulfamethoxazole, and rifampin. Infect Dis Clin North Am 91: 747–67, 1995.

McIllerson H, Wash P, Burger A, et al. Determinants of rifampin, isoniazid, pyrazinamide and ethambutol pharmacokinetics in a cohort of tuberculosis patients. Antimicrob Agents Chemother 50: 1170–77, 2006.

Nguyen S, Pasquet A, Legout L, et al. Efficacy and tolerance of rifampin-linezolid compared with rifampin-cotrimoxazole combinations in prolonged oral therapy for bone and joint infections. Clin Microbiol Infect Dis 15: 1163–1169, 2009.

Perlman DC, Segal Yoniah, Rosenkranz S, et al. The clinical pharmacokinetics of rifampin and ethambutol in HIV-infected persons with tuberculosis. Clin Infect Dis 41: 1638–47, 2005.

Sax PE, Cohen CJ, Kuritzkes DR. HIV Essentials, 5th edition Jones & Bartlett, Sudbury, MA, 2012.

Schlossberg D: An approach to drug-induced liver injury during tuberculosis therapy. Infect Dis Clin Pract 18: 107–108, 2010.

Schlossberg D, Treatment of multi-drug resistant tuberculosis. Antibiotics for Clinicians 9: 317–321, 2005.

Van Scoy RE, Wilkowske CJ. Antituberculous agents. Mayo Clin Proc 67: 179–87, 1992.

Website: www.pdr.net

Rilpivirine (Edurant) RPV

Nhóm thuốc: Thuốc chống retrovirus nhóm ức chế enzym sao chép ngược không phải nucleoside (Antiretroviral NNRTI [non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor]).

Liều thường dùng: 25 mg (uống) mỗi 24 h/lần (trong bữa ăn).

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 1 µg/L

Sinh khả dụng: Không được biết

Bài xuất dưới dạng nguyên vẹn: 1%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 50/50 giờ

Liên kết với protein huyết tương: 99%

Thể tích phân bố (V_d): Không được biết

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều*

CrCl < 10 mL/phút	Thận trọng khi dùng
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan nhẹ đến vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không có số liệu

Tương tác thuốc: Clarithromycin (↓ nồng độ clarithromycin). Tất cả các thuốc gây cảm ứng hoặc ức chế CYP3A

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

có thể làm ↑ hoặc ↓ nồng độ rilpivirin.

Bị chống chỉ định với carbamazepin, oxycarbazepin, phenobarbital, phenytoin, rifabutin, rifampin, rifapentin, thuốc ức chế bơm proton, dexamethason (ngoại trừ dùng liều đơn) thảo dược **St. John's Wort**.

Phản ứng bất lợi: Buồn nôn, nôn, đau bụng, fmệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, trầm cảm, mất ngủ, giấc mơ bất thường, nổi ban da, ↑ QTc.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Cần dùng tách biệt thuốc trung hòa acid dịch vị và thuốc kháng thụ thể H_2. Không dùng với các thuốc chống retrovirus nhóm ức chế enzym sao chép ngược (reverse transcriptase) không phải nucleoside (NNRTIs) khác. Chỉ dùng thuốc khi thấy lợi ích vượt trội hơn nguy cơ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Miller CD, Crain J, Tran V, et al. Rilipivirine: A new addition to the anti-HIV-1 armamentarium. Drugs Today 47: 5–15, 2011.

Molina JM, Cahn P, Grinsztejn B, et al. Rilipivirine versus efavirenz with tenofovir and emtricitabine in treatment- naïve adults infected with HIV-1 (ECHO): A phase 3 randomised double- blind active-controlled trail. Lancet ID 16: 238–246, 2011.

Rimantadine (Flumadine)

Nhóm thuốc: Thuốc kháng virus.

Liều thường dùng: 100 mg (uống) mỗi 12 giờ (*Xem Bình luận*).

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 0,7 µg/mL.

Sinh khả dụng: 90%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 25%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 25/38 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 40%

Thể tích phân bố (V_d): 4,5 L/kg.

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều*

CrCl 10-50 mL/phút	Không thay đổi
CrCl < 10 mL/phút	100 mg (uống) mỗi 24 h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	100mg (uống) mỗi 24 h/lần

Tương tác thuốc: Rượu (↑ tác động lên hệ TKTW); benztropin,

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

trihexyphenidyl, scopolamin (↑ tác dụng của thuốc tương tác: khô miệng, mất điều vận động, nhìn mờ, nói nhíu, loạn thần nhiễm độc); cimetidin (↓ độ thanh thải rimantadin); chất kích thích hệ TKTW (kích thích tăng thêm); digoxin (↑ nồng độ của digoxin); trimethoprim (↑ nồng độ của rimantadin và trimethoprim).

Phản ứng bất lợi: Chóng mặt, đau đầu, mất ngủ, các tác động kháng cholinergic (nhìn mờ, khô miệng, hạ huyết áp tư thế đứng, bí tiểu, táo bón).

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Ít tác dụng phụ kháng cholinergic hơn so với amantadin. Bệnh nhân ≥ 60 tuổi hoặc có tiền sử co giật nên dùng liều 100 mg (uống) mỗi 24 h/ lần. **Liều dùng cho bệnh nhân cúm (dự phòng)**: 100 mg (uống) mỗi 12 h/ lần trong suốt giai đoạn phơi nhiễm/ vụ dịch cúm. **Liều dùng cho bệnh nhân cúm (điều trị)**: 100 mg (uống) mỗi 12 h/lần x 7 ngày. **Có thể giúp cải thiện tình trạng oxy hóa máu/chức năng đường thở ngoại biên trong các trường hợp viêm phổi nặng do cúm. Thuốc có hoạt tính cao đối với cúm A. Không có hoạt tính đối với các virus khác.**

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: 10%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[No authors listed.] Antiviral drugs for prophylaxis and treatment of influenza. Med Lett Drugs Ther 46: 85–7, 2004.

Dolin R, Reichman RC, Madore HP, et al. A controlled trial of amantadine and rimantadine in the prophylaxis of Influenza A infection. N Engl J Med 307: 580–4, 1982.

Gravenstein S, Davidson HE. Current strategies for management of influenza in the elderly population. Clin Infect Dis 35: 729–37, 2002.

Jefferson T, Deeks JJ, Demicheli V, et al. Amantadine and rimantadine for preventing and treating influenza A in adults. Cochrane Database Syst Rev 3: CD001169, 2004.

Keating MR, Antiviral agents. Mayo Clin Proc 67: 160–78, 1992.

Schmidt AC, Antiviral therapy for influenza: a clinical and economic comparative review. Drugs 64: 2031–46, 2004.

Wintermeyer SM, Nahata MC. Rimantadine: A clinical perspective. Ann Pharmacotherapy 29: 299–310, 1995.

Website: www.pdr.net

Ritonavir (Norvir) RTV

Nhóm thuốc: Thuốc chống retrovirus nhóm ức chế men protease.

Liều thường dùng: 100-400 mg (uống) mỗi 12-24 h/lần (*Xem Bình luận*)

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 11 µg/mL.

Sinh khả dụng: Không có số liệu.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 3,5%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 4 giờ/ không có số liệu.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Liên kết với protein huyết tương: 99%

Thể tích phân bố (V_d): 0,41 L/kg.

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều*

CrCl < 10 mL/min	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không cần dùng
Suy gan nhẹ đến vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi; thận trọng khi dùng thuốc

Điều chỉnh liều thuốc chống retrovirus

Atazanavir	Ritonavir 100 mg mỗi 24 h/lần + atazanavir 300 mg mỗi 24 h/lần trong bữa ăn
Delavirdin	Delavirdin: Không thay đổi; ritonavir: không có thông tin
Efavirenz	Ritonavir 600 mg mỗi 12 h/lần (500 mg mỗi 12 h/lần nếu không dung nạp được thuốc)
Fosamprenavir	Fosamprenavir 1400 mg + ritonavir 200 mg mỗi 24 h/lần
Indinavir	Ritonavir 100-200 mg mỗi 24 h/lần + indinavir 800 mg mỗi 12 h/lần,hoặc 400 mg mỗi 12 h/lần với mỗi thuốc
Nelfinavir	Ritonavir 400 mg mỗi 12 h/lần + nelfinavir 500-750 mg mỗi 12 h/lần
Nevirapin	Không thay đổi
Saquinavir	Ritonavir 400 mg mỗi 12 h/lần + saquinavir 400 mg mỗi 12 h/lần
Ketoconazol	Thận trọng; không dùng quá 200 mg mỗi 24 h/lần
Rifampin	Tránh dùng
Rifabutin	Rifabutin 150 mg mỗi 48 h/lần hoặc 3 lần/ tuần

Tương tác thuốc: Thuốc chống retrovirus, rifabutin, rifampin (xem Bảng chỉnh liều ở trên); saquinavir (↑ QTc/ xoắn đỉnh, ↑ khoảng PR) alprazolam, diazepam, estazolam, flurazepam, midazolam, triazolam, zolpidem, meperidin, propoxyphen, piroxicam, quinidin, amiodaron, encainid, flecainid, propafenon, astemizol, bepridil, bupropion, cisaprid, clorazepat, clozapin, pimozid, thảo dược St. John, terfenadin (tránh dùng); alfentanil, fentanyl, hydrocodon, tramadol, disopyramid, lidocain, mexiletin, erythromycin, clarithromycin, warfarin, dronabinol, ondansetron, metoprolol, pindolol, propranolol, timolol, amlodipin, diltiazem, felodipin, isradipin, nifedipin, nimodipin, nisoldipin, nitrendipin, verapamil,

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

etoposid, paclitaxel, tamixifen, vinblastin, vincristin, loratadin, thuốc chống trầm cảm ba vòng, paroxetin, nefazodon, sertralin, trazodon, fluoxetin, venlafaxin, fluvoxamin, cyclosporin, tacrolimus, chlorpromazin, haloperidol, perphenazin, risperidon, thioridazin, clozapin, pimozid, methamphetamin (↑ nồng độ thuốc tương tác); voriconazol (↓ nồng độ voriconazol); telithromycin (tăng nồng độ ritonavir); codein, hydromorphon, methadon, morphin, ketoprofen, ketorolac, naproxen, diphenoxylat, thuốc tránh thai đường uống, theophyllin (↓ nồng độ thuốc tương tác); carpamazepin, phenytoin, phenobarbital, clonazepam, dexamethason, prednison (↓ nồng độ của ritonavir, ↑ nồng độ thuốc tương tác; theo dõi nồng độ thuốc chống co giật); metronidazol (phản ứng giống như disulfiram); sildenafil (không vượt quá liều 25 mg trong 48 giờ); tadalafil (liều cao nhất là 10 mg/72 giờ); vardenafil (liều cao nhất là 2,5 mg/72 giờ).

Phản ứng bất lợi: Chán ăn, thiếu máu, giảm bạch cầu, tăng nồng độ đường huyết (làm nặng thêm bệnh đái tháo đường, khởi phát bệnh đái tháo đường, nhiễm toan centon do đái tháo đường), ↑ cholesterol/triglycerid (cần đánh giá nguy cơ bị bệnh mạch vành/viêm tụy), tái phân bố mỡ trong cơ thể, ↑ CPK, buồn nôn, nôn, ỉa chảy, đau bụng, dị cảm quanh miệng/ dị cảm chi, ↑ SGOT/ SGPT, viêm tụy, mất cảm giác vị giác, có thể làm tăng chảy máu ở bệnh nhân bị bệnh hemophilia.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Dùng thường xuyên với liều thấp (100-200 mg/ngày) như một biện pháp làm tăng dược động học của các thuốc ức chế men protease khác. Tình trạng không dung nạp trên đường tiêu hóa giảm theo thời gian. Uống thuốc trong bữa ăn nếu có thể (nồng độ thuốc trong huyết thanh tăng thêm 15%, ít tác dụng phụ trên đường tiêu hóa hơn). Dùng liều cách biệt với didanosin, khoảng 2 giờ.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: < 1%

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cameron DW, Japour AJ, Xu Y, et al. Ritonavir and saquinavir combination therapy for the treatment of HIV infection. AIDS 13: 213–224, 1999.

Deeks SG, Smith M, Holodniy M, et al. HIV-1 protease inhibitors: A review for clinicians. JAMA 277: 145–53, 1997.

Kaul DR, Cinti SK, Carver PL, et al. HIV protease inhibitors: Advances in therapy and adverse reactions, including metabolic complications. Pharmacotherapy 19: 281–98, 1999.

Lea AP, Faulds D. Ritonavir. Drugs 52: 541–6, 1996.

McDonald CK, Kuritzkes DR. Human immunodeficiency virus type 1 protease inhibitors. Arch Intern Med 157: 951–9, 1997.

Piliero PJ. Interaction between ritonavir and stains. Am J Med 112: 510–1, 2002.

Rathbun RC, Rossi DR. Low-dose ritonavir for protease inhibitor pharmacokinetic enhancement. Ann Pharmacother 36: 702–6, 2002.

Thompson MA, Aberg JA, Cahn P, et al. Antiretroviral treatment of adult HIV infection: 2010. Recommen-dations of the international AIDS society – USA panel. JAMA. 304: 321–333, 2010.

Saquinavir (Invirase) SQV)

Nhóm thuốc: Thuốc chống retrovirus nhóm ức chế protease.

Liều thường dùng: 1000 mg (uống) mỗi 12 h/lần (*xem Bình luận*) với ritonavir 100 mg (uống) mỗi 12 h/lần.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 0,07 µg/mL.

Sinh khả dụng: dạng nang cứng (4%).

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 13%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 13 giờ/ không có số liệu.

Liên kết với protein huyết tương: 98%

Thể tích phân bố (V_d): 10 L/kg.

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều*

CrCl < 10 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan vừa	Thận trọng khi dùng
Suy gan nặng	Tránh dùng

Điều chỉnh liều khi dùng với các thuốc chống retrovirus khác

Darunavir	Tránh sử dụng
Delavirdin	Không có thông tin
Efavirenz	Tránh dùng như một thuốc ức chế protease đơn độc
Indinavir	Không có thông tin
Lopinavir/ritonavir 2 viên nang mỗi 12 giờ	Saquinavir 1 g mỗi 12 giờ
Nelfinavir	Saquinavir 1 g mỗi 12 h/lần hoặc 1200 mg mỗi 12 h/lần
Nevirapin	Không có thông tin
Ritonavir	Ritonavir 100 mg mỗi 12 h/lần + saquinavir 1 g mỗi 12 h/lần
Rifampin	Tránh sử dụng
Rifabutin	Tránh sử dụng

Tương tác thuốc: Các thuốc chống retrovirus, rifabutin, rifampin (xem Bảng điều chỉnh liều ở trên); astemizol, terfenadin, nhóm benzodiazepin, cisaprid, ergotamin, nhóm statin, thảo dược St. John's wort (tránh sử dụng khi có thể); carbamazepin, phenytoin, phenobarbital, dexamethason, prednison (↓ nồng độ saquinavir, ↑ nồng độ các thuốc tương tác; theo dõi nồng độ thuốc chống co giật); clarithromycin, erythromycin, telithromycin (↑ nồng độ saquinavir

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

và các kháng sinh nhóm macrolid); nước bưởi ép, itraconazol, voriconazol, ketoconazol (↑ nồng độ saquinavir); sildenafil (không dùng > 25 mg/48 giờ); tadalafil (liều tối đa là 10 mg/72 giờ), vardenafil (liều tối đa là 2,5mg/72 giờ), ritonavir (QTc kéo dài/xoắn đỉnh, khoảng PR kéo dài), thuốc ức chế bơm proton (↑ nồng độ saquinavir). Atovaquon/proguanil (↑ nồng độ saquinavir.

Chống chỉ định: Rifapentin, trazadon.

Phản ứng bất lợi: Chán ăn, đau đầu, thiếu máu, giảm bạch cầu, tăng đường huyết (bao gồm đái tháo đường tiến triển nặng thêm, đái tháo đường mới mắc, nhiễm toan centon do đái tháo đường), ↑ cholesterol/triglycerid (đánh giá nguy cơ bệnh mạch vành/viêm tụy), ↑ SGOT/SGPT, tăng acid uric máu, rối loạn phân bố mỡ, có thể làm tăng nguy cơ chảy máu ở bệnh nhân bị hemophilia.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Uống thuốc trong bữa ăn, tránh các gia vị làm từ tỏi do có thể làm ↓ nồng độ saquinavir ~ 50%. Liều khởi động lại (Boosted dose): 1 g saquinavir/100 mg ritonavir (uống) mỗi 12 h/lần. Dạng bào chế được ưa chuộng sử dụng là viên nang cứng 500 mg (Invirase 500). Viên nang mềm (Fortovase) hiện nay không còn được lưu hành trên thị trường.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: < 1%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cameron DW, Japour AJ, Xu Y, et al. Ritonavir and saquinavir combination therapy for the treatment of HIV infection. AIDS 13: 213–224, 1999.

Canducci F, Ceresola ER, Saita D, et al. The new and less toxic protease inhibitor saquinavir-NO maintains antiHIV-1 properties in vitro indistinguishable from those of the parenteral compound saquinavir. Antiviral Res 91: 292–295, 2011.

Hsu A, Granneman GR, Cao G, et al. Pharmacokinetic interactions between two human immunodeficiency virus protease inhibitors, ritonavir and saquinavir. Clin Pharmacol Ther 63: 453–64, 1998.

Hughes PJ, Cretton-Scott E, Teague A, et al. Protease inhibitors for patients with HIV-1 infection. Pharm Ther 36: 332–344, 2011.

Noble S, Faulds D. Saquinavir: A review of its pharmacology and clinical potential in the management of HIV infection. Drugs 52: 93–112, 1996.

Perry CM, Noble S. Saquinavir soft-gel capsule formation: A review of its use in patients with HIV infection. Drugs 55: 461–86, 1998.

Tomassi C, Bellagamba R, Tempestilli M, et al. Marked increase in etravirine and saquinavir plasma concentrations during atovaquone/proguanil prophylaxis. Malar J 10: 141, 2011.

Thompson MA, Aberg JA, Cahn P, et al Antiretroviral treatment of adult HIV infection: 2010 recommendations of the international AIDS society – USA panel. JAMA 304: 321–333, 2010.

Vella S, Floridia M. Saquinavir: Clinical pharmacology and efficacy. Clin Pharmacokinet 34: 189–201, 1998.

Website: www.fortovase.com

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Spectinomycin (Spectam, Trobicin)

Nhóm thuốc: Aminocyclitol

Liều thường dùng: 2 g (tiêm bắp) × 1 liều.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 100 µg/mL.

Sinh khả dụng: Không áp dụng.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 80%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (người bình thường/bệnh thận giai đoạn cuối): 1,6/16 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 20%

Thể tích phân bố (V_d): 0,25 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl < 10 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không cần dùng
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Không có.

Phản ứng bất lợi: Đau tại vùng tiêm.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Không có hiệu quả điều trị đối với nhiễm lậu cầu ở họng (pharangeal GC) do thuốc xâm nhập kém vào các dịch tiết).

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: < 10%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Fiumara NJ. The treatment of gonococcal proctitis: An evaluation of 173 patients treated with 4 gm of spectinomycin. JAMA 239: 735–7, 1978.

Holloway WJ. Spectinomycin. Med Clin North Am 66: 169–173, 1995.

McCormack WM, Finland M. Spectinomycin. Ann Intern Med 84: 712–16, 1976.

Tapsall J. Current concepts in the management of gonorrhoea. Expert Opin Pharmacother 3: 147–57, 2002.

Website: www.pdr.net

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Stavudine (Zerit) d4T

Nhóm thuốc: Thuốc chống retrovirus nhóm ức chế men sao chép ngược nucleoside (Nucleoside revverse transcriptase inhibitor [NRRI]).

Liều thường dùng: ≥ 60 kg: 40 mg (uống) mỗi 12 h/lần; < 60 kg: 30 mg (uống) mỗi 12 h/lần

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 4,2 µg/mL.

Sinh khả dụng: 86%

Bài xuất dưới dạng nguyên vẹn (qua nước tiểu): 40%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 1,0/5,1 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 0%

Thể tích phân bố (V_d): 0,5 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều* ≥ 60 kg/ [≤ 60 kg]

CrCl 50-80 mL/phút	40 mg (uống) mỗi 12 h/lần [30 mg (uống) mỗi 12 h/lần]
CrCl 25-50 mL/phút	20 mg (uống) mỗi 12 h/lần [15 mg (uống) mỗi 12 h/lần]
CrCl ~ 10-25 mL/ phút	20 mg (uống) mỗi 24 h/lần [15 mg (uống) mỗi 24 h/lần]
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	20 mg (uống) [15 mg (uống)]
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không có thông tin
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	20 mg (uống) mỗi 24 giờ [15 mg (uống) mỗi 24 h/lần]
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Ribavirin (↓ tác dụng của stavudin, ↑ nguy cơ nhiễm toan acid lactic); dapson, INH, các thuốc gây độc thần kinh khác (tăng nguy cơ bệnh thần kinh), didanosin (↑ nguy cơ bị bệnh thần kinh, nhiễm toan lactic). Tránh phối hợp zidovudin với stavudin.

Phản ứng bất lợi: Nhiễm toan lactic và gan thoái hóa mỡ nặng (kể cả những trường hợp tử vong) đã được báo cáo ở bệnh nhân dùng thuốc tương tự nucleoside (nucleoside analogues) đơn độc hay phối hợp (bao gồm stavudin và các thuốc chống retrovirus khác). Tử vong do nhiễm toan lactic đã được ghi nhận ở phụ nữ mang thai dùng phối hợp stavudin và didanosin với các thuốc chống retrovirus khác trong thai kỳ. Dùng kết hợp stavudin và didanosin nên được sử dụng một cách rất thận trọng trong thời gian có thai và chỉ khi thực sự cần thiết.

Sốt/ nổi ban da do thuốc, buồn nôn, nôn, rối loạn tiêu hóa, ỉa chảy, đau đầu, mất ngủ, bệnh lý thần kinh ngoại vi phụ thuộc vào liều dùng, đau cơ, viêm tụy, ↑ SGOT/SGPT, ↑ cholesterol, mất lớp mỡ ở mặt, loạn dưỡng lipid, giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu, nhiễm toan lactic kèm theo gan thoái hóa mỡ. Có tăng nguy cơ gây độc cho gan ở bệnh nhân được điều trị bằng stavudin phối hợp với didanosin và hydroxyurea. Hội chứng phục hồi miễn dịch (Immune reconstitution syndrome) có thể xảy ra.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Viêm tụy cấp có thể nặng/ thậm chí tử vong. Tránh dùng chung với AZT hoặc ddC. Giảm liều xuống 20 mg (uống) mỗi 12 h/lần ở bệnh nhân

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

bị bệnh lý thần kinh ngoại vi. Phụ nữ có thai khi sử dụng stavudin cùng với didanosin (ddI) có thể bị tăng nguy cơ nhiễm toan lactic/ tổn thương gan. Liều khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới là 30 mg mỗi 12 h/lần không tính đến cân nặng.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: 30%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Berasconi E, Boubaker K, Junghans C, et al. Abnormalities of body fat distribution in HIV-infected persons treated with antiretroviral drugs: The Swiss HIV Cohort Study. J Acquir Immune Defic Syndr 31: 50–5, 2002.

Dudley MN, Graham KK, Kaul S, et al. Pharmacokinetics of stavudine in patients with AIDS and AIDS-related complex. J Infect Dis 166: 480–5, 1992.

[No authors listed.] FDA notifi catiòns. FDA changes information for stavudine label. Aids Alert 17: 67, 2002.

Joly V, Flandre P, Meiffredy V, et al. Effi cacy of zidovudine compared to stavudine, both in combination with lamivudine and indinavir, in human immunodeficiency virus-infected nucleoside-experienced patients with no prior exposure to lamivudine, stavudine, or protease inhibitors (Novavir trial). Antimicrob Agents Chemother 46: 1906–13, 2002.

Lea AP, Faulds D. Stavudine: A review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties and clinical potential in HIV infection. Drugs 51: 846–64, 1996.

Miller KD, Cameron M, Wood LV, et al. Lactic acidosis and hepatic steatosis associated with use of stavudine: Report of four cases. Ann Intern Med 133: 192–196, 2000.

Murphy RL, Brun S, Hicks C, et al. ABT-378/ ritonavir plus stavudine and lamivudine for the treatment of antiretroviral-naive adults with HIV-1 infection: 48-week results. AIDS 15: F1–9, 2001.

Thompson MA, Aberg JA, Cahn P, et al. Antiretroviral treatment of adult HIV infection: 2010. recommendations of the international AIDS society – USA panel. JAMA 304:321–333, 2010.

Website: www.zerit.com

Streptomycin

Nhóm thuốc: Thuốc điều trị lao nhóm aminoglycosid.

Liều thường dùng: 15 mg/kg (tiêm bắp) mỗi 24 h/lần hoặc 1 g (tiêm bắp) mỗi 24 h/lần (*Xem Bình luận*).

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 25-50 µg/mL.

Sinh khả dụng: Không áp dụng.

Bài xuất dưới dạng nguyên vẹn (qua nước tiểu): 90%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 2,5/100 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 35%

Thể tích phân bố (V_d): 0,26 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Điều chỉnh liều*

CrCl 10-50 mL/phút	15 mg/kg (tiêm bắp) mỗi 72 h/lần hoặc1 g (tiêm bắp) mỗi 72 h/lần
CrCl < 10 mL/phút	15 mg/kg (tiêm bắp) mỗi 72 h/lần hoặc 1 g (tiêm bắp) mỗi 72 h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	15 mg/kg (tiêm bắp) hoặc 1 g (tiêm bắp) 2-3 lần/tuần
Liều dùng sau lọc màng bụng	15 mg/kg (tiêm bắp) hoặc 1 g (tiêm bắp) hoặc 20-40 mg/mL trong dịch lọc mỗi 24 h/lần
Liều dùng khi CWH/CWHD/CWHDF	15 mg/kg (tiêm bắp) hoặc 1 g (tiêm bắp) mỗi 96 h/lần
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Amphotericin B, cephalothin, cyclosporin, enfluran, methoxy-fluran, các thuốc chống viêm không steroid, polymixin B, chất cản quang dùng để chụp chiếu, vancomycin (↑ độc tính với thận); cis-platinum (↑ độc tính với thận, ↑ độc tính với tai); các thuốc lợi tiểu "quai" (↑ độc tính với tai); các thuốc gây block thần kinh-cơ (↑ nguy cơ ngừng thở và liệt kéo dài); các thuốc giãn cơ không phân cực (↑ nguy cơ ngừng thở).

Phản ứng bất lợi: Là aminoglycosid gây độc cho tai nhất (thường gây độc đối với tiền đình); ít độc với thận.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: D

Bình luận: Có thể truyền tĩnh mạch chậm trong vòng 1 giờ. **Liều điều trị lao có kiểm soát trực tiếp TB D.O.T Dose)**: 20-30 mg/kg (tiêm bắp) 2-3 lần/tuần. **Liều điều trị bệnh "sốt thỏ" (Tularemia dose)**: 1 g (TM/tiêm bắp) mỗi 12 h/lần. **Liều điều trị dịch hạch**: 2 g (TM/tiêm bắp) mỗi 12 h/lần.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: 20%

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Akaho E, Maekawa T, Uchinashi M. A study of streptomycin blood level information of patients undergoing hemodialysis. Biopharm Drug Dispos 23: 47–52, 2002.

Davidson PT, Le HQ. Drug treatment of tuberculosis 1992. Drugs 43: 651–73, 1992.

Kim-Sing A, Kays MB, Vivien EJ, et al. Intravenous streptomycin use in a patient infection with highlevel gentamicin-resistant Streptococcus faecalis. Ann Pharmacother 27: 712–4, 1993.

Morris JT, Cooper RH. Intravenous streptomycin: A useful route of administration. Clin Infect Dis 19: 1150–1, 1994.

Roushan MRH, Mohraz M, Hajiahmadi M, et al. Efficacy of gentamicin plus doxycycline versus streptomycin plus doxycycline in the treatment of brucellosis in humans. Clin Infect Dis 42: 1075–80, 2006.

Van Scoy RE, Wilkowske CJ. Antituberculous agents. Mayo Clin Proc 67: 179–87, 1992.

Ormerod P. The clinical management of the drugresistant patient. Ann NY Acad Sci 953: 185–91, 2001.

Telaprevir (Incivek)

Nhóm thuốc: Thuốc ức chế protease NS3/4A để điều trị virus viêm gan C (HCV) (genotyp 1).

Liều thường dùng: 750 mg dùng đường uống mỗi 7–9 giờ với thức ăn , không phải với chế độ ăn chứa ít mỡ (+ ribavirin và peginterferon alfa).

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 3510 µg/mL.

Sinh khả dụng: Không có số liệu.

Bài xuất dưới dạng nguyên vẹn: 1%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 4,5/4-5 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 60-76%

Thể tích phân bố (V_d): 252 L/kg.

Đường thải từ chính: Gan qua CYP3A4/5

Điều chỉnh liều*

CrCl < 10 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan từ vừa đến nặng	Tránh dùng

Tương tác thuốc: Chất ức chế mạnh và được chuyển hóa qua CYP3A4/5. **Bị chống chỉ định với alfuzosin, rifampin, rifabutin, dẫn xuất ergot, cisaprid, thảo dược St. John's Wort, lovastatin, simvastatin, drosperinon, Revatio hoặc Adcirca, pimozid, triazolam, salmeterol** dùng đường hít. ↑ nồng độ digoxin, carbamazapin, trazodon, itraconazol, posiconazol, colchicin, alprazolan, midazolam, thuốc chẹn kênh canxi, prednison, methylprednison, steroid dùng đường hít/ nhỏ mũi, atazanavir, tenofovir, thuốc ức chế miễn dịch, salmeterol hít, chất ức chế PDE5. ↑ hoặc ↓ nồng độ warfarin, phenytoin, phenobarbital và voriconazol. ↓ nồng độ ethinyl estradilol, efavirenz (↓ nồng độ) . ↑ telaprevir lên 1125 mg mỗi 8 h/lần.

Phản ứng bất lợi: Nổi ban (ban da với tăng bạch cầu ưa acid và hội chứng Stevens-Johnson), ngứa, rối loạn vị giác (dysgeusia), buồn nôn, nôn, ỉa chảy, khó chịu vùng hậu môn-trực tràng, mệt mỏi, thiếu máu.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Cao

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B đối với Incivek, X đối với ribavirin, (Xem *Tóm tắt thông tin về thuốc mục Ribavirin*)

Bình luận: Không được sử dụng thuốc như một thuốc điều trị đơn độc, chỉ dùng thuốc phối hợp với ribavirin và peginterferon alfa. Không có dữ liệu đối với bệnh nhân bị xơ gan thuộc nhóm Child-Pugh B và C, sau ghép tạng, nhiễm HIV, đồng nhiễm virus viêm gan B hoặc trẻ < 18 tuổi. Ngừng dùng thuốc khi có tình trạng ban da nặng hoặc tiến triển. Nếu quên không dùng liều trong

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

vòng 4 giờ khi dùng theo phác đồ thời gian liều thường dùng , uống liều thuốc bị quên và sau đó dùng lại thuốc theo lịch trình liều thường quy. Nếu liều bị quên dùng được ghi nhận là đã quá 4 giờ so với thời gian liều dùng thường quy, bỏ qua liều bị quên và tiếp tục dùng liều kế tiếp. Áp dụng biện pháp ngừa thai bằng hormon có thể không đủ độ tin cậy trong khi dùng Incivek và trong vòng 2 tuần sau khi ngừng thuốc. Điều chỉnh liều theo mức độ giảm nồng độ hemoglobin máu (Xem phần *Các thông tin tóm tắt về ibavirin Drug Summary*)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Jacobson IM, McHutchinson JG, Dusheiko G. Telaprevir for previously untreated chronic Hepatitis C virus infection. N Eng Journal of Medicine 23: 2405–2416, 2011.

Kilbanov OM, Williams SH, Smith LS, et al. Telaprevir: a novel NS3/4 protease inhibitor for the treatment of hepatitis C. Pharmacotherapy 31: 951–974, 2011.

Kumada H, Toyota J, Okanoue T, et al. Telaprevir with peginterferon and ribacirin for treatment-naïve patients chronically infected with HCV of genotype 1 in Japan, J Hepatol 2011.

Leise MD, Kim WR, Canterbury KM, et al. Drug therapy: telaprevir. Hepatology 54: 1463–1469, 2011.

Telavancin (Vibativ)

Nhóm thuốc: Lipolycopeptid

Liều thường dùng: 10 mg/kg (TM) mỗi 24 h/lần.

Phổ tác dụng: (*Xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 332-335*)

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 93-108 µg/mL.

Sinh khả dụng: Không được áp dụng.

Bài xuất dưới dạng nguyên vẹn: 76%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 6-9 giờ/không có số liệu.

Liên kết với protein huyết tương: 93%

Thể tích phân bố (V_d): 0,133-0,145 mL/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl > 50 mL/phút	Không thay đổi
CrCl 30-50 mL/phút	7,5 mg/kg(TM) mỗi 24 h/lần
CrCl 10-29 mL/phút	10 mg/kg (TM) mỗi 48 h/lần
CrCl < 10 mL/phút	Tránh dùng
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	7,5 mg/kg (TM) mỗi 24 h/lần
Suy gan nhẹ hoặc vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Sử dụng thận trọng

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tương tác thuốc: Các thuốc gây kéo dài khoảng QTc (tác dụng cộng thêm); kéo dài PT, INR, PTT (↑ nồng độ thuốc); các tương tác khác ít gặp do thuốc không được chuyển hóa qua hệ cytochrome P-450.

Phản ứng bất lợi: Đau đầu, rối loạn vị giác, buồn nôn, nôn, ỉa chảy, độc tính với thận, hội chứng "người đỏ".

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Truyền trong vòng ít nhất 60 phút để làm giảm tới mức thấp nhất các phản ứng liên quan tới truyền. Thuốc có hiệu quả để điều trị nhiễm trùng da và tổ chức da có biến chứng (cSSSIs) do tụ cầu vàng nhạy với methicillin (MSSA)/ tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA). Hiệu quả có thể giảm đi nếu CrCl < 50 mL/phút.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Màng não không bị viêm: 1%

Viêm màng não: 2% *(xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 790).*

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Damodaran SE, Madhan S. Telavancin: A novel lipoglycopeptide antibiotic. J Pharmacother 2: 135–137, 2011.

Joson J, Grover C, Downer C, et al. Successful treatment of methicillin-resistant Staphylococcus aureus mitral valve endocarditis with sequential linezolid and telavancin monotherapy following daptomycin failure. J Antimicrob Chemother 66: 2186–2188, 2011.

Leonard SN, Szeto YG, Zolotarev M, et al. Comparative in vitro activity of telavancin, vancomycin, and linezolid against heterogeneously vancomycin-intermediate Staphylococcus aureus (hVISA). Int J Antimicrob 37: 558–561, 2011.

Marcos LA, Camins BC. Successful treatment of vancomycin-intermediate Staphylococcus aureus pacemaker lead infective endocarditis with telavancin. Antimicrob Agents Chemother 54: 5376–5378, 2010.

Plotkin P, Patel K, Uminski A, et al. Telavancin (Vibativ), a new option for the treatment of gram-positive infections. Pharm Ther 36: 127–138, 2011a.

Plotkin P, Patel K, Uminski A, et al. Telavancin for the treatment of methicillin-resistant staphylococcus aureus J Antimicrob Chemother 66: 2675–2677, 2011b.

Saravolatz LD, Stein GE, Johnson LB. Telavancin: a novel lipoglycopeptide. Clin Infect Dis 49: 1908–1914, 2009.

Shams W, Walker ES, Levy F, et al. Comparative activity of telavancin and other antimicrobial agents against methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolates collected from 1991 to 2006. Chemotherapy 56: 411–416, 2010.

Stryjewski ME, Graham DR, Wilson SE, et al. Telavancin versus vancomycin for the treatment of complicated skin and skin-structure infections caused by grampositive organisms. Clin Infect Dis 46: 1683–1693, 2008.

Twilla JD, Gelfand MS, Cleveland KO, et al. Telvancin for the treatment of methicillin-resistant Staphylococcus aureus osteomyelitis. J Antimicrob Chemother 66: 2675–2677, 2011.

Wilson SE, O'Riordan W, Hopkins A, et al. Telavancin versus vancomycin for the treatment of complicated skin and skin-structure infections associated with surgical procedures. Am J Surg 197: 791–796, 2009 .

Website: www.vibativ.com

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Telbivudine (Tyzeka)

Nhóm thuốc: Thuốc kháng virus HBV

Liều thường dùng: 600 mg (uống) mỗi 24 h/lần.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 3,69 µg/mL.

Sinh khả dụng: Cao

Bài xuất dưới dạng nguyên vẹn: 42%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 20/32 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 3%

Thể tích phân bố (V_d): không có số liệu.

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl 30-49 mL/phút	Viên nén 600 mg (uống) mỗi 48 h/lần hoặc dung dịch 400 mg (uống) mỗi 24 h/lần
CrCl < 30 mL/phút	Viên nén 600 mg (uống) mỗi 72 h/lần hoặc dung dịch 200 mg (uống) mỗi 24 h/lần
CrCl < 10mL/phút	Viên nén 600 mg (uống) mỗi 96 h/lần hoặc dung dịch 120 mg (uống) mỗi 24 h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Viên nén 600 mg (uống) mỗi 96 h/lần hoặc dung dịch 120mg (uống) mỗi 24 h/lần
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không có số liệu
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Viên nén 600 mg (uống) mỗi 72 h/lần hoặc dung dịch 200 mg mỗi 24 h/lần
Suy gan vừa đến nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Interferon (↑ nguy cơ bị bệnh lý thần kinh ngoại vi); các thuốc gây độc cho thận (↑ độc tính với thận).

Phản ứng bất lợi: Bệnh cơ; bệnh lý thần kinh ngoại biên; mệt mỏi; chóng mặt; đau đầu; đau họng; ho; ỉa chảy; đau bụng; chướng bụng; buồn nôn; đau khớp; nổi ban da; sốt; đau cơ; mất ngủ. ↑ CPK, ↑ SGOT/SGPT.

Bình luận: Có thể gây nhiễm toan lactic và gan to, đã ghi nhận một vài trường hợp tử vong.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Có hoạt tính cao đối với virus viêm gan B.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Liaw YF, et al. 2-year GLOBE trial results: telbivudine is superioir to lamivudine in patients with crhonic hepatitis B. Gastroenterology 136: 486–95, 2009.

Zhou X, et al. Pharmacokinetics in telbivudine in subjects with various degrees of renal impairment. Antimicrob Agents Chemother 51: 4231–35, 2007.

Telithromycin (Ketek)

Nhóm thuốc: Ketolid

Liều thường dùng: *Viêm xoang cấp/đợt tiến triển cấp của viêm phế quản mạn tính:* 800 mg (uống) mỗi 24 h/lần × 5 ngày. *Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng:* 800 mg (uống) mỗi 24 h/lần × 7-10 ngày. Liều 800 mg (uống) được chia thành 2 lần, mỗi lần uống một viên 400 mg.

Phổ tác dụng: (Xem đặc điểm về độ nhạy cảm thuốc trang 324-335).

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 2,27 µg/mL.

Sinh khả dụng: 57%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 13%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 9,8/11 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 65%

Thể tích phân bố (V_d): 2,9 L/kg

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều*

CrCl < 30 mL/phút	600 mg (uống) mỗi 24 h/lần
CrCl < 30 mL/phút + suy tế bào gan	400 mg (uống) mỗi 24 h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo/lọc màng bụng	400 mg (uống)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	400 mg (uống) mỗi 24 h/lần

Tương tác thuốc: Digoxin (↑ nồng độ thuốc tương tác); các dẫn xuất ergot (ngộ độc cấp ergot); itraconazol, ketoconazol (↑ nồng độ telithromycin); midazolam, triazolam (↑ nồng độ thuốc tương tác, gây tình trạng an thần); thuốc chống đông dùng đường uống (có thể làm ↑ tác dụng chống đông; cần theo dõi PT/ INR); simvastatin (↑ nguy cơ bị tiêu cơ vân; dùng simvastatin 12 giờ sau khi sử dụng telithromycin làm giảm nồng độ simvastatin ~ 50%); theophyllin (làm tăng thêm cảm giác buồn nôn). Chất ức chế/cơ chất của CYP 3A4. Telithromycin bị chống chỉ định dùng với cisaprid và pimozid.

Phản ứng bất lợi: Buồn nôn, ỉa chảy, chóng mặt, ngất, khó điều tiết mắt.

Thuốc bị chống chỉ định ở bệnh nhân có tiền sử viêm gan/vàng da (hiếm gặp trường hợp viêm gan bùng phát/ cấp tính gây tử vong hoặc suy tế bào gan cấp ở các đối tượng có bệnh gan từ trước). Tránh sử dụng cho bệnh nhân bị nhược cơ (↑ nguy cơ suy hô hấp).

Khả năng gây dị ứng: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Có thể uống thuốc vào bữa ăn hay xa bữa ăn. Loại viên nén mới kích thước nhỏ hơn có thể giúp làm giảm thiểu các khó chịu trên đường tiêu hóa có thể gặp.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Aubier M, Aldons PM, Leak A, et al. Telithromycin is as effective as amoxicillin/clavulanate in acute exacerbations of chronic bronchitis. Respir Med 96: 862–71, 2002.

Brown SD, Farrell DJ. Antibacterial susceptibility among Streptococcus pneumoniae isolated from paediatric and adult patients as part of the PROTECT US study in 2001–2002. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 54 (Suppl. S1): 23–29, 2004.

Brown SD, Rybak MJ. Antimicrobial susceptibility of Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes and Haemophilus influenzae collected from patients across the USA, in 2001–2002, as part of the PROTECT US study. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 54 (Suppl. S1): 7–15, 2004.

Carbon C, Moola S, Velancsics I, et al. Telithromycin 800 mg once daily for seven to ten days is an effective and well-tolerated treatment for communityacquired pneumonia. Clin Microbiol Infect 9: 691–703, 2003.

Dunbar LM, Carbon C, van Rensburg D, et al. Efficacy of telithromycin in community-acquired pneumonia caused by atypical and intracellular pathogens. Infect Dis Clin Pract 13: 10–16, 2005.

Ferguson BJ, Guzzetta RV, Spector SL, et al. Efficacy and safety of oral telithromycin once daily for 5 days versus moxifl oxacin one daily for 10 days in the treatment of acute bacterial rhinosinusitis. Otolaryngol Head Neck Surg 131: 207–14, 2004.

Hagberg L, Torres A, van Rensburg D, et al. Efficacy and tolerability of once-daily telithromycin compared with high-dose amoxicillin for treatment of communityacquired pneumonia. Infection 30: 378–386, 2002.

Kim, DM, Yu KD, Lee JH, et al. Controlled trial of 5-day course of telithromycin versus doxycycline for treatment of mild to moderate scrub typhus. Antimicrob Agents Chemother 51: 2011–2015, 2007.

Klugman KP, Lonks JR. Hidden epidemic of macrolideresistant pneumococci. Emerg Infect Dis 11: 802–807, 2005.

Low DE, Brown S, Felmingham D. Clinical and bacteriology efficacy of the ketolide telithromycin against isolates of key respiratory pathogens: a pooled analysis of phase III studies. Clin Microbiol Infect 10: 27–36, 2004.

Ortega M, Marco F, Almela M, et al. Activity of telithromycin against erythromycin-susceptible resistant Streptococcus pneumoniae is from adults with invasive infections. Int J Antimicrob Agents 24: 616–8, 2004.

Website: www.ketek.com

Tenofovir disoproxil fumarate (Viread) TDF

Nhóm thuốc: Thuốc chống retrovirus (chất tương tự nucleotid).

Liều thường dùng: 300 mg (uống) mỗi 24 h/lần.

Thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 0,29 µg/mL.

Sinh khả dụng: 25%/39% (lúc đói/sau bữa ăn giàu chất béo).

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 32%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 17 giờ/không có số liệu.

Liên kết với protein huyết tương: 0,7-7,2%

Thể tích phân bố (V_d): 1,3 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Điều chỉnh liều*

CrCl 30-49 mL/phút	300 mg (uống) mỗi 48 h/lần
CrCl 10-29 mL/phút	300 mg (uống) x 2 lần/tuần
CrCl < 10 mL/phút	Tránh dùng
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	300 mg mỗi 7 ngày
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không có thông tin
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	300 mg x 2 lần/tuần
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Didanosin (nếu có thể, tránh dùng chung với didanosin do làm suy giảm đáp ứng CD4 và tăng nguy cơ điều trị thất bại virus); valganciclovir (↑ nồng độ tenofovir); atazanavir, lopinavir/ritonavir (↑ nồng độ tenofovir) (↓ nồng độ atazanavir; sử dụng atanazavir 300 mg/ritonavir 100 mg với tenofovir); telaprevir (↑ nồng độ tenofovir)

Phản ứng bất lợi: Nhiễm toan lactic và gan to nhiều với thoái hóa mỡ gan (bao gồm cả các trường hợp tử vong) khi dùng thuốc tương tự nucleosid. Đợt tiến triển cấp nặng của viêm gan ở bệnh nhân nhiễm virus viêm gan B xảy ra ở các đối tượng ngừng đã ngừng điều trị thuốc chống virus viêm gan B (bao gồm tenofovir). Có thể gặp buồn nôn nhẹ, nôn, khó chịu trên đường tiêu hóa, suy nhược, đau đầu, ỉa chảy, nhiễm toan do ống thận, giảm tỷ trọng xương. Lưu ý rằng cần tính toán độ thanh thải creatinin ở tất cả các bệnh nhân trước khi bắt đầu điều trị và đánh giá đáp ứng lâm sàng trong khi điều trị bằng tenofovir. Hội chứng giống Fanconi, cần theo dõi thường quy độ thanh thải creatinin và nồng độ phospho trong huyết thanh ở các bệnh nhân có nguy cơ bị suy giảm chức năng thận. Hội chứng " hồi phục lại miễn dịch" ("ICS") có thể xảy ra.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Thuốc được thải trừ nhờ quá trình lọc ở cầu thận/bài tiết ở ống thận. Có thể uống thuốc vào bữa ăn hay xa bữa ăn. Nếu có thể, tránh dùng đồng thời với didanosin (Xem *Tương tác thuốc*). Có hoạt tính đối với virus viêm gan B.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: Không có số liệu.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Anderson PL, Kiser JJ, Gardner EM, et al. Pharmacological considerations for tenofovir and emtricitabine to prevent HIV infection. J Antimicrob Chemother 66: 240–250, 2011.

Calcagno A, Bonora S, Simiele M, et al. Tenofovir and emtricitabine cerebrospinal fluid-to-plasma ratios correlate to the extent of blood-brainbarrier damage. AIDS 25: 1437–1439, 2011.

Cooper RD, Wiebe N, Smith N, et al. Systematic review and Meta-analysis: Renal safety of tenovovir disoproxil fumarate in HIV-infected patients. Clin Infect Dis 51: 496–505, 2010.

Daudé M, Rostaing L, Sauné K, et al. Tenofovir therapy in hepatitis B virus-positive solid-organ transplant recipients. Transplantation 91: 916–920, 2011.

Fabbiani M, Bracciale L, Doino M, et al. Tenofovir discontinuation could predispose to urolithiasis in atazanavir-treated patients. J Infect 62: 319–321, 2011a.

Fabbiani M, Bracciale L, Doino M, et al. Lipid-lowering effect of tenofovir in HIV-infected patients. J Antimicrob Chemother 66: 682–683, 2011b.

Gallant JE, Deresinski S, Tenofovir disoproxil furnarate. Clin Infect Dis 37: 944–50, 2003.

Hall AM, Hendry BM, Nitsch D, et al. Tenofovirassociated kidney toxicity in HIV-infected patients: A review of new evidence. Am J Kidney Dis 57: 773–780, 2011.

Ratcliffe L, Beadsworth MD, Pennell A, et al. Managing hepatits B/HIV co-infected: adding entecavir to truvada (tenofovir disoproxil/emtricitabine) experienced patients. AIDS 25: 1051–1056, 2011.

Sarrecchia C, Svicher V, Volpi A, et al. Successful switch to tenofovir after suboptimal response to entecavir in an immunocompromised patient with chronic hepatitis B and without genotypic hepatitis B virus resistance 39: KK367–370, 2011.

Sax PE, Tierney C, Collier AC, et al. Abacavir/lamivudine versus tenofovir DF/emtricitabine as part of combination regimens for initial treatment of HIV: final results. AIDS clinical trials group study A5202 team 204: 1191–1201, 2011.

Si-Ahmen SN, Pradat P, Soutendijik R, et al. Efficacy and tolerance of a combinatory of tenofovir disoproxil fumarate plus emtricitabine in patients with chronic hepatitis B: A European multicenter study 92: 90–95, 2011.

Thompson MA, Aberg JA, Cahn P, et al. Antiretroviral treatment of adult HIV infection: 2010 recommendations of the international AIDS society – USA panel. JAMA 304: 321–333, 2010.

Website: www.viread.com

Terbinafine (Lamisil, Daskil)

Nhóm thuốc: Thuốc chống nấm.

Liều thường dùng: 250 mg (uống) mỗi 24 h/lần.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 1µg/mL.

Sinh khả dụng: 70%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 1%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/bệnh thận giai đoạn cuối): 24 giờ/không có số liệu.

Liên kết với protein huyết tương: 99%

Thể tích phân bố (V_d): 13,5 L/kg.

Đường thải trừ chính: Gan/thận

Điều chỉnh liều*

CrCl~50-60mL/phút	Không thay đổi
CrCl < 50mL/phút	Tránh dùng
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Tránh dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Tránh dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Tránh dùng
Suy gan vừa hoặc nặng	Tránh dùng

Tương tác thuốc: Cimetidin (↓ độ thanh thải terbinafin, ↑ nồng độ terbinafin); Phenobarbital, rifampin (↑ thanh thải terbinafin, ↓ nồng độ

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

terbinafin trong máu).

Phản ứng bất lợi: Sốt, nổi ban da do thuốc, giảm số lượng bạch cầu lympho, giảm bạch cầu, ↑ SGOT/SGPT, rối loạn thị giác, buồn nôn, nôn, khó chịu trên đường tiêu hóa.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp.

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Có thể gây ra màu lục và làm thay đổi thủy tinh thể/võng mạc.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: <10%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Abdel-Rahman SM, Nahata MC. Oral terbinafine: A new antifungal agent. Ann Pharmacother 31: 445–56, 1997.

Amichai B, Grunwald MH. Adverse drug reactions of the new oral antifungal agents – terbinafine, fluconazole, and itraconazole. Int J Dermatol 37: 410–5, 1998.

Darkes MJ, Scott LJ, Goa KL. Terbinafine: a review of its use in onychomycosis in adults. Am J Clin Dermatol 4: 39–65, 2003.

Jain S, Sehgal VN. Itraconazole versus terbinafine in the management of onychomycosis: an overview. J Dermatolog Treat 14: 30–42, 2003.

Website: www.pdr.net

Tetracycline

Nhóm thuốc: Tetracylin.

Liều thường dùng: 500 mg (uống) mỗi 6 giờ (uống thuốc xa bữa ăn).

Phổ tác dụng: *(Xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn, trang 324-335).*

Nguy cơ bị đề kháng: Cao (Phế cầu [*S.pneumoniae*], tụ cầu vàng nhạy với Methicillin [MSSA]).

Các thông số dược động học :

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 1,5µg/mL

Sinh khả dụng: 60%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 60%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 8/108 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 5%

Thể tích phân bố (V_d): 0,7 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl 50-80 mL/phút	500 mg (uống) mỗi 12 h/lần
CrCl 10- 50mL/phút	500 mg (uống) mỗi 24 h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo/ lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	500 mg (uống) mỗi 12 h/lần
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	≤ 1 g/24 giờ (uống) mỗi 24 h/lần

Tương tác thuốc: Thuốc trung hòa acid dạ dày, Al^{+++}, Ca^{++}, Fe^{++}, Mg^{++}, Zn^{++}, multivitamin, sucralfat (↓ hấp thu tetracyclin), barbiturat, carbamazepin,

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

phenytoin (↓ thời gian bán thải của tetracyclin); bicarbonat (↓ hấp thu và ↑ độ thanh thải tetracyclin); Digoxin (↑ nồng độ digoxin), insulin (↑ tác dụng insulin; methoxyfluran (↑ độc tính trên thận).

Phản ứng bất lợi: Buồn nôn, nôn, khó chịu trên đường tiêu hóa, ỉa chảy, độc tính với gan, nhiễm nấm Candida âm đạo, phản ứng tăng nhạy cảm với ánh sáng, tăng áp lực nội sọ lành tính (pseudotumor cerebri).

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Mức độ toàn trong thai nghén: D

Bình luận: Uống thuốc xa bữa ăn. Độc tính trên gan phụ thuộc theo liều (≥ 2 g/ngày), nhất là ở phụ nữ có thai/ bệnh nhân suy thận. Tránh tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời. Doxycyclin hoặc minocyclin được ưu tiên sử dụng cho mọi chỉ định dùng tetracylin.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Màng não không bị viêm: 5%

Viêm màng não:5%

Khả năng thấm vào mật: 1000% (*Xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 512*).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Agwuh KN, MacGowan A. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of the tetracyclines includingglycylcyclines. J of Antimicrob Chemotherapy 58: 256–265, 2006.

Cunha BA, Comer J, Jonas M. The tetracyclines. Med Clin North Am 66: 293–302, 1982.

Dahl EL, Shock JL, Shenai BR, et al. Tetracyclines specifically target the apicoplast of the malaria parasite Plasmodium falciparum. Antimicrob Agents Chemother 50: 3124–31, 2006.

Malfertheiner P, Bazzoli F, Delchier JC, et al. Helicobacter pylori eradication with a capsule containing bismuth subcitrate potassium, metronidazole, and tetracycline given with omeprazole versus clarithromycin-based triple therapy: a randomized, open-label, non-inferiority, phase 3 trial. Lancet 33: 905–913, 2011.

Pugliese A, Cunha BA. Tetracyclines. Int J Urogyn 5: 221–7, 1994.

Smilack JD, Wilson WE, Cocerill Fr 3rd. Tetracycline, chloramphenicol, erythromycin, clindamycin, and metronidazole. Mayo Clin Proc 66: 1270–80, 1991.

Ticarcillin (Ticar)

Nhóm thuốc: Penicillin kháng trực khuẩn mủ xanh.

Liều thường dùng: 3 g (TM) mỗi 6 h/lần

Phổ tác dụng: (*Xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 234-327*).

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 118-300 µg/mL.

Sinh khả dụng: không được áp dụng.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 95%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 1/5 giờ.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Liên kết với protein huyết tương: 45%

Thể tích phân bố (V_d) : 0,2 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl 50-80 mL/phút	Không thay đổi
CrCl 10-50mL/phút	2 g (TM) mỗi 8 h/lần
CrCl < 10mL/phút	2 g (TM) mỗi 12 h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	2 g (TM)
Liều dùng sau lọc màng bụng	3 g (TM)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	2 g (TM) mỗi 8 h/lần
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Aminoglycosid (gây bất hoạt ticarcilin ở bệnh nhân suy thận), warfarin (↑ INR), thuốc viên tránh thai (↓ tác dụng của thuốc tránh thai dùng đường uống), cefotixin (↓ tác dụng ticarcillin).

Phản ứng bất lợi: Sốt/nổi ban da do thuốc, hồng ban đa dạng/hội chứng Stevens-Johnson, phản ứng quá mẫn (tụt huyết áp, co thắt thanh quản, co thắt phế quản), mày đay, bệnh huyết thanh. Gây ức chế kết tập tiểu cầu phụ thuộc liều rất ít /không gặp, tiêu chảy/ viêm đại tràng do *C. difficile*.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Cao.

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Dùng thuốc một giờ trước hoặc sau khi dùng aminoglycosid. Hàm lượng Na^+ có trong chế phẩm = 5,2 mEq/g.

Liều cho màng não = liều thường dùng.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Màng não không bị viêm = 1%

Viêm màng não = 30%

(Xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 512).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Donowitz GR, Mandell GL. Beta-lactam antibiotics. N Engl J Med 318: 419–26 and 318: 490–500, 1993.

Tan JS, File TM, Jr. Antipseudomonal penicillins. Med Clin North Am 79: 679–93, 1995.

Wright AJ. The penicillins. Mayo Clin Proc 74: 290–307, 1999.

Ticarcillin/Clavulanate (Timetin)

Nhóm thuốc: Penicilin chống trực khuẩn mủ xanh.

Liều thường dùng: 3,1 g (TM) mỗi 6 h/lần.

Phổ tác dụng: *(Xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn, trang234-327).*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 330mg/mL.

Sinh khả dụng: Không được áp dụng.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 95/45%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): [1/13] /[1/2] giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 45/25%

Thể tích phân bố (V_d): 0,2/0,3 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl 30-60 mL/phút	3,1g (TM) mỗi 8 h/ lần
CrCl 10-30mL/phút	3,1 g (TM) mỗi 12 h/lần
CrCl < 10mL/phút	2 g (TM) mỗi 12 h/ lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	3,1 g (TM)
Liều dùng sau lọc màng bụng	3,1 g (TM)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVA HDF	3,1 g (TM) mỗi 8 h/lần
Suy gan vừa	Nếu CrCl < 10 mL/ phút: 2 g (TM) mỗi 24 h/lần
Suy gan nặng	Nếu CrCl < 10mL/ phút: 2 g (TM) mỗi 24 h/lần

Tương tác thuốc: Aminoglycosid (↓ nồng độ aminoglucosid); methotrexat (↑ nồng độ của methotrexat);vecuronium (↑ tác dụng của vecuronium).

Phản ứng bất lợi: Sốt/nổi ban da do thuốc, hồng ban đa dạng/Hội chứng Stevens- Johnson, phản ứng phản vệ (tụt huyết áp, co thắt thanh quản, co thắt phế quản), mày đay, bệnh huyết thanh, tiêu chảy/viêm đại tràng do *C. difficile*.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Cao

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: **20% clavulanat được loại bỏ bằng thẩm tách** máu. Hàm lượng Na^+ trong chế phẩm= 4,75 mEq/g. Hàm lượng K^+= 0,15 mEq/g.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: <10%

Khả năng thấm vào mật:

Không có tắc mật = 100%

Có tình trạng tắc mật = 10%

(xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 793).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Donowitz GR, Mandell GL. Beta-lactam antibiotics. N Engl J Med 318: 419–26 and 318: 490–500, 1993.

Graham DR, Talan DA, Nichols RL, et al. Once-daily, high-dose levofl oxacin versus ticarcillin-clavulanate alone or followed by amoxicillin-clavulanate for complicated skin and skin-structure infections: a randomized, open-label trial. Clin Infect Dis 35: 381–9, 2002.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Itokazu GS, Danziger LH. Ampicillin-sulbactam and ticarcillin-clavulanic acid: A comparison of their in vitro activity and review of their clinical efficacy. Pharmacotherapy 11: 382–414, 1991.

Winston LG, Charlebois ED, Pang S, et al. Impact of a formulary switch from ticarcillin-clavulanate to piperacillin-tazobactam on colonization with vancomycin-resistant enterococci. Am J Infect Control 32: 462–9, 2004.

Website: www.timentin.com

Tigecycline (Tygacil)

Nhóm thuốc: Glycylcycline.

Liều thường dùng: **Liều nạp**: 100 mg (TM) x 1 liều, (liều được nhà sản xuất khuyến cáo [PI dose]) hoặc 200mg (TM), sau đó dùng 100 mg mỗi 24h/lần (liều dược động học [PK dose]). **Liều duy trì**: 50 mg (TM) mỗi 12 h/lần (liều được nhà sản xuất khuyến cáo) hoặc 100 mg (TM) mỗi 24 h/lần (liều dược động học). (Xem thêm phần *Bình luận*)

Phổ tác dụng: (*Xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn, trang 332-335*).

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp (*Acinetobacter baumanii*).

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 1,45 mg/mL (liều 100 mg), 0,87 µg/mL (liều 50 mg).

Sinh khả dụng: Không được áp dụng.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 22%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 42/42giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 89%

Thể tích phân bố (V_d): 8 L/kg.

Đường thải trừ chính: Mật

Điều chỉnh liều*

CrCl < 10 mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không cần dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không cần dùng
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	100 mg (TM) x 1 liều, sau đó 25 mg (TM) mỗi 12 h/lần

Tương tác thuốc: Warfarin (↑INR). Không bị ức chế và không được chuyển hóa bởi cytocrome P450.

Phản ứng bất lợi: Buồn nôn/ nôn, khó tiêu, tiêu chảy, chóng mặt, suy nhược, ↑SGOT, ↑ phosphatase kiềm, viêm tụy, (↑ amylase/lipase), ↑ LDH, ↑ ure máu, ↓ protein toàn phần.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: D

Bình luận: Hiệu quả trong điều trị nhiễm khuẩn da và cấu trúc da có biến

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

chứng (cSSSI)/nhiễm khuẩn trong ổ bụng có biến chứng (cIAIs).

Có thể cần dùng liều nạp/ liều duy trì cao hơn đối với các nhiễm khuẩn toàn thân nặng hoặc trong trường hợp nhiễm Klebsiella pneumonia đa kháng thuốc hoặc Acinetobacter baumanii đa kháng thuốc§†. Sau liều nạp khởi đầu được dựa trên thông số dược động học, tigecyclin cũng có thể được dùng mỗi 24 h/lần như liều đơn duy trì hàng ngày.* Thuốc được sử dụng an toàn cho bệnh nhân dị ứng với penicillin/ sulfamid.

Tigecyclin hiếm khi gây buồn nôn/nôn nếu được pha loãng đầy đủ và truyền tĩnh mạch chậm. Nếu xuất hiện triệu chứng buồn nôn/nôn, ↑ thể tích dịch truyền và thời gian truyền dịch theo bảng dưới đây:

Liều Tegecyclin†	Thể tích dịch truyền	Thời gian truyền
100 mg	100 mL	30 phút
200 mg *	250 mL	60 phút
400 mg §	500 mL	120 phút

**Dành cho trường hợp nhiễm khuẩn nặng toàn thân.*

§ *Dành cho trực khuẩn Gram âm, nhiễm trùng nặng toàn thân hoặc viêm đường tiết niệu do vi khuẩn Gram âm đa kháng thuốc song nhạy với Tigecyclin*

†*Liều duy trì bằng một nửa liều liều nạp.*

Khả năng thấm qua dịch não-tủy: Không có số liệu.

Khả năng ngấm vào mật: 3800%. (*Xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 518*).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Aslam S, Trautner BW, Ramanathan V, et al. Combination of tigecycline and N-acetylcysteine reduces biofi lm-embedded bacteria on vascular catheters. Antimicrob Agents Chemother 51: 1556–1558, 2007.

Babinchak T, Ellis-Grosse E, Dartois N, et al. The efficacy and safety of tigecycline for the treatment of complicated intra-abdominal infections: analysis of pooled clinical trial data. Clin Infect Dis 41(Suppl 5:S3): 54–67, 2005.

Baines SD, Saxton K, Freeman K, et al. Tigecycline does not induce proliferation or cytotoxin production by epidemic Clostridium difficile strains in a human gut model. J Antimicrob Chemother 58: 1062–1065, 2006.

Bendu C, Culebras E, Gomez M, et al. In vitro activity of tigecycline against Bacteroides species. J Antimicrob Chemother 56: 349–52, 2005

Bergallo C, Jasovich A, Teglia O, et al. Safety and efficacy of intravenous tigecycline in Treatment of community-acquired pneumonia: results from a double-blind randomized Phase 3 comparison study with levofl oxacin. Diagn Microbiol Infect Dis 63: 52–61, 2009.

Bolmstrom A, Karlsson A, Engelhardt A, et al. Validation and reproducibility assessment of tigecycline MIC determinations by Etest. J Clin Microbiol 45: 2474–2479, 2007.

Bopp LH, Baltch AL, Ritz WJ, et al. Activities of tigecycline and comparators against Legionella pneumophila and Legionella micdadei extracellularly and in human monocytederived macrophages. Diagn Microbiol Infect Dis 69: 86–93, 2011.

Bouza E. New therapeutic choices for

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

infections caused by methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Clin Microbiol Infect Dis 15: 44–52, 2009.

Bradford PA, Weaver-Sands DT, Petersen PJ. In vitro activity of tigecycline against isolates from patients enrolled in phase 3 clinical trials of treatment for complicated skin and skin-structure infections and complicated intra-abdominal infections. Clin Infect Dis 41(Suppl 5): S315–32, 2005.

Breedt J, Teras J, Gardovskis J, et al. Safety and efficacy of tigecycline in treatment of skin and skin structure infections: results of a double-blind phase 3 comparison study with vancomycin-aztreonam. Antimicrobial Agents Chemother 49: 4658–4666, 2005.

Bulik CC, Wiskirchen DE, Shepard A, et al. Tissue penetration and pharmacokinetics of tigecycline in diabetic patients with chronic wound infections described by using in vivo microdialysis. Antimicrob Agents Chemother 54: 5209–4213, 2010.

Cai Y, Wang R, Liang B, et al. Systematic review and meta-analysis of the effectiveness and safety of tigecycline for treatment of infectious disease. Antimicrob Agents Chemother 55: 1162–1172, 2011.

Cheong EY, Gottlieb T. Intravenous tigecycline in the treatment of severe recurrent Clostridium difficile colitis. Med J. Aust 4: 374–375, 2011.

Conde-Estévez D, Grau S, Horcajada JP, et al. Offlabel prescription of tigecycline: clinical and microbiological characteristics and outcomes. Int J Antimicrob Agents 36: 471–472, 2010

Cunha BA, McDermott B, Nausheen S. Single once daily high dose therapy of tigecycline in a urinary tract infection due to multi-drug resistant (MDR) Klebsiella pneumoniae and MDR Enterobacter agglomerans. Journal of Chemotherapy 19: 753-754, 2008.

Cunha BA. Once daily tigecycline therapy of multidrugresistant and non-multidrug resistant gram-negative bacteremias. J of Chemother 19: 232–33, 2007.

Cunha BA. Antimicrobial therapy of multidrug-resistant Streptococcus pneumoniae, vancomycin-resistant enterococci, and methicillin-resistant Staphlycoccus aureus. Med Clin N Am 90: 1165–82, 2006.

Daly MW, Riddle DJ, Ledeboer NA, et al. Tigecycline for treatment of pneumonia and empyema caused by carbapenems-producing Klebsiella pneumoniae. Pharmacotherapy 27: 1052–1057, 2007.

Dandache P, Nicolau DP, Sakoulas G. Tigecycline for the treatment of multidrug-resistant Klebsiella pneumoniae meningitis . Infect Dis in Clin Practice 17: 66–68 , 2009.

Dartois N, Castiang N, Gandjini H, et al. Tigecycline versus levofl oxacin for the treatment of communityacquired pneumonia: European experience. J Chemother 20: 28–35, 2008.

Dizbay M, Kilic S, Hizel K, et al. Tigecycline: its potential for treatment of brucellosis. Scand J Infect Dis 39: 432–434, 2007.

Dominguez EA. Single agent therapy with tigecycline in the treatment of complicated skin and skin structure and complicated intraabdominal infections . Infectious Diseases in Clinical Practice 17: 144–149 , 2009 .

Ellis-Grosse EJ, Babinchak T, Dartois N, et al. The efficacy and safety of tigecycline in the treatment of skin and skin-structure infections: results of 2 double-blind phase 3 comparison studies with vancomycin-aztreonam. Clin Infect Dis 41(Suppl 5): S341–53, 2005.

Fraise AP. Tigecycline: The answer to beta-lactam and fluoroquinolone resistance? Journal of Infection 53: 293–300, 2006.

Gardiner D, Dukart G, Cooper A, et al. Safety and Efficacy of Intravenous Tigecycline in Subjects with Secondary Bacteremia: Pooled Results from 8 Phase III Clinical Trials. Clin Infect Dis 50: 229–238, 2010.

Geerlings SE, van Donselaar-van der Pant KA, Keur I. Successful treatment with tigecycline of two patients with complicated urinary tract infections caused by extended-spectrum betalactamase-producing Escherichia coli. J Antimicrob Chemother

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

65: 2048–2049, 2010.

Hawkey P, Finch R. Tigecycline: in-vitro performance as a predictor of clinical efficacy. Clin Microbiol Infect 13: 354–362, 2007.

Hawser SP. Activity of tigecycline against recent European clinical isolates of Clostridium diffi cile. Int J Antimicrob Agents 35: 97–98, 2010.

Herpers BL, Vlaminckx B, Burkhardt O, et al. Intravenous tigecycline as adjunctive or alternative therapy for severe refractory Clostridium difficile infection . Clin Infect Dis 48: 1732–1735 , 2009 .

Hoban DJ, Bouchillon SK, Dowzicky MJ. Antimicrobial susceptibility of extended-spectrum beta-lactamase producers and multidrug-resistant Acinetobacter baumannii throughout the United States and comparative in vitro activity of tigecycline, a new glycylcyline antimicrobial. Diagn Microbiol Infect Dis 57: 423–428, 2007.

Hope R, Mushtaq S, James D, et al. Tigecycline activity: low resistance rates but problematic disc breakpoints revealed by a multicentre sentinel survey in the UK. J Antimicrob Chemother 65: 2602–2609, 2010.

Huang V, Cheung CM, Kaatz GW, et al. Evaluation of dalbavancin, tigecycline, minocycline, tetracycline, teicoplanin and vancomycin against communityassociated and multidrug-resistant hospital-associated meticillin-resistant Staphylococcus aureus. Int J Antimicrob Agents 35: 25–29, 2010.

Hunte CA, Abbo LM. Skin and soft tissue infections due to methicillin-resistant Staphylococcus aureus: Role of tigecycline. Clin Infect Dis 52: 1468–1467, 2011.

Humphries RM, Kelesidis T, Dien Bard J, et al. Successful treatment of pan-resistant Klebsiella pneumoniae pneumonia and bacteraemia with a combination of high-dose tigecycline and colistin. J Med Microbiol 59: 1383–1386, 2010.

Insa R, Cercenado E, Goyanes MJ, et al. In vitro activity of tigecycline against clinical isolates of Acinetobacter baumannii and Stenotrophomonas maltophilia. J Antimicrob Chemother 59: 583–585, 2007.

Jenkins I. Linezolid- and vancomycin-resistant Enterococcus faecium endocarditis: successful treatment with tigecycline and daptomycin. J Hosp Med 2: 343–344, 2007.

Jones RN, Ferraro MJ, Reller LB, et al. Multicenter studies of tigecycline disk diffusion susceptibility results for Acinetobacter spp. J Clin Microbiol 45: 227–230, 2007.

Jump RL, Li Y, Pultz, JF, et al. Tigecycline exhibits inhibitory activity against Clostridium diffi cile in the colon of mice and does not promote growth or toxin production. Antimicrob. Agents Chemother 55:546–549, 2011.

Kresken M, Leitner E, Brauers J, et al. Susceptibility of common aerobic pathogens to tigecycline: results of a surveillance study in Germany . Eur J Clin Microbiolg Infec Dis 28: 83–90 , 2009 .

Kuo SC, Wang FD, Fung CP, et al. Clinical experience with tigecycline as treatment for serious infections in elderly and critically ill patients. J Microbiol Immunol Infect 44: 45–51, 2011.

Lengerke C, Haap M, Mayer F, et al. Low tigecycline concentrations in the cerebrospinal fl uid of a neutropenic patient with inflamed meninges. Antimicrob Agents Chemother 55: 449–450, 2011.

Lu CL, Liu CY, Liao CH, et al. Severe and refractory Clostridium diffi cile infection successfully treated with tigecycline and metronidazole. Int J Antimicrob Agents 35: 311–312, 2010.

McKeage K, Keating GM. Tigecycline: in communityacquired pneumonia. Drugs 68: 2633–2644, 2008.

Meagher AK, Ambrose PG, Grasela TH, et al. The pharmacokinetic and pharmacodynamic profile of tigecycline. Clin Infect Dis 41(Suppl 5): S333–40, 2005.

Mendes RE, Farrell DJ, Sader HS, et al. Comprehensive assessment of tigecycline activity tested against a worldwide collection of Acinetobacter spp. (2005–2009). Diagn Microbiol Infect Dis 68:

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

307–311, 2010.

Metan G, Alp E, Yildiz O, et al. Clinical experience with tigecycline in the treatment of carbapenem-resistant Acinetobacter infections. J Chemother 22: 110–114, 2010.

Muralidharan G, Micalizzi M, Speth J, et al. Pharmacokinetics of tigecycline after single and multiple doses in healthy subjects. Antimicrob Agents Chemother 49: 220–9, 2005.

Nagy E, Dowzicky MJ. In vitro activity of tigecycline and comparators against a European compilation of anaerobes collected as part of the Tigecycline Evaluation and Surveillance Trial (TEST). Scand J Infect Dis 42: 33–38, 2010.

Nillson LE, Frimodt-Moller N, Vaara M, et al. Comparative activity of tigecycline and tetracycline on Gram-negative and Gram-positive bacteria revealed by a multicentre study in four North European countries. Scand J Infect Dis 43: 707–713, 2011.

Nix DE, Matthias KR. Should tigecycline be considered for urinary tract infections? A pharmacokinetic re-evaluation. J Antimicrob Chemother 65: 1311–1312, 2010.

Nord CE, Sillerstrom E, Wahlund E. Effect of Tigecycline on Normal Oropharyngeal and Intestinal Microflora. Antimicrob Agents Chemother 50: 3375–80, 2006.

Noskin GA. Tigecycline: a new glycylcycline for treatment of serious infections. Clin Infect Dis 41(Suppl 5): S303–14, 2005.

Noviello S, Ianniello F, Leone S, et al. In vitro activity of tigecycline: MICs, MBCs, time-kill curves and post-antibiotic effect. J Chemotherapy 20: 577–580 , 2008 .

Ozbek B, Otük G. In vitro activities of tigecycline alone and in combination with colistin sulfate or sulbactam against carbapenem-susceptible andresistant Acinetobacter baumannii strains isolated from Intensive Care Units. Int J Antimicrob Agents 36: 191–192, 2010.

Ozbek B, Sentruk A. Postantibiotic effects of tigecycline, colistin sulfate, and levofl oxacin alone or tigecycline-colistin sulfate and tigecycline-levofloxacin combinations against Acinetobacter baumannii. Chemotherapy 56: 466–471, 2010.

Pankey GA. Tigecycline. J Antimicrob Chemother 53: 470–80, 2005.

Pavan M, Chaudhari AP, Ranganth R. Altered bioavailability of tacrolimus following intravenous administration of tigecycline. Am J Kidney Dis57: 345, 2011.

Peleg AY, Potoski BA, Rea R, et al. Acinetobacter baumannii bloodstream infection while receiving tigecycline: a cautionary report. J Antimicrob Chemother 59: 128–31, 2007.

Polidori M, Nuccorini A, Tascini C, et al. Vancomycinresistant Enterococcus faecium (VRE) bacteremia in infective endocarditis successfully treated with combination daptomycin and tigecycline. J Chemother 23: 240–241, 2011.

Raad I, Hanna H, Jiang Y, et al. Comparative activities of daptomycin, linezolid, and tigecycline against catheter-related methicillin-resistant Staphylococcus bacteremic isolates embedded in biofilm. Antimicrob Agents Chemother 51: 1656–1660, 2007.

Rodvold KA, Gotfried MH, Cwik M, et al. Serum, tissue and body fluid concentrations of tigecycline after a single 100 mg dose. J Antimicrob Chemother 58: 1221–1229, 2006.

Rubinstein E, Vaughan D. Tigecycline: a novel glycylcycline. Drugs 65: 1317–36, 2005.

Sands M, McCarter Y, Sanchez W. Synergy testing of multidrug resistant Acinetobacter baumannii against tigecycline and polymyxin using an E-test methodology. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 26: 521–522, 2007.

Scheetz MH, Q Chao, Warren JR, et al. In vitro activities of various antimicrobials alone and in combination with tigecycline against carbapenem-intermediate or -resistant Acinetobacter baumannii. Antimicrob Agents Chemother 51: 1621–1626, 2007.

Slover CM, Rodvold KA, Danziger LH. Tigecycline: a novel broad-spectrum antimicrobial. Ann Pharmacother 41: 965–972, 2007.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Sotto A, Bouziges N, Jourdan N, et al. In vitro activity of tigecycline against strains isolated from diabetic foot ulcers. Pathol Biol 55: 398–406, 2007.

Stein GE, Craig WA. Tigecycline: A Critical Analysis. Clin Infect Dis 43: 518–24, 2006.

Swoboda S, Ober M, Hainer C, et al. Tigecycline for the treatment of patients with severe sepsis of septicshock: a drug use evaluation in a surgical intensive care unit. J Antimicrob Chemother 61: 729–733, 2008.

Taccone FS, Rodriguez-Villalobos H, DeBacker D, et al. Successful treatment of septic shock due to panresistant Acinetobacter baumannii using combined antimicrobial therapy including tigecycline. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 25: 257–60, 2006.

Tanaseanu C, Bergallo C, Teglia O, et al. Integrated results of 2 phase studies comparing tigecycline and levofloxacin in community-acquired pneumonia. Diagn Microbiol Infect Dis 61: 329–338, 2008.

Valve K, Vaalasti A, Anttila VJ, et al. Disseminated Legionella pneumophila infection in an immunocompromised patient treated with tigecycline. Scand J Infect Dis 42: 152–155, 2010.

Wilcox MH. Evidence for low risk of Clostridium difficile infection associated with tigecycline. Clin Microbiol Infect 13: 949–952, 2007.

Woodford N, Hill RL, Livermore DM. In vitro activity of tigecycline against carbapenem-susceptible and resistant isolates of Klebsiella spp. and Enterobacter spp. J Antimicrob Chemother 59: 582–583, 2007.

Zinner SH. Overview of antibiotic use and resistance: setting the stage for tigecycline. Clin Infect Dis 41(Suppl 5): S289–92, 2005.

Website: www.tygacil.com

Tipranavir (Aptivus) TPV

Nhóm thuốc: Ức chế Protease.

Liều thường dùng: 500 mg (uống) với ritonavir 200 mg (uống) mỗi 12 h/lần.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 77-94 µg/mL.

Sinh khả dụng: Không có số liệu.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 44%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/bệnh thận giai đoạn cuối): 5,5-6/5,5-6 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 99,9%

Thể tích phân bố (V_d): 7-10 L/kg.

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều*:

CrCl < 10mL/phút	Không thay đổi
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không thay đổi
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không thay đổi
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Không thay đổi
Suy gan nhẹ	Không thay đổi
Suy gan vừa hoặc nặng	Tránh dùng

Tương tác thuốc: Rifabutin (↑ nồng độ), Clarithromycin (↑ nồng độ), loperamid (↓ nồng độ), các thuốc nhóm statin (↑ nguy cơ bị bệnh

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

cơ), abacavir, saquinavir, tenofovir, zidovudin, amprenavir/retonavir, lopinavir/retonavir (↓ nồng độ), thuốc giảm tiết acid dạ dày chứa muối nhôm/ magiê (↓ hấp thu 25-35%). Ritonavir (tăng nguy cơ viêm gan), thảo dược St. John's Worth (↓ nồng độ tipranavir). Cần được bảo quản ở nhiệt độ 2-8°C. Được chuyển hóa qua cytochrome P3A4.

Chống chỉ định phối hợp với sinvastatin, atorvastatin, lovastatin, rifapentine

Phản ứng bất lợi: Bị chống chỉ định khi có suy gan vừa/nặng. ↑ nguy cơ gây độc cho gan trên bệnh nhân HIV bị đồng nhiễm virus viêm gan B/viêm gan C. Đã có báo cáo trường hợp xuất huyết não–sử dụng thận trọng trên bệnh nhân có rối loạn đông máu.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Cao. Tipranavir là một sulfonamid, sử dụng thận trọng ở bệnh nhân dị ứng với nhóm thuốc này.

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Nên sử dụng thuốc vào bữa ăn. Tăng sinh khả dụng khi thuốc được sử dụng trong bữa ăn. Phải dùng phối hợp với 200 mg ritonavir. Tipranavir chứa nhóm chức sulfonamide (cũng như darunavir và fosamprenavir).

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: Không có số liệu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Barbaro G, Scozzafava A, Mastrolorenzo A, et al. Highly active antiretroviral therapy: current state of the art, new agents and their pharmacological interactions useful for improving therapeutic outcome. Curr Pharm Des 11: 1805–43, 2005.

Clotet B. Strategies for overcoming resistance in HIV-1 infected patients receiving HAART. AIDS Rev 6: 123–30, 2004.

Croom KF, Keam SJ. Tipranavir: a ritonavir-boosted protease inhibitor. Drugs 65: 1669–79, 2005.

de Mendoza C, Soriano V. Resistance to HIV protease inhibitors: mechanisms and clinical consequences. Curr Drug Metab 5: 321–8, 2004.

Gulick RM. New antiretroviral drugs. Clin Microbiol Infect 9: 186–93, 2003.

Kandula VR, Khanlou H, Farthing C. Tipranavir: a novel second-generation nonpeptidic protease inhibitor. Expert Rev Anti Infect Ther 3: 9–21, 2005.

Kashuba AD. Drug-drug interactions and the pharmacotherapy of HIV infection. Top HIV Med 13: 64–9, 2005.

Plosker GL, Figgitt DP. Tripanavir. Drugs 63: 1611–8, 2003.

Thompson MA, Aberg JA, Cahn P, et al. Antiretroviral treatment of adult HIV infection: 2010 recommendations of the international AIDS society – USA panel. JAMA 304:321–333, 2010.

Turner D, Schapiro JM, Brenner BG, Wainberg MA. The influence of protease inhibitor profiles on selection of HIV therapy in treatment-naïve patients. Antivir Ther 9: 301–14, 2004.

Yeni P. Tipranovir: a protease inhibitor from a new class with distinct antiviral activity. J Acquir Immune Defic Syndr 34 (Suppl 1): S91–4, 2003.

Website: www.aptivus.com

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tobramycin (Nebcin)

Nhóm thuốc: Aminoglycosid.

Liều thường dùng: 240 mg hoặc 5 mg/kg (TM) mỗi 24 h/lần (ưu tiên dùng liều mỗi 8 h/lần *xem Bình luận*).

Phổ tác dụng: *(Xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 332-335).*

Nguy cơ bị đề kháng: Cao (*P.aeruginosa*, trực khuẩn Gram âm ái khí)

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 4-8 µg/mL (dùng liều mỗi 8h/lần), 16-24 µg/mL (dùng liều mỗi 24 h/lần).

Sinh khả dụng: Không được áp dụng.

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 95%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/bệnh thận giai đoạn cuối): 2,5/56 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 10%

Thể tích phân bố (V_d): 0,24 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrC 50-80 mL/phút	120 mg (TM) mỗi 24 h/lần hoặc 2,5 mg/kg (TM) mỗi 24 h/lần
CrCl 10-50 mL/phút	120 mg (TM) mỗi 48 h/lần hoặc 2,5 mg/kg (TM) mỗi 48 h/lần
CrCl < 10mL/phút	60 mg (TM) mỗi 48 h/lần hoặc 1,25 mg/kg (TM) mỗi 48 h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	80 mg (TM) hoặc 1 mg/kg (TM)
Liều dùng sau HFHD	120 mg (TM) hoặc 2,5 mg/kg (TM)
Liều dùng sau lọc màng bụng	40 mg (TM) hoặc 0,5 mg/kg (TM) hoặc 2-4 mg/L trong dịch thẩm tách mỗi 24 h/lần
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	120 mg (TM) mỗi 48 h/lần hoặc 2,5 mg/kg
Suy gan mức độ vừa	Không thay đổi
Suy gan mức độ nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Amphotericin B, cyclosporin, enflurane, methoxyfluran, thuốc chống viêm không steroid, polymyxin B, thuốc cản quang dùng để chụp X quang, vancomycin (↑ độc tính trên thận); cis platinum (↑ độc tính trên thận, ↑ độc tính với tai) ; thuốc lợi tiểu quai (↑ độc tính với tai); thuốc ức chế thần kinh-cơ (↑ nguy cơ ngừng thở, kéo dài tình trạng liệt cơ), thuốc giãn cơ không phân cực (↑ nguy cơ ngừng thở).

Phản ứng bất lợi: Ức chế thần

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

kinh-cơ khi truyền/hấp thu thuốc nhanh. Độc tính trên thận chỉ gặp khi sử dụng thuốc kéo dài/ nồng độ đáy của thuốc trong huyết thanh rất cao; có thể gây suy thận thể còn nước tiểu có thể hồi phục (hoại tử ống thận cấp). Độc tính đối với tai có liên quan tới dùng thuốc kéo dài/ nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh rất cao (thường không thể hồi phục). Độc tính trên ốc tai (chiếm 1/3 các độc tính đối với tai của thuốc) biểu hiện bằng giảm thính lực ở tần số cao, song hiếm khi gây điếc. Độc tính đối với tiền đình (chiếm 2/3 các độc tính đối với tai) xuất hiện trước khi có biểu hiện độc tính với tai và thường được biểu hiện bằng triệu chứng ù tai.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: D

Bình luận: Liều đơn dùng hàng ngày giúp làm giảm căn bản nguy cơ tiềm tàng gây độc tính trên thận/tai. Thuốc không tương hợp với các dung dịch chứa β–lactams, erythromycin, chloramphenicol, furosemid, natri bicarbonat. Nên truyền tĩnh mạch chậm trong vòng 1 giờ. Thuốc có thể được dùng theo đường tiêm bắp. **Tránh truyền thuốc vào khoang phúc mạc do nguy cơ gây ức chế thần kinh-cơ. Tránh nhỏ thuốc vào trong khí quản hoặc khí dung vào phổi do dễ có chiều hướng chọn lọc các vi khuẩn kháng lại kháng sinh.**

V_d tăng lên khi có phù/cổ chướng, chấn thương, bỏng, xơ hóa nang vì vậy có thể cần phải tăng liều. V_d giảm đi khi có tình trạng mất nước, béo phì, vì vậy có thể cần phải giảm liều.

Đếm số lượng trụ niệu của thận là chỉ dẫn tốt nhất để đánh giá tình trạng gây độc thận do aminoglycosid, mà không phải là nồng độ cretinin huyết thanh. Lọc máu loại bỏ khoảng 1/3 lượng tobramycin có trong huyết thanh. Liều Tobramycin dùng đường khí dung: 300 mg qua máy khí dung mỗi 12 h/lần **(không được khuyến cáo do làm tăng nguy cơ kháng thuốc)**.

Liều dùng cho bệnh nhân lọc màng bụng ngoại trú liên tục (CAPD): 2-4 mg/L dịch thẩm phân (truyền vào trong khoang phúc mạc) cho mỗi lần thay đổi dịch lọc.

Nồng độ thuốc trong huyết thanh có tác dụng điều trị (đạt hiệu quả điều trị, không gây độc tính): *Nồng độ đỉnh* (liều dùng mỗi 24 h/lần/khoảng thời gian dùng liều mỗi 8 h/lần)=16-24/8-10 µg/mL. *Nồng độ đáy* (liều dùng mỗi 24 giờ/ khoảng thời gian dùng liều mỗi 8 h/lần) = 0/1-2 µg/mL.

Liều tác dụng hiệp đồng: 120 mg (TM) mỗi 24 h/lần hoặc 2,5 mg/kg (TM) mỗi 24 h/lần.

Liều tiêm vào khoang nội tủy sống: 5 mg (IT) mỗi 24 h/lần.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Màng não không bị viêm = 0%

Viêm màng não= 20%

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Khả năng thấm vào mật: 30% (*Xem thêm phần Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh, trang 514*).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Begg EJ, Barclay ML. Aminoglycosides - 50 years on. Br J Clin Pharmacol 39: 597–603, 1995.

Buijk SE Mouton JW, Gyssens IC, et al. Experience with a once-daily dosing program of aminoglycosides in critically ill patients. Intensive Care Med 28: 936–42, 2002.

Cheer SM, Waugh J, Noble S. Inhaled tobramycin (TOBI): a review of its use in the management of Pseudomonas aeruginosa infections in patients with cystic fibrosis. Drugs 63: 2501–20, 2003.

Cunha BA. Aminoglycosides: Current role in antimicrobial therapy. Pharmacotherapy 8: 334–50, 1988.

Dupuis LL, Sung L, Taylor T, et al. Tobramycin pharmacokinetics in children with febrile neutropenia undergoing stem cell transplantation once-daily versus thrice-daily administration. Pharmacotherapy 24: 564–73, 2004.

Edson RS, Terrel CL. The aminoglycosides. Mayo Clin Proc 74: 519–28, 1999.

Geller DE, Pistlick WH, Nardella PA, et al. Pharmacokinetics and bioavailability of aerosolized tobramycin in cystic fibrosis. Chest 122: 219–26, 2002.

Gilbert DN. Once-daily aminoglycoside therapy. Antimicrob Agents Chemother 35: 399–405, 1991.

Hustinx WN, Hoepelman IM. Aminoglycoside dosage regimens: Is once a day enough? Clin Pharmacokinet 25: 427–32, 1993.

Kahler DA, Schowengerdt KO, Fricker FJ, et al. Toxic serum trough concentrations after administration of nebulized tobramycin. Pharmacotherapy 23: 543–5, 2003.

Lortholary O, Tod M, Cohen Y, et al. Aminoglycosides. Med Clin North Am 79: 761–87, 1995.

Website: www.pdr.net

Trimethoprim (Proloprim, Trimpex) TMP

Nhóm thuốc: Thuốc đối kháng folat (Folate antagonist).

Liều thường dùng: 100 mg (uống) mỗi 12 h/lần (*Xem Bình luận*).

Phổ tác dụng: *(Xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 186 – 190).*

Nguy cơ bị đề kháng: Cao (Phế cầu, *E. Coli*).

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 2 – 8 µg/mL.

Sinh khả dụng: 98%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 67%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 8/24 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 44%

Thể tích phân bố (V_d) : 1,8 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl 10–30 mL/phút	50 mg (uống) mỗi 12 h/lần
CrCl < 10 mL/phút	Tránh dùng (trừ để điều trị viêm phổi do P. jirovec, xem TMP – SMX)
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Tránh dùng (trừ để điều trị viêm phổi do P. jiroveci, xem TMP – SMX)

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Liều dùng sau lọc màng bụng	100 mg (uống)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	50 mg (uống) mỗi 12 h/lần
Suy gan vừa hoặc nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Azathioprin (giảm bạch cầu); amantadin, dapson, digoxin, methotrexat, phenytoin, rifampin, zidovudin (↑ nồng độ thuốc tương tác, rung giật nhãn cầu với phenytoin); các thuốc lợi tiểu (↑ K^+ máu với thuốc lợi tiểu giữ K^+, giảm Na^+ với thuốc lợi tiểu thiazid; warfarin (↑ INR, chảy máu).

Phản ứng bất lợi: Thiếu hụt Folat, tăng kali máu.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Hiệu quả cho các bệnh nhân dị ứng với sulfa không thể sử dụng TMP–SMX.

Liều điều trị viêm phổi do *P.jiroveci* (PCP): 5 mg/kg (uống) mỗi 8 h/lần phối hợp với dapson 100 mg (uống) mỗi 24 h/lần.

Liều cho màng não: 5 mg/kg hoặc 300 mg (uống) mỗi 6 h/lần.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: 40 %

Khả năng thấm vào mật: 100%. *(Xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 515).*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Brogden RN, Carmine AA, Heel RC, et al. Trimethoprim: A review of its antibacterial activity, pharmacokinetics and therapeutic use in urinary tract infections. Drugs 23: 405–30, 1982.

Friesen WT, Hekster YA, Vree TB. Trimethoprim: clinical use and pharmacokinetics. Drug Intelligence & Clinical Pharmacy 15: 325–30, 1981.

Neu HC. Trimethoprim alone for treatment of urinary tract infection. Rev Infect Dis 4: 366–71, 1982.

Website: www.pdr.net

Trimethoprim - Sulfamethoxazole (Bactrim, Septra) TMP - SMX

Nhóm thuốc: Thuốc đối kháng folat/ sulfonamid.

Liều thường dùng: 2,5-5 mg/kg (TM/ Uống) mỗi 6 h/lần.

Phổ tác dụng: *(Xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 186 – 190).*

Nguy cơ bị đề kháng: Cao (Phế cầu [*S.pneumoniae*], *E. Coli).*

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 2 – 8/40–80 µg/mL.

Sinh khả dụng: 98%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 67/85%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/bệnh thận giai đoạn cuối): (10/8)/40–80 giờ.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Liên kết với protein huyết tương: 44–70%

Thể tích phân bố (V_d) : 1,8/0,3 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl 15– 30 mL/ phút	1,25–2,5 mg/kg (TM/ Uống) mỗi 6 h/lần
CrCl < 15 mL/ phút	Tránh dùng (trừ khi để điều trị viêm phổi do P. jiroveci dùng 1,25–2,5 mg/kg (TM/Uống) mỗi 8 h/lần)
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	2,5 mg/kg (TM/Uống)
Liều dùng sau lọc màng bụng	0,16 mg/kg (TM/Uống)
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	2,5 mg/kg (TM/Uống) mỗi 6 h/lần
Suy gan vừa hoặc nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: *Thành phần TMP*: Azathioprin (giảm bạch cầu); amantadin, dapson, digoxin, methotrexat, phenytoin, rifampin, zidovudin (↑ nồng độ thuốc tương tác, rung giật nhãn cầu với phenytoin); các thuốc lợi niệu (↑ K^+ máu với thuốc lợi niệu giữ K^+, giảm Na^+ với thuốc lợi tiểu thiazid); warfarin (↑ INR, chảy máu).

Thành phần SMX: Cyclosporin (↓ nồng độ cyclosporin); phenytoin (↑ nồng độ phenytoin, rung giật nhãn cầu, rối loạn phối hợp động tác); methotrexat (↑ hoạt tính kháng folat); sulfonylurea, thiopental (↑ nồng độ thuốc tương tác); warfarin (↑ INR, chảy máu xuất).

Phản ứng bất lợi: Nguyên nhân thường gặp của viêm màng não vô khuẩn do thuốc gây ra.

TMP: Thiếu hụt folat, tăng kali máu.

SMX: Giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu, thiếu máu do tan máu ± thiếu hụt enzym G6PD, thiếu máu do giảm sinh tủy, ↑ SGOT/SGPT, các phản ứng quá mẫn nặng (hồng ban đa dạng/ hội chứng Stevens – Johnson), ↑ nguy cơ bị hạ đường huyết trong suy thận mãn.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Rất cao (SMX); không có (TMP).

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Sốt/nổi ban do thuốc tăng lên ở bệnh nhân HIV/AIDS. Sinh khả dụng rất tốt (đường tĩnh mạch = đường uống).

TMP–SMX dùng đường tĩnh mạch và **đường uống với liều tương đương**:

TMP–SMX (thành phần TMP) **10 mg/ kg (TM) mỗi 24 h/lần** (cho bệnh nhân nặng 70 kg) = 2 viên loại SS† (uống) mỗi 6 h/lần ***hoặc***

=1 viên loại DS†† (uống) mỗi 6h/lần

TMP–SMX (thành phần TMP) **20 mg/ kg (TM) mỗi 24 h/lần (cho bệnh nhân nặng 70 kg)** = 4 viên SS (uống) mỗi 6 giờ ***hoặc***

= 2 viên loại DS (uống) mỗi 6 h/lần

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

† *1 viên loại SS = 80 mg TMP + 400 mg SMX*

†† *1 viên loại DS= 160 mg TMP + 800 mg SMX*

Đối với bệnh nhân dị ứng với sulfa, sử dụng TMP (SMX là thành phần gây dị ứng) do hoạt chất này có hiệu quả tương đương với TMP – SMX.

Liều cho màng não: 5 mg/kg (TM/Uống) mỗi 6 h/lần.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Màng não không bị viêm = 40 %

Màng não bị viêm = 40 %

Khả năng thấm vào mật: 100%. *(Xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 515).*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cockerill FR, Edson RS. Trimethoprim-sulfamethoxazole. Mayo Clin Proc 66: 1260–9, 1991.

Cunha BA. Oral antibiotic therapy of serious systemic infections. Med Clin N Am 90: 1197–1222, 2006.

Euga G, Murillo O, Fernandez-Sabe N, et al. Treatment of chronic staphylococcal osteomyelitis: intravenous or oral? how long? Antimicrob Agents Chemother 53: 2672–2676, 2009.

Francis P , Patel VB , Bill PL , et al. Oral trimethoprimsulfamethoxazole in the treatment of cerebral toxoplasmosis in AIDS patients-a prospective study. S Afr Med J 94: 51–3, 2004.

Giannakopoulos G Johnson ES. TMP–SMX. Antibiotics for Clinicians 1: 63–9, 1997.

Hooton TM , Besser R , Foxman B , et al. Acute uncomplicated cystitis in an era of increasing antibiotic resistance: a proposed approach to empirical therapy. Clin Infect Dis 39: 75–80, 2004.

Lundstrom TS , Sobel JD. Vancomycin, trimethoprimsulfamethoxazole, and rifampin. Infect Dis Clin North Am 9: 747–67, 1995.

Masters PA, O'Bryan TA, Zurlo JM , et al. Trimethoprimsulfamethoxazole revisited. Arch Intern Med 163: 402–10, 2003.

Miller LG , Tang AW. Treatment of uncomplicated urinary tract infections in an era of increasing antimicrobial resistance. Mayo Clin Proc 79: 1048–53, 2004.

Website: www.pdr.net

Valacyclovir (Valtrex)

Nhóm thuốc: Thuốc kháng virus HSV, VZV *(Xem Bình luận).*

Liều thường dùng:

HSV-1/2: *Nhiễm Herpes vùng môi*: 2 g (uống) mỗi 12 h/lần x 1 ngày. *Herpes sinh dục: Điều trị khởi đầu*: 1 g (uống) mỗi 12 h/lần x 3 ngày. Điều trị tái phát/ngắt quãng (< 6 đợt/năm): Đối tượng là người bình thường: 500 mg (uống) mỗi 24 h/lần x 5 ngày; HIV (+) : 1 g (uống) mỗi 12 h/lần x 7–10 ngày. Điều trị ức chế mạn tính *(Chronic suppressive therapy)* (> 6 đợt/năm): Đối tượng là người bình thường: 1 g (uống) mỗi 24 h/lần x 1 năm; HIV (+): 500 mg (uống) mỗi 12 h/lần x 1 năm. *Viêm phổi liên quan tới thở máy khởi phát muộn do HSV-1*: 1 g (uống) mỗi 8 h/lần x 10 ngày. *Viêm màng não/viêm não*: 2 g (uống) mỗi 6 h/lần x 10 ngày.

VZV: *Thủy đậu*: 1 g (uống) mỗi 8 giờ x

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

5 ngày. *Viêm phổi do VZV*: 1–2 g (uống) mỗi 8 giờ x 10 ngày. *Herpes zoster (thủy đậu) (dermatomal/disseminated)*:1 g (uống) mỗi 8 h/lần x 7–10 ngày.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 3,7– 5 µg/mL.

Sinh khả dụng: 55%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 1%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 3/14 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 15%

Thể tích phân bố (V_d): 0,7 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều * (trên cơ sở dùng liều 1 g mỗi 8 h/lần)

CrCl 30-50 mL/phút	1 g (uống) mỗi 12 h/lần
CrCl 10 – 30 mL/ phút	1 g (uống) mỗi 24 h/lần
CrCl < 10 mL/phút	500 mg (uống) mỗi 24 h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	1 g (uống)
Liều dùng sau lọc màng bụng	500 mg
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	500 mg (uống) mỗi 24 h/lần
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Cimetidin, probenecid (↑ nồng độ acyclovir).

Phản ứng bất lợi: Đau đầu, buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng, yếu cơ. Hiếm gặp, hội chứng tan máu tăng urê huyết (HUS)/ ban xuất huyết giảm tiểu cầu tắc mạch (TTP) (chỉ gặp ở bệnh nhân HIV).

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: B

Bình luận: Được chuyển đổi thành acyclovir ở gan.

Thuốc có hoạt tính cao đối với HSV>VZV. Thuốc có hoạt tính nhất định đối với CMV. Không có hoạt tính đối với EBV, virus hợp bào hô hấp (RSV) và các adenovirus.

VZV IC_{90} (trung bình) ~ 2 x HSV

Liều cho màng não= HSV 1g (uống) mỗi 8 h/lần.

VZV (uống) 2g mỗi 6 h/lần.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: 50%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Acost EP, Fletcher CV. Valacyclovir. Ann Pharmacotherapy 31: 185–91, 1997.

Jacobsen T, Sipointis N. Drug interactions and toxicities associated with the antiviral management of cytomegalovirus infection. Am J Health Syst Pharm 67: 1417–1425, 2010.

Kotton CN, Kumar D, Caliendo AM, et al. International consensus guidelines on the management of cytomegalovirus in solid organ transplantation. Transplantation 89: 779–795, 2010.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Pouplin T, Pouplin JN ,Van Toi P,et al. valacyclovir for Herpes simplex encephalitis. Antimicrob Agents Chemother 55: 3624-3626,2011

Vigil KJ, ChemalyRF. Valacyclovir: approved and off-label uses for the treatment of herpes virus infections in immunocompetent and immunocompromised adults. Expert Opin Pharmacother 11: 1901–1913, 2010.

Website: www.valtrex.com

Valganciclovir (Valcyte)

Nhóm thuốc: Thuốc kháng virus CMV, HSV, HHV-6 (*Xem Bình luận*)

Liều thường dùng: **Liều dẫn**: 900 mg (uống) mỗi 12 h/lần x 21 ngày, sau đó **Liều duy trì**: 900 mg (uống) mỗi 24 h/lần (đối với người bình thường; tới khi chữa khỏi virus; Đối tượng bị suy giảm miễn dịch: điều trị ức chế kéo dài). Liều 900 mg được dùng với 2 viên nén hàm lượng 450 mg x 1 lần/ngày vào bữa ăn.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 5,6 µg/mL.

Sinh khả dụng: 59,4%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 90%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 4,1/67,5 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 1%

Thể tích phân bố (V_d) : 15,3 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl 40–60 mL/ phút	450 mg (uống) mỗi 12 h/lần (liều dẫn), sau đó 450 mg (uống) mỗi 24 h/lần (liều duy trì)
CrCl 25– 40 mL/ phút	450 mg (uống) mỗi 24 h/lần (liều dẫn), sau đó 450 mg (uống) mỗi 48 h/lần (liều duy trì)
CrCl 10– 25 mL/ phút	450 mg (uống) mỗi 48 h/lần (liều dẫn), sau đó 450 mg (uống) x 2 lần /tuần (liều duy trì)
CrCl < 10 mL/phút	Tránh dùng
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Tránh dùng
Liều dùng sau lọc màng bụng	Sử dụng cùng liều như khi CrCl 25 – 40 mL/phút
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	Sử dụng cùng liều như khi CrCl 25 – 40 mL/phút
Suy gan nhẹ tới vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Sử dụng thận trọng

Tương tác thuốc: Thuốc gây độc tế bào (có thể gây độc tính thêm: viêm miệng, ức chế tủy xương, rụng tóc); imipenem (↑ nguy cơ co giật); probenecid (↑ nồng độ valganciclovir); zidovudin (↓ nồng độ valganciclovir, ↑ nồng độ zidovudin, có thể gây giảm bạch cầu trung tính); didanosin (↑ didanosin); cyclosporin, amphotericin (↑ độc tính với thận); mycophenolat mofetil (↑ nồng độ của mycophenolat mofetil và ganciclovir trong suy thận); tenofovir (↑ nồng độ tenofovir, ganciclovir).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Phản ứng bất lợi: Sốt/nổi ban da do thuốc, tiêu chảy, buồn nôn, nôn, khó chịu trên đường tiêu hóa, giảm bạch cầu, thiếu máu, giảm số lượng tiểu cầu, dị cảm/bệnh lý thần kinh ngoại vi, bong võng mạc, thiếu máu bất sản.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Diện tích dưới đường cong (AUC) khi dùng valganciclovir rộng hơn so với khi dùng ganciclovir đường tĩnh mạch. Phải uống viên thuốc vào bữa ăn. Valganciclovir được thủy phân nhanh thành ganciclovir. Không thể dùng thay thế từ dạng viên sang dạng viên đối với ganciclovir dùng đường uống. Sinh khả dụng cao hơn nhiều so với ganciclovir dạng viên nhộng; nồng độ thuốc trong huyết thanh tương đương với ganciclovir dùng đường tĩnh mạch. Được chỉ định để điều trị liều dẫn/ duy trì cho nhiễm khuẩn do CMV. Được ưa dùng hơn ganciclovir cho tất cả các chỉ định ngoại trừ để dự phòng CMV trong ghép gan. **Thuốc có hoạt tính cao đối với CMV, HHV-6 và HSV. Có hoạt tính nhất định đối với VZV, EBV và adenovirus. Không có hoạt tính đối với virus hợp bào hô hấp (RSV).**

Liều cho màng não = liều thường dùng.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: 70%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Avery RK. Low-dose valganciclovir for cytomegalovirus phylaxis in organ transplantation: is less really more? Clin Infect Dis 52: 322-324, 2011.

Asberg A, Rollag H, Hartmann A. Valganciclovir for the prevention and treatment of CMV in solid organ transplant recipients. Expert Opin Pharmacother 11: 1159–1166, 2010.

Boillat Blanco N, Pascual M, Venetz JP, et al. Impact of preemptive strategy after 3 months of valganciclovir cytomegalovirus prophylaxis in kidney transplant recipients. Transplantation 91: 251–255, 2011.

Czock D, Scholle C, Rasche FM, et al. Pharmacokinetics of valganciclovir and ganciclovir in renal impairment. Clin Pharmacol Ther 72: 142–50, 2002.

Humar A, Limaye AP, Blumberg EA, et al. Extended valganciclovir prophylaxis in D+/R- kidney transplant recipients is associated with long-term reduction in cytomegalovirus disease: two-year results of the IMPACT study. Transplantation 90: 1427-1431, 2010.

Jacobsen T, Sipointis N. Drug interactions and toxicities associated with the antiviral management of cytomegalovirus infection. Am J Health Syst Pharm 67: 1417–1425, 2010.

Kalil AC, Midru C, Florescu DF. Effectiveness of valganciclovir 900 mg versus 450 mg forcytomegalovirus prophylaxis in transplantation: direct and indirect treatment comparison meta-analysis. Clin Infect Dis 52: 313-321, 2011.

Kotton CN, Kumar D, Caliendo AM, et al. International consensus guidelines on the management of cytomegalovirus in solid organ transplantation. Transplantation 89: 779–795, 2010.

Lopau K, Greser A, Wanner C. Efficacy and safety of preemptive anti-CMV therapy with valganciclovir after kidney transplantation. Clin Transplant 21: 80–85, 2007.

Luan, FL, Kommareddi M, Ojo AO. Impact of cytomegalovirus disease in D+/R- kidney transplant patients receiving 6 months low-dose valganciclovir prophylaxis. Am J Transplant 11: 1936-1942, 2011.

Razonable RR, Paya CV. Valganciclovir for the prevention and treatment of cytomegalovirus disease in immunocompromised hosts. Expert Rev Anti Infect Ther 2: 27–41, 2004.

Website: www.rocheusa.com/products/

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Vancomycin (Vancocin)

Nhóm thuốc: glycopeptid.

Liều thường dùng: 1 g (TM) mỗi 12 h/lần (*xem Bình luận*).

Phổ tác dụng: *(Xem Các đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trang 332-335).*

Nguy cơ bị đề kháng: Thấp (tụ cầu vàng nhạy với methicillin [MSSA], tụ cầu vàng kháng methicillin [MRSA], cầu khuẩn ruột nhạy với vancomycin [VSE]; ↑ tần suất hiện mắc cầu khuẩn ruột kháng vancomycin [VRE]).

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 63 µg/mL.

Sinh khả dụng: Đường tĩnh mạch (không được áp dụng)/đường uống (0%).

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 90%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/bệnh thận giai đoạn cuối): 6/180 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 55%

Thể tích phân bố (V_d): 0,7 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Điều chỉnh liều*

CrCl 50 – 80 mL/phút	1 g (TM) mỗi 12 h/lần
CrCl 10 – 50 mL/phút	1 g (TM) mỗi 24 h/lần
CrCl < 10 mL/phút	1 g (TM) hàng tuần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không dùng
Liều dùng khi HFHD	500 mg (TM)
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không dùng
Liều dùng khi CVVH/CVVHD/ CVVHDF	1 g (TM) mỗi 24 h/lần
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: aminoglycosid, amphotericin B, polymyxin B (↑ độc tính cho thận).

Phản ứng bất lợi: "hội chứng người đỏ (Red man)/neck syndrome" khi truyền nhanh thuốc tĩnh mạch (qua phản ứng trung gian histamin), giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu, ngừng tim, tụt huyết áp.

Dược Duy Dũng GROUP DỮ LIỆU Y HỌC 0978.336.075

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: không gây độc cho thận. "hội chứng người đỏ/neck syndrome" có thể được dự phòng/hạn chế bằng cách truyền vancomycin tĩnh mạch chậm trong vòng 1 – 2 giờ. Hấp thu qua màng bụng = 40%. **Sử dụng vancomycin đường tĩnh mạch làm tăng tần suất mắc cầu khuẩn ruột kháng vancomycin (VRE). Liều điều trị la chảy do *C.difficile***: Vancomycin 250 mg (uống) mỗi 6 h/lần. Nếu không có đáp ứng sau 72 giờ ↑ liều lên 500 mg (uống) mỗi 6 h/lần đến khi hoàn chỉnh

liệu trình điều trị. **Liều điều trị ỉa chảy do *C.difficile*** tái phát: 500 mg (uống) mỗi 6 h/lần x 1 tháng và đánh giá lại. Nếu sau đó *C.difficile* tái phát, điều trị x 2 hoặc 3 tháng với liều 500 mg (uống) mỗi 6 h/lần. **Không giảm liều**. Vancomycin dùng đường uống thường không có hiệu quả trong điều trị viêm đại tràng do *C.difficile*. Vancomycin không thấm tốt vào dịch não-tủy nếu màng não không bị viêm. Để đạt nồng độ điều trị trong dịch não-tủy, dùng vancomycin đường tĩnh mạch cộng với vancomycin đường nội tủy sống.

Nồng độ thuốc trong huyết thanh có tác dụng điều trị (có hiệu quả điều trị, không gây độc):

Nồng độ đỉnh = 25 – 40 µg/mL

Nồng độ đáy = 5 – 12 µg/mL

Không có các dữ liệu đủ sức thuyết phục cho thấy vancomycin là một chất gây độc tính cho tai hoặc thận. CrCl mà không phải là nồng độ creatinin huyết thanh, được sử dụng để điều chỉnh liều vancomycin. Dùng vancomycin liều cao/kéo dài (60 mg/kg/ngày hoặc 2 g đường tĩnh mạch mỗi 12 h/lần) đã được sử dụng để điều trị viêm xương tủy do tụ cầu vàng, nhiễm khuẩn tụ cầu vàng với nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) cao (*S. aureus* nhạy cảm trung gian với Vancomycin) và các nhiễm khuẩn ở các mô thuốc khó thâm nhập song không gây độc tính. Ở xương hoặc dịch não-tủy, nồng độ vancomycin trong mô khoảng 15% nồng độ trong huyết thanh.

Liều tiêm nội tủy sống (intrathecal): 20 mg (tiêm vào ngoài màng cứng) không có NaCl trong chất bảo quản.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy:

Màng não không bị viêm = 0%

Viêm màng não = 15%

Khả năng thấm vào mật: 50% (*Xem thêm Chương Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp liên quan với sử dụng kháng sinh trang 515*)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Ajao AO, Harris AD, Roghmann MC, et al. Systematic review of measurement and adjustment for colonization pressure in studies of methicillin-resistant Staphylococcus aureus, vancomycin-resistant enterococci, and clostridium difficile acquisition. Infect Control Hosp Epidemiol 32: 481-489, 2011.

Black E, Lau TT, Ensom MH. Vancomycin-induced neutropenia: is it dose- or duration-related? Ann Pharmacother 45: 629-638, 2011.

Bhavnani SM, Prakhya A, Hammel JP, et al. CostEffectiveness of daptomycin versus vancomycin and gentamicin for patients with methicillinresistant Staphylococcus aureus bacteremia and/or endocarditis. Clin Infect Dis 49: 691–698, 2009.

Bouza E. New therapeutic choices for infections caused by methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Clin Microbiol Infect Dis 15: 44–52, 2009.

Cantu TG, Yamanaka-Yuen NA, Lietman PS. Serum vancomycin concentrations: Reappraisal of their clinical value. Clin Infect Dis 18: 533–43, 1994.

Cosgrove SE, Carroll KC, Perl TM. Staphylococcus aureus with reduced susceptibility to vancomycin. Clin Infect Dis 39: 539–45, 2004.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Cruciani M, Gatti G, Lazzarini L, et al. Penetration of vancomycin into human lung tissue. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 38: 865–69, 1996.

Cunha BA, Mohan SS, Hamid N, McDermott GP, Daniels P. Cost ineffectiveness of serum vancomycin levels. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 13: 509–511, 2007.

Cunha BA. Vancomycin revisisted: a reappraisal of clinical use. Critical Care Clinics of North America 24: 394–420, 2008.

Cunha BA. Vancomycin. Med Clin North Am 79: 817–31, 1995.

Cunha BA. Vancomycin serum levels: unnecessary, unhelpful, and costly. Antibiotics for Clinicians 8: 273–77, 2004.

Cunha BA, Deglin J, Chow M, et al. Pharmacokinetics of vancomycin in patients undergoing chronic hemodialysis. Rev Infect Dis 3: 269–72, 1981.

DelDot ME, Lipman J, Tett SE. Vancomycin pharmacokinetics in critically ill patients receiving continuous venovenous haemodiafiltration. Br J Clin Pharmacol 58: 259–68, 2004.

del Mar Fernandez de Gatta Garcia, Revilla N, Calvo MV, et al. Pharmacokinetic/ pharmacodynamic analysis of vancomycin in ICU patient. Intensive Care Med 33: 279–285, 2007.

Deresinski S. Vancomycin: does it still have a role as an antistaphylococcal agent? Expert Rev Anti Infect Ther 5: 393–401, 2007.

El Amari EB, Vuagnat A, Stern R, et al. High versus standard dose vancomycin for osteomyelitis. Scand J Infect Dis 36: 712–7, 2004.

Hidayat LK, Hsu DI, Quist R, et al. High-dose vancomycin therapy for methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections. Arch Inter Med 166: 2138–44, 2006.

Huttner A, Harbarth S: Guidelines for vancomycin use. Clin Infect Dis 50: 616, 2010.

Johnson JR Vancomycin levels, effi cacy, and toxicity. Arch Intern Med 167: 1207–1209, 2007.

Leonard SN, Szeto YG, Zolotarev M, et al. Comparative in vitro activity of telavancin, vancomycin, and linezolid against heterogeneously vancomycinintermediate Staphylococcus aureus (hVISA). Int J Antimicrob 37: 558-561, 2011.

Menzies D. Goel K, Cunha BA. Vancomycin. Antibiotics for Clinicians 2: 97–9, 1998.

Moellering RC Jr. Monitoring serum vancomycin levels: climbing the mountain because it is there? Clin Infect Dis 18: 544–6, 1994.

Okamoto H. Vancomycin-induced immune thrombocytopenia. N Engl J Med 356: 2537–2538, 2007.

Patanwala AE, Erstad BL, Nix DE. Cost-effectiveness of linezolid and vancomycin in the treatment of surgical site infections. Curr Med Res Opin 23: 185–193, 2007.

Patel N, Lubanski P, Ferro S, et al. Correlation between vancomycin MIC values and those of other agents against gram-positive bacteria among patients with bloodstream infections caused by methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Antimicrob Agents Chemother 53: 5141–5144, 2009.

Pope SD, Roecker A. Vancomycin for treatment of invasive, multi-drug resistant Staphylococcus aureus infections. Exp Opin Pharmacother 8: 1245–1261, 2007.

Ricard JD, Wolff M, Lacerade JC, et al. Levels of vancomycin in cerebrospinal fl uid of adult patients receiving adjunctive corticosteroids to treat pneumococcal meningitis: a prospective multicenter observational study. Clin Infect Dis 44: 250–255, 2007.

Rybak MJ. The pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of vancomycin. Clin Infect Dis 42: S35–9, 2006.

Rybak MJ, Lomaestro BM, Rotschafer JC, et al. Vancomycin therapeutic guidelines: a summary of consensus recommendations from the Infectious diseases Society of America, the American Society of Health-System Pharmacists, and the Society of Infections Diseases Pharmacists. Clin Infect Dis 49: 325–327, 2009.

Saribas S, Bagdatli Y. Vancomycin tolerance in enterococci. Chemotherapy 50: 250–4, 2004.

Website: www.pdr.net

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Voriconazole (Vfend)

Nhóm thuốc: Thuốc điều trị nấm nhóm triazol

Liều thường dùng: *Liều dùng đường tĩnh mạch*: **liều nạp**: 6 mg/kg (TM) mỗi 12 h/lần x 1 ngày, sau đó dùng **Liều duy trì**: 4 mg/kg (TM) mỗi 12 h/lần. Có thể chuyển sang dùng liều duy trì theo đường uống tính theo cân nặng bất kỳ lúc nào trong quá trình dùng liều duy trì đường tĩnh mạch (*Xem Bình luận*).

Liều dùng đường uống: Cân nặng ≥ 40 kg: Liều nạp 400 mg (uống) mỗi 12 h/lần x 1 ngày, sau đó dùng Liều duy trì 200 mg (uống) mỗi 12 h/lần. Nếu đáp ứng không thỏa đáng, có thể tăng liều lên 300 mg (uống) mỗi 12 h/lần. Cân nặng < 40 kg: Liều nạp là 200 mg (uống) x 1 ngày, sau đó dùng Liều duy trì 100 mg (uống) mỗi 12 h/lần. Nếu đáp ứng không thỏa đáng, có thể tăng liều lên 150 mg (uống) mỗi 12 h/lần. Đối với các nhiễm khuẩn mạn tính/không đe dọa tính mạng, có thể dùng liều nạp theo đường uống (*Xem Bình luận*).

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 2,3 – 4,7 µg/mL.

Sinh khả dụng: 96%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 2%.

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/bệnh thận giai đoạn cuối): 6/6 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 58%

Thể tích phân bố (V_d): 4,6 L/kg.

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều*

CrCl 50 – 80 mL/phút	Không thay đổi
CrCl 10 – 50 mL/phút	Liều theo đường uống không thay đổi, không dùng đường tĩnh mạch
CrCl < 10 mL/phút	Liều theo đường uống không thay đổi, không dùng đường tĩnh mạch
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Dùng liều thường dùng theo đường uống, không dùng đường tĩnh mạch
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không có thông tin
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	4 mg/kg (uống) mỗi 12 h/lần, không dùng đường tĩnh mạch
Suy gan nhẹ đến vừa	6 mg/kg (TM) mỗi 12 h/lần x 1 ngày hoặc 200 mg (uống) mỗi 12 h/lần x 1 ngày, sau đó 2 mg/kg (TM) mỗi 12 h/lần hoặc 100 mg (uống) mỗi 12 h/lần (> 40 kg)
Suy gan nặng	Thận trọng khi dùng thuốc

Tương tác thuốc: Benzodiazepin, các alkaloid của cây dừa cạn (↑ nồng độ thuốc tương tác); carbamazepin, alkaloids của ergot, rifampin, rifabutin, sirolimus, barbiturat tác dụng kéo dài (bị chống chỉ định với voriconazol); cyclosporin (↓ liều cyclosporin xuống 50% và cần theo dõi khi dùng

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

thuốc); efavirenz (↑ liều duy trì của voriconazol lên 400 mg (uống) mỗi 12 h/lần và giảm liều efavirenz xuống 300 mg (uống) mỗi 12 h/lần trong khi đang dùng voriconazol), omeprazol (↑ nồng độ thuốc tương tác, ↓liều thuốc tương tác đi 50%), tacrolimus (↑ nồng độ tacrolimus, ↓ liều tacrolimus xuống 66%); phenytoin (↓ nồng độ voriconazol); ↑ liều voriconazol từ 4 mg/kg (TM) lên 5 mg/kg (TM) và từ 200 mg (uống) lên 400 mg (uống); warfarin (↑ INR); statin (↑ nguy cơ bị tiêu cơ vân); thuốc chẹn kênh canxi nhóm dihydropyridin (tụt huyết áp); sulfonylurea (gây hạ đường huyết). Voriconazol còn chưa được nghiên cứu khi dùng phối hợp với các thuốc ức chế protease hoặc thuốc chống retrovirus nhóm ức chế enzym sao chép ngược không phải nucleoside (antiretroviral NNRTIs), song có thể dự kiến sẽ gây ↑ nồng độ voriconazol (↑ độc với gan/tác dụng phụ).

Phản ứng bất lợi: ↑ SGOT/SGPT, rối loạn về thị giác (nhìn mờ, nhìn chói, đau; xảy ra ngay sau khi uống thuốc và thường thuyên giảm nhanh (~ ½ giờ), ảo giác, hạ đường huyết, rối loạn nhịp tim phụ thuộc vào liều, QTc kéo dài; nổi ban da, bao gồm hội chứng Stevens – Johnson; các phản ứng tăng nhạy cảm với ánh sáng (tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời); ung thư tế bào hắc tố (↑ nguy cơ khi điều trị dài ngày).

Nguy cơ dị ứng thuốc: Cao

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: D

Bình luận: Nếu xảy ra tình trạng không dung nạp trong quá trình điều trị, có thể giảm liều duy trì đường tĩnh mạch xuống 3 mg/kg và có thể giảm liều duy trì đường uống từng bước một 50 mg/ngày tới liều tối thiểu là 200 mg/ngày mỗi 12 h/ngày (cân nặng ≥ 40 kg) hoặc 100 mg mỗi 12 h/lần. Động học của thuốc không có dạng tuyến tính (tăng gấp đôi liều đường uống sẽ làm tăng nồng độ thuốc trong huyết thanh lên gấp 2,8). 10–15% bệnh nhân có nồng độ thuốc trong huyết thanh > 6 µg/mL. Thức ăn làm giảm Sinh khả dụng; nên uống thuốc 1 giờ trước hoặc sau bữa ăn. Không nên dùng voriconazol theo đường tĩnh mạch nếu CrCl < 50 mL/phút để tránh gây tích tụ của tá dược (sulphobutyl ether cyclodextrin [SBECD]), thay vào đó nên sử dụng dạng bào chế dùng đường uống (không có SBECD). Có thể dùng liều nạp theo đường uống đối với những nhiễm khuẩn mạn tính/không nguy hiểm đến tính mạng. Do thuốc có các tác động lên thị giác, người đang uống thuốc không nên lái xe hoặc vận hành máy móc. Theo dõi chức năng gan trước và trong quá trình điều trị. Uống thuốc không xa bữa ăn; dạng nhũ dịch chứa sucrose.

Thuốc có hoạt tính cao đối với *C. albicans*, Candida không phải albicans, Aspergillus, Hansenula và Pseudoallescheria/Scedosporium. Thuốc có hoạt tính nhất định đối với Fusaria, *C. albicans* kháng

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

lại fluconazol/intraconazol, Coccidiomycosis và Penicillium marneffei. Không có hoạt tính đối với Rhizopus hay Mucor.

Liều cho màng não = liều thường dùng.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: 90%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Aypar E, Kendirli T, Tutar E, et al. Voriconazole-induced QT interval prolongation and torsades de pointes. Pediatr Int 53: 761-763, 2011.

Bruggemann RJM, Alffenaar JWC, Blijlevens NMA, et al. Clinical relevance of the pharmoacokinetic interactions of azole antifungal drugs with coadministered agents. Clin Infect Dis 48: 1441–1458 , 2009 .

Camuset J, Nunes H, Dombret MC, et al. Treatment of chronic pulmonary aspergillosis by voriconazole in nonimmunocompromised patients. Chest 131: 1435–1441, 2007.

Capitano B, Potoski BA, Husain S, et al. Intrapulmonary penetration of voriconazole in patients receiving an oral prophylactic regimen. Antimicrob Agents Chemother 50: 1878–80, 2006.

Cowen EW, Nguyen JC, Miller DD, et al. Chronic phototoxicity and aggressive squamous cell carcinoma of the skin in children and adults during treatment with voriconazole. J Am Acad Dermatol 62: 31–37, 2010.

den Hollander JG, van Arkel C, Rijnders BJ, et al. Incidence of voriconazole hepatotoxicity during intravenous and oral treatment for invasive fungal infections. J Antimicrob Chemother 57: 1248–50, 2006.

Denes E, Boumediene A, Durox H, et al. Voriconazole concentrations in synovial fluid and bone tissues. J Antimicrob Chemother 59: 818–819, 2007.

Denning DW, Ribaud P, Milpied N, et al. Efficacy and safety of voriconazole in the treatment of acute invasive aspergillosis. Clin Infect Dis 34: 563–71, 2002.

Dickmeyer NJ, Kiel PJ. Dosing voriconazole in an obese patient. Clin Infect Dis 53: 745, 2011.

Dodds Ashley ES, Zaas AK, Fang AF, et al. Comparative pharmacokinetics of voriconazole administered orally as either crushed or whole tablets. Antimicrob Agents Chemother 51: 877–880, 2007.

Dominguez-Gil A, Martin I, Garcia Vargas M, et al. Economic evaluation of voriconazole versus caspofungin for the treatment of aspergillosis in Spain. Clin Drug Investig 27: 197–205, 2007.

Elter T, Sieniawski M, Gossmann A, et al. Voriconazole brain tissue levels in rhinocerebral aspergillosis in a successfully treated young woman. Int J Antimicrob Agents 28: 262–5, 2006.

Herbrecht R, Denning DW, Patterson TF, et al. Voriconazole versus amphotericin B for primary therapy of invasive aspergillosis. N Engl J Med 347: 408–15, 2002.

Ho DY, Lee JD, Rosso F, et al. Treating disseminated fusariosis: amphotericin B, voriconazole or both? Mycoses 50: 227–231, 2007.

Hoffman HL, Rathbun RC. Review of the safety and efficacy of voriconazole. Expert Opin Investig Drugs 11: 409–29, 2002.

Jain LR, Denning DW. The effi cacy and tolerability of voriconazole in the treatment of chronic cavitary pulmonary aspergillosis. J Infect 52: e133–7, 2006.

Jurkunas UV, Langston DP, Colby K. Use of voriconazole in the treatment of fungal keratitis. Int Ophthalmol Clin 47: 47–59, 2007.

Keirns J, Sawamoto T, Holum M, et al. Steady-state pharmacokinetics of micafungin and voriconazole after separate and concomitant dosing in healthy adults. Antimicrob Agents Chemother 51: 787–790, 2007.

Leveque D, Nivoix Y, Jehl F, Herbrecht R. Clinical pharmacokinetics of voriconazole. Int J Antimicrob Agents 27: 274–84, 2006.

Masomoto Y, Nannya Y, Kurokawa M. Voriconazole is effective as secondary

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

antifungal prophylaxis in leukemia patients with prior pulmonary fungal disease: case series and review of literature. J Chemother 23: 17–23, 2011.

Miceli MH, Diaz JA, Lee SA. Emerging opportunistic yeast infections. Lancet Infectious Diseases.11: 142–151, 2011.

Miller DD, Cown EW, Ngugen JC, et al. Melanoma associated with long-term voriconazole therapy: a new manifestation of chronic photosensitivity. Arch Dermatol 146: 300–304, 2010.

Pagano L, Valentini CG, Fianchi L, et al. Treatment strategies for invasive aspergillosis in neutropenic patients: voriconazole or liposomal amphotericin- B J Chemother 23: 5–8, 2011.

Poza G, Montoya J, Redondo C, et al. Meningitis caused by Pseudallescheria boydii treated with voriconazole. Clin Infect Dis 30: 981–2, 2000.

Radaj J, Krouzecky A, Stehlik P, et al. Pharmacokinetic evaluation of voriconazole treatment in critically ill patients undergoing continuous venovenous hemofiltration. Ther Drug Monit 33: 393–397, 2011.

Sambatakou H, Dupont B, Lode H, Denning DW. Voriconazole treatment for subacute invasive and chronic pulmonary aspergillosis. Am J Med 119: 527, 2006.

Schwartz S, Ruhnke M, Ribaud P, et al. Improved outcome in central nervous system aspergillosis, using voriconazole treatment. Amer Soc of Hematology 106: 2641–5, 2006.

Scott LJ; Simpson D. Voriconazole: a review of its use in the management of invasive fungal infections. Drugs 67: 269–98, 2007.

Shehab N, DePestel DD, Mackler ER, et al. Institutional experience with voriconazole compared with liposomal amphotericin B as empiric therapy for febrile neutropenia. Pharmacotherapy 27: 970–979, 2007.

Smith J, Safdar N, Knasinski V, et al. Voriconazole Therapeutic Drug Monitoring. Antimicrob Agents Chemother 50: 1570–72, 2006.

Supparatpinyo K, Schlamm HT. Voriconazole as therapy for systemic Penicillium marneffei infections in AIDS patients. Am J Trop Med Hyg 77: 350–353, 2007.

Tan K, Brayshaw N, Tomaszewski K, et al. Investigation of the potential relationships between plasma voriconazole-concentrations and visual adverse events or liver function test abnormalities. J Clin Pharmacol 46: 235–43, 2006.

Website: www.vfend.com

Zalcitabine (HIVID) ddC

Nhóm thuốc: Thuốc chống retrovirus nhóm ức chế enzym sao chép ngược loại nucleoside (Antiretroviral NRTI [nucleoside reverse transcriptase inhibitor]).

Liều thường dùng: 0,75 mg (uống) mỗi 8 h/lần.

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 0,08 µg/mL.

Sinh khả dụng: 80%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 75%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 2/8,5 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: 0%

Thể tích phân bố (V_d) : 0,54 L/kg.

Đường thải trừ chính: Thận

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Điều chỉnh liều*

CrCl 10 – 50 mL/phút	0,75 mg (uống) mỗi 12 h/lần
CrCl < 10 mL/phút	0,75 mg (uống) mỗi 24 h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo	Không có thông tin
Liều dùng sau lọc màng bụng	Không có thông tin
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	0,75 mg (uống) mỗi 12 h/lần
Suy gan vừa	Không thay đổi
Suy gan nặng	Không thay đổi

Tương tác thuốc: Cimetidin, probenecid, TMP – SMX (↑ nồng độ zalcitabin); dapson, didanosin, stavudin, INH, phenytoin, metronidazol, các chất gây độc cho thần kinh khác hoặc tiền sử có các rối loạn về thần kinh (↑ nguy cơ bị bệnh lý thần kinh ngoại biên); thuốc trung hòa acid dịch vị chứa magiê/nhôm, metoclopramid (↓ Sinh khả dụng của zalcitabin); pentamidin đường tĩnh mạch, acid valproic, rượu hoặc các tác nhân có thể gây viêm tụy khác (↑ nguy cơ viêm tụy).

Phản ứng bất lợi: Sốt/nổi ban do thuốc, giảm bạch cầu, thiếu máu, giảm tiểu cầu, gan to, độc tính với gan/hoại tử gan, bệnh lý thần kinh ngoại biên, viêm tụy, viêm miệng, loét miệng/sinh dục, nuốt khó, viêm khớp, tăng đường huyết, loạn dưỡng mỡ, suy kiệt, nhiễm toan lactic với gan thoái hóa mỡ (ít gặp, nhưng độc tính tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm tính mạng cho bệnh nhân khi dùng thuốc ức chế enzym sao chép ngược nucleosid).

Nguy cơ dị ứng thuốc: Cao

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Foscarnet có thể làm tăng độc tính của thuốc. Không dùng với stavudin, didanosine hoặc lamivudin để tránh làm tăng độc tính. Thức ăn làm giảm 39% hấp thu thuốc. Phác đồ điều trị thuốc chống retrovirus hữu hiệu bao gồm ít nhất 3 thuốc chống retrovirus (cùng/khác nhóm thuốc).

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: 25%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[No authors listed.] Drugs for AIDS and associated infections. Med Lett Drug Ther 35: 79–86, 1993.

[No authors listed.] HIV Trialists' Collaborative Group. Zidovudine, didanosine, and zalcitabine in the treatment of HIV infection: Meta-analyses of the randomised evidence. Lancet 353: 2014–2025, 1999.

Shelton MJ, O'Donnell AM, Morse GD. Zalcitabine. Ann Pharmacotherapy 27: 480–9, 1993.

Skowron G, Bozzette SA, Lim L, et al. Alternating and intermittent regimens of zidovudine and dideoxycytidine in patients with AIDS or AIDS-related complex. Ann Intern Med 118: 321–30, 1993.

Thompson MA, Aberg JA, Cahn P, et al. Antiretroviral treatment of adult HIV infection: 2010 recommendations of the international AIDS society – USA panel. JAMA 304:321–333, 2010.

Website: www.rocheusa.com/products/

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Zidovudine (Retrovir) ZDV Azidothymidine AZT

Nhóm thuốc: Thuốc chống retrovirus nhóm ức chế enzym sao chép ngược loại nucleoside (antiretroviral NRTI [nucleoside reverse transcriptase inhibitor]).

Liều thường dùng: 300 mg (uống) mỗi 12 h/lần hoặc 200 mg (uống) mỗi 8 h/lần (*xem Bình luận*). Dung dịch dùng đường tĩnh mạch 10 mg/mL (liều 1 mg/kg x 5–6 lần/ngày).

Các thông số dược động học:

Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh: 1,2 µg/mL

Sinh khả dụng: 64%

Bài xuất (qua nước tiểu) dưới dạng nguyên vẹn: 16%

Thời gian bán thải thuốc trong huyết thanh (chức năng thận bình thường/ bệnh thận giai đoạn cuối): 1,1/1,4 giờ.

Liên kết với protein huyết tương: < 38%

Thể tích phân bố (V_d) : 1,6 L/kg.

Đường thải trừ chính: Gan

Điều chỉnh liều *

CrCl < 10 mL/ phút	100 mg (uống) mỗi 24 h/lần hoặc 300 mg (uống) mỗi 24 h/lần
Liều dùng sau chạy thận nhân tạo/lọc màng bụng	100 mg hoặc 300 mg
Liều dùng khi CVVH/ CVVHD/ CVVHDF	300 mg (uống) mỗi 24 h/lần
Suy gan vừa đến nặng	Sử dụng thận trọng

Tương tác thuốc: Paracetamol, atovaquon, fluconazol, methadon, probenecid, acid valproic (↑ nồng độ zidovudin); clarithromycin, nelfinavir, rifampin, rifabutin (↓ nồng độ zidovudin); dapson, flucytosin, ganciclovir, interferon alpha, các tác nhân gây ức chế tủy xương/độc tế bào (↑ nguy cơ gây độc đối với máu); indomethacin (↑ nồng độ các chất chuyển hóa có độc tính của zidovudin); phenytoin (↑ nồng độ zidovudin, ↑ hoặc ↓ nồng độ phenytoin); ribavirin (↓ tác dụng của zidovudin; tránh dùng).

Phản ứng bất lợi: zidovudin có thể gây các độc tính trên máu bao gồm giảm bạch cầu trung tính và thiếu máu nặng. Dùng zidovudin kéo dài có thể gây các bệnh cơ có triệu chứng cũng như nhiễm toan lactic và gan to kèm với thoái hóa mỡ (thậm chí gây tử vong) khi dùng thuốc ức chế men sao mã ngược nucleoside. Có thể gây buồn nôn, nôn, khó chịu trên đường tiêu hóa, tiêu chảy, khó ở, chán ăn, giảm bạch cầu, thiếu máu nặng, hồng cầu to, giảm tiểu cầu, đau đầu, mất ngủ, móng tay đổi thành màu xanh/đen và suy nhược. ↑ SGOT/SGPT.

Nguy cơ dị ứng thuốc: Thấp

Độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai: C

Bình luận: Bị ganciclovir hoặc ribavirin đối kháng. Cũng là thành phần của dạng bào chế phối hợp Combivir và Trizivir. Bệnh nhân đang được điều trị bằng đường tĩnh mạch nên được chuyển sang đường uống

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

ngay khi có thể uống được thuốc. Khi điều trị thuốc bằng đường tĩnh mạch, pha thuốc trong dung dịch glucose 5% để có được một nồng độ thuốc không > 4 mg/mL và truyền trong vòng 1 giờ.

Khả năng thấm vào dịch não-tủy: 60%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Barry M, Mulcahy F, Merry C, et al. Pharmacokinetics and potential interactions amongst antiretroviral agents used to treat patients with HIV infection. Clin Pharmacol 36: 289–304, 1999.

Been-Tiktak AM, Boucher CA, Brun-Vezinet F, et al. Efficacy and safety of combination therapy with delavirdine and zidovudine: A European/Australian phase II trial. Intern J Antimcrob Agents 11: 13–21, 1999.

McDowell JA, Lou Y, Symonds WS, et al. Multipledose pharmacokinetics and pharmacodynamics of abacavir alone and in combination with zidovudine in human immunodeficiency virus infected adults. Antimicrob Agents Chemother 44: 2061–7, 2000.

Montaner JS, Reiss P, Cooper D, et al. A randomized, double-blind trial comparing combinations of nevirapine, didanosine, and zidovudine for HIVinfected patients: The INCAS trial. Italy, the Netherlands, Canada and Australia Study. J Am Med Assoc 279: 930–937, 1998.

Mushatt DM, Mihm LB, Dreisbach AW, et al. Antibiotic dosing in slow extended daily dialysis. Clin Infect Dis 49:433–437, 2009.

Piscitelli SC, Gallicano KD. Interactions among drugs for HIV and opportunistic infections. N Engl J Med 344: 984–996, 2001.

TEXTBOOKS

Ambrose P, Nightingale AT (eds). Principles of Pharmacodynamics. Marcel Dekker, Inc., New York, 2001.

Baddour L, Gorbach SL (eds). Therapy of Infectious Diseases. Saunders, Philadelphia, 2003.

Bennet WM, Aronoff GR, Golper TA, Morrison G, Brater DC, Singer I (eds). Drug Prescribing in Renal Failure, 2nd Edition, American College of Physicians, Philadelphia, 2000.

Bowden RA, Ljungman P, Snydman DR (eds). Transplant Infections 3rd Edition, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, PA, 2010.

Bryskier A (ed). Antimicrobial Agents. ASM Press, Washington, D.C., 2005.

Finch RG, Greenwood D, Norrby SR, Whitley RJ (eds). Antibiotic and Chemotherapy. Churchill Livingstone, United Kingdom, 2003.

Gorbach SL, Bartlett JG, Blacklow NR (eds). Infectious Diseases, 4th Edition, Lippincott Williams Wilkins, Philadelphia, 2004.

Grayson ML (ed). Kucers' The Use of Antibiotics, 6th Edition, ASM Press, Washington, DC, 2010.

Koff RS, Hepatitis Essentials. Jones & Bartlett, Sudbury, MA, 2011.

Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds). Mandell, Douglas and Bennett's Principles and Practice of Infectious Disease, 7thEdition. Elsevier, Philadelphia, 2010.

Pai MP, Momary KM, Rodvold KA. Antibiotic Drug Interactions. Med Clin N Am 90:1223–55, 2006.Physicians' Desk Reference, 66th Edition, Thompson PDR, Montvale, NJ, 2012.

Piscitelli SC, Rodvold KE (eds). Drug Interactions in Infectious Diseases. Humana Press, Totowa, 2001.

Ristuccia AM, Cunha BA (eds). Antimicrobial Therapy. Raven Press, New York, 1984.

Sax PE, Cohen CJ, Kuritzkes DR. HIV Essentials. 5th Edition, Jones & Bartlett, Sudbury, MA , 2012.

Schlossberg D (ed). Current Therapy of Infectious Disease, 3rd Edition. Mosby-Yearbook, St. Louis, 2008.

Schlossberg D (ed). Tuberculosis and Non-Tuberculous Mycobacterial Infections, 7th Edition, McGraw-Hill, New York, 2011.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

PHỤ LỤC

Sốt rét ở người lớn (Ở Hoa Kỳ)

Chẩn đoán lâm sàng/ Loài Plasmodium gây bệnh	Vùng bị tác động	Liều điều trị được khuyến cáo dùng cho người lớn
Sốt rét nặng [1,2,3,4]	**Tất cả các vùng tại Hoa Kỳ**	**Quinidin gluconat**[2] **cộng với hoặc: Doxycyclin hoặc Clindamycin** **Quinidin gluconat**: 6,25mg dạng base/kg (=10mg dạng muối/kg) truyền TM trong vòng 1–2 giờ, sau đó dùng liều 0,0125mg dạng base /kg/phút (=0,02 mg dạng muối /kg/phút) truyền TM liên tục trong ít nhất 24 giờ. *Phác đồ điều trị thay thế* là dùng liều nạp 15 mg dạng base/kg (= 24 mg dạng muối /kg) truyền TM trong vòng 4 giờ, được tiếp theo sau đó với liều 7,5 mg dạng base/kg (=12 mg dạng muối /kg) truyền TM trong vòng 4 giờ mỗi 8h/lần, bắt đầu 8 giờ sau khi dùng liều nạp 8 giờ. Khi mật độ kí sinh trùng trong máu còn < 1% và bệnh nhân có thể dùng thuốc bằng đường uống, hoàn thành liệu trình bằng quinin dùng đường uống, với liều như được nêu ở trên. Liệu trình điều trị bằng quinidin/quinin kéo dài 7 ngày ở khu vực Đông Nam Á và kéo dài 3 ngày ở Châu Phi hoặc khu vực Nam Mỹ. **Doxycyclin**: Điều trị như trên, thuốc được dùng với liều 100mg (TM/Uống) mỗi 12h/lần x 7 ngày. **Clindamycin**: Điều trị như trên. Nếu bệnh nhân không thể dùng thuốc bằng đường uống, cho clindamycin với liều 10mg dạng base/kg (TM) sau đó dùng liều 5mg dạng base/kg (TM/Uống) mỗi 8h/lần x 7 ngày.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Sốt rét không có biến chứng/ Do nhiễm *P. falciparum* hoặc không xác định được loài Plasmodium (Nếu "kí sinh trùng sốt rét không xác định được loài" sau đó được xác định là hoặc : Xem phần điều trị đối với và bằng primaquin)	**Kí sinh trùng sốt rét đề kháng với chloroquin hoặc không rõ tình trạng kháng thuốc của kí sinh trùng sốt rét [5]** (Các nước thuộc khu vực Trung đông có bệnh sốt rét do đề kháng với chloroquin gồm: Iran, Oman, Ả Rập Xê Út và Yemen. Cần lưu ý là, cho tới hiện tại, những trường hợp mắc sốt rét thuộc các nước mới được độc lập tách ra từ Liên bang Xô Viết cũ và Hàn Quốc đều chỉ do nhiễm kí sinh trùng sốt rét thuộc loài gây ra, vì vậy nên được điều trị như đối với nhiễm kí sinh trùng sốt rét còn nhạy cảm với chloroquin)	**A. Atovaquon-proguanil (Malarone)[6]** uống 4 viên nén mỗi 24h/lần ×3 ngày. ***hoặc*** **B. Artemether-lumefantrine (Coartem)[6]** Phác đồ điều trị 3 ngày với tổng cộng 6 liều dùng theo đường đường uống được khuyến cáo dựa theo cân nặng của bệnh nhân. Bệnh nhân cần dùng liều khởi, được tiếp theo sau 8 giờ sau đó bằng liều thứ hai 8 giờ, sau đó 1 liều (uống) mỗi 12 h/lần x 2 ngày. ≥ 35 kg: 4 viên nén mỗi liều. ***hoặc*** **C. Quinin sulfat cộng với hoặc Doxycyclin[9] hoặc Clindamycin** **Quinin sulfat[8]**: 542mg dạng base (=650mg dạng muối)[7] mỗi uống 8h/lần x 3 hoặc 7 ngày **Doxycyclin**: 100mg (uống) mỗi 12h/lần x 7 ngày. **Clindamycin**: 20mg dạng base/kg/ngày (uống) mỗi 8h/lần ×7 ngày. ***hoặc*** **D. Mefloquin (*Lariam*)[10]**: Liều đầu là 684mg dạng base (=750 mg dạng muối) (uống), được tiếp theo bằng liều 456mg dạng base (=500mg dạng muối) (uống) dùng 6-12 giờ sau liều khởi đầu. Tổng liều=1250mg dạng muối.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Sốt rét không biến chứng/ Do nhiễm *P. falciparum* hoặc không xác định được loài Plasmodium	**Kí sinh trùng sốt rét còn nhạycảm với chloroquin** (Khu vực Trung Mỹ phía tây kênh đào Panama, Haiti, Cộng Hòa Dominic và hầu hết các nước Trung Đông.)	**Chloroquin phosphat (Aralen)** Liều khởi đầu là 600mg dạng base (=750 mg dạng muối) (uống), được tiếp theo bằng liều 300mg dạng base (=500mg dạng muối) (uống), sau đó uống 300 mg dạng base (500mg dạng muối) tại các thời điểm 6, 24 và 48 giờ sau liều đầu tiên. Tổng liều là 1500 mg dạng base (=2.500mg dạng muối). ***hoặc*** **Hydroxychloroquin (Plaquenil)** Uống ngay 620mg dạng base (=800mg dạng muối), tiếp sau đó với liều 310mg dạng base (=400mg dạng muối) (uống) tại các thời điểm 6, 24 và 48 giờ sau liều khởi đầu. Tổng liều: 1550mg dạng base (=2000mg dạng muối).
Sốt rét không biến chứng/Do nhiễm *P. malariae* hoặc *P. knowlesi*	**Tất cả các vùng tại Hoa Kỳ**	**Chloroquin phosphat**: Điều trị như ở trên ***hoặc*** **Hydroxychloroquin**: Điều trị như ở trên.
Sốt rét không biến chứng/Do nhiễm *P. vivax* hoặc ***P. ovale***	**Tất cả các vùng tại Hoa Kỳ** (Khi nghi ngờ P. vivax đề kháng với chloroquin- xem phần dưới)	**Chloroquin phosphat cộng với Primaquin phosphat[11]:** **Chloroquin phosphat**: Điều trị như trên. **Primaquin phosphat**: 30mg dạng base (uống) mỗi 24 h/lần × 14 ngày ***hoặc*** **Hydroxychloroquin cộng với Primaquin phosphat[11]** **Hydroxychloroquin**: Điều trị như trên. **Primaquin phosphat**: 30mg dạng base (uống) mỗi 24 h/lần ×14 ngày.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Sốt rét không biến chứng/*P. vivax*	**Kí sinh trùng đề kháng với chloroquin[12]** (Papua Tân Guinea và Indonesia)	**A. Quinin sulfat cộng với hoặc Doxycyclin cộng với Primaquin phosphat[11]** **Quinin sulfat:** Điều trị như trên. **Doxycyclin:** Điều trị như trên **Primaquin phosphat:** Điều trị như trên ***hoặc*** **B. Atovaquone-proguanil cộng với Primaquin phosphat** **Atovaquone-proguanil:** Điều trị như trên. **Primaquin phosphat:** Điều trị như trên. ***hoặc*** **C. Mefloquine[10] cộng với Primaquin phosphat[11]** **Mefloquin:** Điều trị như trên **Primaquin phosphat:** Điều trị như trên
Sốt rét không biến chứng: Phác đồ điều trị thay thế ở phụ nữ có thai[13,14,15,16]	**Kí sinh trùng nhạy cảm với Chloroquin** (Xem mục sốt rét không biến chứng ở trên đối với các loại Plasmodium nhậy cảm với chloroquin theo khu vực)	**Chloroquin phosphat:** Điều trị như trên. ***hoặc*** **Hydroxychloroquin:** Điều trị như trên
	***P. falciparum*[1] đề kháng với Chloroquin:** (Xem mục sốt rét không biến chứng ở các vùng có đề kháng với chloroquin)	**Quinin sulfat cộng với Clindamycin:** **Quinin sulfat:** Điều trị như trên **Clindamycin:** Điều trị như trên
	***P. vivax* đề kháng với Chloroquin** (Xem phần sốt rét không biến chứng ở các vùng có đề kháng với chloroquin)	**Quinin sulfat** **Quinin sulfat[7]:** 650mg dạng muối (uống) mỗi 8h/lần × 7 ngày.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

1. Những đối tượng có kết quả giọt máu đàn dương tính với kí sinh trùng sốt rét hoặc có thể có tiền sử phơi nhiễm gần đây và không có một bệnh lý khác phát hiện được, khi họ có một hoặc nhiều tiêu chuẩn lâm sàng sau đây: suy giảm ý thức/hôn mê, thiếu máu hồng cầu bình thường ở mức độ nặng, suy thận, phù phổi, hội chứng suy hô hấp cấp (ARDS), tình trạng sốc, đông máu rải rác trong lòng mạch, chảy máu tự nhiên, nhiễm toan máu, có hemoglobin niệu vàng da, co giật toàn thể tái phát và/hoặc mật độ kí sinh trùng trong máu > 5%) được coi là bị sốt rét nặng. Sốt rét nặng rất thường do *P. falciparum* gây nên.

2. Các bệnh nhân được chẩn đoán bị sốt rét nặng cần được điều trị tích cực bằng điều trị thuốc chống sốt rét theo đường tiêm. Điều trị bằng quinidin đường tĩnh mạch nên được bắt đầu càng sớm càng tốt sau khi chẩn đoán sốt rét nặng. Các bệnh nhân bị sốt rét nặng cần được cho một liều nạp quinidin đường tĩnh mạch trừ khi họ đã được dùng trên 40 mg/kg Quinin trong vòng 48 giờ trước đó hoặc nếu họ đã được dùng mefloquine trong vòng 12 giờ trước đó. Nên hội chẩn với thầy thuốc chuyên khoa tim mạch và thầy thuốc có kinh nghiệm điều trị sốt rét khi tiến hành điều trị cho bệnh nhân sốt rét bằng quinidin.Trong thời gian truyền quinidin, cần theo dõi liên tục huyết áp (để phát hiện tình trạng tụt huyết áp) và điện tim (để phát hiện tình trạng QRS giãn rộng và/hoặc kéo dài khoảng QTc) và cần theo dõi định kỳ nồng độ đường huyết (để phát hiện tình trạng hạ đường huyết). Xuất hiện các biến chứng tim, nếu ở mức độ nặng, có thể cần tạm thời ngừng truyền hoặc giảm tốc độ truyền tĩnh mạch của thuốc đang sử dụng cho bệnh nhân.

3. Cân nhắc biện pháp truyền thay máu (exchange transfusion) nếu mật độ kí sinh trùng sốt rét (tức là nồng độ kí sinh trùng trong máu) >10% *hoặc* nếu bệnh nhân bị rối loạn ý thức, phù phổi không do tăng gánh thể tích hoặc xuất hiện các biến chứng thận. Có thể ước tính mật độ kí sinh trùng trong máu bằng cách kiểm tra tiêu bản máu đàn mỏng 1 lớp hồng cầu bằng vật kính phóng đại nhúng dầu. Tiêu bản có thể được coi là đạt tiêu chuẩn để tiến hành soi tìm kí sinh trùng sốt rét khi số lượng tế bào hồng cầu vào khoảng 400 hồng cầu trên một vi trường. Khi đó, có thể ước tính mật độ kí sinh trùng dựa trên tỷ lệ phần trăm các hồng cầu bị nhiễm kí sinh trùng và cần được soi kiểm tra lại mỗi 12 giờ để theo dõi. Cần tiếp tục tiến hành truyền thay máu tới khi mật độ kí sinh trùng <1% (thường cần tới 8-10 đơn vị máu để truyền thay máu). Không được chậm trễ dùng quinidin đường tĩnh mạch do tiến hành truyền thay máu và điều trị này có thể được dùng đồng thời trong suốt quá trình truyền thay máu.

4. Các phụ nữ có thai được chẩn đoán bị sốt rét nặng phải được điều trị tích cực bằng các thuốc điều trị sốt rét đường tiêm.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

5. Hiện nay có 4 lựa chọn điều trị (A,B,C hoặc D) cho các trường hợp sốt rét không biến chứng do *P. falciparum* để kháng với chloroquin gây ra. Các lựa chọn A, B và C được khuyến cáo ở mức độ ngang nhau. Do gây một tỷ lệ bị phản ứng thần kinh- tâm thần nghiêm trọng cao hơn khi dùng với liều điều trị, phác đồ D (dùng mefloquine) không được khuyến cáo, trừ khi không thể sử dụng được các lựa chọn điều trị khác. Đối với phác đồ C, do có nhiều dữ kiệ về hiệu quả của quinin kết hợp với doxycyclin, điều trị kết hợp này được ưu tiên áp dụng hơn so với điều trị kết hợp quinin với clindamycin.

6. Nên uống thuốc trong bữa ăn hoặc với sữa không tách bơ. Nếu bệnh nhân nôn trong vòng 30 phút sau khi uống thuốc, khi đó, cần dùng lại liều cho bệnh nhân.

7. Viên nhộng quinin sulfat được bào chế tại Hoa Kỳ có hàm lượng 324mg, vì vậy, 2 viên nang là đủ đối với liều dùng cho người lớn. Liều dùng đối với trẻ em có thể khó do không có tương đương sinh khả dụng của các dạng bào chế quinin không đóng thành viên nhộng.

8. Đối với các nhiễm kí sinh trùng sốt rét ở khu vực Đông Nam Á, cần điều trị quinin liên tục trong 7 ngày. Đối với các nhiễm kí sinh trùng mắc phải ở các nơi khác, chỉ cần điều trị quinin liên tục trong trong 3 ngày.

9. Không chỉ định dùng doxycyclin cho trẻ dưới 8 tuổi. Đối với các trẻ dưới 8 tuổi bị nhiễm *P. falciparum* để kháng với chloroquin, atovaquone-proguanil và artemether-lumefantrin là các lựa chọn điều trị được khuyến cáo; Có thể cân nhắc dùng mefloquine, nếu không có sẵn các lựa chọn điều trị khác để áp dụng cho trẻ. Đối với các trẻ dưới 8 tuổi bị nhiễm *P.vivax* để kháng với chloroquin, mefloquine là điều trị được khuyến cáo. Nếu không có sẵn thuốc để dùng cho bệnh nhân hoặc nếu bệnh nhân không dung nạp được với thuốc và nếu nguy cơ do dùng thuốc vượt quá lợi ích của điều trị, atovaquone-proguanil hoặc artemether-lumefantrin được sử dụng thay thế.

10. Điều trị bằng mefloquine không được khuyến cáo sử dụng cho các đối tượng bị mắc sốt rét từ vùng Đông Nam Á do có tình trạng kháng thuốc cao.

11. Sử dụng primaquin để làm sạch kí sinh trùng thể ngủ (hypnozoites) trong gan, để dự phòng các đợt tái phát đối với nhiễm kí sinh trùng sốt rét loại *P.vivax* và *P. ovale*. Do primaquin có thể gây thiếu máu tan máu ở bệnh nhân bị thiếu hụt enzym G6PD, vì trước khi tiến hành điều trị bằng primaquin cần tiến hành sàng lọc tình trạng thiếu hụt G6PD. Đối với các đối tượng bị thiếu hụt enzym G6PD ở mức ranh giới hoặc như một thuốc thay thế cho các phác đồ điều trị nêu trên, có thể cho primaquin với liều 45mg theo đường uống mỗi tuần một lần trong 8 tuần. Hội chẩn với thấy thuốc chuyên khoa

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

về bệnh nhiễm khuẩn và/hoặc bệnh nhiệt đới nếu phác đồ điều trị thay thế này được cân nhắc áp dụng cho đối tượng bị thiếu hụt G6PD. Không được dùng primaquin trong khi có thai.

12. Hiện nay có 3 lựa chọn (A, B hoặc C) để điều trị sốt rét không biến chứng do *P. vivax* để kháng chloroquin gây nên. Tỷ lệ thất bại điều trị cao do *P.vivax* để kháng chloroquin đã được báo cáo gặp ở Papua Tân Guinea và Indonesia. Một vài trường hợp hiếm gặp về nhiễm *P.vivax* để kháng với chloroquin cũng đã được báo cáo gặp ở Burma (Myanmar), Ấn Độ và khu vực Trung và Nam Mỹ. Những đối tượng nhiễm P. vivax ngoài khu vực Papua Tân Guinea hoặc Indonesia nên được bắt đầu điều trị bằng chloroquin. Nếu bệnh nhân không đáp ứng với điều trị, nên chuyển sang phác đồ điều trị *P.vivax* để kháng với chloroquin và cần thông báo ngay cho trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa kỳ (theo số của đường dây nóng được liệt kê ở dưới). Đối với điều trị nhiễm *P.vivax* để kháng với chloroquin, cả ba phác đồ A, B và C được khuyến cáo với mức lựa chọn ngang nhau.

13. Đối với các phụ nữ có thai được chẩn đoán bị sốt rét không biến chứng do *P. falciparum* hoặc *P. vivax* để kháng với chloroquin gây nên, nói chung không có chỉ định điều trị bằng doxycyclin. Tuy nhiên, có thể dùng kết hợp doxycyclin với quinin (như được khuyến cáo cho người lớn không có thai), nếu các lựa chọn điều trị khác không có sẵn để sử dụng hoặc không được bệnh nhân dung nạp và lợi ích do điều trị mang lại được chứng minh là vượt hơn nguy cơ do thuốc gây cho bệnh nhân.

14. Nói chung Atovaquon-proguanil và artemether-lumefantrin không được khuyến cáo sử dụng cho phụ nữ có thai, nhất là trong 3 tháng đầu do còn thiếu các dữ liệu đánh giá độ an toàn của thuốc. Đối với các phụ nữ có thai được chẩn đoán bị sốt rét không có biến chứng do nhiễm *P. falciparum* để kháng với chloroquin gây nên, có thể dùng atovaquone-proguanil hoặc artemether-lumefantrin nếu các lựa họn điều trị khác không có sẵn để sử dụng hoặc không được bệnh nhân dung nạp và lợi ích do điều trị mang lại được chứng minh là vượt hơn nguy cơ do thuốc gây cho bệnh nhân.

15. Do các mối quan hệ nhân-quả có thể gặp khi điều trị bằng mefloquine trong khi có thai và gia tăng tỷ lệ thai chết lưu, nên nói chung mefloquine không được khuyến cáo sử dụng điều trị ở phụ nữ có thai. Tuy vậy, mefloquine có thể được dùng nếu đây là lựa chọn điều trị duy nhất và nếu lợi ích tiềm tàng mang lại do dùng thuốc được chứng minh là vượt hơn so với nguy cơ tiềm tàng do thuốc gây cho bệnh nhân.

16. Đối với các trường hợp nhiễm *P. vivax* và *P. ovale*, không nên dùng primaquin phosphat để điều trị làm sạch các thể ngủ của kí sinh trùng (hypnozoites)

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

ở phụ nữ có thai. Các bệnh nhân có thai bị nhiễm P. vivax và P.ovale cần được duy trì điều trị dự phòng bằng chloroquin trong thời gian họ mang thai. Liều điều trị dự phòng bằng thuốc khi dùng chloroquin phosphat là 300 mg dạng base (= 500 mg dạng muối) uống một lần/tuần. Sau khi sinh con, nên điều trị cho các bệnh nhân này nếu họ không bị thiếu hụt enzym G6PD bằng primaquin.

Các thông tin nói trên được dựa trên khuyến cáo của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ đối với bệnh sốt rét tại Mỹ

Đường dây nóng thông báo về Bệnh sốt rét của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ: Các ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều: (770) 488-7788.

Ngoài giờ làm việc và trong các ngày nghỉ: (770) 488-7100

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Sốt rét ở trẻ em (Ở Hoa Kỳ)

Chẩn đoán lâm sàng/ Loại Plasmodium gây bệnh	Vùng bị tác động	Các thuốc được khuyến cáo và liều dùng cho trẻ em (liều dùng cho trẻ em không được vượt quá liều dùng cho người lớn)
Sốt rét nặng[1,2,3]	**Tất cả các vùng tại Hoa Kỳ**	**Quinidin gluconat2** ***cộng với*** **hoặc Doxycyclin8 hoặc Clindamycin** **Quinidin gluconat**: Liều tương tự như liều được khuyến cáo cho người lớn. **Doxycyclin**: Điều trị như trên. Đối với trẻ nặng < 45kg: dùng liều 2,2mg/kg (TM) mỗi 12h/lần và sau đó chuyển sang dùng doxycyclin (uống) (với liều như trên) ngay khi bệnh nhân có thể dùng được thuốc bằng đường uống. Đối với trẻ nặng ≥ 45kg, sử dùng cùng liều như đối với người lớn. Điều trị trong vòng 7 ngày. **Clindamycin**: Điều trị như trên. Liều nạp là 10mg dạng base/kg cân nặng (TM), sau đó dùng với liều 5mg dạng base/kg (TM/Uống) mỗi 8h/lần x 7 ngày.

Sốt rét không có biến chứng/ Do nhiễm *P. falciparum* hoặc không xác định được loài Plasmodium [4]. (Nếu "kí sinh trùng sốt rét không xác định được loài" sau đó được xác định là *P. vivax* hoặc *P. ovale*: Xem phần điều trị đối với P. vivax và *P. ovale* bằng primaquin)	**Kí sinh trùng sốt rét đề kháng với chloroquin hoặc không rõ tình trạng kháng thuốc của kí sinh trùng sốt rét**[11] (Các nước vùng Trung đông có *P. falciparum* đề kháng với chloroquin bao gồm: Iran, Oman, Ả rập Xê Út và Yemen. Cần lưu ý là, cho tới hiện tại, những trường hợp mắc sốt rét thuộc các nước mới được độc lập tách ra từ Liên bang Xô Viết cũ và Hàn Quốc đều chỉ do nhiễm kí sinh trùng sốt rét thuộc loài *P. vivax* gây ra, vì vậy nên được điều trị như đối với nhiễm kí sinh trùng sốt rét còn nhạy cảm với chloroquin)	**A. Atovaquon-proguanil (Malarone)**[6] *Viên nén dùng cho người lớn= 250mg atovaquone/ 100mg proguanil* *Viên nén dùng cho trẻ em= 62,5mg atovaquone/25mg proguanil* 5–8 kg: 2 viên dùng cho trẻ em (uống) mỗi 24h/ lần x 3 ngày 9–10kg: 3 viên dùng cho trẻ em (uống) mỗi 24h/lần x 3 ngày 11–20 kg: 1 viên cho người lớn (uống) mỗi 24 h/ lần x 3 ngày 21–30 kg: 2 viên cho người lớn (uống) mỗi 24 h/ lần x 3 ngày 31–40 kg: 3 viên cho người lớn (uống) mỗi 24 h/ lần x 3 ngày >40 kg: 4 viên cho người lớn (uống) mỗi 24 h/ lần x 3 ngày ***hoặc*** **B. Artemether-lumefantrine (Coartem)**[5] *1 viên nén = 20mg artemether/120mg lumefantrine* Phác đồ điều trị 3 ngày với tổng cộng 6 liều dùng theo đường đường uống được khuyến cáo dựa theo cân nặng của bệnh nhân. Bệnh nhân cần dùng liều khởi, được tiếp theo sau 8 giờ sáu đó bằng liều thứ hai 8 giờ, sau đó 1 liều (uống) mỗi 12 h/lần x 2 ngày. 5 – <15 kg: 1 viên cho mỗi liều. 15 – <25 kg: 2 viên cho mỗi liều 25 –< 35 kg: 3 viên cho mỗi liều ≥ 35 kg: 4 viên cho mỗi liều ***hoặc*** **C. Quinin sulfat[3] cộng với hoặc Doxycyclin[8] hoặc Clindamycin** **Quinin sulfat**[6,7]: 8,3mg dạng base/kg (=10mg dạng muối /kg) (uống) chia 3 lần/ngày x 3 hoặc 7 ngày. **Doxycyclin**: 2,2mg/kg (uống) mỗi 12h/lần x × 7 ngày **Clindamycin**: 20mg dạng base/kg/ngày (uống) chia 3 lần/ngày × 7 ngày. ***hoặc*** **D. Mefloquine (Lariam)**[9] Liều khởi đầu:13,7mg dạng base/kg (=15mg dạng muối/kg) (Uống), được tiếp theo bằng liều 9,1 mg dạng base/kg (=10mg dạng muối/kg) (uống) cho sau liều khởi đầu từ 6–12 giờ. Tổng liều = 25mg dạng muối /kg.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Sốt rét không biến chứng/ Do nhiễm *P. falciparum* hoặc không xác định được loài Plasmodium	**Kí sinh trùng sốt rét còn nhạy cảm với chloroquin** (Khu vực Trung Mỹ phía tây kênh đào Panama, Haiti, Cộng Hòa Dominic và hầu hết các nước Trung Đông).	**Chloroquin phosphat (Aralen)** 10mg dạng base/kg (uống) ngay lập tức, tiếp theo với liều 5mg dạng base/kg (uống) vào các thời điểm 6, 24 và 48 giờ sau liều đầu tiên. Tổng liều:.25 mg dạng base/kg ***hoặc*** **Hydroxychloroquin** (Plaquenil và các biệt dược khác): 10mg dạng base/kg (uống) ngay lập tức, tiếp theo với liều 5 mg dạng base/kg vào các thời điểm 6, 24 và 48 giờ sau liều đầu tiên. Tổng liều: 25mg dạng base/kg
Sốt rét không biến chứng/ Do nhiễm *P. malariae* hoặc *P. knowlesi*	**Tất cả các vùng tại Hoa Kỳ**	**Chloroquin phosphat**: Điều trị như trên ***hoặc*** **Hydroxychloroquin**: Điều trị như trên.
Sốt rét không biến chứng/Do nhiễm *P. vivax* hoặc *P. ovale*	**Tất cả các vùng tại Hoa Kỳ** (Khi nghi ngờ *P. vivax* đề kháng với chloroquin- xem phần dưới)	**Chloroquin phosphat cộng với Primaquin phosphat[10]** **Chloroquin phosphat**: Điều trị như trên. **Primaquin**: 0,5mg dạng base/kg (uống) 1 lần/ ngày x 14 ngày ***hoặc*** **Hydroxychloroquin cộng với Primaquin phosphat[10]** **Hydroxychloroquin**: Điều trị như trên **Primaquin phosphat**: 0,5mg dạng base/kg (uống) 1 lần/ngày x14 ngày

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Sốt rét không biến chứng/Do nhiễm *P. vivax*	**Kí sinh trùng đề kháng với chloroquin[11]** (Papua Tân Guinea và Indonesia)	**A. Quinin sulfat cộng với hoặc Doxycyclin[8] cộng với Primaquin phosphat[10]** **Quinin sulfat**: Điều trị như trên. **Doxycyclin**: Điều trị như trên. **Primaquin phosphat**: Điều trị như trên. ***hoặc*** **B. Atovaquone-proguanil cộng với Primaquin phosphat** **Atovaquone-proguanil**: Điều trị như trên **Primaquin phosphat**: Điều trị như trên ***hoặc*** **C. Mefloquine cộng với Primaquin phosphat[10]** **Mefloquine**: Điều trị như trên **Primaquin phosphat**: Điều trị như trên

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

1. Những đối tượng có kết quả giọt máu đàn dương tính với kí sinh trùng sốt rét hoặc có thể có tiền sử phơi nhiễm gần đây và không có một bệnh lý khác phát hiện được, khi họ có một hoặc nhiều tiêu chuẩn lâm sàng sau đây: suy giảm ý thức/hôn mê, thiếu máu hồng cầu bình thường ở mức độ nặng, suy thận, phù phổi, hội chứng suy hô hấp cấp (ARDS), tình trạng sốc, đông máu rải rác trong lòng mạch, chảy máu tự nhiên, nhiễm toan máu, có hemoglobin niệu vàng da, co giật toàn thể tái phát và/hoặc mật độ kí sinh trùng trong máu > 5%) được coi là bị sốt rét nặng. Sốt rét nặng rất thường do *P. falciparum* gây nên.

2. Các bệnh nhân được chẩn đoán bị sốt rét nặng cần được điều trị tích cực bằng điều trị thuốc chống sốt rét theo đường tiêm. Điều trị bằng quinidin đường tĩnh mạch nên được bắt đầu càng sớm càng tốt sau khi chẩn đoán sốt rét nặng. Các bệnh nhân bị sốt rét nặng cần được cho một liều nạp quinidin đường tĩnh mạch trừ khi họ đã được dùng trên 40 mg/kg Quinin trong vòng 48 giờ trước đó hoặc nếu họ đã được dùng mefloquine trong vòng 12 giờ trước đó. Nên hội chẩn với thầy thuốc chuyên khoa tim mạch và thầy thuốc có kinh nghiệm điều trị sốt rét khi tiến hành điều trị cho bệnh nhân sốt rét bằng quinidin.Trong thời gian truyền quinidin, cần theo dõi liên

tục huyết áp (để phát hiện tình trạng tụt huyết áp) và điện tim (để phát hiện tình trạng QRS giãn rộng và/hoặc kéo dài khoảng QTc) và cần theo dõi định kỳ nồng độ đường huyết (để phát hiện tình trạng hạ đường huyết). Xuất hiện các biến chứng tim, nếu ở mức độ nặng, có thể cần tạm thời ngừng truyền hoặc giảm tốc độ truyền tĩnh mạch của thuốc đang sử dụng cho bệnh nhân.

3. Cân nhắc biện pháp truyền thay máu (exchange transfusion) nếu mật độ kí sinh trùng sốt rét (tức là nồng độ kí sinh trùng trong máu) >10% *hoặc* nếu bệnh nhân bị rối loạn ý thức, phù phổi không do tăng gánh thể tích hoặc xuất hiện các biến chứng thận. Có thể ước tính mật độ kí sinh trùng trong máu bằng cách kiểm tra tiêu bản máu đàn mỏng 1 lớp hồng cầu bằng vật kính phóng đại nhúng dầu. Tiêu bản có thể được coi là đạt tiêu chuẩn để tiến hành soi tìm kí sinh trùng sốt rét khi số lượng tế bào hồng cầu vào khoảng 400 hồng cầu trên một vi trường. Khi đó, có thể ước tính mật độ kí sinh trùng dựa trên tỷ lệ phần trăm các hồng cầu bị nhiễm kí sinh trùng và cần được soi kiểm tra lại mỗi 12 giờ để theo dõi. Cần tiếp tục tiến hành truyền thay máu tới khi mật độ kí sinh trùng <1% (thường cần tới 8-10 đơn vị máu để truyền thay máu). Không được chậm trễ dùng quinidin đường tĩnh mạch do tiến hành truyền thay máu và điều trị này có thể được dùng đồng thời trong suốt quá trình truyền thay máu.

4. Hiện nay có 4 lựa chọn điều trị (A, B, C hoặc D) cho các trường hợp sốt rét không biến chứng do *P. falciparum* đề kháng với chloroquin gây ra. Các lựa chọn A, B và C được khuyến cáo ở mức độ ngang nhau. Do gây một tỷ lệ bị phản ứng thần kinh- tâm thần nghiêm trọng cao hơn khi dùng với liều điều trị, phác đồ D (dùng mefloquine) không được khuyến cáo, trừ khi không thể sử dụng được các lựa chọn điều trị khác. Đối với phác đồ C, do có nhiều dữ kiệ về hiệu quả của quinin kết hợp với doxycyclin, điều trị kết hợp này được ưu tiên áp dụng hơn so với điều trị kết hợp quinin với clindamycin.

5. Nên uống thuốc trong bữa ăn hoặc với sữa không tách bơ. Nếu bệnh nhân nôn trong vòng 30 phút sau khi uống thuốc, khi đó, cần dùng lại liều cho bệnh nhân.

6. Viên nhộng quinin sulfat được bào chế tại Hoa Kỳ có hàm lượng 324mg, vì vậy, 2 viên nang là đủ đối với liều dùng cho người lớn. Liều dùng đối với trẻ em có thể khó do không có tương đương sinh khả dụng của các dạng bào chế quinin không đóng thành viên nhộng.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

7. Đối với các nhiễm kí sinh trùng sốt rét ở khu vực Đông Nam Á, cần điều trị quinin liên tục trong 7 ngày. Đối với các nhiễm kí sinh trùng mắc phải ở các nơi khác, chỉ cần điều trị quinin liên tục trong trong 3 ngày.

8. Không chỉ định dùng doxycyclin cho trẻ dưới 8 tuổi. Đối với các trẻ dưới 8 tuổi bị nhiễm P. falciparum đề kháng với chloroquin, atovaquone-proguanil và artemether-lumefantrin là các lựa chọn điều trị được khuyến cáo; Có thể cân nhắc dùng mefloquine, nếu không có sẵn các lựa chọn điều trị khác để áp dụng cho trẻ. Đối với các trẻ dưới 8 tuổi bị nhiễm *P.vivax* đề kháng với chloroquin, mefloquine là điều trị được khuyến cáo. Nếu không có sẵn thuốc để dùng cho bệnh nhân hoặc nếu bệnh nhân không dung nạp được với thuốc và nếu nguy cơ do dùng thuốc vượt quá lợi ích của điều trị, atovaquone-proguanil hoặc artemether-lumefantrin được sử dụng thay thế.

9. Điều trị bằng mefloquine không được khuyến cáo sử dụng cho các đối tượng bị mắc sốt rét từ vùng Đông Nam Á do có tình trạng kháng thuốc cao.

10. Sử dụng primaquin để làm sạch kí sinh trùng thể ngủ (hypnozoites) trong gan, để dự phòng các đợt tái phát đối với nhiễm kí sinh trùng sốt rét loại *P.vivax* và *P. ovale*. Do primaquin có thể gây thiếu máu tan máu ở bệnh nhân bị thiếu hụt enzym G6PD, vì trước khi tiến hành điều trị bằng primaquin cần tiến hành sàng lọc tình trạng thiếu hụt G6PD. Đối với các đối tượng bị thiếu hụt enzym G6PD ở mức ranh giới hoặc như một thuốc thay thế cho các phác đồ điều trị nêu trên, có thể cho primaquin với liều 45mg theo đường uống mỗi tuần một lần trong 8 tuần. Hội chẩn với thầy thuốc chuyên khoa về bệnh nhiễm khuẩn và/hoặc bệnh nhiệt đới nếu phác đồ điều trị thay thế này được cân nhắc áp dụng cho đối tượng bị thiếu hụt G6PD. Không được dùng primaquin trong khi có thai.

11. Hiện nay có 3 lựa chọn (A, B hoặc C) để điều trị sốt rét không biến chứng do *P. vivax* đề kháng chloroquin gây nên. Tỷ lệ thất bại điều trị cao do *P.vivax* đề kháng chloroquin đã được báo cáo gặp ở Papua Tân Guinea và Indonesia. Một vài trường hợp hiếm gặp nhiễm *P.vivax* đề kháng với chloroquin cũng đã được báo cáo gặp ở Burma (Myanmar), Ấn Độ và khu vực Trung và Nam Mỹ. Những đối tượng nhiễm *P. vivax* ngoài khu vực Papua Tân Guinea hoặc Indonesia nên được bắt đầu điều trị bằng chloroquin. Nếu bệnh nhân không đáp ứng với điều trị, nên chuyển sang phác đồ điều trị *P.vivax* đề kháng với chloroquin và cần thông báo ngay cho trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (theo số của đường dây nóng được liệt kê ở dưới). Đối với điều trị nhiễm *P.vivax*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

để kháng với chloroquin, cả ba phác đồ A, B và C được khuyến cáo với mức lựa chọn ngang nhau.

Các thông tin nói trên được dựa trên khuyến cáo của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ đối với bệnh sốt rét tại Mỹ.

Đường dây nóng thông báo về Bệnh sốt rét của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ: Các ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều: (770) 488-7788.

Ngoài giờ làm việc và trong các ngày nghỉ: (770) 488-7100.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

ATLAS MÀU

Hình ảnh nhuộm Gram
bệnh phẩm dịch não-tủy, đờm và nước tiểu

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

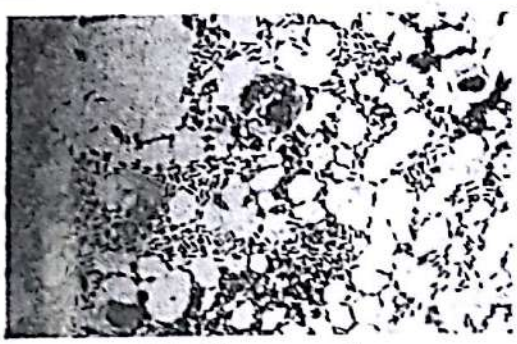
NHUỘM GRAM DỊCH NÃO-TỦY

Tụ cầu vàng (*Staphylococcus eureus*)

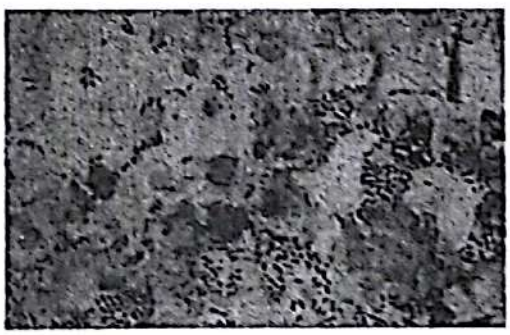
Listeria moncxytogenes

H. influenzae

Não mô cầu *(Neisseria meningitidis)*



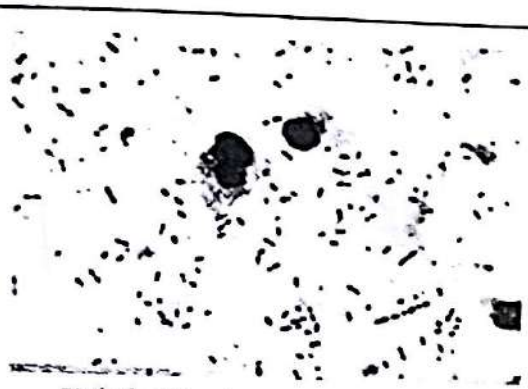
Klebsiella pneurroniae



Phế cầu *(Streplororcus pneumoniae)*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

NHUỘM GRAM ĐỜM

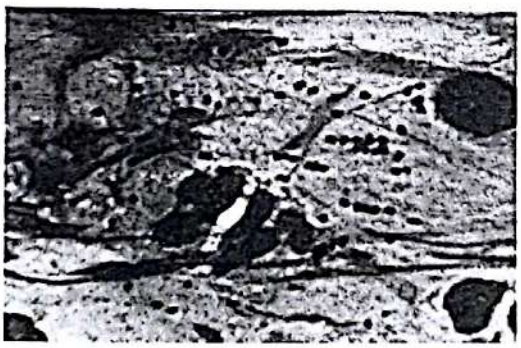


Phế cầu (*Streptococcus pneumoniae*)

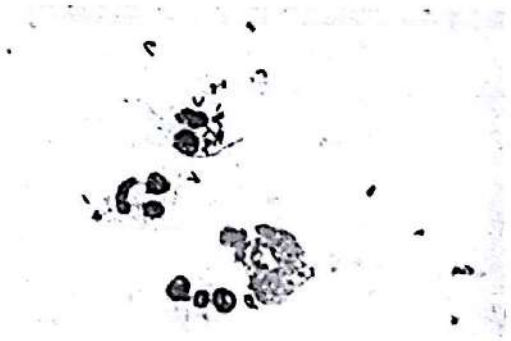
Klebsiella pneumoniae

Hemophilus influenzae

Tụ cầu vàng (*Staphylococcus aureus*)



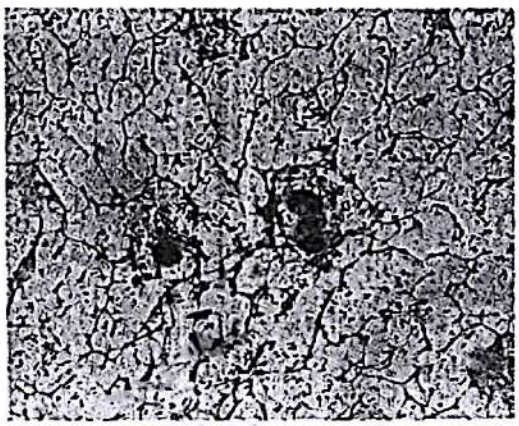
Moraxella catarrhalis



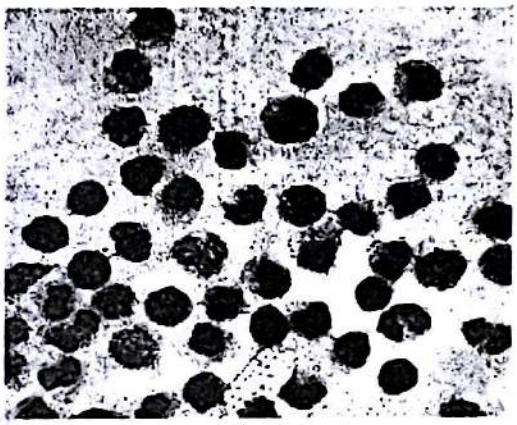
Trực khuẩn mủ xanh (*Pseudomonas aeruginosa*)

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

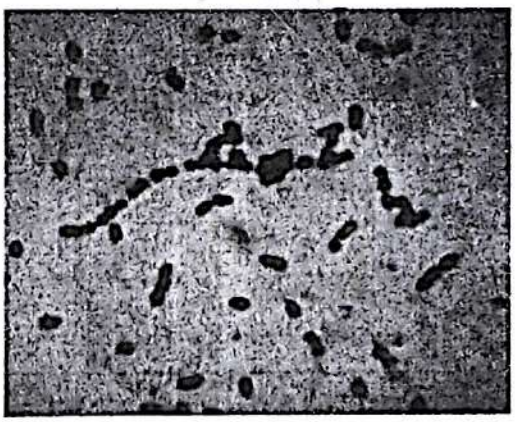
NHUỘM GRAM NƯỚC TIỂU



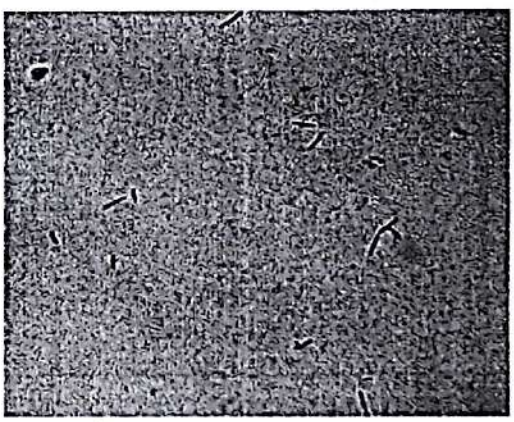
Ecoli



Liên cầu nhóm B



Cầu khuẩn ruột (Enterococci)



Trực khuẩn mủ xanh (*Pseudomonas aeruginosa*)

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

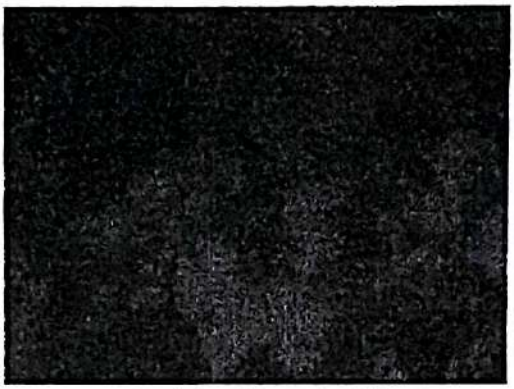
ATLAS MÀU

Nhuộm tìm nấm

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

NHUỘM TÌM NẤM

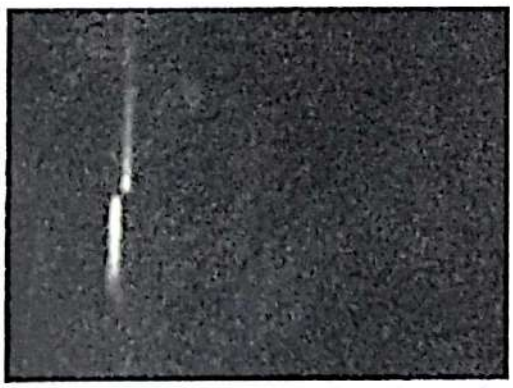
Actinomyces (Sinh thiết phổi)



Candida albicans (máu)

Alternaria (sinh thiết da)

Candida albcans với giả sợi nấm (máu)



Aspergillus (sinh thiết phổi)

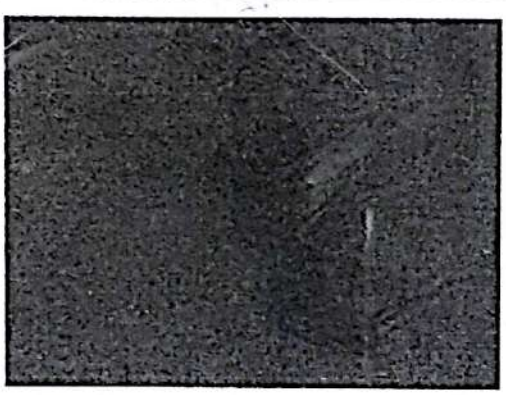
Candida dưới dạng quả cầu nấm (sinh thiết phổi)

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Candida (sinh thiết gan)

Fusarium (sinh thiết da)

Cryptococcus (sinh thiết phổi)

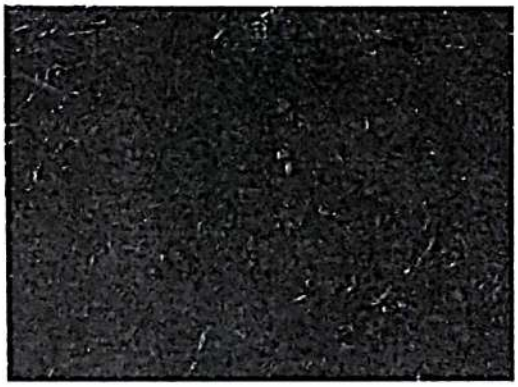


Histoplasma capsulatum (sinh thiết phổi)

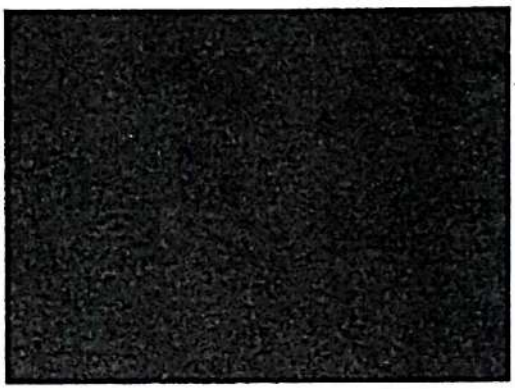
Cunninghamella (sinh thiết phổi)

Malasezzia (máu)

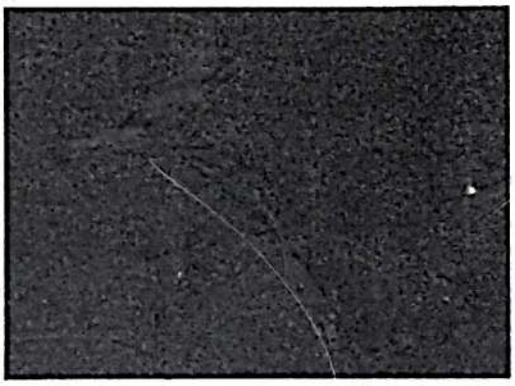
Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075



Bệnh nấm Zygomycosis/Phycomycosis (sinh thiết xương)

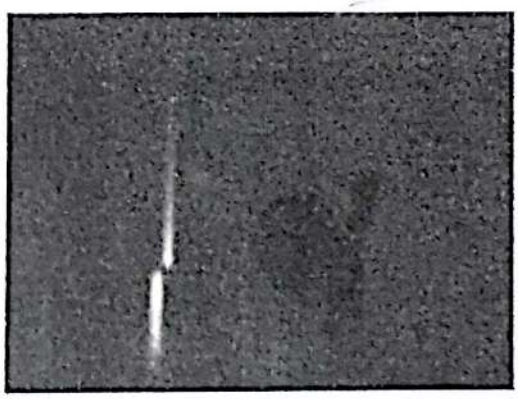


Pneumocystis (sinh thiết phổi)



Nocardia (sinh thiết phổi)

Rhizomucor (sinh thiết xoang)



Paracoccidioidomycosis (sinh thiết xương)

Scedosporium (sinh thiết phổi)

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

INDEX

Ghi chú: Các bảng được ghi chú bằng chữ "b"

A

A. flavus, endophthalmitis
A. flavus viêm nội nhãn....65
A. fumigatus, endophthalmitis
A. fumigatus, viêm nội nhãn....65
A. hemolyticum, pharyngitis
A. hemolyticum, viêm họng....73
Abacavir (ABC)....827
Abacavir + lamivudin (Epzicom)....825
Abacavir + lamivudin + zidovudin (trizivir)....827
ABC (abacavir)....827
ABCD....844
ABC/3TC (Epzicom)....825
ABC/3TC/ZDV (Trizivir)....827
Abdominal abnormalities (DDx)
Các bất thường của bụng (chẩn đoán phân biệt)....756
Abdominal wall nodules
Khối u nhỏ ở thành bụng....757 b
Abdominal wall sinus tract
Đường rò thành bụng....756 b
Abdominal wall tenderness
Căng đau thành bụng....756b
Abdominal tenderness (20 to pancreatitis)
Căng đau bụng (thứ phát do viêm tụy) 756
Ascites
Cổ trướng....757 b
hepatomegaly
gan to....757b
hepatosplenomegaly
gan lách to....757 b
Left upper abdominal quadrant tenderness (splenic tenderness)
Căng đau hạ sườn trái (vùng lách)....757 b
Perubilical purpura (thumbprint sign)
Xuất huyết quanh rốn (dấu hiệu: ấn ngón tay cái)....757 b
Right lower quadrant tenderness
Căng đau hố chậu phải....757 b
Right upper quadrant mass
Có khối hạ sườn phải....757b
right upper quadrant tenderness
Căng đau hạ sườn phải....757 b
right upper quadrant tympany
Chướng hơi hạ sườn phải....756 b
rose spots
Hồng ban....756b
splenomegaly
Lách to....758b
Abdominal wall sinus tract, abdominal abnormalities (DDx)
Rò thành bụng, chẩn đoán phân biệt....756 b
Abdominal wall tenderness, abdominal abnormalities (DDx)
Ấn căng đau thành bụng, các bất thường ở bụng, (chẩn đoán phân biệt)....756 b
Abelcet....842
ABLC....842
Abscess
Ápxe
brain
não....51
cold
Ápxe lạnh....472
Gallbladder wall
Thành túi mật....166
intraabdominal

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

trong ổ bụng 178
intrarenal
Trong thận 194
ischiorectal
Ụ ngồi trực tràng 267
liver
gan 170
lung
phổi 123
necrotizing
hoại tử 239
pancreatic
tụy 170
pelvic
Khung chậu 178
Perirectal
Quanh trực tràng 267
prostatic
Tuyến tiền liệt 196
renal
Thận 194
skin
da 248
tuboovarian
Vòi tử cung-buồng trứng 202
Absidia
Nấm Absidia 445
Cutaneous zygomycosis
Nấm Zygomycosis ở da 483
Pulmonary zygomycosis
Nấm Zygomycetes ở phổi 445
Acanthamoeba
Acanthamoeba
Granulomatous amebic encephalitis
Viêm não u hạt do amip 43
Keratitis
Viêm giác mạc 60
meningitis
Viêm màng não 39
A-cillin
A-cillin 835
Acinetobacter baumanii, acute bacterial meningitis
Acinetobacter baumanii, viêm màng não cấp do vi khuẩn 35
Acinetobacter baumanii, lwoffi, calcoaceticus, haemolyticus
Acinetobacter baumanii, lwoffi, calcoaceticus, hemolyticus ..... 358 b
Acinetobacter sp
Acinetobacter sp ..... 325 b
Acquired resistance
Kháng thuốc mắc phải 5
Actinobacillus, endocarditis
Actinobacillus, viêm nội tâm mạc 132
Actinomyces, brain abscess
Actinomyces, ápxe não 51
Actinomyces israelii
Actinomyces israelii 383
Cutaneous actinomycosis
Bệnh nấm Actinomyces da 470
Pulmonary Actinomycosis
Bệnh nấm Actinomyces ở phổi 442
Actinomyces odontolyticus
Actinomyces odontolyticus ..... 383 b
Actinomyces sp
Actinomyces sp ..... 330 b
Actinomycosis
Bệnh do nấm Actinomyces 702
Cavitary infiltrates (thick-walled)
Xâm nhiễm phổi tạo hang (thành dày) 726
Unilateral ill-defined infiltrates without effusion
Xâm nhiễm mờ một bên không kèm tràn dịch màng phổi 690
Acute bacterial endocarditis (ABE)
Viêm nội tâm mạc cấp nhiễm khuẩn 138
Acute bacterial meningitis (ABM), empiric therapy
Viêm màng não mủ cấp tính (ABM), điều trị theo kinh nghiệm 38, 628
Acute bacterial sinusitis

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm xoang cấp do vi khuẩn 57
Acute exacerbation of Chronic bronchitis (AECB)
Đợt cấp của viêm phế quản mạn (AECB) 87
Chronic medical prophylaxis
Dự phòng nội khoa mạn tính ..... 594 b
Acute infections. See specific clinical syndromes
Nhiễm trùng cấp tính. Xem các hội chứng lâm sàng đặc trưng
Acute mastoiditis
Viêm xương chũm cấp tính 72
Acute non-bacterial meningitis
Viêm màng não cấp không do vi khuẩn 39
Acute otitis media
Viêm tai giữa cấp 69, 638
Acute rheumatic fever (ARF), chronic medical prophylaxis
Sốt thấp khớp cấp (ARF), dự phòng nội khoa mạn tính 595
Acyclovir
Acyclovir 828
Pediatric dose
Liều dùng cho trẻ em 674
Adefovir dipivoxil
Adefovir dipivoxil 830
Adenovirus
Adenovirus
Conjunctivitis
Viêm kết mạc 61
Transplant infections
nhiễm trùng ở người được ghép tạng 283
Unilateral focal segmental/lobar infiltrate with effusion
Xâm nhiễm thùy hoặc tiểu thùy khu trú một bên có tràn dịch màng phổi 701
Unilateral ill-defined infiltrates without effusion
Xâm nhiễm không rõ một bên không có tràn dịch 696
Adult Immunizations
Tiêm chủng ở người lớn 613
Bacille Calmette Guérin (BCG)
Bacille-Calmette-Guérin (BCG) 613b
Hemophilus influenzae
Hemophilus influenzae ..... 613 b
Hepatitis A
Viêm gan A ..... 613 b
Hepatitis B
Viêm gan B ..... 614 b
Herpes zoster (HZV)
Herpes zoster (HZV) ..... 615 b
influenza
cúm 615b
measles
sởi ..... 616 b
meningococcus (invasive disease)
não mô cầu (bệnh xâm nhập) ..... 616 b
mumps
quai bị ..... 616 b
papilloma (human) virus
Virus gây u nhú trên người 616b
Pertussis
Ho gà ..... 617 b
Pneumococcus (S.pneumoniae)
Phế cầu (S. pneumoniae) ..... 617 b
rubella
rubella ..... 617 b
tetanus-diphtheria
Uốn ván –bạch hầu ..... 618 b
Varicella (VZV) chickenpox
Varicella (VZV), thủy đậu ..... 618 b
Adult respiratory distress syndrome (ARDS), bilateral infiltrates without effusion
Hội chứng suy hô hấp tiến triển người lớn (ARDS), xâm nhiễm hai phổi không kèm tràn dịch màng phổi 716
Aerobic GNBs
Vi khuẩn Gram âm ưa khí (GNBs)
Acute pancreatitis
Viêm tụy cấp 169
endocarditis
Viêm nội tâm mạc 135
IV line Infections
Nhiễm trùng đường truyền tĩnh mạch 147

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Liver abscess
Ápxe gan 170
Pacemaker infections
Nhiễm trùng do đặt máy tạo nhịp 148
Pancreatic abscess
Ápxe tụy 169
Surgical prophylaxis
Dự phòng nhiễm trùng trong phẫu thuật 577b
Aerobic isolates, clinical significance, pending susceptibility testing
Phân lập được vi khuẩn ái khí, ý nghĩa lâm sàng, trong khi chờ kết quả xét nghiệm độ nhạy của vi sinh vật với thuốc ..... 342 b
Aeromonas, travel prophylaxis
Aeromonas, dự phòng khi du lịch 607b
Aeromonas hydrophila
Aeromonas hydrophila 359
African tick bite fever
Sốt do ve châu Phi cắn 486
Agenerase
Agenerase 848
Agent-specific antibiotic resistance
Đề kháng kháng sinh đặc hiệu theo thuốc 4
Aggregatibacter (actinobacillus) actinomycetem-comitans
Aggregatibacter (actinobacillus) actinomycetem-comitan ..... 359 b
AIDS. See HIV
AIDS. Xem phần HIV
Alcaligenes xylosoxidans
Alcaligenes xylosoxidan ..... 360 b
Alcoholics, pr eumonia
Nghiện rượu, viêm phổi 96
Alinia 1001
Alkaline phosphatase (AP), elevations, liver test abnormalities (DDx)
Tăng phosphatase kiềm, các bất thường về xét nghiệm chức năng gan (Chẩn đoán phân biệt) ..... 779 b
Allergic potential, explanation
Nguy cơ dị ứng, giải thích 817
Allogeneic BMT/lung transplants, ztransplant prophylaxis (BMT/SOT)
Ghép tủy dị thân / ghép phổi, dự phòng phẫu thuật (ghép tủy/ ghép tạng đặc) ..... 598 b
Alopecia, localized/generalized, head abnormalities (DDx)
Rụng tóc, khu trú/toàn thể, các bất thường ở đầu khác (chẩn đoán phân biệt) ..... 745 b
Alternaria alternata, cutaneous alternaria
Alternaria alternata, nhiễm alternaria da 480
Alveolar cell carcinoma
Ung thư biểu mô tế bào phế nang
Bilateral infiltrates without effusion
Xâm nhiễm hai phổi không có tràn dịch màng phổi 718
Unilateral focal segmental/lobar infiltrate with effusion
Xâm nhiễm thùy hoặc tiểu thùy khu trú một bên có tràn dịch màng phổi 699
Unilateral focal segmental/lobar infiltrate without effusion
Xâm nhiễm thùy hoặc tiểu thùy khu trú một bên không có tràn dịch màng phổi 693
Unilateral ill-defined infiltrates with effusion
Xâm nhiễm không rõ một bên kèm tràn dịch màng phổi 710
Unilateral ill-defined infiltrates without effusion
Xâm nhiễm ranh giới không rõ một bên không có tràn dịch màng phổi 705
Alveolar echinococcosis
Bệnh nhiễm echinococcus phế nang 731
cavitary infiltrates (thick-walled)
Xâm nhiễm dạng hang (thành dày) 731
Amantadine
Amantadin 831
AmBisome
AmBisom 843
Amebiasis
Bệnh do amíp ..... 607 b
Travel prophylaxis
Dự phòng khi đi du lịch ..... 607 b

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

See also Entamoeba histolytica
Xem thêm phần Entamoeba histolytica
Amebic cysts, cavitary infiltrates (thick-walled)
Kén amíp, xâm nhiễm tạo hang (thành dày) 731
American trypanosomiasis. See also Chagas' disease
Bệnh do trypanosoma châu Mỹ... 447 Xem thêm bệnh Chagas
Amikacin 832
Pediatric dose
Liều dùng cho trẻ em 674
Amikin 832
Aminoglycosides
Aminoglycosid
Dosing
Liều dùng 832
Susceptibility profiles
Thông tin về độ nhạy cảm của vi sinh vật với thuốc điều trị 321
Amoxicillin 835
Pediatric dose
Liều dùng cho trẻ em 675
Amoxicillin/clavulanic acid
Amoxicillin/acid clavulanic 836
Pearls & pitfalls
Điểm nhấn và các sai lầm cần tránh 792
Pediatric dose
Liều dùng cho trẻ em 674
Amoxicillin/clavulanic acid ES-600
Amoxicillin/ acid clavulanic ES-600 837
Amoxicillin/clavulanic acid XR
Amoxicillin/ acid clavulanic XR 839
Amoxil 835
Amphotec 844
Amphotericin B 844
cholesteryl sulfate complex
Phức chất cholesteryl sulfat 844
colloidal dispersion
Phân tán dưới dạng keo 844
lipid-associated formulations
Công thức kết hợp lipid ..... 821 b
Lipid complex
Phức hợp lipid 823
liposomal
liposomal 823
Ampicillin 846
Pearls & pitfalls
Điểm nhấn và các sai lầm cần tránh 791
Pediatric dose
liều dùng cho trẻ em 675
various
Biệt dược khác 388
Ampicillin/sulbactam 847
Pediatric dose
Liều dùng cho trẻ em 675
Amprenavir (APV) 848
Amylase, elevation pleural fluid abnormalities (DDx)
Amylase, dịch màng phổi (chẩn đoán phân biệt) ..... 784 b
Anaerobes, brain abscess
Vi khuẩn kị khí, áp xe não 51
Anaerobic isolates, clinical significance, pending susceptibility testing
Phân lập được vi khuẩn kị khí, ý nghĩa lâm sàng khi chưa có kết quả độ nhạy của vi sinh vật với kháng sinh 339
Anaerobic streptococci complicated skin/ skin structure
Nhiễm trùng da/ cấu trúc da phức tạp do liên cầu kị khí 248
Tissue infections
Nhiễm khuẩn mô mềm 240
Surgical prophylaxis
Kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật 577b
Anaplasma (Ehrlichia) phagocytophilium
Anaplasma (Ehrlichia) phagocytophilium 419
Ancef 869
Ancobon 947
Ancylostoma braziliense, cutaneous larva migrans
Ancylostoma braziliense, ấu trùng di trú trên da 475
Ancylostoma duodenale, hookworm

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Ancylostoma tá tràng, giun móc 458
Anemia, acute, RBC abnormalities (DDx)
Thiếu máu, cấp tính, các bất thường của hồng cầu (Chẩn đoán phân biệt) .....774 b
Angiostrongyliasis
Bệnh do nhiễm giun Angiostrongylus.....456
Angiostrongylus cantonensis
A. cantonensis.....456
Angiotensin-converting enzyme levels (ACE), rheumatic test abnormalities (DDx)
Định lượng men chuyển Angiotensin (ACE), các bất thường xét nghiệm bệnh lý do thấp (Chẩn đoán phân biệt).....782 b
Angular chelitis, mouth abnormalities (DDx)
Viêm môi bong vảy, các bất thường của miệng (Chẩn đoán phân biệt) .....741 b
Anidulafungin 850
Animal bites
Anidulafungin 257
Pediatric
Nhi khoa 670
septic arthritis secondary to
Viêm khớp nhiễm trùng thứ phát do động vật cắn.....224
Travel precautions
Khuyến cáo khi đi du lịch 606b
Aniscoria, neurological abnormalities (DDx)
Đồng tử không đều, các bất thường về thần kinh (Chẩn đoán phân biệt).....768 b
Anterior cervical adenopathy, lymph node abnormalities (DDx)
Hạch vùng cổ trước, các bệnh lý hạch (Chẩn đoán phân biệt).....759 b
Anthrax
Bệnh than.....303
Bioterrorist
Khủng bố sinh học 303
Antibiotic failure (DDx) apparent, causes of
Điều trị kháng sinh thất bại (Chẩn đoán phân biệt), nguyên nhân.....20
Antibiotic prescribing, pitfalls in
Kê thuốc kháng sinh: những sai lầm cần tránh ...25
Antibiotic resistance, combination therapy and
Đề kháng kháng sinh và cách kết hợp kháng sinh.....13 b
Antibiotic selection, factors in
Lựa chọn KS: Các yếu tố cân nhắc 3
Antibiotic resistance
Đề kháng kháng sinh..... 4
Cost
Chi phí..... 5
Safety profile
Thông tin về tính an toàn..... 5
Spectrum
Phổ tác dụng 3
Tissue penetration
Ngấm thuốc vào mô 3
Antibiotic spectrum, defined
Phổ tác dụng của kháng sinh: định nghĩa 3
Antibiotic susceptibility profiles
Các thông tin về độ nhạy cảm của vi sinh vật với kháng sinh 323
aminoglycosides, fluoroquinolones carbapenems, others
aminoglycosid, fluoroquinolon carbapenem và các kháng sinh khác .....332 b
cephalosporins
cephalosporin 328b
penicillins, macrolides, tetracyclines, others
penicillin, macrolid, tetracyclin và các kháng sinh khác.....323 b
Antibiotic therapy bactericidal vs. bacteriostatic
Kháng sinh kìm (cản) khuẩn so với kháng sinh diệt khuẩn
Therapy
Phác đồ 7
Bioavailability
Sinh khả dụng ..... 18 b
Cytochrome P450 isoenzymes
Cytochrom P450 isoenzym.....818 b
Dosing
Chế độ liều..... 7
Duration of therapy
Khoảng thời gian điều trị 19
Empiric therapy. See also Empiric therapy

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Điều trị theo kinh nghiệm 20
Intravenous vs. oral switch therapy
Điều trị theo đường tĩnh mạch so với chuyển sang điều trị đường uống..... 16
Mono vs. combination therapy
Điều trị một kháng sinh đơn độc so với phác đồ phối hợp kháng sinh 16
Pearls & pitfalls
Điểm nhấn và những sai lầm cần tránh.... 789
Selection, when isolate is known
Lựa chọn kháng sinh khi đã phân lập được vi khuẩn gây bệnh ..... 341 b
Antimicrobial therapy. See Antibiotic therapy
Thuốc kháng sinh… Xem thêm phần điều trị kháng sinh
Anti-nuclear antibody titers (ANA), elevation, rheumatic test abnormalities (DDx)
Hiệu giá kháng thể kháng nhân (ANA), các bất thường xét nghiệm bệnh miễn dịch (Chẩn đoán phân biệt)..... 781 b
Antiretroviral therapy
Điều trị thuốc chống retrovirus..... 515 b
Anti-smooth muscle antibodies (ASM), elevation, rheumatic test abnormalities (DDx)
Tăng nồng độ kháng thể kháng cơ trơn (ASM), các bất thường xét nghiệm bệnh miễn dịch (Chẩn đoán phân biệt) ..... 781 b
Aortic graft infection
Nhiễm trùng cầu nối động mạch chủ 150
Aphthous ulcers
Loét họng miệng Áp-tơ..... 83
Appendicitis
Viêm ruột thừa 181
Aptivus (tipranavir)..... 1066
APV (amprenavir)..... 848
Arachnia propionica
Arachnia propionica 383
Arava 971
Arboviral encephalitis
Viêm não do Arbovirus..... 47, 633
Arcanobacterium, pharyngitis
Viêm họng do Arcanobacterium 73
Arcanobacterium (Corynebacterium) haemolyticum
Tan máu do Arcanobacterium (Corynebacterium)..... 354 b
Argyll-Robertson pupils, eye abnormalities (DDx)
Đồng tử Argyll-Robertson, các bệnh lý về mắt (Chẩn đoán phân biệt)..... 746 b
Arm lesions nodular, extremity abnormalities (DDx)
Tổn thương dạng u nhỏ ở tay, chân (Chẩn đoán phân biệt)..... 765 b
Verrucous
Mụn cơm..... 763 b
Arthritis, Lyme
Viêm khớp, bệnh Lyme 226
Arthritis, septic
Viêm khớp nhiễm khuẩn 217
Arthroscopy, surgical prophylaxis
Nội soi khớp, kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật..... 582 b
ART therapy, HIV infection,
Điều trị thuốc chống retrovirus (ART), nhiễm HIV ..... 515 b
Ascariasis
Ascariasis 459
Ascaris lumbricoides
Ascaris lumbricoides 459
Ascites, abdominal abnormalities (DDx)
Dịch cổ trướng, các bệnh lý ổ bụng (Chẩn đoán phân biệt)..... 758 b
Aspergilloma, pulmonary
U nấm phổi do Aspergillus..... 531
Aspergillosis, cutaneous
U nhỏ trên da do Aspergillus..... 765
Aspergillus
Aspergillus..... 338 b
Acute pneumonia
Viêm phổi cấp..... 122
Bronchopulmonary Aspergillosis (BPA)
Nhiễm nấm phế quản phổi do Aspergillus (BPA)..... 772
Chronic medical prophylaxis
Dự phòng nội khoa mạn tính..... 595 b
Community-acquired pneumonia

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng.....89
Cutaneous aspergillosis
Bệnh do nấm Aspergillus trên da.....478
Febrile neutropenia
Sốt giảm bạch cầu 280
HIV/AIDS.....500
Organ transplants
Ghép tạng.....283
Pneumonia acute invasive
Viêm phổi xâm nhập cấp tính 438
chronic
Viêm phổi xâm nhập mạn tính.....438
Pulmonary aspergilloma
U nấm Aspergillus ở phổi.....436
sepsis
nhiễm khuẩn huyết.....273
transplant infections
nhiễm trùng ở người được ghép tạng 183, 284
Aspiration pneumonia
Viêm phổi do hít vào phổi.....118
Asplenia
Không có lách 274
Asplenia/ impaired splenic function, chronic medical prophylaxis
Không có lách/giảm chức năng lách, dự phòng nội khoa mạn tính.....593 b
Asymptomatic bacteriuria in pregnancy, chronic medical prophylaxis
Có vi khuẩn niệu không triệu chứng ở phụ nữ có thai, dự phòng nội khoa mạn tính.....593 b
Atazanavir (ATV).....852
Atelectasis, unilateral focal segmental/ lobar infiltrate without effusion
Xẹp phổi, xâm nhiễm khu trú một bên không kèm tràn dịch màng phổi 692
Athlete's foot
Bàn chân vận động viên.....263
Atovaquone
Atovaquon 855
Atovaquone + proguanil
Atovaquon + proguanil 856
Atripla [efavirenz (EFV) + emtricitabine (FTC) + tenofovir (TDF)]
Atripla [efavirenz (EFV) + emtricitabine (FTC) + tenofovir (TDF)] 927
ATV (atazanavir) 852
Atypical lymphocytes, WBC abnomalities (DDx)
Các bạch cầu lympho không điển hình, các bất thường của bạch cầu (Chẩn đoán phân biệt) 761b
Augmentin 837
ES-600
ES-600 837
XR formulation
Công thức XR.....839
Avelox 984
AV graft infection
Nhiễm trùng cầu nối động tĩnh mạch.....150
Avian influenza
Cúm gia cầm ..... 112 ,585
Community-acquired pneumonia
Viêm phổi mắc phải ở cộng đồng.....92
Post-exposure prophylaxis
Dự phòng sau phơi nhiễm.....585 b
Axillary adenopathy, lymth node abnormalities (DDx)
Hạch to, bệnh lý hạch lympho (Chẩn đoán phân biệt).....760 b
Azactam 860
Azidothymidine
Azidothymidin.....1085
azithromycin.....857
Pediatric dose
Liều dùng cho trẻ em 676
AZT (zidovudine).....1085

B

B.cepacia, community-acquired pneumonia
Viêm phổi từ cộng đồng.....96
Babesia microti
Babesia microti.....419
Bebesiosis

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh do Babesia 419
Bacillary angiomatosis
U mạch do trực khuẩn 477
Bacille Calmette Guérin (BCG)
Bacille Calmette Guérin (BCG)
Adult immunization
Tiêm chủng ở người lớn ....613 b
Granulomatous hepatitis
Viêm gan u hạt 172
Sepsis
nhiễm khuẩn huyết 273
Bacillus anthracis
Bacillus anthracis 354
anthrax
Bệnh than 303
Bacillus cereus
Bacillus cereus 355
Keratitis
Viêm giác mạc 59
Subtilis, megaterium
B. subtilis, B. megabacterium ....354 b
Back abnormalities (DDx)
Bệnh lý ở lưng (Chẩn đoán phân biệt)
D'espine's sign
Dấu hiệu tổn thương cột sống ngực ....755 b
Spinal tenderness
Đau vùng cột sống ....755 b
Unilateral CVA tenderness
Ấn đau hố lưng một bên ....755 b
Bacteremias transplant infections
Nhiễm trùng ở người được ghép tạng 283
Bacterial conjunctivitis
Viêm kết mạc do vi khuẩn 60
Bacterial endophthalmitis
Viêm nội nhãn do vi khuẩn 66
Bacterial pharyngitis
Viêm họng do vi khuẩn 74
Bacterial resistance, to antimicrobial therapy
Vi khuẩn kháng thuốc 4
Bacterial sinusitis
Viêm xoang do vi khuẩn 57
Bactericidal vs. bacteriostatic therapy
Điều trị kháng sinh diệt khuẩn so với điều trị kháng sinh kìm khuẩn 16
Bacteroides fragilis
Bacteroides fragilis ....388 b
Acute pancreatitis
Viêm tụy cấp 169
Decubitus ulcers
Loét to tì đè 243
Diabetic foot ulcers
Loét bàn chân ở người bị đái tháo đường 246
Endometritis
Viêm nội mạc tử cung 202
Group
nhóm ....382 b
intraabdominal abscess
ápxe trong ổ bụng 181
ischiorectal/ perirectal abscess
ápxe ụ ngồi trực tràng/quanh trực tràng 267
liver abscess
ápxe gan 170
osteomyelitis
viêm tủy xương 231
pancreatic abscess
ápxe tụy 169
PID
Bệnh lý viêm nhiễm tiểu khung 202
salpingitis
Viêm vòi tử cung 202
Sepsis
nhiễm khuẩn 268
septic abortion
sảy thai do nhiễm trùng 202
surgical prophylaxis
dự phòng trong phẫu thuật 567
tuboovarian abscess
ápxe phần phụ 202
Bactrim 1071
Balanitis

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm quy đầu 207
Balantidiasis
Bệnh do nấm Balantidium 455
Balantidium coli
Balantidium coli 455
Baraclude 936
Bartonella henselae
Bartonella henselae
Cat scratch disease
Bệnh do mèo cào 257
quintana, bacilliformis
quintana, bacilliformis ..... 360 b
Bartonella sp. bacillary angiomatosis
Bệnh u mạch do bacillary 479
Basophilia WBC abnormalities (DDx)
Tăng bạch cầu ái kiềm (Chẩn đoán phân biệt) ..... 772 b
Bedaquiline
Bedaquilin 94
Beef tapeworm
Sán dây bò 461
Bell's palsy, neurological abnormalities (DDx)
Liệt dây VII ngoại biên, bệnh lý hệ thần kinh (Chẩn đoán phân biệt) ..... 768 b
β-hemolytic streptococci, usual/ unusual susceptibility patterns
Liên cầu tan máu β, đặc điểm nhạy cảm thường gặp và không thường gặp ..... 12 b
β –lactamase inhibitor combinations, pearls & pitfalls
Phối hợp với chất ức chế β-lactamase, Điểm nhấn và các sai lầm cần tránh 797
Biaxin 901
Biaxin XL 903
Bifidobacterium sp
Bifidobacterium sp 384
Biliary tract penetration explanation
Giải thích khả năng thấm vào đường mật 820
Biliary tract surgery surgical prophylaxis
Dự phòng trong phẫu thuật đường mật ... 580 b
Bilirubin, total, elevation, liver test abnormalities (DDx)
Tăng Bilirubin toàn phần, các bất thường xét nghiệm chức năng gan (Chẩn đoán phân biệt) ..... 780 b
Bioavailability
Sinh khả dụng
Explanation
Giải thích 816
Oral antimicrobials
Kháng sinh dùng đường uống ..... 18 b
Bioterrorist agents in adults
Tác nhân khủng bố sinh học ở người lớn
Treatment
Điều trị 303
anthrax
Bệnh than 304
Botulism
Độc tố botulism 304
Ebola
virus Ebola 304
pneumonic plague
Bệnh than thể hô hấp 303
Smallpox
Đậu mùa 304
Tularemic pneumonia
Viêm phổi tularemia 306
BK virus, transplant infections
Virus BK, nhiễm trùng ở người được ghép tạng 286
β-lactams. See individual penicillins cephalosporins
β-lactam. Xem phần riêng biệt đối với penicillin, cephalosporin.
Blastocystis
Nhiễm nấm Blastocystis 455
Blastocystis hominis
Blastocystis hominis 455
Blastomyces dermatitidis
Blastomyces dermatitidis
Cutaneous blastomycosis
Bệnh nấm Blastomyces ở da 470
Epididymitis
Viêm mào tinh hoàn 188

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Pulmonary blastomycosis
Bệnh Blastomyces ở phổi 437
Blood, parasites, fungi, unusual organisms in
Nấm, kí sinh trùng và các vi sinh vật ít gặp trong máu 409
Bloody pleural fluid abnormalities (DDx)
Tràn máu màng phổi (Chẩn đoán phân biệt) ..... 698 b
Boceprevir 862
Body fluid secretions, travel precautions
Dịch tiết của cơ thể, thận trọng khi đi du lịch ..... 606 b
Body lice
Chấy rận 265
Bone infections, empiric therapy of
Nhiễm khuẩn xương: điều trị theo kinh nghiệm 217
Bone marrow transplant (BMT), transplant infections
Nhiễm trùng ở người được ghép tủy xương/ ghép tạng 283
Bordetella pertussis
Bordetella pertussis hay vi khuẩn ho gà ..... 360 b
Community-acquired pneumonia
Viêm phổi mắc phải ở cộng đồng 99
Post-exposure prophylaxis
Dự phòng sau phơi nhiễm ..... 584 b
Borrelia burgdorferi
Borrelia burgdorferi 378
Lyme disease
Bệnh Lyme 226
Meningitis
Viêm màng não 39
Pericarditis/myocarditis
Viêm màng ngoài tim /viêm cơ tim 142
Vincent's angina
Viêm họng Vincent 44
Borrelia recurrentis
Borrelia recurrentis 279b
Relapsing fever
Sốt hồi quy 417
Botulism
Độc tố botulism 300, 304
Bioterrorist
Khủng bố sinh học 304
Boutonneuse fever
Sốt nổi mụn 490
Brachiola, microsporidia enteritis
Viêm ruột do Brachiola, microsporidia 551
Brain
Não
Cysts/mass lesions in
Nang/tổn thương dạng khối 425
Parasites, fungi, unusual organisms in
Kí sinh trùng, nấm và các vi sinh vật ít gặp trong não 425
Brain abscess
Ápxe não 51
Cardiac source
Nguồn gốc từ tim 52
Dental source
Nguồn gốc từ răng 51
Mastoid/otitic source
Nguồn gốc từ tai/xương chũm 52
Neurosurgical procedure
Thủ thuật/phẫu thuật thần kinh 52
Open trauma
Chấn thương hở 52
Pulmonary source
Nguồn gốc từ phổi 53
Sinus source
Nguồn gốc từ xoang 52
Transplant infections
nhiễm trùng ở người được ghép tạng 283
Bronchiectasis
Giãn phế quản 121
Bronchiolitis obliterans with organizing pneumonia (BOOP), bilateral infiltrates without effusion
Viêm tiểu phế quản-phổi tắc nghẽn có tổ chức hóa (BOOP), xâm nhiễm hai phổi không kèm tràn dịch 720
Bronchitis, acute bacterial exacerbation of chronic (AECB)

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Đợt cấp của viêm phế quản mạn tính (AECB) 87
Bronchogenic carcinoma, unilateral ill-defined infiltrates with effusion
Ung thư biểu mô phế quản, xâm nhiễm mờ một bên có tràn dịch 710
Without effusion
Không có tràn dịch màng phổi 704
Bronchogenic cyst, cavitary infiltrates (thin-walled)
Nang phế quản, xâm nhiễm dạng hang (thành mỏng) 736
Bronchopulmonary aspergillosis (BPA)
Bệnh do nấm Aspergillus phế quản-phổi (BPA) 442
Brownish pleural fluid abnormalities (DDx)
Dịch màng phổi màu nâu (Chẩn đoán phân biệt) .....784 b
Brucella sp 223
Endocarditis
Viêm nội tâm mạc 52
Meningitis
Viêm màng não 32
Septic arthritis
Viêm khớp nhiễm khuẩn 218
Brugia malayi
Brugia malayi 410
Bullae skin
Bọng nước trên da 251
Bull neck, neck abnormalities (DDx)
Cổ sưng to (to & ngắn), các bất thường ở cổ (Chẩn đoán phân biệt) .....753 b
Burkholderia cepacia
Burkholderia cepacia .....362 b
Burkholderia pseudomallei
Burkholderia pseudomallei .....362 b b
Bursitis septic
Viêm bao hoạt dịch nhiễm khuẩn 217
Buruli ulcer
Loét Buruli 474, 469

C

Calf tenderness, extremity abnormality (DDx)
Đau bắp chân, các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt) .....764 b
California encephalitis (CE)
Viêm não California (CE) 47
Camelback fever pattern, fever curves (DDx)
Sốt kiểu lưng lạc đà, đường cong sốt (Chẩn đoán phân biệt) .....741 b
Campylobacter sp.
Campylobacter sp.
Fetus
Thai nhi 362
Infectious diarrhea
Ỉa chảy nhiễm khuẩn 154
jejuni
tá tràng 263
HIV/AIDS 545
Travel prophylaxis
Dự phòng khi đi du lịch .....607 b
CA-MRSA. See Community acquired MRSA (CA-MRSA)
CA-MRSA. Xem Tụ cầu vàng kháng Methicilin mắc phải ở cộng đồng
c-ANCA, elevation, rheumatic test abnormalities (DDx)
Tăng c-ANCA, các bất thường xét nghiệm bệnh miễn dịch (Chẩn đoán phân biệt) .....781 b
Candida albicans
Candida albican .....242 b
candidemia
Nhiễm nấm Candida máu 161
Catheter-associated candiduria
Nhiễm Candida niệu do đặt ống thông tiểu 187
Chorioretinitis
Viêm màng mao mạch võng mạc 34
Chronic medical prophylaxis
Dự phòng nội khoa mạn tính .....595 b
Endophthalmitis

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm nội nhãn 66
esophagitis
Viêm thực quản 151
Febrile neutropenia
Sốt giảm bạch cầu 280
Fungal cystitis
viêm bàng quang do nấm 184
fungal peritonitis/ abscess
viêm phúc mạc/ápxe ổ bụng do vi khuẩn 181
hepatosplenic candidiasis
Nấm Candida ở gan và lách 171
IV line infection
Nhiễm trùng đường truyền tĩnh mạch 174
Mucocutaneous candidiasis
Nấm Candida ở da-niêm mạc 262
onychomycosis
bệnh nấm móng 263
sepsis
nhiễm khuẩn huyết 268
thrush
nấm, thực quản 151
vaginitis, in HIV
Viêm âm đạo, ở người nhiễm HIV/AIDS 556
Candida chorioretinitis
Viêm màng mạch võng mạc do Candida 63
Candidadiasis, oropharyngeal/ esophageal, HIV/AIDS
Nhiễm nấm Candida, miệng-họng/ thực quản, ở người nhiễm HIV/AIDS 552
Candida non-albicans
Candida không phải albican 392
Candidemia
Nấm Candida máu 292
Chronic medical prophylaxis
Dự phòng nội khoa mạn tính ..... 595 b
Febrile neutropenia
sốt giảm bạch cầu 280
fungal peritonitis/abscess
viêm phúc mạc/ápxe do vi khuẩn 181
IV line infection
Nhiễm trùng đường truyền tĩnh mạch 147
Pacemaker infection
nhiễm trùng liên quan đặt máy tạo nhịp 148
sepsis
nhiễm khuẩn huyết 268
Candidas
Nhiễm nấm Candida 292
Catheter-associated candiduria
Nhiễm trùng tiết niệu do Candida do đặt ống thông tiểu 187
Nodular/pustular candidiasis
Mụn/mủ do nấm Candida 479
Prosthetic valve endocarditis
Viêm nội tâm mạc do van nhân tạo 139
Candida vaginitis, balanitis
Viêm âm đạo/ viêm quy đầu do nấm Candida . 297
Candidemia, transplant infections
Nhiễm nấm Candida máu, nhiễm trùng ở người được ghép tạng 292
Capastat 863
CAPD-associated peritonitis
Viêm phúc mạc liên quan với lọc màng bụng ngoại trú liên tục 180
Capillaria philippinensis
Capillaria philippinensis 457
Capillariasis
Nhiễm giun Capillaris 457
Capnocytophaga canimorsus/ cynodegni
Capnocytophaga canimorsus/cynodegni ..... 380 b
Capnocytophaga ochraceus
Capnocytophaga ochraceus ..... 380 b
Capnophilic isolates, clinical significance, pending susceptibility testing
Các căn nguyên ưa CO_2, những lưu ý lâm sàng khi chưa có xét nghiệm độ nhạy kháng sinh 380 b
Capreomycin 863
Carbapenems
Carbapenem
Pearls & pitfalls
Điểm nhấn và các sai lầm cần tránh 797
Susceptibility profiles
Các thông tin về độ nhạy cảm của vi sinh vật với thuốc ..... 332 b

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Cardiac conditions, indications for infective endocarditis (IE) prophylaxis
Các bệnh lý tim mạch, chỉ định dự phòng cho viêm nội tâm mạc nhiễm trùng ..... 602 b
Cardiac valve replacement, surgical prophylaxis
Thay van tim, dự phòng trong phẫu thuật ..... 579 b
Cardiobacterium hominis
Cardiobacterium hominis 363
Endocarditis
Viêm nội tâm mạc 132
Cardiovascular infections, empiric therapy
Nhiễm khuẩn tim mạch, kháng sinh kinh nghiệm 129
Carpal tunnel syndrome, extremity abnormalities (DDx)
Hội chứng ống cổ tay, các bất thường ngọn chi ..... 764 b
Caspofungin 864
Pediatric dose
Liều dùng cho trẻ em 653
Catheter-associated bacteriuria (CAB)
Có vi khuẩn niệu liên quan với ống thông tiểu (CAB) 186
Catheter-associated candiduria (CAC)
Nhiễm nấm Candida niệu liên quan với ống thông tiểu (CAC) 187
Cat scratch disease (CSD)
Bệnh do mèo cào (CSD) 257
Pediatric
Trẻ em hay nhi khoa 669
Cavernous vein thrombosis
Huyết khối tĩnh mạch xoang hang 51
CD_4 cell counts, in HIV
Đếm số lượng CD 4, HIV 509
Ceclor 867
Cedax 888
Cefaclor 867
Cefadroxil 868
Cefamandole
Cefamandol 868
Cefazolin 869
Pediatric dose
Liều dùng cho trẻ em 676
cefdinir 871
Cefditoren 872
Cefepime
Cefepim 873
Pediatric dose
Liều dùng cho trẻ em 677
Cefixime
Cefixim 875
Cefizox 889
Cefobid 878
Cefoperazone
Cefoperazon 876
Cefotan 878
Cefotaxime
Cefotaxim 868
Pediatric dose
Liều dùng cho trẻ em 656
Cefotetan 878
Cefoxitin 882
Pediatric dose
Liều dùng cho trẻ em 677
Cefpodoxime
Cefpodoxim 880
Cefprozil 881
Ceftolozane/tazobactam
Ceftolozan/tazobactam 887
Ceftaroline fosamil
Ceftaroline fosamil 882
Ceftazidime
Ceftazidim 884
Pediatric dose
Liều dùng cho trẻ em 677
Ceftibuten 888
Ceftin 892
Ceftizoxime
Ceftizoxim 889
Ceftriaxone
Ceftriaxon 890
Pediatric dose

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Liều dùng cho trẻ em.....677
Cefuroxime
Cefuroxim 892
Pediatric dose
Liều dùng cho trẻ em 677
Cefzil 881
Cellulitis
Viêm mô tế bào
Above-the-waist
Trên eo 236
Below-the-waist
Dưới eo.....237
Facial
Vùng mặt 55
Pediatric
Nhi khoa 635
Periorbital
quanh hốc mắt 55
Severe
nặng 242
Central IV line (CVC) infections
Nhiễm trùng liên quan catheter tĩnh mạch trung tâm 144
Cephalexin 893
Cephalosporins, susceptibility profiles
Cephalosporin, các thông tin về độ nhạy cảm của vi sinh vật với kháng sinh .....328 b
Cerebral amebiasis
Amip não 425
Cerebral coenurosis
Bệnh sán nhiều đầu ở não 426
Cerebral echinococcosis (hydatid cyst disease)
Sán dây nhỏ ở não 426
Cerebral gnathostomiasis
Bệnh do giun gnathostoma ở não.....426
Cerebral nocardiosis
Nhiễm Nocardia ở não.....426
Cerebral paragonimiasis (lung fluke)
Sán lá phổi thể não 426
Cerebral toxoplasmosis
Toxoplasma thể não.....426
Cerebrospinal fluid (CSF) abnormalities (DDx)
Các bất thường của dịch não tủy 786
Cerebrospinal fluid penetration, explanation
Ngấm thuốc vào dịch não tủy, bình luận.....817
Cervicitis
Viêm cổ tử cung
gonococcal
Do lậu cầu 204
Non-gonococcal
Không phải lậu cầu 204
Cestodes (tapeworms), intestinal
Cestodes (sán dây), đường ruột.....461
Chagas' disease (American trypanosomiasis)
Bệnh Chagas
(bệnh do Trypanosoma châu Mỹ) 413, 447
Blood
Máu 412
Cerebral
Não 426
Heart
Tim 755
Chlamydophilia
Chlamydophilia
Community-acquired pneumonia
Viêm phổi mắc phải ở cộng đồng.....103
Pharyngitis
Viêm họng.....76
Chancroid
Hạ cam 209
Post-exposure prophylaxis
Dự phòng sau phơi nhiễm ..... 584 b
Chest abnormalities (DDx) chest dullness, consolidation/pleural effusion
Các bất thường ở lồng ngực (Chẩn đoán phân biệt) gõ đục/tràn dịch màng phổi.....754 b
Chest wall sinuses
Rò thành ngực .....754 b
Costochondral tenderness
Sưng đau sụn sườn .....754 b
Diffuse wheezing
Thở rít lan tỏa hai phổi .....754 b

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Shoulder tenderness
Căng đau vùng vai ..... 494 b
Spontaneous pneumothorax
Tràn khí màng phổi tự nhiên.....754 b
Sternal tenderness
Đau xương ức 754b
Trapezius tenderness
Sưng đau cơ thang .....754 b
Chest dullness, consolidation/pleural effusion, chest abnormalities (DDx)
Gõ đục trường phổi, tràn dịch màng phổi , các bất thường ở lồng ngực (Chẩn đoán phân biệt)..... 754 b
Chest wall sinuses, chest abnormalities (DDx)
Rò thành ngực, các bất thường thành ngực (Chẩn đoán phân biệt).....754 b
Chest x-ray atlas
Atlas phim chụp X quang ngực..... 688
Bilateral infiltrates with effusion
Xâm nhiễm hai phổi kèm tràn dịch màng phổi 721
Infectious causes
Nguyên nhân nhiễm khuẩn 721
Noninfectious causes
Nguyên nhân không do nhiễm khuẩn.....722
Bilateral infiltrates without effusion
Xâm nhiễm hai phổi không có tràn dịch màng phổi 712
Infectious causes
Nguyên nhân nhiễm khuẩn 712
Non-infectious causes
Nguyên nhân không do nhiễm trùng.....716
Cavitary infiltrates (thick-walled)
Xâm nhiễm dạng hang (thành dày).....726
Infectious causes
Nguyên nhân nhiễm khuẩn 727
Infectious causes based on speed of cavitation
Nguyên nhân nhiễm khuẩn dựa trên tốc độ hình thành hang..... 726
Non-infectious causes
Nguyên nhân không do nhiễm khuẩn.....732
Cavitary infiltrates (thin-walled)
Xâm nhiễm dạng hang (thành mỏng).....734
Infectious causes
Nguyên nhân nhiễm khuẩn.....734
Non-infectious causes
Nguyên nhân không do nhiễm khuẩn 736
unilateral focal segmental/lobar infiltrate with effusion
Xâm nhiễm thùy hoặc tiểu thùy khu trú một bên có tràn dịch màng phổi 694
Infectious causes
Nguyên nhân nhiễm khuẩn.....694
Non-infectious causes
Nguyên nhân không do nhiễm khuẩn 698
unilateral focal segmental/lobar infiltrate without effusion
Xâm nhiễm thùy hoặc tiểu thùy khu trú một bên không có tràn dịch màng phổi 689
Infectious causes
Nguyên nhân nhiễm trùng.....690
Non-infectious causes
Nguyên nhân không do nhiễm khuẩn 692
Unilateral ill-defined infiltrates with effusion
Xâm nhiễm mờ một bên có tràn dịch màng phổi 707
Infectious causes
Nguyên nhân nhiễm khuẩn 707
Non-infectious causes
Nguyên nhân không do nhiễm khuẩn 709
unilateral ill-defined infiltrates without effusion
Xâm nhiễm ranh giới không rõ một bên không có tràn dịch màng phổi 700
Infectious causes
Nguyên nhân nhiễm khuẩn 700
Non-infectious causes
Nguyên nhân không do nhiễm khuẩn 704

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

chickenpox
Thủy đậu
pediatric
ở trẻ em 672
therapy
phác đồ điều trị 669
Chlamydia trachomatis
Chlamydia trachomatis
Conjunctivitis
viêm kết mạc 62
Dysuria-pyuria syndrome
Hội chứng đái khó-đái mủ 183
Endometritis
viêm nội mạc tử cung....202
Epididymitis
viêm mào tinh hoàn 188
lymphogranuloma venereum
u hạt bạch huyết hoa liễu (LGV) hay bệnh hạt xoài hay bệnh Nicolas-Fabre....211
PID
Bệnh lý viêm tiểu khung 202
salpingitis
Viêm vòi tử cung 202
septic abortion
Sảy thai do nhiễm trùng 202
tuboovarian abscess
ápxe phần phụ. 202
urethritis/cervicitis
viêm niệu đạo/viêm cổ tử cung....204
Chlamydophilia
Chlamydophilia (Chlamydia)
Community-acquired pneumonia
viêm phổi mắc phải ở cộng đồng 89
Chlamydophilia (Chlamydia)
Chlamydophilia (Chlamydia)
pneumoniae 89
Community-acquired pneumonia
viêm phổi mắc phải ở cộng đồng.89
pharyngitis
viêm họng....76
Chlamydophilia (Chlamydia) psittaci (psittacosis)
Chlamydophilia (Chlamydia) psittaci (Virus vẹt)
Community-acquired pneumonia
viêm phổi mắc phải ở cộng đồng 89
endocarditis
viêm nội tâm mạc....132
zoonotic atypical pneumonia
viêm phổi không điển hình lây từ động vật sang người 107
Chloramphenicol 886
Pearls & pitfalls
Điểm nhấn và các sai lầm cần tránh 799
Chloromycetin 894
Cholangitis
Viêm đường mật....165
Cholecystitis
Viêm túi mật....165
emphysematous
viêm túi mật khí thũng....165
Chorioretinitis
Viêm màng mạch võng mạc....63
Eye abnormalities (DDx)
Các bất thường của mắt (Chẩn đoán phân biệt)....746 b
Chromobacterium violaceum
Chromobacterium violaceum....374
Chromomycosis
Chromomycosis 481
Chronic bacterial sinusitis
Viêm xoang mạn do vi khuẩn 58
Chronic fatigue syndrome (CFS)
Hội chứng mệt mỏi mạn tính 76
Chronic infections. See specific clinical syndromes
Nhiễm trùng mạn tính. Xem các Hội chứng lâm sàng đặc biệt
Chronic mastoiditis
Viêm xương chũm mạn tính 72
Chronic medical prophylaxis
Dự phòng nội khoa mạn tính....595 b
Acute exacerbation of chronic bronchitis

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

(AECB)
Đợt tiến triển cấp của viêm phế quản phổi mạn (AECB) ..... 595 b
Acute rheumatic fever (ARF)
Sốt thấp khớp cấp ..... 595 b
asplenia/impaired splenic function
không có lách/rối loạn chức năng lách ..... 593 b
asymptomatic bacteriuria in pregnancy
Có vi khuẩn niệu không triệu chứng ở phụ nữ có thai ..... 593 b
Neonatal group B streptococcal (GBS) infection (primary prevention)
Nhiễm trùng liên cầu nhóm B ở trẻ sơ sinh (GBS) (dự phòng tiên phát) ..... 595 b
Prophylaxis of fungal infections in neutropenic patients
Dự phòng nhiễm nấm ở bệnh nhân giảm bạch cầu hạt ..... 594 b
Recurrent genital herpes (less than 6 episodes/year)
Herpes sinh dục tái phát (dưới 6 đợt/năm) ..... 594 b
Recurrent genital herpes (more than 6 episodes/year)
Herpes sinh dục tái phát (trên 6 đợt/năm) ..... 594 b
UTIs (recurrent)
Nhiễm khuẩn tiết niệu (tái phát) ..... 593 b
Chronic meningitis
Viêm màng não mạn tính 46
Chryseobacterium (Flavobacterium) meningosepticum
Chryseobacterium (Flavobacterium) meningosepticum 364
Chyluria, urinary abnormalities (DDx)
Đái dưỡng chấp, các bất thường của nước tiểu (Chẩn đoán phân biệt) ..... 783 b
Cidofovir 896
Cipro 897
Ciprofloxacin 897
Extended-release
phóng thích chậm 899
Cipro Xr 899
Citrobacter sp
Citrobacter sp 365
Cladosporium/fonsecaea, myositis
Cladosporium/fonsecaea, viêm cơ 493
Claforan 877
Clarithromycin 901
Clarithromycin XL 903
Cleocin 904
Clindamycin 904
Pearls & pitfalls
Điểm nhấn và các sai lầm cần tránh 800
pediatric dose
Liều dùng cho trẻ em 677
Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)
Viện tiêu chuẩn về lâm sàng và xét nghiệm (CLSI) 14
Clonorchiasis
Clonorchiasis 447
Clonorchis sinensis
Clonorchis sinensis 447
Clostridial myonecrosis
Clostridial myonecrosis 238
Clostridium botulinum
Clostridium botulinum 384
Botulism
Nhiễm độc tố botulinum 300
Clostridium difficile
Clostridium difficile 385
Diarrhea
Ỉa chảy 155
Colitis
Viêm đại tràng 155
Clostridium difficile diarrhea, HIV
Ỉa chảy do Clostridium difficile, ở người nhiễm HIV/AIDS 546
Clostridium perfringens
Clostridium perfringens
cholecystitis
viêm túi mật 164
C.septicum, C.novyi
C.septicum, C. novyi 386

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Clostridium sordelli
Clostridium sordelli
septic abortion
sảy thai nhiễm trùng 202
toxic shock syndrome
hội chứng sốc nhiễm độc 297
Clostridium sp. complicated skin/skin structure tissue infections
Clostridium sp. Nhiễm khuẩn da/cấu trúc da phức tạp 238
Clostridium tetani
Clostridium tetani 386
tetanus
uốn ván 301
clubbing, extremity abnormalities (DDx)
Ngón tay/chân hình dùi trống, các bất thường đầu chi ..... 762 b
CNS infections, empiric therapy
Nhiễm khuẩn thần kinh trung ương, điều trị theo kinh nghiệm 32
CNS shunt, surgical prophylaxis
Shunt thần kinh trung ương, dự phòng trong phẫu thuật ..... 579 b
CNS shunt infections, acute bacterial meningitis
Nhiễm trùng shunt thần kinh trung ương, viêm màng não mủ cấp 38
Coccidioides immitis
Coccidioides immitis
Chronic septic arthritis
viêm khớp nhiễm khuẩn mạn tính 224
cutaneous coccidioidomycosis
nấm Coccidioidomyces trên da 470
fungal arthritis
viêm khớp do nấm 220
HIV/AIDS 557
Pulmonary coccidioidomycosis
Bệnh nấm Coccidioidomyces ở phổi 444
Coccidiomycosis
Bệnh nấm Coccidiomyces
cavitary infiltrates (thin-walled)
xâm nhiễm dạng hang (thành mỏng) 735
cutaneous
trên da 275
meningitis
viêm màng não 32
coin lesions, pulmonary
Tổn thương dạng đồng xu ở phổi 436
Cold abscesses, cutaneous, extremity abnormalities (DDx)
Ápxe lạnh, các bất thường da đầu chi (Chẩn đoán phân biệt) ..... 765 b
Cold agglutinins, elevated, serum test abnormalities (DDx)
Tăng Agglutinin lạnh, các bất thường xét nghiệm huyết thanh (Chẩn đoán phân biệt) ..... 777 b
Colistin methanesulfonate
Colistin methanesulfonate 908
Colistin/polymyxin E 908
Colon surgery, surgical prophylaxis
Phẫu thuật đại tràng, dự phòng trong phẫu thuật ..... 581 b
Coly-Mycin M
Coly-Mycin M 906
Combination therapy vs. monotherapy
Điều trị kháng sinh đơn độc và điều trị kháng sinh kết hợp 16
Combivir [Lamivudine (3TC) + Zidovudine (ZDV)] 968
Community-acquired MRSA (CA-MRSA)
Tụ cầu vàng kháng methicilin mắc phải ở cộng đồng (CA-MRSA) 23
complicated skin/ skin structure tissue infections
nhiễm khuẩn da/cấu trúc da phức tạp 238
pyomyositis/necrotizing abscesses
viêm mủ cơ/ápxe cơ hoại tử 239
Community-acquired pneumonia (CAP)
Viêm phổi mắc phải ở cộng đồng (CAP). 89
Atypical pathogens
tác nhân gây bệnh không điển hình 99
avian influenza (H_5N_1, H_7, N_9)
cúm gia cầm (H5N1) 112
C. pneumoniae 92
C. psittaci (psittacosis)

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

C. psittaci (Virus vẹt) 92
Coxiella burnetii (Q fever)
coxiella burnetii (sốt Q) 91
Francisella tularensis (tularemia)
francisella tularensis (bệnh tularemia hay bệnh sốt thỏ) 91
influenza A
Cúm A 92
Legionella 92
M. pneumoniae 92
Swine influenza (H1N1)
Cúm lợn (H1N1) 93
Pertussis
Ho gà 99
Typical pathogens
Các tác nhân gây bệnh điển hình 89
B. pertussis 89
H. influenzae 89
M. catarrhalis 89
S.pneumoniae
Phế cầu 89
Community onset MRSA (CO-MRSA)
Nhiễm tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA) khởi phát ở cộng đồng ..... 23 b
Complera [Emtricitabine (FTC) + Rilpivirine (RPV) + Tenofovir (TDF)]
Complera [Emtricitabine (FTC) + Rilpivirine (RPV) + Tenofovir (TDF)] ..927
Complicated skin/skin structure tissue infections (cSSSIs)
Nhiễm trùng da/cấu trúc phức tạp 248
CO-MRSA. See Community onset MRSA
Concentration-dependent kinetics, antibiotics with
CO-MRSA. xem phần Dược động học của kháng sinh tác dụng phụ thuộc nồng độ trong điều trị nhiễm trùng tụ cầu kháng Methicillin (MRSA) khởi phát ở cộng đồng 23
Condylomata acuminata
Mụn cóc quanh hậu môn 212
Congestive heart failure
Suy tim tiến triển
Bilateral infiltrates with effusion
xâm nhiễm hai phổi có tràn dịch màng phổi 721
Conjunctival suffusion, eye abnormalities (DDx)
Xuất huyết dưới kết mạc, các bất thường của mắt (Chẩn đoán phân biệt) ..... 747 b
Conjunctivitis
Viêm kết mạc 61
bacterial
do vi khuẩn 61
trachoma
bệnh mắt hột 61
unilateral/bilateral, eye abnormalities (DDx)
Bất thường của mắt, ở một bên/ cả hai mắt (Chẩn đoán phân biệt) ..... 746 b
viral
do virus .....
Copegus
Copegus (thuốc điều trị viêm gan C) 1024
Corneal haziness, eye abnormalities (DDx)
Tình trạng đục giác mạc, các bất thường của mắt (Chẩn đoán phân biệt) ..... 748 b
Coronary artery bypass graft (CABG), surgical prophylaxis
Phẫu thuật làm cầu nối mạch vành (CABG), dự phòng trong phẫu thuật ..... 580 b
Corynebacterium diphtheriae 355
diphtheria
bệnh bạch hầu 298
Pericarditis/myocarditis
Viêm màng ngoài tim/viêm cơ tim 142
Pharyngitis
Viêm họng 73
Post-exposure prophylaxis
Dự phòng sau phơi nhiễm ..... 576 b
Corynebacterium hemolyticum, phary8ngitis
Viêm họng do Corynebacterium hemolyticum ..73
Corynebacterium jeikeium (JK)
Corynebacterium jeikeium (JK) 325
Corynebacterium minutissimum, erythrasma 467
Costochondral tenderness, chest abnormalities (DDx)

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Sưng đau sụn-sườn, các bất thường lồng ngực (Chẩn đoán phân biệt).....754 b
Coxiella burnetii (Q fever)
Coxiella burnetii (sốt Q)
community-acquired pneumonia
viêm phổi mắc phải ở cộng đồng do 89
Edocarditis
Viêm nội tâm mạc 132
Zoonotic atypical pneumonia
Viêm phổi không điển hình lây từ động vật sang người 107
Coxsackie A virus
Virus Coxsackie A
herpangina
herpangina 81
Pericarditis/myocarditis
viêm màng ngoài tim/viêm cơ tim 142
Crabs
Chấy rận 265
Cranial nerve abnormalities, unilateral/bilateral, neurological abnormalities (DDx)
Các bất thường thần kinh sọ, một bên/hai bên, các bất thường về thần kinh (Chẩn đoán phân biệt).....768 b
Crimson crescents, mouth abnormalities (DDx)
Trăng lưỡi liềm đỏ, các bất thường ở miệng (Chẩn đoán phân biệt).....752b
Crixivan (Indinavir).....958
Cryptosporidia enteritis, HIV/AIDS
Viêm ruột do Cryptosporidia, ở người nhiễm HIV/AIDS.....549
Cryptococcomas/meningitis
Cryptococcomas/viêm màng não.....425
Cryptococcosis, cutaneous
Nhiễm nấm Cryptococcosis, da.....479
Cryptococcus meningitis
Viêm màng não do Cryptococcus 45
Cryptococcus neoformans
Cryptococcus neoformans 392
Cryptococcomas/meningitis
cryptococcomas/viêm màng não.....425
cutaneous cryptococcosis
bệnh do nấm Cryptococcus ở da.....479
meningitis
viêm màng não 32
HIV/AIDS.....541
Pulmonary cryptococcosis
Bệnh nấm Cryptococcus ở phổi 445
Transplant infections
nhiễm trùng ở người được ghép tạng 283
Cryptosporidia
Bệnh do Cryptosporidium parvum 161
Chronic watery diarrhea, HIV/AIDS
Ỉa chảy phân nước mạn tính, ở người nhiễm HIV/AIDS 161
Travel prophylaxis
dự phòng khi đi du lịch .....607 b
Cryptosporidiosis
Bệnh do Cryptosporidium.....453
CSF
Dịch não tủy
Cysts/mass lesions in
Tổn thương dạng nang/khối 425
Parasites, fungi, unusual organisms in
kí sinh trùng, nấm, vi sinh vật hiếm gặp ... 425
CSF abnormalities (DDx)
Các bất thường dịch não tủy (Chẩn đoán phân biệt)
CSF eosinophils
Tăng bạch cầu ái toan trong dịch não tủy.....787 b
CSF lactic acid levels, elevation
Tăng acid lactic trong dịch não tủy.....787 b
CSF plasma cells
Các tế bào plasma trong dịch não tủy .....787 b
CSF with negative Gram stain and predominantly lymphocytes/ decreased glucose
Dịch não tủy với kết quả nhuộm Gram âm tính và có bạch cầu lympho ưu thế/ giảm nồng độ glucose trong dịch não tủy.....786 b
CSF with negative Gram stain and predominantly lymphocytes/normal glucose
Dịch não tủy với kết quả nhuộm Gram âm tính và có bạch cầu lympho ưu thế/ nồng độ glucose trong dịch não tủy bình thường .....786 b
CSF with negative Gram stain and

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

predominantly PMNs/decreased glucose
Dịch não tủy với kết quả nhuộm Gram âm tính và có tăng ưu thế bạch cầu đa nhân trung tính / giảm nồng độ glucose trong dịch não tủy.....786 b
Highly elevated CSF protein
Nồng độ protein trong dịch não tủy tăng cao.....787 b
Purulent CSF with negative Gram stain
Dịch não tủy mủ với kết quả nhuộm Gram tìm vi khuẩn âm tính .....776 b
RBCs in CSF
Có hồng cầu trong dịch não tủy.....786
CSF Gram stain, clinical use
Kết quả nhuộm Gram dịch não tủy, ứng dụng trong lâm sàng .....246 b
CSF lactic acid levels, elevation, CSF abnormalities (DDx)
Tăng nồng độ acid lactic trong dịch não tủy, các bất thường dịch não tủy (Chẩn đoán phân biệt).....787 b
CSF protein, highly elevated, CSF abnormalities (DDx)
Nồng độ protein trong dịch não tủy tăng cao, các bất thường dịch não tủy (Chẩn đoán phân biệt) .....787 b
Cubicin 598
Cutaneous actinomycosis
Bệnh nấm Actinomyces da .....468 b
Cutaneous alternaria
Bệnh nấm Alternaria ngoài da .....477 b
Cutaneous amebiasis
Bệnh Amíp da .....468 b
Cutaneous aspergillosis
Bệnh nấm Aspergillus ngoài da.....478
Cutaneous blastomycosis
Bệnh nấm Blastomyces da.....470
Cutaneous coccidioidomycosis
Bệnh nấm Coccidioidomyces da.....470
Cutaneous cold abscesses, extremity abnormalities (DDx)
Ápxe lạnh, các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt).....765 b
Cutaneous cryptococcosis
Bệnh do Cryptococcus da 479
Cutaneous fusarium
Bệnh nấm Fusarium trên da 481
Cutaneous gnathostomiasis
Nốt sần/hạt nhỏ trên da.....477
Cutaneous histoplasmosis
Nhiễm Histoplasma ở da 484
Cutaneous larva migrans (creeping eruption)
Di trú của ấu trùng ở da (ban di chuyển) 475
Cutaneous leishmaniasis (Old World/New World)
Leishmania da (thế giới cũ/thế giới mới) 465
Cutaneous MAI
MAI trên da 469
Cutaneous mycobacteria
Mycobacteria da 468
Cutaneous nocardiosis
Bệnh do Nocardia da.....471
Cutaneous onchocerciasis
Onchocerca da 479
Cutaneous penicillium
Bệnh do nhiễm nấm Penicillium ở da.....482
Cutaneous prototheca
Nhiễm vi tảo Prototheca trên da.....482
Cutaneous sporotrichosis
Sporothrix da.....479
Cutaneous zygomycosis (mucormycosis)
Nấm Zygomyces da (nhiễm nấm Mucormycosis) 477
CVA tenderness, unilateral, back abnormalities (DDx)
Căng đau hố thắt lưng một bên, các bất thường ở lưng (Chẩn đoán phân biệt) 755
Cycloserine
Cycloserine.....909
Cyclospora
Cyclospora 455
Diarrhea
tiêu chảy.....162
travel prophylaxis
dự phòng khi đi du lịch.....769 b
cystic bronchiectasis, cavitary infiltrates (thin-walled)

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Giãn phế quản dạng nang, xâm nhiễm dạng hang (thành mỏng) 737
Cystic fibrosis
Xơ hóa nang 121
Cystic lesions/masses
Tổn thương dạng nang/khối
CSF/brain
Dịch não tủy/não 425
Liver flukes
Sán lá gan....447
Pulmonary
Phổi 436
Cystitis
Viêm bàng quang 184
Bacterial
Do vi khuẩn 184
Candidal
Do nấm 184
Cystoscopy, surgical prophylaxis
Soi bàng quang, dự phòng trong phẫu thuật .... 583 b
Cysts/masses, infected
Nhiễm khuẩn nang/khối 248
Cytochrome P450 isoenzymes
Cytochrome P450 ....820 b
Cytoid bodies (cotton wool spots), eye abnormalities (DDx)
Thể dạng tế bào (đốm bông xơ), các bất thường về mắt (Chẩn đoán phân biệt)....749 b
Cytomegalovirus (CMV)
Bilateral infiltrates without effusion
xâm nhiễm hai phổi không có tràn dịch màng phổi 726
colitis
viêm đại tràng 546
community-acquired pneumonia
viêm phổi mắc phải từ cộng đồng 89
cytomegalovirus colitis
viêm đại tràng do cytomegalovirus....156
encephalitis
viêm não....50
HIV infection
nhiễm HIV....541
Esophagitis
viêm thực quản....151
HIV infection
nhiễm HIV. 548
hepatitis
viêm gan....176
meningitis
viêm màng não 45
pharyngitis
viêm họng....73
retinitis, HIV infection
viêm võng mạc, ở người nhiễm HIV 538, 539
transplant infections
nhiễm trùng ở người được ghép tạng.... 284
cytovene
Cytovene 953

D

D-actylitis, extremity abnormalities (DDx)
Viêm ngón, các bất thường chi (Chẩn đoán phân biệt)....762 b
Dapsone
Dapson 910
Daptomycin
Daptomycin....911
Pearls & pitfalls
Điểm nhấn và các sai lầm cần tránh....808
Daraprim 1027
Darunavir 915
Daskil 1056
ddC (zalcitabine).... 1083
Ddl (didanosine)....918
Deafness
Điếc
Acute, ear abnormalities (DDx)
các bất thường ở tai cấp tính (Chẩn đoán phân biệt) ....484 b

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

transient, neurological abnormalities (DDx)

các bất thường thần kinh thoáng qua (Chẩn đoán phân biệt) .....767 b

Decubitis ulcers

Loét do tì đè 243

Delavirdine (DLV)

Delavirdin 917

Dental infections, severe

Nhiễm khuẩn răng nặng 83, 85

Dermatophyte nail infections

Các nhiễm trùng móng do nấm da 264

D'espines sign, back abnormalities (DDx)

Dấu hiệu D'espines, các bất thường ở lưng (Chẩn đoán phân biệt) 755

Desquamation of hands/feet, extremity abnormalities (DDx)

Mất lớp sừng ở bàn tay/bàn chân, các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt) .....766 b

D4T (stavudine) 1045

Diabetes mellitus, chronic osteomyelitis

Đái tháo đường, viêm tủy xương mạn 246

Diabetic foot ulcers

Loét bàn chân ở người đái tháo đường 246

Diarrhea, infectious

Ỉa chảy nhiễm khuẩn 154

Acute watery

Phân nước, cấp tính 154, 158

C. difficile

C. difficile 155, 158

Chronic, watery

Phân nước, mạn tính 157,160

Typhoid/enteric fever

Sốt thương hàn đường ruột 154

Didanosine Ec (DDL) 918

Dientamoeba fragilis

Dientamoeba fragilis 453

Dientamoebiasis

Dientamoeba 453, 454

Differential diagnosis

Chẩn đoán phân biệt 739

Abdominal abnormailities

Các bất thường trong ổ bụng .....756 b

back abnormailities

Các bất thường ở lưng .....755 b

chest abnormailities

Các bất thường vùng ngực 753

CSF abnormailities

Các bất thường dịch não -tủy .....786 b

ear abnormailities

Các bất thường ở tai .....750 b

extremity abnormailities

Các bất thường ở chi 762b

eye abnormailities

Các bất thường của mắt .....746 b

fever curves

Biểu đồ nhiệt độ ở BN sốt .....741 b

general appearance abnormailities

Các bất thường khi thăm khám tổng quát .....742 b

genitourinary abnormailities

Các bất thường về tiết niệu sinh dục .....761 b

head abnormailities

Các bất thường vùng đầu .....744 b

heart abnormailities

Các bất thường tim .....755 b

liver test abnormailities

Các bất thường xét nghiệm chức năng gan .....779 b

lymph node abnormailities

Các bất thường của hạch lympho .....759 b

Mouth abnormailities

Các bất thường ở khoang miệng .....751 b

Nasal abnormailities

Các bất thường ở mũi .....750 b

neck abnormailities

Các bất thường vùng cổ .....753 b

neurological abnormailities

các bất thường hệ thần kinh .....767 b

platelet abnormailities

Các bất thường của tiểu cầu 775b

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

pleural fluid abnormailities
Các bất thường của dịch màng phổi ..... 784 b
RBC abnormailities
Các bất thường của hồng cầu ..... 773 b
Rheumatic test abnormailities
Các bất thường xét nghiệm bệnh miễn dịch ..... 780 b
Serum test abnormailities
Các bất thường của xét nghiệm huyết thanh ..... 776 b
Urinary abnormailities
Các bất thường của nước tiểu ..... 781 b
WBC abnormailities
Các bất thường của bạch cầu ..... 760 b
Diflucan 943
Digital gangrene, extremity abnormailities (DDx)
Hoại tử ngón, các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt) ..... 762 b
diphtheria
Bạch hầu 301, 302
Adult immunization
Tiêm chủng người lớn ..... 613 b
Post-exposure prophylaxis
dự phòng sau phơi nhiễm 586b
travel prophylaxis
dự phòng khi đi du lịch ..... 609 b
Diphyllobothrium latum, fish tapeworm
Diphyllobothrium latum, sán dây cá 461
Dirofilaria immitis, dog heartworm
Dirofilaria immitis, giun chỉ chó 436
Diskitis, pediatric
Viêm đĩa đệm, trẻ em 664
Distal small bowel surgery, surgical prophylaxis
Phẫu thuật ruột non đoạn xa, dự phòng trong phẫu thuật ..... 580 b
Diverticulitis
Viêm túi thừa 181
DLV (delavirdine) 917
Dog heartworm
Giun chỉ chó 436
Donovan bodies, granuloma inguinale
Donovan bodies, u hạt vùng bẹn 211
Doribax 921
Doripenem 921
Dosing
Chế độ liều
Adjustments, explanation
Chỉnh liều, giải thích 922
Antibiotics, factors in
Các yếu tố cần quan tâm trong chế độ liều kháng sinh 6
Recommendations, explanation
khuyến cáo, giải thích 802
double quotidian fevers, fever curves (DDx)
Sốt hai đỉnh trong ngày, biểu đồ nhiệt độ trong sốt (Chẩn đoán phân biệt) ..... 741 b
Double stranded DNA (DS-DNA), elevation, rheumatic test abnormalities (DDx)
Tăng kháng thể kháng chuỗi kép AND (DS-DNA), các bất thường trong xét nghiệm bệnh miễn dịch(Chẩn đoán phân biệt) ..... 781 b
Doxycycline
Doxycyclin 923
Dracunculus medinensis, Guinea worm
Dracunculus medinensis, giun Guinea 475
Drug fever, clinical features of
Sốt do thuốc, đặc điểm lâm sàng ..... 22 b
Drug-induced bilateral infiltrates
Xâm nhiễm phổi hai bên do thuốc
with effusion
có tràn dịch màng phổi 725
without effusion
không có tràn dịch màng phổi 712
DRV (darunavir) 915
Dry eyes, eye abnormalities (DDx)
Mắt khô, các bất thường ở mắt (Chẩn đoán phân biệt) ..... 748 b
Duration of therapy
Thời gian điều trị 18
Duricef 868
Dwarf tapeworm
Sán dây Dwarf 461
Dysentery, acute
Lỵ cấp

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

E. histolytica 162
shigella
Lỵ 162
Dysuria-pyuria syndrome (acute urethral syndrome)
Hội chứng tiểu khó, tiểu mủ (hội chứng niệu đạo cấp acute urethral syndrome) 183

E

E.basidiobolus, entomorphthoromycosis
E.basidiobolus, bệnh do entomophthoromyces 480
E. conidiobolus, entomophthoromycosis
E. conidiobolus, bệnh do entomorphthoromyces 480
Ear abnormalities (DDx)
Các bất thường ở tai (Chẩn đoán phân biệt)
Acute deafness
Điếc cấp ....750 b
External ear lesions
Các bệnh lý tai ngoài ....750 b
Ear lesions, external, ear abnormalities (DDx)
Bệnh lý tai, ống tai ngoài, trong tai (Chẩn đoán phân biệt) ....750 b
East African trypanosomiasis
Bệnh do trypanosoma Đông Phi 412
Eastern equine encephalitis (EEE)
Viêm não do ngựa vùng miền Đông Hoa kỳ 757
Ebola virus
Virus Ebola 304
Ebstein Barr virus (EBV)
Virus Ebstein Barr (EBV)
hepatitis
viêm gan 73
meningitis
viêm màng não 39
pharyngitis
viêm họng 73
transplant infections
nhiễm trùng ở người được ghép tạng ....283 b
Ecalta 850
Echinococcus granulosus
Echinococcus granulosus
Cerebral
Nhiễm echinococcus não 426, 428
hepatic echinococcosis
nhiễm echinococcus gan 449
Echinococcus multilocularis
Echinococcus multilocularis
Alveolar echinococcosis
nhiễm echinococcus phế nang 433
Cerebral echinococcosis
nhiễm echinococcus não 425
Edema, generalized, general appearance abnormalities (DDx)
Phù toàn thân, các bất thường khi thăm khám toàn thân (Chẩn đoán phân biệt) ....743 b
Edematous pancreatitis
Viêm tụy thể phù nề 169
Edurant (rilpivirine) 1038
Edwardsiella tarda
Edwardsiella tarda ....365 b
Efavirenz (EFV) 925
Efavirenz + emtricitabine + tenofovir disoproxil fumarate (Atripla)
Efavirenz + emtricitabin + tenofovir disoproxil fumarat (Atripla) 927
EFV (efavirenz) 925
EFV/FTC/TDF (Atripla) 927
Ehrlichia chaffeensis (HME)
Ehrlichia chaffeensis (HME) 419
Ehrlichia ewubguum
Ehrlichia ewubguum 419
Ehrlichiosis
Ehrlichiosis/anaplasmosis 419
Ehrlichiosis (HME)
Ehrlichiosis (HME/HGA) 419
Eikenella corrodens
Eikenella corrodens ....381 b
endocarditis

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

viêm nội tâm mạc 132
human bite wounds
vết thương do người cắn 257
septic arthritis
viêm khớp nhiễm khuẩn 219
elephant skin, general appearance abnormalities (DDx)
Dấu hiệu da voi, các bất thường khi khám toàn thân (Chẩn đoán phân biệt) ..... 743 b
Elvitegravir + Combicistat + Emtricitabine + Tenofovir (Stribild) 610
EMB
Ethambutol 940
Emphysema, cavitary infiltrates (thin-walled)
Giãn phế nang (các bọng khí/kén khí, xâm nhiễm dạng hang (thành mỏng) 736
Emphysematous cholecystitis
Viêm túi mật khí thũng 165
Empiric antibiotic therapy, antibiotic spectrum as basis for
Phác đồ kháng sinh kinh nghiệm, phổ tác dụng của kháng sinh cơ bản 3
Empiric therapy
Điều trị theo kinh nghiệm
Bone and joint infections
nhiễm trùng xương và khớp 217
Cardiovascular infections
nhiễm khuẩn tim mạch 129
CNS infections
Nhiễm trùng thần kinh trung ương 32
pediatric
trẻ em 628
gastrointestinal tract infections
nhiễm khuẩn đường tiêu hóa 151
pediatric
trẻ em 656
genitourinary tract infections
nhiễm trùng đường tiết niệu - sinh dục 184
HEENT infections
Nhiễm khuẩn vùng đầu mặt cổ 55
pediatric
trẻ em 635
lower respiratory tract infections
nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới 87
pediatric
trẻ em 635
sexually transmitted diseases
bệnh lây qua đường tình dục 204
skin and soft tissue infections
nhiễm khuẩn da và mô mềm 236
pediatric
trẻ em 668
syndrome based
dựa vào hội chứng 29
vascular infections, pediatric
nhiễm khuẩn mạch máu, trẻ em 653
Empyema
Mủ màng phổi 123
Subdural
dưới màng cứng 51
Emtricitabine (FTC)
Emtricitabin (FTC) 930
Emtricitabine + Rilpivirine + Tenofovir (Complera) 933
Emtricitabine (FTC) + tenofovir (TDF) [Truvada] 931
Emtriva (emtricitabine)
Emtriva (emtricitabine) 930
Encephalitis
Viêm não 47
Amebic, granulomatous
U hạt do amíp 428
arboviral
Arbo virus 47
CMV, HIV 539
HHV-6 47
HSV-1 47
Liseria 47
Mycoplasma 47
Organ transplants
ghép tạng 288
pediatric
trẻ em 632

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

primary amebic meningo-encephalitis
viêm não/màng não tiên phát do amíp ... 425
toxoplasma, HIV
toxoplasma, ở người nhiễm HIV/AIDS..... 544
encephalopathy, acute, neurological abnormalities (DDx)
Bệnh não cấp, các bất thường của hệ thần kinh (Chẩn đoán phân biệt).....767 b
endocarditis
Viêm nội tâm mạc
Acute bacterial (ABE)
Nhiễm trùng cấp (ABE) 54, 138
IV drug abusers
ở người tiêm chích ma túy 137
prosthetic valve (PVE)
Van nhân tạo (PVE).....171
Subacute bacterial (SBE)
nhiễm khuẩn bán cấp (SBE) 129
culture negative
Cấy máu âm tính 134, 135
GI/GU source
Nguồn gốc tiêu hóa/tiết niệu - sinh dục... 134
No obvious source
Không rõ nguồn gốc.....133
Endocarditis prophylaxis for above-the-waist (dental, oral, esophageal, respiratory tract) procedures
Dự phòng Viêm nội tâm mạc do các thủ thuật trên eo (răng, miệng, thực quản, đường hô hấp
IV prophylaxis
Dự phòng theo đường TM.....603b
Oral prophylaxis
Dự phòng theo đường uống.....603 b
Endocarditis prophylaxis for below-the-waist (genitourinary, gastrointestinal) procedures
Dự phòng viêm nội tâm mạc đối với các thủ thuật dưới eo (tiết niệu sinh dục, đường tiêu hóa)
IV prophylaxis
Dự phòng theo đường TM .....604 b
Oral prophylaxis
Dự phòng theo đường uống.....604 b
Endometritis
Viêm nội mạc tử cung.....202
Endomyometritis
Viêm nội mạc-cơ tử cung 202
Endophthalmitis
Viêm nội nhãn 66
bacterial
Nhiễm trùng.....66, 65
Eye abnormalities (DDx)
các bất thường ở mắt (Chẩn đoán phân biệt) .....746 b
fungal
nấm 66
infected lens implant
nhiễm trùng sau thay thủy tinh thể 67
tuberculosis
lao 117
ENF (eneuvirtide) 934
Enfuvirtide (T20)
Enfuvirtid (T20) 934
Enlarged greater auricularnerve, neck abnormalities (DDx)
Phì đại thần kinh thính giác, các bất thường ở cổ (Chẩn đoán phân biệt) .....753 b
Entamoeba histolytica
Entamoeba histolytica 449
Cerebral amebiasis
amíp não 425
cutaneous amebiasis
amíp da.....471
dysentery
lỵ 157
hepatic amebiasis
ápxe gan amíp..... 449
liver abscess
ápxe gan.....170
pulmonary amebiasis
amíp phổi.....433
Entecavir 935
Enterobacteriaceae. See also Citrobacter, Edwardsiella, Enerobacter, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Providencia, Salmonella, Serratia, Shigella acute bacterial

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Enterobacteriaceae. Xem thêm Citrobacter, Edwardsiella, Nhiễm trùng cấp do Enterobacter, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Providencia, Salmonella, Serratia, Shigella
pyelonephritis
viêm thận bể thận 192
bacterial cystitis
viêm bàng quang do vi khuẩn 184, 185
brain abscess
ápxe não 51
CAPD-associated peritonitis
viêm phúc mạc liên quan lọc màng bụng ngoại trú liên tục 180
Chronic pyelonephritis
viêm thận bể thận mạn tính 192
complicated skin/skin structure tissue infections
nhiễm khuẩn da/cấu trúc da phức tạp 236
endophthalmitis
viêm nội nhãn cầu 65
febrile neutropenia
sốt giảm bạch cầu 280
intraabdominal abscess
ápxe trong ổ bụng 181
ischiorectal/ perirectal abscess
ápxe ụ ngồi trực tràng/quanh trực tràng .. 267
osteomyelitis
viêm tủy xương 231
prostatitis/prostatic abscess
viêm tuyến tiền liệt/ápxe tuyến tiền liệt ... 196
prosthetic valve endocarditis
viêm nội tâm mạc trên van nhân tạo 139
renal abscess
ápxe thận 194
sepsis
sepsis 268
septic arthritis
viêm khớp nhiễm khuẩn 218
solid organ transplant
ghép tạng đặc 283
suppurative parotitis
viêm tuyến mang tai mưng mủ 72
urosepsis
sepsis do nhiễm khuẩn tiết niệu 198
usual/unusual susceptibility patterns
mô hình nhạy cảm thông thường/bất thường ..... 12 b
Enterobacter sp
Enterobacter sp 536
Acute bacterial meningitis
viêm màng não mủ cấp 32
brain abscess
ápxe não 50
burn wounds
vết thương do bỏng 256
sepsis
sepsis 268
usual/unusual susceptibility patterns
mô hình nhạy cảm thông thường/bất thường ..... 12 b
Enterobius vermicularis, pinworm
Enterobius vermicularis, giun kim 460
Enterococci
Enterococci hay cầu khuẩn ruột
cholangitis
viêm đường mật 165
cholecystitis
viêm túi mật 165
chronic medical prophylaxis
dự phòng nội khoa mạn tính ..... 595 b
Gallbladder abscess
ápxe thành túi mật 166
liver abscess
ápxe gan 170
vascular graft infections
nhiễm trùng cấu nối mạch máu 149
Enterococcus faecalis (VSE) ..... 346 b
Bone marrow transplant infection
nhiễm trùng trong ghép tủy 283
catheter-associated bacteriuria
Có vi khuẩn niệu liên quan với ống thông tiểu 186

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

cholangitis
viêm đường mật.....165
cholecystitis
viêm túi mật.....165
cystitis
viêm bàng quang do vi khuẩn.....184
endocarditis
viêm nội tâm mạc.....130
gallbladder wall abscess
ápxe thành túi mật.....166
liver abscess
ápxe gan.....170
pyelonephritis
viêm thận–bể thận.....190
sepsis
sepsis.....268
surgical prophylaxis
dự phòng trong ngoại khoa.....579 b
urosepsis
sepsis do nhiễm khuẩn tiết niệu.....198
Enterococcus faecium (VRE).....347 b
Acute bacterial pyelonephritis
viêm thận bể thận cấp do vi khuẩn.....107
Catheter-associated bacteriuria
Có vi khuẩn niệu liên quan với ống thông tiểu.....187
endocarditis
viêm nội tâm mạc.....130
pyelonephritis
viêm thận-bể thận.....192
sepsis
nhiễm khuẩn huyết.....268
surgical peophylaxis
dự phòng trong phẫu thuật.....582 b
transplant infections
nhiễm trùng ở người được ghép tạng.....283
Enterocytozoon bienuesi, microsporidia enteritis
Viêm ruột do Enterocytozoon bienuesi, microsporidia.....551
Enteroviruses
Các Enterovirus
meningitis
viêm màng não.....39
travel prophylaxis
dự phòng khi đi du lịch.....608 b
Entomophthoromycosis
Entomophthoromyces.....480
Eosinophilia, WBC abnormalities (DDx)
Tăng bạch cầu ái toan, các bất thường bạch cầu (Chẩn đoán phân biệt).....772 b
Eosinophilic folliculitis
Viêm nang lông tăng bạch cầu ái toan.....772
Eosinophils CSF abnormalities (DDx)
Tăng bạch cầu ái toan, các bất thường dịch não tủy (Chẩn đoán phân biệt).....787b
Pleural effusion profiles in various diseases (DDx)
Đặc điểm dịch màng phổi trong các bệnh lý khác nhau (Chẩn đoán phân biệt).....785 b
Eosinophiluria, urinary abnormalities (DDx)
Bạch cầu ái toan trong nước tiểu, các bất thường của nước tiểu (Chẩn đoán phân biệt).....784b
Epidemic (louse-borne) typhus
Sốt dịch do rickettsia.....486
Epidermophyton floccosum
Epidermophyton floccosum
onychomycosis
bệnh nấm móng.....263
tinea corporis
nấm da thân.....262
Epididymitis, acute and chronic
Viêm mào tinh hoàn cấp và mạn tính.....188
Epididymoorchitis, genitourinary abnormalities (DDx)
Viêm mào tinh hoàn - tinh hoàn, các bất thường về tiết niệu sinh dục (Chẩn đoán phân biệt).....761 b
Epiglottitis
Viêm nắp thanh quản.....86
Episcleritis, eye abnormalities (DDx)
Viêm thượng củng mạc, các bất thường ở mắt (Chẩn đoán phân biệt).....747 b
Epistaxis, nasal abnormalities (DDx)

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Chảy máu cam, các bất thường ở mũi (Chẩn đoán phân biệt) ....750 b
Epitrochlear adenopathy, lymph node abnormalities (DDx)
Bệnh lý hạch quanh hố ròng rọc, các bất thường hạch bạch huyết (Chẩn đoán phân biệt) ....759 b
Epivir (lamivudine) 967
Epzicom [Abacavir (ABC) + Lamivudine (3TC)] 825
Abacavir 825
Ertapenem 938
Erysipelas
Viêm quầng 236
Erysipelothrix rhusiopathiae
Erysipelothrix rhusiopathiae ....356 b
Erythema multiforme, extremity abnormalities (DDx)
Hồng ban đa dạng, các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt) ....766 b
Erythema nodosum, extremity abnormalities (DDx)
Hồng ban nút, các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt) ....766 b
Erythrasma
Erythrasma (bệnh do nấm corynebacterium minutissimium) 467
Erythrocyte sedimentation rate (ESR), serum test abnormalities (DDx)
Tốc độ lắng hồng cầu, các xét nghiệm huyết thanh bất thường (Chẩn đoán phân biệt) ....775 b
Erythroderma, general appearance abnormalities (DDx)
Đỏ da tróc vảy, các bất thường khi thăm khám toàn thân (Chẩn đoán phân biệt) ....743 b
Erythromycin, pediatric dose
Erythromycin, liều dùng cho trẻ em 678
Erythromycin lactobionate, base (various)
Erythromycin lactobionat, dạng base (đa dạng) 940
Eschar, extremity abnormalities (DDx)
Vảy hoại tử khô, các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt) ....765 b
Escherichia coli
Escherichia coli ....577 b
Acute bacterial meningitis
Viêm màng não cấp do vi khuẩn 32
Catheter-associated bacteriuria
Có vi khuẩn niệu liên quan với ống thông tiểu 186
cellulitis
viêm mô tế bào 236
cholangitis
viêm đường mật 165
cholecystitis
viêm túi mật 165
decubitus ulcers
loét do tì đè 243
diabetic foot ulcers
loét bàn chân ở người đái tháo đường 246
dysuria-pyuria syndrome
hội chứng đái khó-đái mủ 183
gallbladder wall abscess
ápxe thành túi mật 166
infectious diarrhea
ỉa chảy nhiễm khuẩn 154
ischemic foot ulcers
loét bàn chân do thiếu máu cục bộ 247
osteomyelitis
viêm tủy xương 231
pneumonia
viêm phổi 124
sepsis
sepsis 268
skin abscesses/infected cysts
ápxe da/Nhiễm trùng nang 248
surgical prophylaxis
dự phòng trong phẫu thuật ....579 b
travel prophylaxis
dự phòng khi đi du lịch ....605 b
esophageal candidiasis, HIV
Bệnh nhiễm candida thực quản, ở người HIV/AIDS 336
esophagitis
Viêm thực quản 151
fungal
nấm 151

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

viral
do virus . 151, 152
Ethambutol 940
Ethionamide
Ethionamide 941
Ethmoid sinus, acute bacterial sinusitis
Viêm xoang cấp tính do vi khuẩn 57
ETR (etravirine) 942
Etravirine (ETR) 942
Eubacterium sp 386 b
EVF/FTC/TDF (Stribild) 927
Excreted unchanged
Bài xuất nguyên dạng 817
Extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) organisms, susceptibility patterns of
Tiết beta-lactamase phổ rộng (ESBL) organisms, đặc điểm nhạy cảm 13 b
External otitis
Viêm tai ngoài 68
benign
lành tính 68
malignant
ác tính 69
Extracellular debris, pleural fluid abnormalities (DDx)
Extracellular debris, các bất thường của dịch màng phổi (Chẩn đoán phân biệt) 763 b
Extremity abnormalities (DDx)
Các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt)
arthritis (septic/reactive)
viêm khớp (nhiễm trùng/phản ứng) 764 b
calf tenderness
căng đau bắp chân 763 b
carpal tunnel syndrome
hội chứng ống cổ tay 763 b
clubbing
ngón tay dùi trống 763 b
Cutaneous cold abscesses
Ápxe lạnh dưới da 765 b
dactylitis
viêm ngón chi 762 b
desquamation of hands/feet
mất lớp sừng bàn tay/bàn chân 765
digital gangrene
hoại thư ngón 762 b
edema of the dorsum of hand/ foot phù mu tay/chân 763 b
Erythema multiforme
hồng ban đa dạng 765 b
erythema nodosum
hồng ban nút 765 b
eschar
hoại tử khô 765 b
foot/leg ulcers
loét bàn chân/cẳng chân 764 b
hyperpigmented shins
tăng sắc tố da 765 b
leg edema, unilateral/bilateral
phù chân một/hai bên 763 b
lymphangitis
viêm hạch bạch huyết 762 b
migratory rashes
ban đỏ di chuyển 766 b
nodular arm/leg lesions
tổn thương dạng khối u ở tay/chân 765 b
Nodular lymhangitis
Viêm hạch bạch huyết 762 b
Painful leg nodules
Khối u nhỏ vùng chân có đau 765 b
Painless purple palm/sole lesions
Tổn thương gan bàn tay/chân màu tím không đau 765 b
Palpable purpura
Tử ban 765 b
papular axillary lesions
Nốt sần ở nách 765 b
Plantar hyperkeratoses
Dầy sừng ở gan chân 766 b
Purple nodules
Các khối u nhỏ màu tím 765 b
Rash of palms/soles
Ban ở lòng bàn tay/chân 766 b

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

scleroderma
xơ cứng bì ..... 766 b
Splinter hemorrhages
Xuất huyết nền móng tay ..... 762 b
Tender fingertips
Đau đầu ngón tay ..... 762 b
Tender muscles
Đau cơ 764b
tenosynovitis
viêm bao hoạt dịch gân ..... 764 b
thigh tenderness (bilateral)
Đau bắp đùi (hai bên) ..... 764 b
thrombophlebitis
Viêm tắc tĩnh mạch ..... 764 b
Verrucous foot/leg lesions
Mụn cơm ở bàn chân/chân ..... 765 b
Verrucous hand/arm lesions
Mụn cơm bàn tay/cánh tay ..... 763 b
Wrist swelling
Sưng cổ tay ..... 763 b
Eye anormalities (DDx)
Các bất thường ở mắt (Chẩn đoán phân biệt) 746
Argyll-Robertson pupils
Đồng tử Argyll-Robertson ..... 746 b
Bilateral lid edema
Phù mi mắt hai bên ..... 746 b
Bilateral upper lid edema
Phù mi mắt trên hai bên ..... 746 b
chorioretinitis
viêm màng mạc -võng mạc ..... 749 b
conjunctivitis, unilateral/bilateral
viêm kết mạc, một bên/hai bên 746
conjunctival suffusion
Xuất huyết dưới kết mạc ..... 747 b
Corneal haziness
Đục giác mạc ..... 748 b
Corneal ulcers
Loét giác mạc ..... 749 b
Cytoid bodies (cotton wool spots)
Thể dạng tế bào (đốm dạng vẩy bông) ..... 749 b
Dry eyes
Khô mắt 748b
endophthalmitis
Viêm nội nhãn ..... 749 b
episcleritis
viêm thượng củng mạc ..... 749 b
heliotrope eyelid discoloration
Mi mắt chuyển màu tím ..... 746 b
Hemorrhagic conjunctivitis, unilateral/bilateral
viêm kết mạc xuất huyết một bên/hai bên ..... 747 b
iritis
Viêm mống mắt ..... 746 b
keratitis
viêm kết mạc ..... 746 b
periorbital edema, unilateral/bilateral
Phù quanh hốc mắt, một bên/hai bên . 746 b
Periphlebitis (candle wax drippings)
Viêm quanh tĩnh mạch (chảy sáp nến) .. 749 b
Roth spots
Đốm Roth ..... 749 b
Scleral nodules
Khối u củng mạc ..... 748 b
subconjunctival hemorrhage, hemorrhagic conjunctivitis, unilateral/bilateral
xuất huyết dưới kết mạc, viêm kết mạc xuất huyết, một bên/hai bên ..... 747 b
uveitis
Viêm màng bồ đào ..... 748 b
Watery eyes
Chảy nước mắt (mắt ướt) ..... 748 b
Eyebrow loss, total/partial, head abnormalities (DDx)
Rụng lông mày, một phần/toàn bộ, các bất thường ở đầu (Chẩn đoán phân biệt) ..... 745 b
Eyelashes, long, head abnormalities (DDx)
Lông mi dài, các bất thường ở đầu (Chẩn đoán phân biệt) ..... 745 b
Eyelid edema, bilateral, eye abnormalities (DDx)
Phù mi mắt, hai bên, các bất thường ở mắt (Chẩn đoán phân biệt) ..... 746 b

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

F

Facial cellulitis
viêm mô tế bào vùng mặt.....55
Facial erythema, head abnormalities (DDx)
Phù mặt, các bất thường ở đầu (Chẩn đoán phân biệt).....44 b
Facial red spots, head abnormalites (DDx)
Các nốt đỏ ở mặt, các bất thường ở đầu (Chẩn đoán phân biệt).....744 b
Facial swelling (edema), head abnormalities (DDx)
Phù mặt, các bất thường ở đầu (Chẩn đoán phân biệt).....744 b
Famciclovir 943
Famvir 943
Fasciola gigantica
Fasciola gigantica 447
Fasciola hepatica
Fasciola hepatica 447
Fascioliasis
Fascioliasis 447
Fasciolopsiasis
Bệnh do nhiễm sán lá 463
Fasciolopsis buski
Fasciolopsis buski 463
Fascitis
Viêm cân 239
Fat emboli, bilateral infiltrates without effusion
Tắc mạch do mỡ, xâm nhiễm hai phổi không có tràn dịch 718
Febrile neutropenia
Sốt ở BN giảm bạch cầu hạt 280
Fecal Gram stain, clinical use
Nhuộm Gram phân, ứng dụng lâm sàng....401 b
Feet, desquamation of, extremity abnormalities (DDx)
Mất lớp sừng bàn chân, các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt)..... 766 b
Ferritin levels, elevated (acute/chronic), serum test abnormalities (DDx)
Tăng Ferritin (cấp/mạn tính), các bất thường xét nghiệm huyết thanh (Chẩn đoán phân biệt) .....777 b
Fever curves (DDx)
Biểu đồ nhiệt độ (Chẩn đoán phân biệt).....741b
Camelback fever pattern
Sốt kiểu lưng lạc đà.....741 b
Double quotidian fevers
Sốt hai đỉnh .....741 b
Morning (am) temperature spikes
Sốt đỉnh buổi sáng.....741 b
Relative bradycardia
Nhịp tim chậm tương đối .....741 b
Relative tachycardia
nhịp tim nhanh tương đối 741b
single fever spikes
Sốt một đỉnh .....741 b
Filariasis brugia malayi
Filariasis brugia malayi 410
Wuchereia bancrofti
Wuchereia bancrofti.....410
Fingertip tenderness, extrmity abnormalities (DDx)
Sưng đau đầu ngón tay, các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt).....762 b
Fish tapeworm
Sán dây cá 471
5-FC (Flucytosine) 947
Flaccid paralysis (acute), neurological abnormalities (DDx)
Liệt mềm (cấp), các bất thường của hệ thần kinh (Chẩn đoán phân biệt) .....759 b
Flagyl 986
Flatworms, intestinal
Giun dẹp, đường tiêu hóa 463
Fluconazole
Fluconazol 944
Pediatric dose
Liều dùng cho trẻ em 679
Fluconazole-resistant Candida
Candida kháng Fluconazole
catheter-associated candiduria
Candida niệu liên quan với đặt thông tiểu 187
Fungal cystitis

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nang do nấm.....184
thrush
Nấm, thực quản.....156
Flucytosine.....947
Flukes
Sán lá
intestinal
đường tiêu hóa.....463
liver
gan.....447
lung
phổi.....431, 434
Flumadine
Flumadin.....1039
Fluoroquinolones, susceptibility profiles
Fluoroquinolon, các thông tin về độ nhạy cảm của vi sinh vật với thuốc.....332 b
Flying insects, travel precautions
Côn trùng bay, thận trọng khi đi du lịch.....606b
Flying squirrel typhus
Sốt Rickettsia do sóc bay.....486
Fonsecaea pedrosoi/compactum, chromomycosis
Fonsecaea pedrosoi/compactum, chromomycosis.....477
Food-borne infectious disease (fecally-contaminated), travel precautions
Ngộ độc thức ăn (nhiễm bẩn từ phân), thận trọng khi đi du lịch.....606 b
Foot edema, dorsum, extremity abnormality (DDx)
Phù mu tay/chân, các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt).....763 b
Foot ulcers, extremity abnormality (DDx)
Loét bàn chân, các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt).....764 b
Fortaz.....884
Fosamprenavir.....947
Foscarnet.....950
Foscavir.....950
Fosfomycin.....951
Pearls & pitfalls
Điểm nhấn và các sai lầm cần tránh.....811
Fournier's gangrene
Hoại tử Fournier.....239
Fourth cephalosporins, pearls & pitfalls
Cephalosporin thế hệ 4, điểm nhấn và các sai lầm cần tránh.....796
FPV (fosamprenavir).....947
Francisella tularensis (tularemia)
Francisella tularensis (tularemia).....367
Community-acquired pneumonia
viêm phổi mắc phải ở cộng đồng.....89
tularemia pneumonia
viêm phổi tularemia.....306
zoonotic atypical pneumonia
viêm phổi không điển hình lây từ động vật sang người.....107
Frenal ulcer, mouth abnormalities (DDx)
loét hãm lưỡi, các bất thường ở miệng (Chẩn đoán phân biệt).....752 b
Freshwater wounds
Các vết thương phơi nhiễm từ nước ngọt.....258
Fontal sinus, acute bacterial sinusitis
Viêm xoang trán nhiễm trùng.....57
FTC (emtricitabine).....933
FTC/RPV/TDF (Complera).....933
FTC/TDF (Truvada).....931
Fulvicin.....957
Fungal (candida) esophagitis
viêm thực quản do nấm (candida).....152
Fungal (crytococcal) meningitis
Viêm màng não do nấm (cryptococcus).....40
Fungal endophthalmitis
Viêm nội nhãn cầu do nấm.....66
Fungal infections (Complera)
Nhiễm nấm.....574 b
in neutropenic patients, chronic
Người giảm bạch cầu hạt, mạn tính
medical prophylaxis
dự phòng bằng thuốc.....594 b
Of skin/nails
Da/móng.....262
Fungizone

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Fungizone.....842
Furunculosis
Nhọt đầu đinh.....248
Fusarium, cutaneous
Fusarium, ngoài da.....481
Fusarium solani, cutaneous fusarium
Fusarium solani, cutaneous fusarium.....481
Fusobacterium necrophorum, Lemierre's syndrome
Nhiễm trùng vùng sâu của cổ, hội chứng Lemierre.....83
Fusobacterium nucleatum
Fusobacterium nucleatum.....388 b
Complicated skin/skin structure tissue infections
Nhiễm khuẩn da/cấu trúc da phức tạp.....236
Vincent's angina
Viêm họng Vincent.....80
Fuzeon (enfuvirtide).....934

G

G-allbladder wall abscess/perforation
Ápxe thành túi mật/thủng túi mật.....166
Ganciclovir.....953
Gangrene, digital
Hoại tử đầu chi.....762 b
Garamycin.....954
Gardnerella vaginalis
Gardnerella vaginalis.....206
Gas gangrene
Hoại thư sinh hơi.....238
Gastric perforation
Thủng dạ dày.....154
Gastroenteritis, pediatric
Viêm dạ dày ruột, trẻ em.....544
Gastrointestinal tract infections
Nhiễm trùng đường tiêu hóa
Empiric therapy
Điều trị theo kinh nghiệm.....151
opportunistic
cơ hội.....545
General appearance abnormalities (DDx)
Các bất thường khi thăm khám toàn thân (Chẩn đoán phân biệt)
bullae
bọng nước.....743 b
Erythroderma
Đỏ da tróc vảy.....743 b
Generized edema/nephrotic syndrome
Phù toàn thân, hội chứng thận hư.....743 b
hyperpigmentation
tăng sắc tố da.....743 b
Hypotension/shock
tụt huyết áp/sốc.....743 b
jaundice
vàng da.....743 b
Lizard/elephant skin
Da thằn lằn/da voi.....743 b
Rash (below waist)
Ban đỏ.....744
Soft tissue crepitance
Lép bép dưới mô mềm.....742 b
urticaria
Mày đay.....744 b
vitiligo
Bạch tạng.....743 b
Genital herpes
Herpes sinh dục.....208
Less than 6 episodes/year, chronic medical prophylaxis
Tái phát dưới 6 đợt/năm dự phòng nội khoa mạn tính.....595 b
more than 6 episodes/year, chronic medical prophylaxis
Tái phát trên 6 đợt/năm, dự phòng nội khoa mạn tính.....595 b
Genital ulcers
Loét sinh dục.....209
Genital vesicles
Mụn nước vùng sinh dục.....208
Genital warts

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Mụn cóc vùng sinh dục....212
Genitourinary abnormalities (DDx)
Các bất thường về tiết niệu sinh dục (Chẩn đoán phân biệt) ....761 b
epididymoorchitis
viêm mào tinh hoàn - tinh hoàn....761 b
groin mass
Khối u ở bẹn....761 b
Perirectal fistula
Rò trực tràng....761 b
Perirectal ulcer
Loét quanh trực tràng ....761 b
Prostate enlargement/tenderness
Phì đại tuyến tiền liệt/đau....761 b
Scrotal enlargement
Sưng bìu ....761 b
Genitourinary tract infections, empiric therapy
Nhiễm khuẩn tiết niệu – sinh dục Điều trị theo kinh nghiệm....183
Gentamicin 954
Pediatric dose
Liều dùng cho trẻ em 680
GGT (GGTP), elevation, liver test abnormalities (DDx)
Tăng GGT (GGTP), Các bất thường về xét nghiệm chức năng gan (Chẩn đoán phân biệt)779 b
Giardia lamblia....454
diarrhea
Ỉa chảy....154
travel prophylaxis
dự phòng khi đi du lịch....607 b
giardiasis
Bệnh do Giardia....453
Giemsa stain, technique for
Nhuộm Giemsa, kĩ thuật....386 b
Gingivitis, mouth abnormalities (DDx)
Viêm lợi, các bất thường ở miệng (Chẩn đoán phân biệt)....752 b
Glucose decreased, pleural fluid abnormalities (DDx)
Giảm đường, các bất thường của dịch màng phổi (Chẩn đoán phân biệt) ....784 b
Gnathostoma spinigerum
Gnathostoma spinigerum
cerebral
não 426
cutaneous gnathostomiasis
Gnathostoma ở da 475
Gnathostomiasis, cutaneous
Gnathostomia ở da 476
Gonorrhea (GC), post-exposure prophylaxis
Lậu (GC), dự phòng sau phơi nhiễm ....587 b
Goodpasture's syndrome
Hội chứng Goodpasture
Bilateral infiltrates with effusion
xâm nhiễm hai phổi có tràn dịch màng phổi 723
bilateral infiltrates without effusion
xâm nhiễm hai phổi không có tràn dịch màng phổi 717
Gram-negative bacilli (GNB)
Trực khuẩn Gram âm (GNB)
aerobic
Ái khí....325 b
anaerobic
Kị khí....326 b
capnophilic
Ưa CO_2....371 b
Chronic medial prophylaxis
Dự phòng nội khoa mạn tính ....595 b
Gram-negative bacteria, septic shock
Vi khuẩn Gram âm, Sốc nhiễm khuẩn....274
Gram-negative cocci
Cầu khuẩn Gram âm....325 b
Aerobic, pairs
Ái khí, xếp thành cặp ....325 b
Gram-positive bacilli
Trực khuẩn Gram dương
aerobic
Ái khí....325 b
anaerobic
Kị khí....326 b
Gram-positive bacteria, septic shock
Vi khuẩn Gram dương, Sốc nhiễm khuẩn....274

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Gram-positive cocci (GPCs)
Cầu khuẩn Gram dương (GPCs)
aerobic
Ái khí....325 b
chains
Xếp thành chuỗi....325 b
clusters
Xếp thành đám....342
pairs
Xếp thành cặp....352 b
Gram stains
Nhuộm Gram
CSF
Dịch não - tủy....396 b
sputum
Đờm....399 b
Technique for
Kĩ thuật....410 b
urine
Nước tiểu....410 b
Granuloma inguinale (Donovanosis)
U hạt vùng bẹn (donovanosis)....211
Granulomatous amebic encephalitis
Viêm não u hạt do amíp....425
Granulomatous amebic meningoencephalitis
Viêm não-màng não do amip thể u hạt....39
Granulomatous hepatitis (BCG)
Viêm gan u hạt (BCG)... 97 172
Gray hair (premature), head abnormalities (DDx)
Tóc bạc sớm, các bất thường ở đầu (Chẩn đoán phân biệt)....744b
Grifulvin....957
Grisactin....957
Griseofulvin....957
Gris-PEG
Gris-PEG....957
Groin mass, genitourinary abnormalities (DDx)
các bất thường của tiết niệu sinh dục (Chẩn đoán phân biệt)....761 b
Group A streptococci
Liên cầu nhóm A....348 b
Animal bite wounds
Vết thương do động vật cắn....670
Burn wounds
vết thương do bỏng....256
cellulitis
viêm mô tế bào....55
complicated skin/skin structure tissue infections
nhiễm khuẩn da/cấu trúc da phức tạp....236
decubitus ulcers
loét do tì đè....243
diabetic foot ulcers
loét bàn chân ở người đái tháo đường....246
human bite wounds
vết thương do người cắn....975
ischemic foot ulcers
loét bàn chân do thiếu máu cục bộ....247
ludwig's angina
Viêm họng Ludwig....81
osteomyelitis
viêm tủy xương....231
pharyngitis
viêm họng....73
septic arthritis
viêm khớp nhiễm trùng....217
unilateral focal segmental/lobar infiltrate with effusion
Xâm nhiễm thùy hoặc tiểu thùy khu trú một bên phổi một bên có tràn dịch màng phổi....694
Group B streptococci
Liên cầu nhóm B....349
Bacterial cystitis
viêm bàng quang do vi khuẩn....184
cellulitis
viêm mô tế bào....236
diabetic foot ulcers
loét bàn chân do đái tháo đường....246
endocarditis
viêm nội tâm mạc....130

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

osteomyelitis
viêm tủy xương 231
septic arthritis
viêm khớp nhiễm trùng 217
urosepsis
sepsis do nhiễm khuẩn tiết niệu 198
Group C streptococci
Liên cầu nhóm C 350
endocarditis
viêm nội tâm mạc 130
septic arthritis
viêm khớp nhiễm trùng 217
Group F streptococci
Liên cầu nhóm F 350
Group G streptococci
Liên cầu nhóm G 350
Septic arthritis
viêm khớp nhiễm trùng 217
Guillain-Barré syndrome, neurological abnormalities (DDx)
Hội chứng Guillain-Barré, các bất thường của hệ thần kinh (Chẩn đoán phân biệt) ..... 768 b
Guinea worm
Giun Guinea 475

H

Haemophilus. See Hemophilus
Haemophilus. Xem phần Hemophilus
Hafnia alvei 368
Hairy leukoplakia
Bạch sản dạng tóc 78
"Halo sign", Aspergillus pneumonia and
"Dấu hiệu quầng sáng Halo," viêm phổi do nấm Aspergillus viêm phổi 122
HA-MRSA. See Hospital-acquired MRSA
HA-MRSA. Xem phần MRSA mắc phải ở bệnh viện
Hand lesions, verrucous
Tổn thương ở tay, mụn cơm ..... 763 b
Hands, desquamation of, extremity
abnormalities (DDx)
Mất lớp sừng bàn tay, các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt) ..... 766 b
Hantavirus (HPS), bilateral infiltrates with effusion
Hantavirus (HPS), xâm nhiễm hai phổi có tràn dịch màng phổi 721
Head abnormalities (DDx)
Các bất thường ở đầu (Chẩn đoán phân biệt)
facial erythema
ban đỏ ở mặt ..... 745 b
facial red spots
đốm đỏ ở mặt ..... 745 b
facial swelling (edema)
phù mặt 744
generalized alopecia
rụng tóc toàn bộ ..... 745 b
lacrimal gland enlargement (unilateral/bilateral)
phì đại tuyến lệ (một bên/hai bên) ..... 745 b
localized alopecia
rụng tóc từng vùng ..... 745 b
long eyelashes
lông mi dài ..... 745 b
parotid enlargement
phì đại tuyến nước bọt ..... 745 b
prematurely gray hair
tóc bạc sớm ..... 744 b
scalp nodules
có các bướu nhỏ ở da đầu ..... 745 b
severe seborrheic dermatitis
Viêm da tiết bã nhờn nặng ..... 744 b
Temporal muscle wasting
Teo cơ vùng thái dương ..... 744 b
Total/partial eyebrow loss
Rụng lông mày một phần/toàn bộ ..... 745 b
Head lice
Chấy rận (đầu) 417
Heart
Tim
Chagas' diease
Bệnh Chagas 447

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Parasites, fungi, unusual organisms in liver
Kí sinh trùng, nấm và các vi sinh ít gặp ở gan 447
Heart abnormalities (DDx) heart block, acute/chronic
Các bất thường ở tim (Chẩn đoán phân biệt) bloc tim cấp/mạn tính.....755 b
Heart murmur
Tiếng thổi .....755 b
Pericardial effusion
tràn dịch màng ngoài tim .....755 b
tachycardia
nhịp tim nhanh .....755 b
heart murmur, heart abnormalities (DDx)
Tiếng thổi ở tim, các bất thường ở tim (Chẩn đoán phân biệt).....755 b
Heart transplants, transplant prophylaxis (BMT/SOT)
Ghép tim, dự phòng trong phẫu thuật (ghép tủy/tạng đặc) .....598 b
HEENT infections, empiric therapy
Nhiễm khuẩn vùng đầu-mặt-cổ, điều trị theo kinh nghiệm. 635
Helicobacter pylori
Helicobacter pylori .....368 b
Peptic ulcer disease
bệnh lý loét dạ dày 153
heliotrope eyelid discoloration, eye abnormalities (DDx)
Mi mắt chuyển màu tím (Chẩn đoán phân biệt).....746 b
Hematuria, gross/microscopic, urinary abnormalities (DDx)
Đái máu, đại thể/vi thể, các bất thường của nước tiểu (Chẩn đoán phân biệt).....781 b
Hemiplegia/hemiparesis, neurological abnormalities (DDx)
Liệt nửa người/liệt nửa người nhẹ, các bất thường của hệ thần kinh (Chẩn đoán phân biệt) .....769 b
Hemophagocytosis (erythrophagocytosis), RBC abnormalities (DDx)
thực bào hồng cầu, các bất thường của hồng cầu (Chẩn đoán phân biệt) .....774 b
Hemophilus aphrophilus
Hemophilus aphrophilus .....379 b
Hemophilus ducreyi chancroid
Hạ cam do Hemophilus ducreyi 210
Post-exposure prophylaxis
Dự phòng sau phơi nhiễm .....587 b
Hemophilus influenzae .....369 b
Acute bacterial exacerbation of chronic bronchitis
đợt cấp của viêm phế quản mạn tính 87
acute bacterial meningitis
viêm màng não mủ cấp tính.....32
acute otitis media
viêm tai giữa cấp 69
adult immunization
tiêm chủng người lớn.....613 b
brain abscess
ápxe não..... 51
cellulitis
viêm mô tế bào 55
chronic medical prophylaxis
Dự phòng nội khoa mạn tính .....595 b
Community-acquired pneumonia
viêm phổi mắc phải ở cộng đồng.....89
conjunctivitis
viêm kết mạc 61
endophthalmitis
viêm nội nhãn cầu 65
epiglottitis
viêm nắp thanh quản 86
HIV
HIV 530
mastoiditis
viêm xương chũm 72
post-exposure prophylaxis
dự phòng sau phơi nhiễm .....584 b
preferred prophylaxis
phác đồ dự phòng ưu tiên .....530 b
sepsis
sepsis 268
unilateral focal segmental/lobar infiltrate with effusion
xâm nhiễm khu trú thùy phổi

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

một bên có tràn dịch 695
unilateral focal segmental/lobar infiltrate without effusion
xẩm nhiễm khu trú thùy phổi một bên không có tràn dịch....680
Haemophilus parainfluenzae ....369 b
Haemophilus paraphrophilus
Haemophilus paraphrophilus....369 b
Haemophilus sp 326
Hemorrhagic conjunctivitis, unilateral/bilateral, eye abnormalities (DDx)
Viêm kết mạc xuất huyết một bên/hai bên, các bất thường ở mắt (Chẩn đoán phân biệt) ..747 b
Hemorrhagic/necrotizing pancreatitis
Viêm tụy hoại tử/xuất huyết....169
Hepatic amebiasis
Ápxe gan amíp 449
Hepatic echinococcosis (hydatid cyst disease)
Echinococcus ở gan (nang sán gan)....449
Hepatic insufficiency, dosing strategies in
Suy giảm chức năng gan, chiến lược chế độ liều.... 6 b
Hepatic surgery, surgical prophylaxis
Phẫu thuật gan, dự phòng trong phẫu thuật....580 b
Hepatitis
Viêm gan
Acute viral
Virus cấp 174
Chronic viral
Virus mạn....174
CMV (Cytomegalovirus) 174
Organ transplants
ghép tạng....290
EBV
EBV (Ebsstein-Barr virus) 176
Granulomatous (BCG)
U hạt (BCG)....172
Hepatitis A (HAV) adult immunization
viêm gan A (HAV) tiêm chủng người lớn ...615 b
prophylaxis in HIV
dự phòng ở người HIV/AIDS 565
prophylaxis of opportunistic infections
dự phòng nhiễm trùng cơ hội....565 b
travel prophylaxis
dự phòng khi đi du lịch ....525 b
hepatitis B (HBV) adult immunization
viêm gan B (HBV), tiêm chủng người lớn....615 b
HIV
HIV/AIDS 565
HIV, prophylaxis
HIV/AIDS, dự phòng 526
HIV coinfection
Đồng nhiễm HIV....565
prophylaxis of opportunistic infections
dự phòng các nhiễm trùng cơ hội....585 b
hepatitis C (HCV)
viêm gan C (HCV) 174
HIV
HIV/AIDS.... 565
Transplant infections
nhiễm trùng ở người được ghép tạng.... 290
viral
Do virus....290
hepatobiliary route of elimination
Đào thải qua đường gan-mật ....8 b
Hepatomegaly
Gan to
abdominal abnormalities (DDx)
các bất thường trong ổ bụng (Chẩn đoán phân biệt) ....757 b
Hepatosplenic candidiasis
Nấm Candida ở gan- lách....171
Hepatosplenomegaly, abdominal abnormalities (DDx)
Gan lách to, các bất thường trong ổ bụng (Chẩn đoán phân biệt) ....757 b
Hepsera
Hepsera 830
Herpangina
Herpangina....81

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Herpes encephalitis
Viêm não Herpes 48
Herpes labialis
Herpes môi 82
Mouth abnormalities (DDx)
các bất thường ở miệng (Chẩn đoán phân biệt) ..... 751 b
Herpes simplex (HSV) 251, 252
Genital, HIV
Sinh dục, HIV/AIDS 559
Skin vesicles/bullae
Mụn nước/bọng nước trên da 575
Herpes simplex virus-1 (HSV-1) bilateral infiltrates without
Herpes simplex virus-1 (HSV-1) xâm nhiễm hai phổi không có
effusion
tràn dịch màng phổi 713
encephalitis
viêm não 47
esophagitis
viêm thực quản 151
Herpes gingivostomatitis
viêm miệng - lợi do Herpes 82
Herpes labialis
Herpes môi 82
Herpes Whitlow
Herpes Whitlow (Herpes đầu ngón tay/chân) 253
keratitis
viêm giác mạc 59
meningitis
viêm màng não 39
pneumonia
viêm phổi 126
Herpes simplex virus-2 (HSV-2) chronic medical prophylaxis
Herpes simplex virus-2 (HSV-2) Dự phòng nội khoa mạn tính ..... 595 b
encephalitis
viêm não 50
meningitis
viêm màng não 39
Herpes whitlow
Herpes whitlow 251, 253
Herpes zoster (VZV) 251, 252
Adult immunization
tiêm chủng người lớn ..... 624 b
encephalitis
viêm não 48
pediatric
trẻ em 672
skin vesicles/bullae
mụn nước/bọng nước trên da 475
Heterophyes heterophyes
Heterophyes heterophyes 463
Heterophyiasis
Bệnh nhiễm sán Heterophyes 463
HHV-6
encephalitis
viêm não 47
meningitis
viêm màng não 39
pharyngitis
viêm họng 73
transplant infections
nhiễm trùng ở người được ghép tạng 284
Hickman/Broviac infection
Nhiễm trùng Hickman/Broviac 147
High level (absolute) resistance
Đề kháng mức độ cao (tuyệt đối) 4
Hiprex 985
Hip (total) replacement surgery, surgical prophylaxis
Phẫu thuật thay khớp gối toàn bộ, dự phòng trong phẫu thuật ..... 582 b
Histiocytosis X, cavitary infiltrates (thin-walled)
Hội chứng mô bào, xâm nhiễm dạng hang (thành mỏng) 737
Histoplasma capsulatum
Histoplasma capsulatum ..... 393 b
Cutaneous histoplasmosis
Histoplasma da. 469

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Pulmonary histoplasmosis
Histoplasma phổi 445
Histoplasmosis
Bệnh do Histoplasma
Cavitary infiltrates (thick-walled)
xâm nhiễm dạng hang (thành dày)....729
meningitis
viêm màng não....40
Histoplasmosis, disseminated HIV/AIDS
Bệnh do Histoplasma rải rác, ở đối tượng nhiễm HIV/AIDS
HIVID (zalcitabine) 1083
HIV 490
Acute infection
Nhiễm virus cấp....503
antiretroviral
thuốc chống retrovirus....505
failure
thất bại .... 521, 523 b
indications
chỉ định....523 b
initial therapy
liệu pháp ban đầu....519 b
therapy
phác đồ ....519 b
approach to testing
tiếp cận xét nghiệm 512
ELISA
ELISA 512
HIV RNA viral load assays
Đếm tải lượng HIV RNA....512
Western blot
Western blot 512
ART therapy
điều trị bằng thuốc chống retrovirus (ART) ....515 b
CNS opportunistic infection
Nhiễm trùng cơ hội hệ thần kinh trung ương 538
coinfections
đồng nhiễm 565
diagnosis, evaluation, treatment
chẩn đoán, đánh giá, điều trị 502
hepatitis B coinfection
đồng nhiễm viêm gan B 172
initial assessment
đánh giá ban đầu 510
baseline laboratory testing
các xét nghiệm nền....512 b
CD_4 count
đếm số lượng tế bào CD_4 ....512 b
clinical evaluation
đánh giá lâm sàng....510
opportunistic infections other
nhiễm trùng cơ hội khác 525
prophylaxis
dự phòng ....527 b
treatment
điều trị....526
overview
tổng quan 516
Post-exposure prophylaxis (PEP)
dự phòng sau phơi nhiễm (PEP)....584 b
Pre-exposure prophylaxis (PrEP)
Dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP)
prophylaxis of opportunistic infections
dự phòng nhiễm trùng cơ hội 597
respiratory tract opportunistic infections
viêm đường hô hấp do nhiễm khuẩn cơ hội....531
Hoarseness, mouth abnormalities (DDx)
Khàn tiếng, các bất thường ở miệng (Chẩn đoán phân biệt)....752 b
Home IV theraly, less need for
Điều trị bằng thuốc tiêm tĩnh mạch tại nhà, không cần thiết đối với....26
Hookworm
Giun móc 458
Hospital-acquired MRSA (HA-MRSA)
MRSA mắc phải ở bệnh viện (HA-MRSA)..... 24 b
Hospital-acquired pneumonia (HAP)
Viêm phổi mắc phải từ bệnh viện 125

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Howell-Jolly bodies, RBC abnormalities (DDx)
Thể Howell-Jolly, Các bất thường của hồng cầu (Chẩn đoán phân biệt).....773 b
Human bite
Người cắn 257
pediatric
trẻ em 669
Human granulocytic anaplasmosis (HGA)
Bệnh nhiễm anaplasma trong bạch cầu người (HGA).....419
Human monocytic ehrlichiosis (HME)
Bệnh nhiễm ehrlichia trong bạch cầu mono (HME).....419
Human papilloma virus (HPV)
Virus gây u nhú ở người (HPV)
Adult immunization
tiêm chủng ở người lớn.....616 b
genital/perianal warts
sinh dục/mụn cóc quanh hậu môn 211
Hydradenitis suppurativa
Viêm tuyến mồ hôi mưng mủ.....250
Hymenolepis nana, dwarf tapeworm
Hymenolepis nana, sán dải lùn 461
Hyperinfection syndrome
Hội chứng siêu nhiễm trùng 459, 290
Hyperpigmentation, general appearance abnormalities (DDx)
Tăng sắc tố mô, các bất thường khi thăm khám toàn thân (Chẩn đoán phân biệt) .....743 b
Hyperpigmented shins, extremity abnormalities (DDx)
Tăng sắc tố da, các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt).....765 b
Hyposplenia
Thiểu năng lách.....278
Hypotension, general appearance abnormalities (DDx)
Tụt huyết áp, các bất thường khi thăm khám toàn thân (Chẩn đoán phân biệt) .....742 b

I

I-diopathic pulmonary hemosiderosis (IPH), bilateral infiltrates without effusion
Nhiễm hemosiderin ở phổi vô căn, xâm nhiễm hai phổi không có tràn dịch màng phổi.....720
IDV (indinavir) 958
Imipenem, pediatric dose
Imipenem, liều dùng cho trẻ em 680
Imipenem/cilastatin 956
Immunizations. See also Adult immunizations
Tiêm chủng. Xem thêm Tiêm chủng người lớn
Purpose of
Mục đích 613
Travel vaccines in HIV
Vaccin khi đi du lịch ở người nhiễm HIV....597
Impetigo
Chốc lở 236
pediatric
trẻ em 668
incivek 1049
indian (Bihar state) visceral leishmaniasis (Kala-azar)
leishmania nội tạng Ấn Độ (Kala-azar).....450
Indinavir 959
Infective endocarditis (IE)
Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng (IE).....602b
prophylaxis, indications for
dự phòng, chỉ định đối với 602b
influenza
Cúm
adult immunization
tiêm chủng ở người lớn .....605 b
avian
gia cầm 112
bilateral infiltrates without effusion
xâm nhiễm hai phổi không có tràn dịch màng phổi 712
HIV, prophylaxis
HIV/AIDS, dự phòng 526
pneumonia

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm phổi 92
Seasonal (types A/B)
Theo mùa (types A/B) 112
Post-exposure prophylaxis
dự phòng sau phơi nhiễm ..... 585 b
prophylaxis of opportunistic infections
dự phòng nhiễm khuẩn cơ hội ..... 597 b
influenza A
Cúm A
Clinical presentations in adults
Biểu hiện lâm sàng ở người lớn 114
Community-acquired pneumonia
viêm phổi mắc phải ở cộng đồng 89, 93
sepsis
sepsis 268
influenza B, community-acquired pneumonia
Cúm B, viêm phổi mắc phải ở cộng đồng 93
Infraclavicular adenopathy, lymph node abnormalities (DDx)
Hạch dưới đòn, các bất thường hạch bạch huyết (Chẩn đoán phân biệt) ..... 760 b
Inguinal adenopathy, unilateral/ bilateral, lymph node abnormalities (DDx)
Hạch nách, một bên/hai bên, các bất thường hạch bạch huyết (Chẩn đoán phân biệt) ..... 760 b
Intelence (etravirine) 942
Interferon, HIV/HCV co-infection, adverse effects
Interferon, tác dụng phụ ở bệnh nhân đồng nhiễm HIV/HCV ..... 572 b
Intermediate level (relative) resistance
Kháng trung gian (tương đối) 4
Intestinal
Đường tiêu hóa
cestodes
sán dây 461
nematodes
giun tròn 456
protozoa
sinh vật đơn bào 453
trematodes
sán lá 453
Intestines, parasites, fungi, unusual organisms in
kí sinh trùng, nấm, căn nguyên bất thường đường tiêu hóa 453
intraabdominal abscess
Ápxe trong ổ bụng 181
Intracellular inclusion bodies in blood
Thể vùi nội tế bào trong máu 419
Intrarenal abscess
Ápxe thận 194
Invanz 937
Invirase (saquinavir) 1043
In vitro data, microbiology susceptibility testing limitations
Dữ liệu In vitro, giới hạn của xét nghiệm độ nhạy của vi sinh vật với kháng sinh 11
In vitro susceptibility testing antibiotic-organism combinations, not predictive of in vivo
kết hợp thuốc trong xét nghiệm độ nhạy kháng sinh không có giá trị trong invivo
effectiveness
hiệu quả ..... 11 b
factors dependent on
các yếu tố tác động 11
in vivo efficacy, in vitro data and
hiệu quả lâm sàng, thông tin lâm sàng 10
Iodoquinol, pediatric dose
Iodoquinol, liều dùng cho trẻ em 680
Iritis, eye abnormalities (DDx)
Viêm mống mắt, các bất thường ở mắt (Chẩn đoán phân biệt) ..... 736 b
Ischemic foot ulcers
Loét bàn chân do thiếu máu cục bộ 247
Ischiorectal abscess
Ápxe ụ ngồi - trực tràng 267
Isentress (raltegravir) 1031
Isoniazid 961
Pediatric dose
Liều dùng cho trẻ em 680
isospora, chronic watery diarrhea
Nhiễm Isospora, ỉa chảy phân nước mạn tính 160
Isospora belli 454

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

HIV/AIDS.....550
Isosporiasis
Bệnh do Isospora..... 454
Israeli spotted fever
Sốt đốm người Do thái..... 490
itraconazole
Itraconazol.....964
IV drug abusers, acute bacterial endocarditis
Tiêm chích ma túy,
viêm nội tâm mạc nhiễm trùng 137
IV line infections
Nhiễm trùng đường truyền tĩnh mạch.....144
pediatric
trẻ em.....653

J

Japanese encephalitis (JE)
Viêm não Nhật Bản (JE).....47
Travel prophylaxis
dự phòng khi đi du lịch ..... 609 b
jaundice, general appearance abnormalities (DDx)
Vàng da, các bất thường khi thăm khám toàn thân (Chẩn đoán phân biệt) 743
Jock itch
Ngứa kiểu Jock 263
Joint infections, empiric therapy
Nhiễm trùng khớp, điều trị theo kinh nghiệm.....217
Joint prothesis, infected
Khớp giả, nhiễm trùng.....229
Jugular vein tenderness, neck abnormalities (DDx)
Ấn đau tĩnh mạch cảnh, các bất thường ở cổ (Chẩn đoán phân biệt) .....753 b

K

Kala-azar
Bệnh Kala- azar.....451
Kaletra [Lopinavir (LPV) + Ritonavir (RTV)].....978
Kaposi's sarcoma, HIV infection
Sarcom Kaposi, nhiễm HIV.....553
Keflex 893
Kefurox 892
Kefzol 869
Keratitis
Viêm giác mạc 57
amebic
do amíp 60
bacterial
do vi khuẩn 57
Eye abnormalities (DDx)
Các bất thường của mắt
(Chẩn đoán phân biệt).....746 b
HSV
Virus Herpes- Simplex 559
Viral, HSV-1
Virus, HSV-1 60
Ketek 1053
Ketoconazole
Ketoconazol 966
Kill ratios, calculating
Tỷ số diệt khuẩn, công thức tính.....816
Kingella kingae.....369 b
endocarditis
viêm nội tâm mạc.....130
Klebsiella .....330 b
cholangitis
viêm đường mật 165
cholecystitis
viêm túi mật 165
gallbladder wall abscess
ápxe thành túi mật.....166
sepsis
sepsis 268
surgical prophylaxis
dự phòng trong phẫu thuật.....580 b
urosepsis
sepsis do nhiễm khuẩn tiết niệu 198
usual/unusual susceptibility patterns

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

đặc điểm nhạy cảm thông thường/bất thường ..... 12 b
Klebsiella (Calymmatobacterium) granulomatosis, granuloma inguinale
u hạt do Klebsiella (Calymmatobacterium) ở bẹn 211
Klebsiella oxytoca
Klebsiella oxytoca 370
Klebsiella ozaenae, rhinoscleromatis
Klebsiella ozaenae, Viêm xơ cứng mũi. 226
Klebsiella pneumoniae 370
Acute bacterial meningitis
viêm màng não mủ cấp tính 32
alcoholics
người nghiện rượu 120
cavitary infiltrates (thick-walled)
xâm nhiễm dạng hang (thành dày) 726
cellutitis
viêm mô tế bào 236
community-acquired pneumonia
viêm phổi mắc phải ở cộng đồng 89
decubitus alcers
loét do tì đè 243
diabetic foot ulcers
loét bàn chân đo đái tháo đường 246
lung abscess/empyema
ápxe phổi/mủ màng phổi 123
osteomyelitis
viêm tủy xương 231
pneumonia
viêm phổi 123
sepsis
sepsis 268
skin abscesses/infected cysts
ápxe da/nhiễm trùng nang lông 248
unilateral focal segmental/lobar infiltrate with effusion
xâm nhiễm khu trú thùy phổi một bên có tràn dịch 694
unilateral focal segmental/lobar infiltrate without effusion
xâm nhiễm khu trú thùy phổi một bên không có tràn dịch 700
knee (total) replacement surgery, surgical prophylaxis
Phẫu thuật thay khớp gối, dự phòng trong phẫu thuật ..... 582 b

L

Lacrimal gland enlargement, head abnormalities (DDx)
Phì đại tuyến lệ, các bất thường ở đầu (Chẩn đoán phân biệt) ..... 745 b
Lactate dehydrogenase (LDH), elevated, serum test abnormalities (DDx)
Tăng lactat dehydrogenase (LDH), các bất thường xét nghiệm huyết thanh (Chẩn đoán phân biệt) ..... 778 b
Lactobacillus sp 387
Lamisil 1056
Lamivudine
Lamivudin (3TC) 967
Lamivudine + zidovudine (Combivir)
Lamivudin + zidovudin 827
Lassa fever
Sốt Lassa 310
LCM, meningitis
LCM, viêm màng não 39
Leflunomide 971
Left upper abdominal quadrant tenderness (splenic tenderness), abdominal abnormalities (DDx)
Ấn đau hạ sườn trái (vùng lách), các bất thường trong ổ bụng (Chẩn đoán phân biệt) ..... 484 b
Leg edema, unilateral/bilateral, extremity abnormalities (DDx)
Phù chân một bên/hai bên, các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt) ..... 764 b
Legionnaire's disease
Bệnh của lính lê dương hay bệnh do legionella .. 100
Legionella sp ..... 370 b
Bilateral infiltrates with effusion
xâm nhiễm hai phổi có tràn dịch

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

màng phổi 721
Bilateral infiltrates without effusion
xâm nhiễm hai phổi không có tràn dịch... 715
community-acquired pneumonia
viêm phổi mắc phải ở cộng đồng 89
endocarditis
viêm nội tâm mạc 132
organ transplants
ghép tạng 289
transplant infections
nhiễm trùng ở người được ghép tạng 284
unilateral focal segmental/lobar infiltrate with effusion
xâm nhiễm khu trú thùy phổi một bên có tràn dịch 697
unilateral focal segmental/lobar infiltrate without effusion
xâm nhiễm khu trú thùy phổi một bên không có tràn dịch. màng phổi 691
unilateral ill-defined infiltrates with effusion
Xâm nhiễm mờ một bên kèm tràn dịch màng phổi 707
unilateral ill-defined infiltrates without effusion
xâm nhiễm mờ một bên không kèm tràn dịch màng phổi 700
leg lesions, nodular, extremity abnormalities (DDx)
Các tổn thương ở chân dạng u nhỏ, các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt) ....765 b
leg lesions, verrucous, extremity abnormalities (DDx)
Tổn thương ở chân dạng mụn cơm, các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt) 764b
leg nodules, painful, extremity abnormalities (DDx)
Khối u nhỏ ở chân có đau, các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt) ....765 b
Leg ulcers, extremity abnormality (DDx)
Loét chân, các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt) ....764 b
Leishmania braziliensis
Leishmania braziliensis 465
Leishmania donovani, visceral leishmaniasis
Leishmania donovani, bệnh do leishmania nội tạng 275
Leishmania major
Leishmania major 455
Leishmania mexicana
Leishmania mexicana 465
Leishmaniasis cutaneous (Old World/New World)
Leishmania da (thế giới mới/thế giới cũ) 465
Visceral (Kala-azar)
Nhiễm Leishmania nội tạng hay Bệnh Kala-azar 450
Leishmania tropica
Leishmania tropica 455
Lemierre's syndrome
Hội chứng Lemierre 83
Lens implant, infected, endophthalmitis
Nhiễm trùng sau ghép thủy tinh thể, viêm nội nhãn cầu 65
leprosy
Bệnh phong 465
Leptospira interrogans
Leptospira interrogan ....371 b
Leptospirosis
Bệnh do nhiễm xoắn khuẩn leptospira
Leptospirosis, meningitis
viêm màng não do Leptospira 40
Leuconostoc
Leuconostoc ....352 b
Leukocyte esterase, urinary abnormalities (DDx)
Leukocyte esterase, các bất thường của nước tiểu (Chẩn đoán phân biệt) ....782 b
Leukocytosis, WBC abnormalitites (DDx)
Chứng tăng bạch cầu, Các bất thường của bạch cầu (Chẩn đoán phân biệt) ....770 b
Leukopenia, WBC abnormalities (DDx)
Chứng giảm bạch cầu, Các bất thường của bạch cầu (Chẩn đoán phân biệt) ....770 b
Leukoplakia, mouth abnormalities (DDx)
Chứng bạch sản, các bất thường ở miệng (Chẩn đoán phân biệt) ....751 b
Leukostasis, bilateral infiltrates without effusion
Tăng bạch cầu quá mức, xâm nhiễm hai phổi

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

không có tràn dịch màng phổi 719
Levaquin 972
Levofloxacin 972
Lexiva (fosamprenavir) 948
Lice infestations, body, head, pubic
Chấy, rận thân mình/đầu/mu 265
Linezolid 975
Pearls & pitfalls
Điểm nhấn và các sai lầm cần tránh 807
pediatric dose
liều dùng cho trẻ em 680
Liposomal/lipid complex
Liposomal/hỗn hợp lipid
pediatric dose
liều dùng cho trẻ em 680
listeria, transplant infections
nhiễm trùng ở người được ghép tạng, Listeria 288
Listeria encephalitis
Viêm não do Listeria 47
Listeria monocytogenes
Listeria monocytogenes ..... 356 b
Acute bacterial meningitis
viêm màng não mủ cấp tính 33
encephalitis
Viêm não 47
liver
Gan
abscess
Ápxe 170
cystic masses
khối dạng nang 449
hepatomegaly
gan to 450
Parasites, fungi, unusual organisms in
kí sinh trùng, nấm, căn nguyên bất thường trong 447
liver flukes
Sán lá gan 447
Liver test abnormalities (DDx) alkaline phosphatase (AP), elevation
Các bất thường về xét nghiệm gan (Chẩn đoán phân biệt) tăng alkalin phosphatase (AP) ... 779 b
GGT (GGTP), elevation
Tăng GGT (GGTP) ..... 780 b
Serum transaminases (SGOT/SGPT), elevation
Tăng transaminase huyết thanh (SGOT/ SGPT) ..... 779 b
Total bilirubin, elevation
Tăng bilirubin toàn phần ..... 780 b
Liver transplants, transplant prophylaxis (BMT/SOT)
Ghép gan, dự phòng sau ghép tủy xương/ ghép tạng đặc ..... 601 b
Lizard skin, general appearance abnormalities (DDx)
Da kiểu động vật bò sát, các bất thường khi thăm khám toàn thân (Chẩn đoán phân biệt) ..... 733 b
Loa Loa (Loiasis)
Bệnh Loa Loa 412
Loeffler's syndrome, bilateral infiltrates without effusion
Hội chứng Loeffler, xâm nhiễm hai phổi không có tràn dịch màng phổi 712
Lopinavir + ritonavir (Kaletra) 706
Lorabid 980
Loracarbef 980
Louse-borne relapsing fever (LBRF)
Sốt hồi quy do chấy rận (LBRF) 417
LPV/RTV (Kaletra) 706
Ludwig's angina
Viêm họng Ludwig 81
Lung contusion
Đụng giập phổi
bilateral infiltrates without effusion
xâm nhiễm hai phổi không có tràn dịch màng phổi. 02
unilateral ill-defined infiltrates without effusion
xâm nhiễm mờ một bên không có tràn dịch màng phổi 690
lung fluke. See Paragonimus westermani
Sán lá phổi xem Paragonimus westermani
Lungs, parasites, fungi, unusual organisms in
Kí sinh trùng, nấm, căn nguyên bất thường ở phổi 433
Lyme arthritis

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm khớp Lyme 226
Lyme disease, post-exposure prophylaxis
Bệnh Lyme, dự phòng sau phơi nhiễm. .....589 b
Lymphadenopathy, generalized, lymph node abnormalities (DDx)
Hạch to toàn thân, các bất thường hạch bạch huyết (Chẩn đoán phân biệt) .....760 b
Lymphangitic metastases
Di căn hạch
bilateral infiltrates with effusion
Xâm nhiễm hai phổi có tràn dịch màng phổi 479
Unilateral ill-defined infiltrates with effusion
Xâm nhiễm mờ một bên có tràn dịch màng phổi 709
Unilateral ill-defined infiltrates without effusion
xâm nhiễm mờ một bên không có tràn dịch màng phổi 704

lymphangitis
Viêm hạch
Extremity abnormalities (DDx)
các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt) .....762 b
lymph node abnormalities (DDx)
Các bất thường hạch bạch huyết (Chẩn đoán phân biệt)
Anterior cervical adenopathy
Hạch cổ trước .....759 b
Axillary adenopathy
Hạch nách .....760 b
Epitrochlear adenopathy
Hạch quanh hố ròng rọc .....759 b
Generalized lymphadenopathy
Bệnh lý hạch toàn thân .....760 b
Infraclavicular adenopathy
Hạch dưới đòn .....759 b
Inguinal adenopathy, unilateral/ bilateral
Hạch bẹn, một bên/hai bên .....760 b
Occipital adenopathy
Hạch vùng gáy .....759 b
Periumbilical nodule
Nốt cục quanh rốn .....759 b
Posterior cervical adenopathy, unilateral/bilateral
Hạch cổ trước một/hai bên .....759 b
Prearicular adenopathy
hạch trước tai .....759 b
supraclavicular adenopathy
hạch thượng đòn .....759 b
ulcer-node syndromes
Hội chứng loét-nổi hạch .....769 b
Lymphocytes, pleural fluid abnormalities (DDx)
Tràn dịch màng phổi tăng bạch cầu Lympho (Chẩn đoán phân biệt) .....770 b
Lymphogranuloma venereum (LGV)
Bệnh u hạt bạch huyết hoa liễu (LGV 211
lymphoma
U lympho
Bilateral infiltrates with effusion
xâm nhiễm hai phổi có tràn dịch màng phổi 724
bilateral infiltrates without effusion
xâm nhiễm hai phổi không có tràn dịch màng phổi 705
cavitary infiltrates (thick-walled)
xâm nhiễm dạng hang (thành dày) 732
unilateral focal segmental/lobar infiltrate with effusion
xâm nhiễm khu trú thùy phổi một bên có tràn dịch màng phổi 699
unilateral focal segmental/lobar infiltrate without effusion
xâm nhiễm khu trú thùy phổi một bên không có tràn dịch 693
unilateral ill-defined infiltrates with effusion
xâm nhiễm mờ một bên có tràn dịch màng phổi 709
unilateral ill-defined infiltrates without effusion
xâm nhiễm mờ một bên không có tràn dịch màng phổi 705

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

M

Macrobid

Macrobid 1003

Macrodantin 1003

Macrolides

Macrolid

Pearls & pitfalls

Điểm nhấn và các sai lầm cần tránh.....809

susceptibility profiles

Các thông tin về độ nhạy cảm của vi sinh vật với thuốc .....324 b

Malaria (worldwide)

Sốt rét (toàn cầu) 423

prophylaxis

dự phòng .....610 b

severe

thể nặng 419

uncomplicated

không biến chứng.....421

Malarone

Malaron 858

Malassezia furfur

Malassezia furfur .....393 b

eosinophilic folliculitis

viêm nang lông tăng bạch cầu ái toan 492

tinea versicolor/pityriasis

lang ben/bệnh vảy phấn.....492

Mandelamine

Mandelamin 985

Mandol 868

Maraviroc (MVC).....981

Marburg virus disease

Bệnh do virus Marburg 310

Mass lesions, organ transplants

Tổn thương dạng khối, ghép tạng 293

mastitis

Viêm tuyến vú.....236

Mastoiditis

Viêm xương chũm 72

pediatric

nhi khoa 640

maxillary sinus, acute bacterial sinusitis

Viêm xoang hàm trên, viêm xoang nhiễm trùng cấp.....57

Maxipime

Maxipim 875

MDR

Vi khuẩn kháng nhiều thuốc

acute bacterial meningitis

viêm màng não cấp do vi khuẩn.....32

community-acquired pneumonia

viêm phổi mắc phải từ cộng đồng.....89

pneumonia

viêm phổi.....90

MDR acinetobacter, catheter-associated bacteriuria

Có vi khuẩn niệu liên quan với ống thông tiểu do Acinetobacter đa kháng kháng sinh 186

MDR GNBs, bacterial cystitis

Viêm bàng quang do vi khuẩn Gr (-) đa kháng kháng sinh.....148

MDR Klebsiella, catheter-associated bacteriuria

Có vi khuẩn niệu liên quan với ống thông tiểu do Klebsiella đa kháng 186

MDROs. See Multi-drug resistant organisms (MDROs)

Các vi khuẩn đa kháng kháng sinh. Xem các vi sinh vật kháng nhiều kháng thuốc kháng sinh (MDROs)

MDR P. aeruginosa, catheter-associated bacteriuria

Có vi khuẩn niệu liên quan với ống thông tiểu do P. aeruginosa đa kháng kháng sinh.....186

MDRSP, acute otitis media

Viêm tai giữa cấp do phế cầu (S.pneumoniae) đa kháng kháng sinh.....69

MDR-TB

Trực khuẩn lao đa kháng thuốc

Measles

Bệnh sởi

Adult immunization

tiêm chủng người lớn.....616 b

bilateral infiltrates with effusion

Dr Huỳ Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

xâm nhiễm hai phổi
có tràn dịch màng phổi....722
Measles, mumps, rubella,
Bệnh sởi, quai bị, rubella,
prophylaxis
dự phòng 530
Mediastinitis
Viêm trung thất.... 88
Meditereanean spotted fever
Sốt đốm Địa trung Hải....490
Mefoxin 879
Melioidosis, cavitary infiltrates (thick-walled)
Bọ chét chuột, xâm nhiễm
dạng hang (thành dày)....735
Membranous pharyngitis
Viêm họng giả mạc....74
Meningitis acute bacterial
Viêm màng não cấp
CNS shunt infections
Nhiễm khuẩn....38
elderly
Người già....37
Empiric therapy
Điều trị theo kinh nghiệm....32
malignancy
Ác tính....33
Normal host
Người bình thường....32
pediatric
trẻ em 628
acute non-bacterial
không do vi khuẩn....39
amebic granulomatous
u hạt do amíp 39
primary
tiên phát 39
aseptic/viral
vô khuẩn/virus....41
chronic
mạn tính 46
cryptococcal
Do cryptococcus 45
HIV/AIDS
HIV/AIDS....541
Organ transplants
Được ghép tạng....288
post-exposure prophylaxis
dự phòng sau phơi nhiễm....541
transplant infections
nhiễm trùng ở người được ghép tạng 283
tuberculosis
lao 44
viral
virus 41
Meningococcal meningitis, travel prophylaxis
Viêm màng não do não mô cầu,
dự phòng khi đi du lịch....608 b
Meningococcus (invasive disease), adult immunization
Meningococcus (bệnh lý xâm nhập), tiêm
chủng người lớn ....616 b
Mental confusion, neurological abnormalities (DDx)
Rối loạn ý thức, các bất thường
của hệ thần kinh (Chẩn đoán phân biệt) ....767 b
Mepron 855
Meronem 982
Meropenem....982
Pediatric dose
liều dùng cho trẻ em 680
MERS/Middle East Respiratory syndrome
MERS hay hội chứng hô hấp vùng Trung Đông... 111
Metagonimus yokogawai, heterophyiasis
Metagonimus yokogawai, heterophyiasis 463
Metastatic carcinoma bilateral infiltrates without effusion
Ung thư biểu mô di căn xâm nhiễm hai phổi
không có tràn dịch màng phổi....719
cavitary infiltrates (thick-walled)
xâm nhiễm dạng hang (thành dày) 733
unilateral ill-defined infiltrates with effusion
xâm nhiễm mờ một bên có tràn dịch
màng phổi....711
Methenamine hippurate

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Methenamine hippurat 985

Methicilin-resistant staphylococcus aureus (MRSA)

Tụ cầu vàng kháng methicilin (MRSA) 23

Classification of infections

Phân loại nhiễm trùng ..... 24 b

Metronidazole

Metronidazol 986

Pearls & pitfalls

Điểm nhấn và các sai lầm cần tránh 810

pediatric dose

liều dùng cho trẻ em 681

Mezlin 988

Mezlocillin 988

Micafungin 989

Microbiology susceptibility testing and limitations of

Xét nghiệm đánh giá độ nhạy cảm của vi sinh vật với kháng sinh và các hạn chế của test này 9

overview

tổng quan 9

Microfilaria in blood

Ấu trùng giun chỉ trong máu 409

Microsporidia enteritis, HIV

Viêm ruột do Microsporidia, HIV/AIDS 550

Microsporum canis, tinea corporis

Microsporum canis, nấm da thân 263

Migratory rashes, extremity abnormalities (DDx)

Ban di chuyển, các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt) ..... 766 b

Miliary (disseminated) BCG

Lao kê (lan tỏa) 279

Minocin 991

Minocycline

Minocyclin 991

Mixed aerobic/anaerobic deep soft tissue infection

Nhiễm trùng mô mềm do nhiễm hỗn hợp vi khuẩn ưa khí/kị khí 238

Mobiluncus 206

Mode of elimination, explanation

Đường thải trừ, giải thích 817

Monobactams, pearls & pitfalls

Monobactam, điểm nhấn và các sai lầm cần tránh 774

Monoclonal gammopathy, serum test abnormalities (DDx)

Bệnh tăng gamma đơn dòng, các bất thường xét nghiệm huyết thanh (Chẩn đoán phân biệt) ..... 776 b

Mononeuritis multiplex, neurological abnormalities (DDx)

Viêm đơn dây thần kinh đa ổ, các bất thường của hệ thần kinh (Chẩn đoán phân biệt) ..... 769 b

Monospot test (false+) (DDx)

Monospot (dương tính giả), bất thường xét nghiệm huyết thanh (Chẩn đoán phân biệt) ..... 777 b

Monotherapy vs. combination therapy

Đơn trị liệu so sánh với phác đồ điều trị phối hợp 14

Monurol 951

Moraxella catarrhalis

Moraxella catarrhalis 227

Acute bacterial exacerbation of chronic bronchitis

đợt cấp của viêm phế quản mạn tính 87

acute otitis media

viêm tai giữa cấp 69

community-acquired pneumonia

viêm phổi mắc phải từ cộng đồng 89

conjunctivitis

viêm kết mạc 61

keratitis

viêm giác mạc 59

unilateral focal segmental/lobar infiltrate without effusion

xâm nhiễm khu trú thùy phổi một bên không có tràn dịch màng phổi 690

Morganella morganii 371

Morganella sp

Usual/unusual susceptibility patterns

kiểu nhạy cảm thường gặp/ không thường gặp của vi sinh vật với thuốc ..... 12 b

morning temperature spikes, fever curves (DDx)

Đỉnh sốt buổi sáng, biểu đồ nhiệt độ

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

(Chẩn đoán phân biệt) ..... 741 b
Mouth abnormalities (DDx)
Các bất thường ở miệng (Chẩn đoán phân biệt)
Angular chelitis
Viêm môi bong vảy 751b
Crimson crescents
trăng lưỡi liềm đỏ ..... 752 b
frenal ulcer
Loét hãm lưỡi ..... 752 b
gingivitis
viêm lợi ..... 752 b
Herpes labialis
Herpes môi ..... 752 b
Hoarseness
Khàn tiếng ..... 752 b
leukoplakia
bạch tạng ..... 751 b
oral ulcers, solitary/multiple
loét miệng, đơn độc/nhiều vết loét ..... 752 b
palatal perforation
hở hàm ếch/thủng màn hầu ..... 752 b
palatal petechiae
xuất huyết hàm ếch ..... 752 b
palatal vesicles
mụn nước màn hầu ..... 752 b
tongue tenderness
Ấn đau lưỡi ..... 751 b
Tongue ulcers
loét lưỡi ..... 751 b
tonsillar membrances
viêm amiđan có giả mạc ..... 752 b
tonsillar ulcers
loét amiđan ..... 752 b
trismus
cứng hàm ..... 751 b
uvular edema
phù lưỡi gà ..... 752 b
mouth ulcers/vesicles
Loét/phỏng nước trong miệng 79
Moxifloxacin 993
MRSA. See Methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA)
MRSA. Xem phần tụ cầu vàng kháng methicillin
MSSA, brain abscess
MSSA, áp xe não 50
Mucocutaneous (local/non-disseminated) candidiasis
Nấm Candida da niêm mạc (khu trú/không lan tỏa) 260
Mucor
Mucor
Cutaneous zygomycosis
Zygomyces ở da 290
Pulmonary zygomycosis
Zygomyces ở phổi 445
mucormycosis
Bệnh do Mucormyces 445
Multi-drug resistant organisms (MDROs), susceptibility patterns of
Đặc điểm nhạy cảm của các căn nguyên đa kháng thuốc ..... 13 b
Mumps
Quai bị
Adult immunization
tiêm chủng người lớn ..... 616 b
meningitis
viêm màng não 39
murine (flea-borne) typhus
Sốt Rickettsia do chuột (bệnh do bọ chét) 486
Muscle rigidity, general, neurological abnormalities (DDx)
Cứng cơ toàn thân, các bất thường của hệ thần kinh (Chẩn đoán phân biệt) ..... 767 b
Muscles parasites, fungi, unusual organisms in
Kí sinh trùng, nấm, căn nguyên bất thường ở da/cơ 465
Tenderness in, extremity abnormality (DDx)
Căng đau cơ, các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt) ..... 764 b
MVC (maraviroc) 981
Myambutol 940
Mycamine

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Mycamin 989
Mycobacterium avium-intracellulare (MAI)
Mycobacterium avium-intracellulare (MAI)
Commutnity-acquired pneumonia
viêm phổi mắc phải ở cộng đồng.....95
cutaneous
da 474
HIV/AIDS
HIV/AIDS.....526
prophylaxis
dự phòng 526
pneumonia
viêm phổi.....120
prophylaxis of opportunistic infections
dự phòng nhiễm trùng cơ hội.....529 b
Mycobacterium chelonae, cutaneous
Bệnh do Mycobacterium chelonae ngoài da.....472
Mycobacterium fortuitum, cutaneous
Bệnh do Mycobacterium fortuitum ngoài da.....473
Mycobacterium genitalium, post-exposure prophylaxis
Mycobacterium genitalium, dự phòng sau phơi nhiễm.....587 b
Mycobacterium haemophilum
Mycobacterium haemophilum 472
Cutaneous
Ngoài da.....472
Mycobacterium kansasii pneumonia
Viêm phổi do Mycobacterium kansasii.....95
Mycobacterium leprae, leprosy
Mycobacterium leprae, Bệnh phong.....465
Mycobacterium marinum, swimming pool granuloma
Mycobacterium marinum, u hạt bể bơi.....473
Mycobacterium scrofulaceum, scrofula
Bệnh do Mycobacterium, bệnh tràng nhạc...472
Mycobacterium tuberculosis (TB)
Bệnh do Trực khuẩn lao (TB)
Atypical, cavitary infiltrates (thin-walled)
Xâm nhiễm dạng hang không điển hình (thành mỏng) 734
bilateral infiltrates without effusion
xâm nhiễm hai phổi không có tràn dịch màng phổi 712
cavitary infiltrates (thick-walled)
xâm nhiễm dạng hang (thành dày).....726
chronic pyelonephritis
viêm thận bể thận mạn 192
chronic tuberculosis peritonitis
Lao màng bụng mạn tính 182
Community-acquired pneumonia
viêm phổi mắc phải ở cộng đồng.....89
cutaneous mycobacteria
mycobacteria ngoài da 468
endophthalmitis
viêm nội nhãn cầu 65
epididymitis
viêm mào tinh hoàn 188
HIV extrapulmonary
HIV/AIDS ngoài phổi 548
prophylaxis
dự phòng 526
MDR-TB 53
Trực khuẩn lao đa kháng thuốc
meningitis
viêm màng não.....32
miliary tuberculosis
lao kê 279
organ transplants
ghép tạng 167
pediatric
trẻ em 410
pericarditis
viêm màng ngoài tim 78
pneumonia
viêm phổi 95
HIV/AIDS 534
Post-exposure prophylaxis
dự phòng sau phơi nhiễm. .....591 b
prophylaxis of opportunistic infections
dự phòng nhiễm trùng cơ hội.....527 b

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

renal TB
Lao thận 192
Transplant infections
nhiễm trùng ở người được ghép tạng .283
tuberculosis arthritis
Viêm khớp do lao 220
Tuberculosis osteomyelitis
viêm tủy xương do lao.....232
unilateral focal segmental/lobar infiltrate with effusion
xâm nhiễm khu trú thùy phổi một bên có tràn dịch màng phổi. 698
unilateral ill-defined infiltrates with effusion
xâm nhiễm mờ một bên có tràn dịch màng phổi. 709
Mycobacterium ulcerans, Buruli ulcer
Mycobacterium ulcerans, loét Buruli. 474
Mycobutin 1034
Mycoplasma encephalitis
Viêm não do Mycoplasma 47
Mycoplasma genitalium, urethritis/cervicitis
Mycoplasma genitalium, viêm niệu đạo/ viêm cổ tử cung. 204
Mycoplasma pharyngitis
viêm họng do Mycoplasma 76
Mycoplasma pneumonia
Viêm phổi do Mycoplasma. 102
Community-acquired pneumonia
viêm phổi mắc phải ở cộng đồng 89
encephalitis
Viêm não 47
pharyngitis
viêm họng.....73
pneumonia
viêm phổi 102
unilateral ill-defined infiltrates without effusion
xâm nhiễm mờ một bên không có tràn dịch màng phổi 700
myocarditis
Viêm cơ tim 142
Myoglobinuria (2º to rhabdomyolysis), urinary abnormalities (DDx)
Myoglobin niệu (2º sau tiêu cơ vân), các bất thường của nước tiểu (Chẩn đoán phân biệt).....773b
Myositis
Viêm cơ 93

N

N.meningitidis, conjunctivitis
viêm kết mạc do N.meningitidis .. 61
Naegleria fowleri, meningitis
Viêm màng não do Naegleria fowleri.. 42
Nafcillin 996
pediatric dose
liều dùng cho trẻ em 681
Nails, fungal infections
Nấm móng. 261
Nasal abnormalities (DDx) epistaxis
Các bất thường của mũi (Chẩn đoán phân biệt), Chảy máu cam.....750 b
Nasal septal perforation
Thủng vách ngăn mũi.. .....750 b
Nose tip gangrene
Hoại thư đầu mũi . .....750 b
Purple nose tip
Đỉnh mũi tím.....750 b
Nasal septal perforation, nasal abnormalities (DDx)
Thủng vách ngăn mũi, các bất thường ở mũi (Chẩn đoán phân biệt).....750 b
National Committee for Clinical Laboratory Standards. See Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)
National Committee for Clinical Laboratory Standards. Xem phần Viện tiêu chuẩn lâm sàng và xét nghiệm (CLSI)..... 14 b
Naturally/intrinsically resistant pathogens
Căn nguyên đề kháng tự nhiên/nội sinh 4
Nebcin
Nebcin 1068

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

NebuPent
NebuPent 1014
Necator americanus, hookworm
Necator americanus, Giun móc 458
Neck abnormalities (DDx)
Các bất thường ở cổ (Chẩn đoán phân biệt)
Bull neck
cổ sưng to (to và ngắn) ..... 753 b
enlarged greater auricular nerve
Phì đại dây thần kinh nhĩ lớn ..... 753 b
Jugular vein tenderness
Căng đau tĩnh mạch cảnh 753
Neck sinus tract
Đường rò ở cổ ..... 753 b
Superior vena cava syndrome
Hội chứng tĩnh mạch chủ trên ..... 753 b
Neck infections, deep
Nhiễm trùng vùng sâu của cổ 83
Neck sinus tract, neck abnormalities (DDx)
Đường rò ở cổ, các bất thường ở cổ (Chẩn đoán phân biệt) ..... 753 b
Necrotizing abscesses
Viêm cân mạc hoại tử 239
Necrotizing fasciitis
Viêm cân hoại tử 239
Neisseria gonorrhoeae (GC)
Lậu cầu (GC) 353
cervicitis
viêm cổ tử cung 205
conjunctivitis
viêm kết mạc 61
endometritis
viêm nội mạc tử cung 202
PID
Bệnh lý viêm tiểu khung 202
salpingitis
viêm vòi tử cung 202
septic abortion
sảy thai do nhiễm trùng 202
septic arthritis
viêm khớp nhiễm khuẩn 218
tuboovarian abscess
ápxe phần phụ 202
urethritis
viêm niệu đạo 204
Neisseria meningitidis
Neisseria meningitidis ..... 329 b
Acute bacterial meningitis
viêm màng não mủ cấp tính 32
chronic medical prophylaxis
Dự phòng nội khoa mạn tính ..... 595 b
Post-exposure prophylaxis
Dự phòng sau phơi nhiễm ..... 419 b
sepsis
sepsis 268
travel prophylaxis
dự phòng khi đi du lịch ..... 584 b
usual/unusual susceptibility patterns
mô hình nhạy cảm thông thường/bất thường ..... 12 b
Nelfinavir (NFV) 997
Nematodes (roundworms), intestinal
Nematodes (giun tròn), đường tiêu hóa 456
Neonatal Group B streptococcal (GBS) infection (primary prevention), chronic medical prophylaxis
Nhiễm liên cầu nhóm B ở trẻ sơ sinh (dự phòng tiên phát), Dự phòng nội khoa mạn tính. ... 595 b
Nephrotic syndrome, general appearance abnormalities (DDx)
Hội chứng thận hư, các bất thường khi thăm khám toàn thân (Chẩn đoán phân biệt) ..... 743 b
Neuroborreliosis, meningitis
viêm màng não do Borrelia (Neuroborreliosis) 43
neurobrucellosis
Bệnh brucella thần kinh 44
Neurocysticercosis
Sán lợn thể thần kinh 430
meningitis
viêm màng não 32
neurological abnormalities (DDx)
Các bất thường của hệ thần kinh (Chẩn đoán

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

phân biệt)
anisocoria
đồng tử không đều ....768 b
Bell's palsy
Liệt dây VII (liệt Bell)....768 b
Cranial nerve abnormalities, unilateral/bilateral
các bất thường dây thần kinh sọ, một bên/hai bên ....768 b
flaccid paralysis (acute)
liệt mềm (cấp)....769 b
general muscle rigidity
cứng cơ toàn thân ....767 b
Guillain-Barré syndrome
Hội chứng Guillain-Barré ....769 b
Hemiplegia/hemiparesis
Liệt nửa người/liệt nửa người nhẹ....769 b
Mental confusion/encephalopathy (acute)
Rối loạn ý thức/bệnh não (cấp)....767 b
Mononeuritis multiplex
Viêm đơn dây thần kinh không đối xứng nhiều đoạn ....769 b
Nuchal rigidity
cứng gáy ....767 b
optic nerve atrophy
teo dây thần kinh thị giác....768 b
papilledema
Phù gai thị ....769 b
Transient deafness
Điếc thoáng qua....767b
Transverse myelitis
viêm tủy cắt ngang ....769 b
neurosyphilis
Giang mai thần kinh 216
Nevirapine (NVP) 999
NFV (nelfinavir) 997
Nitazoxanide
Nitazoxanid 1001
Nitrite positive, urinary abnormalities (DDx)
Nitrit dương tính, các bất thường của nước tiểu (Chẩn đoán phân biệt)....783 b
Nitrofurantoin
Nitrofurantoin 1003
Pearls & pitfalls
Điểm nhấn và các sai lầm cần tránh ..805
Nizoral 966
Nocardia asteroides
Nocardia asteroides ....546 b
Pulmonary nocardiosis
Nocardia ở phổi....439
Nocardia brasiliensis
Nocardia brasiliensis ....357 b
Nocardia sp....329
Cavitary infiltrates (thick-walled)
xâm nhiễm dạng hang (thành dày)702
cerebral nocardiosis
nocardia ở não....425
cutaneous nocardiosis
nocardia ở da 471
transplant infections
nhiễm trùng ở người được ghép tạng....289
unilateral ill-defined infiltrates with effusion
xâm nhiễm mờ một bên có tràn dịch màng phổi 702
unilateral ill-defined infiltrates without effusion
xâm nhiễm mờ một bên không có tràn dịch màng phổi 730
nocardiosis, cutaneous
Bệnh do Nocardia ngoài da 471
nodular arm/leg lesions, extremity abnormalities (DDx)
Tổn thương dạng khối u nhỏ ở tay/ chân, các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt) ....765 b
Nodular lymphangitis, extremity abnormalities (DDx)
Viêm hạch bạch huyết, các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt)....752 b
Nodular/pustular candidiasis
Nấm Candida thể u/mụn mủ 479
Nodules, skin
Cục (hạt nhỏ) trên da 477
Non-aeruginosa Pseudomonas, urosepsis
Pseudomonas không phải aeruginosa, sepsis do nhiễm khuẩn tiết niệu 199

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Non-cholera vibrios, travel prophylaxis
Vibrios không phải cholera, dự phòng khi đi du lịch 607b
Non-fermentative GNBs,
Vi khuẩn Gr (-) không lên men
CAPD-associated peritonitis
Viêm phúc mạc liên quan lọc màng bụng ngoại trú liên tục 181
Non-gonococcal urethritis (NGU), post-exposure prophylaxis
viêm niệu đạo không do lậu cầu (NGU), dự phòng sau phơi nhiễm ..... 587 b
Norvir (ritonavir) 1040
Norwalk virus, travel prophylaxis
Norwalk virus, dự phòng khi đi du lịch 607
Nose tip gangrene, nasal abnormalities (DDx)
Hoại tử đỉnh mũi, các bất thường ở mũi (Chẩn đoán phân biệt) ..... 750 b
Nosocomial pneumonia, bilateral infiltrates without effusion
viêm phổi bệnh viện, xâm nhiễm hai phổi không có tràn dịch màng phổi 716
nosocomial pneumonia (NP)
viêm phổi bệnh viện 126
Noxafil 1022
Nuchal rigidity, neurological abnormalities (DDx)
Cứng gáy, các bất thường của hệ thần kinh (Chẩn đoán phân biệt) ..... 767 b
Nuritionally-variant streptococci (NVS), endocarditis
Nuritionally-variant viêm nội tâm mạc (NVS), viêm nội tâm mạc ..... 130 b
Nursing home-acquired pneumonia (NHAP)
viêm phổi mắc phải tại cơ sở dưỡng lão (NHAP) 124
NVP (nevirapine) 999
Nystatin, pediatric dose
Nystatin, liều dùng cho trẻ em 682

O

Occipital adenopathy, lymph node abnormalities (DDx)
Hạch vùng gáy, các bất thường hạch bạch huyết (Chẩn đoán phân biệt) 759
Ochrobactrum anthropi (CDC group Vd)
Ochrobactrum anthropi (CDC group Vd) ..... 371 b
oflox 1004
ofloxacin 1004
Omnicef 871
Onchocerca volvulus, cutaneous onchorcerciasis
Onchocerca volvulus, cutaneous onchorcerciasis 509
Onchocerciasis, cutaneous
Bệnh Onchocerca trên da 509
onychomycosis
Bệnh nấm móng 261
Opisthorchiasis
Bệnh do sán lá Opisthorchis 448, 449
Opisthorchis viverrini
Opisthorchis viverrini 449
Opportunistic infections. See HIV infection
Nhiễm trùng cơ hội. xem HIV
Optic nerve atrophy, neurological abnormalities (DDx)
Teo dây thần kinh thị, các bất thường của hệ thần kinh (Chẩn đoán phân biệt) ..... 768 b
Oral anaerobes
Vi khuẩn kị khí khoang miệng 94
Brain abscess
ápxe não 51
community-acquired pneumonia
viêm phổi mắc phải từ cộng đồng 96
deep neck infections
Nhiễm trùng vùng sâu ở cổ 83
Dental infections
nhiễm khuẩn răng 83
gastric perforation
Thủng dạ dày 154
Human bite wounds
vết thương do người cắn 257
lung abscess/empyema
ápxe phổi/mủ màng phổi 123
mastoiditis
viêm xương chũm 72
suppurative parotitis

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

viêm tuyến mang tai mưng mủ.....72
oral anti-pseudomonal penicillins, pearls & pitfalls
các penicillin đường uống điều trị pseudomonas, điểm nhấn và các sai lầm cần tránh.....792
oral anti-staphylococcal penicillins, pearls & pitfalls
các penicillin đường uống điều trị staphylococcus, ưu điểm & các sai lầm cần tránh.....792
oral first-generation cephalosporins, pearls & pitfalls
Các cephalosporin thế hệ 1 đường uống, điểm nhấn và các sai lầm cần tránh.....793
Oral second-generation cephalosporins, pearls & pitfalls
Các cephalosporin thế hệ 2 đường uống, điểm nhấn và các sai lầm cần tránh.....794
Oral third-generation cephalosporins, pearls & pitfalls
Các cephalosporin thế hệ 3 đường uống, điểm nhấn và các sai lầm cần tránh.....795
Oral ulcers, solitary/multiple, mouth abnormalities (DDx)
Loét miệng, một ổ loét/nhiều ổ loét, các bất thường ở miệng (Chẩn đoán phân biệt).....751 b
Orbital cellulitis, pediatric
viêm mô tế bào khu vực hốc mắt ở trẻ em....635
organ transplants
Ghép tạng
Bacteremia or candidemia
nhiễm trùng máu hoặc nhiễm nấm Candida máu 284
bone marrow
tủy xương.....284
brain abscess/mass lesion
ápxe não/ tổn thương dạng khối.....288
encephalitis/meningitis
Viêm não/viêm màng não 288
Hepatitis, viral
viêm gan virus.....286
infections
nhiễm khuẩn.....283
pneumonias
viêm phổi.....285
solid organ
tạng đặc 284
Oropharyngeal candidiasis, HIV
Nấm Candida miệng họng, ở người nhiễm HIV..552
Orthopedic prosthetic implant surgery, surgical prophylaxis
Phẫu thuật chỉnh hình cấy ghép bộ phận giả, dự phòng trong phẫu thuật .....582 b
Orthopedic surgery (open fracture), surgical prophylaxis
Phẫu thuật chỉnh hình (gãy xương hở), dự phòng trong phẫu thuật.....582 b
Oseltemavir 1005
Osteochondritis, pediatric
Viêm xương sụn, trẻ em 664
Osteomyelitis
Viêm xương-tủy xương 231
acute, pediatric
Cấp tính, trẻ em..... 664
chronic
Mạn tính.....233, 243
Otitis externa
Viêm tai ngoài 68
pediatric
trẻ em 638
Otitis media
Viêm tai giữa
acute
Cấp 69
pediatric
trẻ em 638
Oxacillin 1007
pediatric dose
liều dùng cho trẻ em 678

P

P.cepacia, surgical prophylaxis
P.cepacia, dự phòng trong phẫu thuật.....583 b
P. maltophilia, surgical prophylaxis
P. maltophilia, dự phòng trong phẫu thuật..... 583 b
Pacemaker infections

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nhiễm trùng sau đặt máy tạo nhịp tim 148
Painless purple palm/sole lesions, extremity abnormalities (DDx)
Các tổn thương gan tay/chân màu tím không đau, các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt).....765 b
Palatal perforation, mouth abnormalities (DDx)
Hở hàm ếch/thủng màn hầu Chẩn đoán phân biệt).....752 b
Palatal petechiae, mouth abnormalities (DDx)
Xuất huyết hàm ếch/màn hầu, (Chẩn đoán phân biệt).....752 b
Palatal vesicles, mouth abnormalities (DDx)
Mụn nước ở hàm ếch, các bất thường ở miệng (Chẩn đoán phân biệt) .....752 b
Palpable purpura, extremity abnormalities (DDx)
Tử ban, các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt).....765 b
Pancreatic abscess
Ápxe tụy 170
Pancreatic pseudocyst, infected
Nang giả tụy nhiễm trùng.....170
Pancreatitis
Viêm tụy
acute
cấp 169
edematous
phù nề.....169
Hemorrhagic/necrotizing
hoại tử/xuất huyết.....169
Pancytopenia, platelet abnormalities (DDx)
Giảm ba dòng, các bất thường về tiểu cầu (Chẩn đoán phân biệt).....775 b
Papilledema, neurological abnormalities (DDx)
Phù gai thị, các bất thường của hệ thần kinh (Chẩn đoán phân biệt).....769 b
Papular axillary lesions, extremity abnormalities (DDx)
Tổn thương nách dạng nốt sần, các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt).....763
Papules, skin
Nốt sần trên da.....467
Paracoccidioides brasiliensis, pulmonary paracoccidioidomycosis
Paracoccidioides brasiliensis, paracoccidioidomyces ở phổi.....427
Paragonimiasis, cavitary infiltrates (thin-walled)
Paragonimia, xâm nhiễm dạng hang (thành mỏng).....725
Paragonimus westermani cerebral paragonimiasis
Bệnh do sán paragonimus, bệnh sán Paragonimus westermani não.....421
(lung fluke)
Sán lá phổi.....423
Pulmonary paragonimiasis
Bệnh nhiễm sán paragonimus phổi
Parenteral first-generation cephalosporins, pearls & pitfalls
Cephalosporin thế hệ 1 đường tĩnh mạch, Điểm nhấn và các sai lầm cần tránh.....83
Parenteral second-generation cephalosporins, pearls & pitfalls
Cephalosporin thế hệ 2 đường tĩnh mạch, điểm nhấn và các sai lầm cần tránh.....784
Parenteral third-generation cephalosporins, pearls & pitfalls
Cephalosporin thế hệ 3 đường tĩnh mạch, điểm nhấn và các sai lầm cần tránh.....784
Parenteral fourth-generation cephalosporins, pearls & pitfalls
Cephalosporin thế hệ 4 đường tĩnh mạch, điểm nhấn và các sai lầm cần tránh.....786
Parotid enlargement, head abnormalities (DDx)
Phì đại tuyến nước bọt mang tai, các bất thường ở đầu (Chẩn đoán phân biệt) .....713 b
Parotitis, suppurative
Viêm tuyến mang tai mưng mủ 72
Parvo B19, meningitis
Parvo B19, viêm màng não 39
Pasteurella multocida .....372 b
Animal bite wounds
Vết thương do động vật cắn 254
Septic arthritis
viêm khớp nhiễm khuẩn.....217
PCP

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Pneumocystis (carinii) jiroveci
HIV, prophylaxis
HIV/AIDS, dự phòng .....516 b
Prophylaxis in opportunistic infections
dự phòng nhiễm trùng cơ hội.....515 b
peak serum levels, explanation
Nồng độ đỉnh huyết thanh, giải thích.....805
Pediatric infectious diseases
Các bệnh nhiễm trùng ở trẻ em 615
Bone and joint
Xương và khớp 661
CNS
Thần kinh trung ương 628
dosing
chế độ liều.....674
gastrointestinal
Dạ dày ruột.....656
HEENT
Tai – Mũi – Họng 635
Lower resiratory
đường hô hấp dưới.....644
skin and soft tissue
da và mô mềm 668
vascular
mạch máu 653
pediculas humanus var. capitis, head lice
Pediculus humanus var. capitis, chấy rận (đầu).... 265
Pediculus humanus var. corporis, body lice
Pediculus humanus var. corporis,
rận trên cơ thể 265
Pegasys 1008
Plus ribavirin
Phối hợp ribavirin 1008
Peg-Intron 1010
Plus ribavirin
Phối hợp ribavirin 1010
Pegylated interferon
Pegylated interferon
alfa-2a 1008
alfa-2b 1010
peliosis hepatitis
Viêm gan có ban xuất huyết.....479
Pelvic inflammatory disease (PID)
Bệnh viêm xương chậu (PID) 202
Pelvic (OB/GYN) surgery, surgical prophylaxis
Phẫu thuật xương chậu (sản/phụ khoa),
dự phòng trong phẫu thuật .....580 b
Pelvic peritonitis/abscess
Viêm phúc mạc/ápxe do khung chậu.....180
Penicillin G 1011
pediatric dose
liều dùng cho trẻ em 682
Penicillins
Penicillins
Pearls & pitfalls
Điểm nhấn và các sai lầm cần tránh.....791
susceptibility profiles
Thông tin về độ nhạy cảm của vi sinh vật
với thuốc.....324 b
Penicillin V 1013
pediatric dose
liều dùng cho trẻ em 682
Penicillium, cutaneous
Penicillium ngoài da.....482
Penicillium marneffei 394b
Cutaneous penicillium
penicillium ngoài da 482
Pentam 300 1014
Pentamidine
Pentamidin.....1014
Peptic ulcer disease
Bệnh lý loét dạ dày.....153
Peptococcus .....382 b
Peptostreptococcus .....382 b
Peramivir 1016
Perianal warts
Mụn cóc quanh hậu môn 212
Pericardial effusion, heart abnormalities (DDx)
Tràn dịch màng ngoài tim, các bất thường ở tim
(Chẩn đoán phân biệt).....755 b
Pericarditis

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm màng ngoài tim 142
Periorbital cellulitis
viêm mô tế bào quanh hốc mắt 55
pediatric
trẻ em 635
periorbital edema, unilateral/bilateral, eye abnormalities (DDx)
Phù quanh hố mắt, một bên/hai bên, các bất thường ở mắt (Chẩn đoán phân biệt) ..... 746 b
Peripheral vascular disease (PVD), non-diabetics with, osteomyelitis
Bệnh mạch ngoại biên (PVD) không đo đái tháo đường, viêm tủy xương 232
Perirectal abscess
Ápxe quanh trực tràng 267
Perirectal fistula, genitourinary abnormalities (DDx)
Rò trực tràng, các bất thường về tiết niệu sinh dục (Chẩn đoán phân biệt) ..... 761 b
Perirectal ulcer, genitourinary abnormalities (DDx)
Loét quanh trực tràng, các bất thường về tiết niệu sinh dục (Chẩn đoán phân biệt) ..... 761 b
peritonitis
Viêm phúc mạc
CAPD-associated
Liên quan với lọc màng bụng ngoại trú liên tục 181, 182
Chronic tuberculosis
Lao mạn tính 182
Spontaneous bacterial
Nhiễm trùng tiên phát 181,182
Periumbilical nodule, lymph node abnormalities (DDx)
Các u nhỏ quanh rốn, các bất thường hạch bạch huyết (Chẩn đoán phân biệt) ..... 760 b
Periumbilical purpura (thumbprint sign), abdominal abnormalities (DDx)
Từ ban quanh rốn (dấu ngón tay cái), các bất thường trong ổ bụng (Chẩn đoán phân biệt) ..... 757 b
Persistent fevers, antibiotics for
Kháng sinh trong sốt kéo dài 25
pertussis
Ho gà 99
Adult immunization
tiêm chủng người lớn ..... 617 b
community-acquired pneumonia
viêm phổi mắc phải từ cộng đồng 89
pediatric
trẻ em 649
post-exposure prophylaxis
Dự phòng sau phơi nhiễm ..... 609 b
Travel prophylaxis
dự phòng khi đi du lịch ..... 586 b
pH
pleural fluid [Index PDF]
pH less than 7.2, pleural fluid abnormalities (DDx). [Index chú ĐA]
pH < 7.2, các bất thường dịch màng phổi (Chẩn đoán phân biệt) ..... 784 b
urinary
các bất thường về nước tiểu ..... 782 b
pharyngitis
Viêm họng 74
bacterial
Do vi khuẩn 74
membranous
Có giả mạc 74
other
khác 75
pediatric
trẻ em 641
viral
virus 72
Phegmons
Viêm tấy da và mô liên kết dưới da 262
Phialophora verrucosa, chromomycosis
Bệnh nấm sâu 493
Phthirus pubis, pubic lice
bệnh do Phthirus pubis, rận mu 265
Pilonidal cysts, infected
Nhiễm khuẩn nang lông 250
pinworms
Giun kim 460
piperacillin 1017
pediatric dose

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

liều dùng cho trẻ em 682
Piperacillin/tazobactam 1019
pediatric dose
liều dùng cho trẻ em 682
Pipracil 1017
Plague
Dịch hạch
pneumonic
thể phổi 307
bioterrorist
khủng bố sinh học 304
Plantar hyperkeratoses, extremity abnormalities (DDx)
Mất lớp sừng bàn chân, các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt) ..... 766 b
Plasma protein binding, explanation
Gắn protein huyết tương, giải thích 776
Plasmodium falciparum, malaria
Plasmodium falciparum, sốt rét 420
Plasmodium knowlesi, malaria
Plasmodium knowlesi, sốt rét 421
Plasmodium malariae, malaria
Plasmodium malariae, sốt rét 423
Plasmodium ovale, malaria
Plasmodium ovale, sốt rét 423
Plasmodium vivax, malaria
Plasmodium vivax, sốt rét 423
Platelet abnormalities (DDx)
Các bất thường về tiểu cầu (Chẩn đoán phân biệt)
pancytopenia
Giảm ba dòng ..... 775 b
thrombocytopenia
Giảm tiểu cầu ..... 775 b
thrombocytosis
Tăng tiểu cầu ..... 775 b
Plesiomonas, travel prophylaxis
Plesiomonas, dự phòng khi đi du lịch ..... 607 b
Plesiomonas shigelloides
Plesiomonas shigelloides ..... 372 b
Pleural effusion profiles in various diseases (DDx)
Đặc điểm dịch màng phổi trong các bệnh lý khác nhau (Chẩn đoán phân biệt)
eosinophils
Bạch cầu ái toan 785
glucose 785
RBCs (per mm³)
Hồng cầu (trong 1 mm³) 785
WBCs (per mm) (DDx)
Bạch cầu (trong 1 mm³) (Chẩn đoán phân biệt) 784
Pleural fluid abnormalities (DDx)
Các bất thường của dịch màng phổi (Chẩn đoán phân biệt)
Amylase, elevation
Tăng amylase ..... 785 b
bloody
Có máu ..... 784 b
brownish
Màu nâu ..... 784 b
extracellular debris
Các mảnh vỡ ngoại bào ..... 784 b
glucose, decreased
Giảm glucose ..... 784 b
lymphocytes
Bạch cầu lympho ..... 784 b
other
Khác ..... 786 b
pH less than 7.2
pH < 7.2 ..... 784 b
PMNs
Bạch cầu đa nhân trung tính ..... 785 b
Protein, elevation
Tăng protein ..... 784 b
Rheumatoid factor (RF)
Yếu tố dạng thấp (RF) ..... 780 b
Yellow-green
Vàng-xanh ..... 784 b
Yellow/whitish
vàng/hơi trắng ..... 784 b
PMNs, pleural fluid abnormalities (DDx)
Bạch cầu đa nhân trung tính, các bất thường của dịch màng phổi (Chẩn đoán phân biệt) ..... 785 b

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Pneumatoceles, cavitary infiltrates (thin-walled)
Pneumatoceles,
xâm nhiễm dạng hang (thành mỏng) 735
Pneumococcus, adult immunization
Phế cầu, tiêm chủng người lớn .....526 b
Pneumocystis (carinii) jiroveci pneumonia (PCP)
bilateral infiltrates without effusion
Pneumocystis (carinii) jiroveci,
viêm phổi (PCP) xâm nhiễm hai bên không có
tràn dịch màng phổi.....714
Community-acquired pneumonia
viêm phổi mắc phải ở cộng đồng 96
HIV/AIDS.....526
Pneumonia
Viêm phổi
alcoholics
người nghiện rượu 120
Aspergillus
do Aspergillus.....122
aspiration
do hít vào phổi.....118
Unilateral focal segmental/lobar
infiltrate without effusion
xâm nhiễm khu trú thùy phổi một bên
không có tràn dịch màng phổi.....689
Unilateral ill-defined infiltrate without
effusion
Xâm nhiễm mờ một bên không có
tràn dịch màng phổi.....700
atypical pathogens, non-zoonotic
tác nhân gây bệnh không điển hình,
không do lây từ động vật sang người 91
atypical pathogens, zoonotic
tác nhân gây bệnh không điển hình do lây
từ động vật sang người.....91
bacterial pathogens
căn nguyên gây bệnh là vi khuẩn 99
bronchiectasis
giãn phế quản 121
chronic steroid use
dùng steroid kéo dài 122
community-acquired
mắc phải ở cộng đồng 93
pediatric
trẻ em 644
cystic fibrosis
xơ hóa nang..... 121
HIV/AIDS
Aspergillus
Aspergillus 531
bacterial
Vi khuẩn 532
CAP
Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng
(CAP).....89
M. tuberculosis
M. tuberculosis 528
P. (carinii) jiroveci (PCP)
P. (carinii) jiroveci 534
Hospital-acquired
Mắc phải trong bệnh viện 125
influenza
Cúm 92
M. avium-intracellulare (MAI)
M. avium nội bào (MAI) 119
M. kansasii
M. kansasii 120
M. Pneumoniae
M. Pneumoniae 103
M. Tubeculosis (TB)
Trực khuẩn lao (M. Tubeculosis [TB]) 118
Non-zoonotic atypical, diagnostic features
Lây từ động vật sang người không điển
hình, đặc điểm chẩn đoán.....105
nosocomial
Nhiễm trùng bệnh viện.....125
Nursing home-acquired
Mắc phải ở các cơ sở dưỡng lão.....124
Organ transplants
ghép tạng.....122
SARS
Bệnh SARS 110
Swine influenza
Cúm lợn.....114

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

transplant infections
nhiễm trùng ở người được ghép tạng.....283
tuberculosis
Lao 118
Unknown pathogen
Không biết rõ tác nhân gây bệnh.....89
Ventilator-associated
Do thở máy.....125
Zoonotic atypical
Lây từ động vật sang người không điển hình 105
Pneumonic plague
Dịch hạch thể phổi.....307
Pneumothorax, spontaneous, chest abnormalities (DDx)
Tràn khí màng phổi tiên (tự) phát, các bất thường ở lồng ngực (Chẩn đoán phân biệt).....754 b
Polymox 835
Polymyxin B 1021
Polymyxin B/colistin, pearls & pitfalls
Polymyxin B/colistin, ưu điểm & các sai lầm cần tránh.....812
Pork tapeworm
Sán dây lợn 461
Posaconazole
Posaconazol 1022
Posterior cervical adenopathy, unilateral/bilateral, lymph node abnormalities (DDx)
Hạch cổ trước một bên/hai bên, các bất thường hạch bạch huyết (Chẩn đoán phân biệt) ....759 b
Post-exposure prophylaxis
Dự phòng sau phơi nhiễm.....585 b
Anthrax (inhalation/cutaneous)
Bệnh than (hít/ngoài da).....589 b
Avian influenza
cúm gia cầm .....585 b
chancroid
hạ cam. .....567 b
diphtheria
bạch hầu .....586 b
gonorrhea
lậu .....586 b
hepatitis A (HAV)
viêm gan A (HAV) .....568 b
hepatitis B (HBV)
viêm gan B (HBV.....568 b
hepatitis C (HCV)
viêm gan C (HCV) .....568 b
lyme disease
Bệnh Lyme .....579 b
meningitis
viêm màng não .....608 b
non-gonoccocal urethritis (NGU)
viêm niệu đạo không do lậu (NGU).....585 b
pertussis
Ho gà 585b
Pneumonic plague
Dịch hạch thể phổi 592b
rabies
Dại .....590 b
Rocky Mountain spotted fever
Sốt đốm Rocky Mountain.....589 b
smallpox
đậu mùa 592 b
swine influenza
cúm lợn.....585 b
syphilis
giang mai.....587 b
tuberculosis
Lao .....597 b
Tularemia pneumonia
viêm phổi do tularemia .....696 b
varicella (chickenpox)
varicella (thủy đậu).....618b
viral hemorrhagic fever
Sốt xuất huyết do virus.....592 b
Viral influenza (human seasonal)
Cúm mùa do virus.....585 b
Zoonotic diseases (plague, anthrax)
Các bệnh lây từ động vật sang người (dịch hạch, than).....590 b
Preauricular adenopathy, lymph node abnormalities (DDx)

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Hạch trước tai, các bất thường hạch bạch huyết (Chẩn đoán phân biệt).....759 b
pregnancy
Phụ nữ mang thai
Asymptomatic bacteriuria in
Có vi khuẩn niệu không triệu chứng....593 b
Safety in
An toàn đối với phụ nữ có thai.....819
Prevotella sp
Prevotella sp.....326 b
Prezista (darunavir).....915
Primaquine
Primaquin.....1025
Primary amebic meningoencephalitis (PAM)
Viêm não màng não tiên phát do amip (PAM)... .39
Primaxin
Primaxin.....957
Procalcitonin levels (PCT), elevated, serum test abnormalities (DDx)
Định lượng Procalcitonin (PCT), các bất thường xét nghiệm huyết thanh (Chẩn đoán phân biệt) ...778 b
Progressive multifocal encephalopathy (PML), HIV
Bệnh não đa ổ tiến triển (PML), HIV/AIDS.....352
Proloprim.....1071
Prophylaxis, antibiotic
Kháng sinh. dự phòng
Chronic medical
Bệnh mạn tính.....595 b
endocarditis
viêm nội tâm mạc.....602 b
HIV opportunistic infections
HIV Nhiễm trùng cơ hội.....527 b
Pre-exposure (PrEP).....596 b
Post-exposure
sau phơi nhiễm.....596 b
malaria
sốt rét.....610 b
post-exposure
sau phơi nhiễm.....596 b
surgical
ngoại khoa.....609 b
tetanus
uốn ván.....612 b
transplant (BMT/SOT)
ghép (BMT/SOT).....598
travel
du lịch.....605
Propionibacterium acnes
Propionibacterium acnes.....387 b
Prostaphlin.....1007
Prostate enlargement/tenderness, genitourinary abnormalities (DDx)
Phì đại tuyến tiền liệt/ấn đau, các bất thường về tiết niệu sinh dục (Chẩn đoán phân biệt).....752 b
Prostatic abscess
Ápxe tuyến tiền liệt.....196
Prostatitis
Viêm tuyến tiền liệt.....196
Prosthetic valve endocarditis (PVE)
viêm nội tâm mạc do van nhân tạo (PVE).....139
Protein, elevation, pleural fluid abnormalities (DDx)
Tăng Protein, các bất thường của dịch màng phổi (Chẩn đoán phân biệt).....784 b
Proteinuria, urinary abnormalities (DDx)
Protein niệu, các bất thường của nước tiểu (Chẩn đoán phân biệt).....782 b
Proteus mirabilis, vulgaris
Proteus mirabilis, thông thường.....373 b
Cellulitis
Viêm mô tế bào.....236
Decubitus ulcers
Loét do tì đè.....245
Diabetic foot ulcers
loét bàn chân do đái tháo đường.....246
osteomyelitis
viêm tủy xương.....231
skin abscess/infected cysts
ápxe da/Nhiễm trùng nang.....248
usual/unusual susceptibility patterns
các kiểu nhạy cảm thường/không thường gặp.....12
prototheca, cutaneous

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nhiễm vi tảo Prototheca ngoài da 478
Prototheca wikermanii, cutaneous protothecа
Nhiễm vi tảo prototheca ngoài da do Prototheca wikermanii 478
Protozoa, intestinal
Protozoa, đường tiêu hóa 453
Providencia sp
Providencia sp.....373 b
Usual/unusual susceptibility patterns
mô hình nhạy cảm thông thường/bất thường .12 b
Pseudallescheria boydii, pulmonary pseudallescheriasis
Pseudallescheria boydii, Pseudallescheria ở phổi 445
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa .....372 b
Acute bacterial meningitis
viêm màng não mủ cấp tính 32
bone marrow transplant infection
nhiễm khuẩn sau ghép tủy 283
brain abscess
ápxe não.....50
burn wounds
vết thương do bỏng 256
cavitary infiltrates (thick-walled)
xâm nhiễm dạng hang (thành dày).....726
community-acquired pneumonia
viêm phổi mắc phải ở cộng đồng.....96
endocarditis
viêm nội tâm mạc 136
epididymitis
viêm mào tinh hoàn 188
external otitis
viêm tai ngoài.....68
febrile neutropenia
sốt giảm bạch cầu.....280
HIV infection
Nhiễm HIV..... 562
Keratitis
viêm giác mạc 59
mastoiditis
viêm xương chũm 72
pneumonia, nosocomial
viêm phổi ở bệnh viện 125
sepsis
sepsis.....268
septic arthritis
viêm khớp nhiễm khuẩn 218
surgical prophylaxis
dự phòng trong phẫu thuật.....582 b
urosepsis
sepsis do nhiễm khuẩn tiết niệu.....199
usual/unusual susceptibility patterns
Mô hình nhạy cảm thông thường/bất thường .....12 b
Pseudomonas (Chryseomonas) luteola (CDC group Ve-1)
Pseudomonas (Chryseomonas) luteola (CDC group Ve-1).....374 b
Pseudomonas (Flavimonas) oryzihabitans (CDC group Ve-2)
Pseudomonas (Flavimonas) oryzihabitans (CDC group Ve-2).....375 b
Psittacosis bilateral infiltrates without effusion
Virus vẹt gây xâm nhiễm hai phổi không có tràn dịch màng phổi.....715
Unilateral focal segmental/lobar infiltrate without effusion
xâm nhiễm khu trú thùy phổi một bên không có tràn dịch màng phổi.....689
unilateral ill-defined infiltrates without effusion
xâm nhiễm mờ một bên không có tràn dịch màng phổi.....700
pubic lice
Rận mu 266
Pulmonary actinomycosis
Actinomyces ở phổi.....438
Pulmonary alveolar proteinosis (PAP) bilateral infiltrates without effusion
Bệnh tích tụ protein phế nang (PAP), xâm nhiễm hai phổi không có tràn dịch màng phổi.....720
Pulmonary amebiasis
Amíp phổi.....433
Pulmonary aspergillosis

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Aspergillus ở phổi 438
Pulmonary blastomycosis
Blastomyces ở phổi 445
Pulmonary coccidioidomycosis
Nấm Coccidioides ở phổi.....438
Pulmonary coin lesions
Tổn thương dạng đồng xu ở phổi 436
Pulmonary crytococcosis
Cryptococcus ở phổi 445
Pulmonary cystic lesions/masses
Tổn thương dạng nang/khối ở phổi 433
Pulmonary embolus/infarct
Tắc mạch phổi/nhồi máu phổi
Unilateral focal segmental/lobar infiltrate with effusion
xâm nhiễm khu trú thùy phổi một bên có tràn dịch màng phổi.. 698
Unilateral focal segmental/lobar infiltrate without effusion
Xâm nhiễm khu trú thùy phổi một bên không có tràn dịch màng phổi.....692
Unilateral ill-defined infiltrates with effusion
Xâm nhiễm mờ một bên có tràn dịch màng phổi 709
Pulmonary hemorrhage
Chảy máu phổi
Bilateral infiltrates without effusion
Xâm nhiễm hai phổi không có tràn dịch màng phổi 717
Unilateral ill-defined infiltrates without effusion
xâm nhiễm mờ một bên không có tràn dịch màng phổi 700
Pulmonary histoplasmosis
Bệnh do Histoplasma ở phổi. 445
Pulmonary infiltrates/mass lesions
Xâm nhiễm phổi/tổn thương dạng khối 437
Pulmonary nocardiosis
Bệnh do Nocardia ở phổi 414
Pulmonary paracoccidioidomycosis (South American blastomycosis)
Paracoccidioides ở phổi (blastomycosis Nam Mỹ) 438
Pulmonary pseudallescheriasis
Pseudallescheria ở phổi 445
Pulmonary sporotrichosis
Sporothix ở phổi 438
Pulmonary zygomycosis (mucor-mycosis)
Zygomyces ở phổi (mucor-mycosis) 445
Purple nose tip, nasal abnormalities (DDx)
Tím đầu mũi, các bất thường ở mũi (Chẩn đoán phân biệt).....750 b
Purulent CSF with negative Gram stain, CSF abnormalities (DDx)
Dịch não tủy có mủ với VK Gram (-), Các bất thường dịch não tủy (Chẩn đoán phân biệt). 786 b
Pyelonephritis
Viêm thận bể thận
acute
Cấp. 190
chronic
Mạn 192
Pyodermas abscesses, severe, pediatric
Viêm mủ da ápxe, nặng, trẻ em.....668
Pyogenic lung abscess, cavitary infiltrates (thick-walled)
Pyogenic ápxe phổi, xâm nhiễm tạo hang (thành dày) 726
Pyomyositis
Viêm mủ cơ. 242
Pyrazinamide
Pyrazinamid 1026
pediatric dose
liều dùng cho trẻ em 683
Pyrimethamine
Pyrimethamin 1027
Pyuria, urinary abnormalities (DDx)
Đái mủ, các bất thường của nước tiểu (Chẩn đoán phân biệt) .....782 b
PZA
Pyrazinamide 1026

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Q

Q-fever

Sốt Q

Bilateral infiltrates without effusion

Xâm nhiễm hai phổi không có tràn dịch....715

community-acquiredpneumonia

Viêm phổi mắc phải ở cộng đồng 89

endocarditis

viêm nội tâm mạc.....136

unilateral focal segmental/lobar infiltrate without effusion

xâm nhiễm khu trú thùy phổi một bên không có tràn dịch.....691

unilateral ill-defined infiltrates without effusion

xâm nhiễm mờ một bên không có tràn dịch màng phổi 702

zoonotic atypical pneumonia

viêm phổi không điển hình lây từ động vật sang người 105

Quinine sulfate

Quinin sulfat 1028

Quinolones, pearls & pitfalls

Quinolon, điểm nhấn và các sai lầm cần tránh 804

Quinupristin/dalfopristin..... 1029

Pearls & pitfalls

Điểm nhấn và các sai lầm cần tránh.....808

pediatric dose

liều dùng cho trẻ em.....683

R

R.rickettsia, post-exposure prophylaxis

R.rickettsia, Dự phòng sau phơi nhiễm.....589 b

Rabies

Bệnh dại

Travel prophylaxis

dự phòng khi đi du lịch .....590 b

Radiation pneumonitis, unilateral focal segmental/lobar infiltrate with effusion

Viêm phổi do tia xạ, xâm nhiễm khu trú thùy phổi một bên có tràn dịch 879

RAL (raltegravir) 1031

Rapid influenza diagnostic tests (RIDTs), negative, swine influenza pneumonia in hospitalized adults

Test nhanh chẩn đoán cúm (RIDTs), âm tính, viêm phổi bệnh viện do cúm lợn ở người lớn 115

Rash below waist, general appearance abnormalities (DDx)

Ban từ cổ tay cổ chân trở xuống, các bất thường khi thăm khám tổng quát (Chẩn đoán phân biệt).....744 b

Migratory, extremity abnormalities (DDx)

Ban di chuyển, các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt).....766b

Palms/soles, extremity abnormalites (DDx)

Ban lòng bàn tay/chân, các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt).....766 b

Rat bite fever (streptobacillus monilaformis, spirillum minus)

Sốt do chuột cắn.....418

RBC abnormalities (DDx)

Các bất thường của hồng cầu (Chẩn đoán phân biệt)

Anemia (acute)

thiếu máu (cấp).....774 b

hemophagocytosis (erythrophagocytosis)

thực bào hồng cầu .....774 b

Howell-Jolly bodies

Thể Howell-Jolly.....773 b

RBC inclusions

Thể vùi trong hồng cầu.....773 b

Schistocytes (microangiopathic hemolytic anemia)

Mảnh vỡ hồng cầu (thiếu máu do tan máu vi mạch) .....773 b

spherocytes

hồng cầu hình cầu .....773 b

target cells

hồng cầu hình bia .....773 b

RBC inclusions, RBC abnormalities (DDx)

Thể vùi hồng cầu, Các bất thường của hồng cầu (Chẩn đoán phân biệt)..... 773 b

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

RBCs in CSF, CSF abnormalities (DDx)
Hồng cầu trong dịch não tủy, Các bất thường dịch não tủy (Chẩn đoán phân biệt) .....786 b
RBCs (per mm³), pleural effusion profiles in various diseases (DDx)
Số lượng hồng cầu (trong 1 mm³), trong dịch màng phổi ở các bệnh lý khác nhau (Chẩn đoán phân biệt) .....784 b
Rebetol 1033
Relapsing fever (B, recurrentis), louse-borne and tick-borne
Sốt hồi quy, do chấy rận và do ve 417
Relative bradycardia
Nhịp tim chậm tương đối
Defined
Định nghĩa 23
Fever curves (DDx)
Biểu đồ nhiệt độ (Chẩn đoán phân biệt) ..741 b
Temperature-pulse relationships
Mối quan hệ mạch – nhiệt độ .....23 b
Relative lymphocytosis, WBC abnormalities (DDx)
Giảm bạch cầu lympho tương đối, Các bất thường của bạch cầu (Chẩn đoán phân biệt) .....770 b
Relative tachycardia, fever curves (DDx)
Nhịp tim nhanh tương đối, biểu đồ nhiệt độ (Chẩn đoán phân biệt) 741b
Renal abscess
Ápxe thận. 194
Intrarenal/perinephric
Trong thận/quanh thận 194
Renal failure, chronic
Suy thận mạn
Bilateral infiltrates with effusion
Xâm nhiễm hai phổi có tràn dịch màng phổi 723
Bilateral infiltrates without effusion
xâm nhiễm hai phổi không có tràn dịch màng phổi 712
Renal insufficiency, dosing strategies in
Chiến lược điều chỉnh liều ở bệnh nhân suy giảm chức năng thận 7
Renal route of elimination
Con đường thải trừ qua thận 9
Renal TB
Lao thận 192
Rescriptor (delavirdine) 917
Resistance, antibiotic
Đề kháng kháng sinh 4
Respiratory tract infections, lower, empiric therapy
Viêm đường hô hấp dưới, Điều trị theo kinh nghiệm 87
Respiratory viruses
Virus đường hô hấp
epiglottitis
viêm nắp thanh quản 86
pharyngitis
viêm họng 74
Retinitis. See Chorioretinitis
Viêm võng mạc. xem Viêm màng mạch võng mạc
Retrovir (zidovudine) 1085
Reyataz (atazanavir) 852
Rheumatic test abnormalities (DDx) Các xét nghiệm chẩn đoán thấp (Chẩn đoán phân biệt)
angiotensin-converting enzyme levels (ACE), elevated
Tăng nồng độ men chuyển angiotensin (ACE) .....781 b
Anti-nuclear antibody titers (ANA), elevated
Tăng hiệu giá kháng thể kháng nhân (ANA) .....782 b
Anti-smooth muscle antibodies (ASM), elevated
Tăng kháng thể kháng cơ trơn (ASM) .....781 b
c-ANCA, elevated
tăng nồng độ c-ANCA .....781 b
double stranded DNA (DS-DNA), elevated
Tăng kháng thể kháng chuỗi kép AND (DS-DNA) .....781 b
Rheumatoid factors (RF), elevated
Tăng yếu tố dạng thấp (RF) .....780 b
Rheumatoid factor (RF) elevation, rheumatic test abnormalities (DDx)
Tăng yếu tố dạng thấp (RF), các bất thường trong xét nghiệm thấp (Chẩn đoán phân biệt) 780
Pleural fluid abnormalities (DDx)

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Các bất thường của dịch màng phổi (Chẩn đoán phân biệt) ..... 785 b
Rheumatoid nodules, cavitary infiltrates (thick-walled)
Các nốt thấp, xâm nhiễm tạo hang (thành dày) 733
Rhizopus
Cutaneous zygomycosis
Nhiễm nấm Zygomyces trên da 483
Pulmonary zygomycosis
NhiễmZygomyces ở phổi 445
Rhodococcus equi
Rhodococcus equi 367
unilateral focal segmental/lobar infiltrate with effusion
xâm nhiễm khu trú thùy phổi một bên có tràn dịch 694
Ribavirin 1033
Plus Pegasys
Phối hợp Pegasys 1008
Plus Peg-Intron
Phối hợp Peg-Intron 1010
Rickettsia africae
Rickettsia africae 486
Rickettsia akari
Rickettsia akari 486
Rickettsia conorii
Rickettsia conorii 486
Rickettsialpox
Rickettsialpox 486
Rickettsia parkeri
Rickettsia parkeri 486
Rickettsia prowazekii
Rickettsia prowazekii 486
Rickettsia ricketsii (tick borne), Rocky Mountain spotted fever (RMSF)
Rickettsia ricketsii (bệnh do ve), Sốt đốm Rocky Mountain (RMSF) 486
Rickettsia tsutsugamushi
Rickettsia tsutsugamushi 486
Rickettsia typhi
Rickettsia typhi. 486
Rifabutin 1034
Rifadin 1036
Rifampin 1036
pediatric dose
liều dùng cho trẻ em 683
Right lower quadrant tenderness, abdominal abnormalities (DDx)
Ấn đau hố chậu phải, các bất thường trong ổ bụng (Chẩn đoán phân biệt) ..... 757 b
Right upper quadrant mass, abdominal abnormalities (DDx)
Khối hạ sườn phải, các bất thường trong ổ bụng (Chẩn đoán phân biệt) ..... 757 b
Right upper quadrant tenderness, abdominal abnormalities (DDx)
Ấn đau hạ sườn phải, các bất thường trong ổ bụng (Chẩn đoán phân biệt) ..... 757 b
Right upper quadrant tympany, abdominal abnormalities (DDx)
Bụng chướng khu trú hạ sườn phải, các bất thường trong ổ bụng (Chẩn đoán phân biệt) ..... 756 b
Rilpivirine (RPV) 1038
Rimactane
Rimactan 1036
Rimantadine
Rimantadin 1039
Ringworm
Bệnh nấm da
body
Thân mình 262
scalp
Da đầu 263
Ritonavir (RTV) 1040
Rocephin 890
Rocky Mountain spotted fever (RMSF)
Sốt phát ban Rocky Mountain (RMSF) 487
Rose spots, abdominal abnormalities (DDx)
Các nốt màu hoa hồng, các bất thường trong ổ bụng (Chẩn đoán phân biệt) ..... 755 b
Rotavirus, travel prophylaxis
Rotavirus, dự phòng khi đi du lịch 607b
Roundworms, intestinal
Giun đũa, đường tiêu hóa 459

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

RPV (rilpivirine) 933
RSV (respiratory syncytial virus)
Virus hợp bào hô hấp hay RSV
Bilateral infiltrates without effusion
xâm nhiễm hai phổi không có tràn dịch màng phổi 713
transplant infections
nhiễm trùng ở người được ghép tạng..... 283 b
RTV (ritonavir) 1040
Rubella, adult immunization
Rubella, tiêm chủng người lớn .....618 b

S

S.agalactiae, bacterial cystitis
S.agalactiae, viêm bàng quang do vi khuẩn..... 185
Safety in pregnancy, explanation
An toàn đối với phụ nữ có thai, giải thích 819
Safety profile, antibiotics
Thông tin về tính an toàn của kháng sinh.....5
Salmonella sp .....375 b
Septic arthritis
viêm khớp nhiễm khuẩn.....217
travel prophylaxis
dự phòng khi đi du lịch.....605 b
typhi, non-typhi .....375 b
HIV/AIDS 337
Typhi, travel prophylaxis
typhi, dự phòng khi đi du lịch.....608 b
typhi/paratyphi, typhoid (enteric) fever
typhi/paratyphi, sốt thương hàn 157
vibrio sp. Infectious diarrhea
Vibrio sp. la chảy nhiễm khuẩn 154
Salpingitis
Viêm vòi tử cung.....202
Salwater wounds
Vết thương do nước mặn 256
Saquinavir (SQV) 1042
Sarcoidosis
Bệnh Sarcoidosis
Bilateral infiltrates with effusion
Xâm nhiễm hai phổi có tràn dịch màng phổi 724
Bilateral infiltrates without effusion
xâm nhiễm hai phổi không có tràn dịch màng phổi 718
sarcoptes scabiei, scabies
Sarcoptes scabiei, ghẻ.....265
SARS
Bệnh SARS.....110
Bilateral infiltrates without effusion
xâm nhiễm hai phổi không có tràn dịch màng phổi 713
scarbies
Bệnh ghẻ 265
Scalp nodules, head abnormalities (DDx)
Các bướu nhỏ ở da đầu, các bất thường ở đầu (Chẩn đoán phân biệt) 745b
Scedosporium apiospermum, pulmonary Pseudallescheriasis
Scedosporium apiospermum, bệnh do Bpseudallescheria.....445
Schistocytes (microangiopathic hemolytic anemia), RBC abnormalities (DDx)
Schistocytes (thiếu máu do tan máu vi mạch), Các bất thường của hồng cầu (Chẩn đoán phân biệt) .....773 b
Schistosoma mansoni, japonicum
Schistosoma mansoni, japonicum 452
Schistosomiasis
Bệnh do sán máng Schistosoma.....452
Scleral nodules, eye abnormalities (DDx)
Khối u củng mạc, các bất thường ở mắt (Chẩn đoán phân biệt) .....748 b
Scleroderma (wood hard skin lesions), extremity abnormalities (DDx)
Xơ cứng bì (bệnh da gỗ), các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt).....765
Scrofula
Bệnh tràng nhạc.....471
Scrotal enlargement, genitourinary abnormalities (DDx)

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

ký sinh trùng, nấm, căn nguyên bất thường....465
pustules
mụn mủ....248
Rickettsia....486
subcutaneous lesions
Tổn thương dưới da....465
Subcutaneous serpiginous lesions
Tổn thương vằn vèo dưới da....475
ulcers
Loét....243
Decubitus ulcers
loét do tì đè....243
diabetic foot ulcers
loét bàn chân đo đái tháo đường....246
ischemic foot ulcers
loét bàn chân do thiếu máu cục bộ....247
ulcers/skin tracts/abscesses
Loét/lỗ rò trên da/ápxe....468
vesicles/bullae
Phỏng nước/ bọng nước....252
Sleeping sickness
Rối loạn giấc ngủ....412
smallpox
Đậu mùa....308
bioterrorist
Khủng bố sinh học....304
sofosbuvir....174
soft tissue crepitance, general appearance abnormalities (DDx)
Lép bép trong mô mềm, các bất thường khi thăm khám toàn thân (Chẩn đoán phân biệt)....742 b
Soft tissue infections, empiric therapy
Nhiễm khuẩn mô mềm, Điều trị theo kinh nghiệm....240
Sole rashes, extremity abnormalities (DDx)
Ban lòng bàn chân, các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt)....766 b
Solid organ transplant (SOT), transplant infections
Ghép tạng đặc (SOT), nhiễm trùng ở người được ghép tạng....284
Specific gravity, decreased, urinary abnormalities (DDx)
Giảm tỉ trọng, các bất thường của nước tiểu (Chẩn đoán phân biệt)....783 b
Spectam....1045
Spectinomycin....1045
Spectracef....874
SPEP (polyclonal gammopathy), serum test abnormalities (DDx)
SPEP (bệnh tăng gamma đa dòng), các bất thường xét nghiệm huyết thanh (Chẩn đoán phân biệt)....776 b
Sphenoid sinus, acute bacterial sinusitis
Viêm xoang bướm do nhiễm trùng....57
Spherocytes, RBC abnormalities (DDx)
Hồng cầu hình cầu, Các bất thường của hồng cầu (Chẩn đoán phân biệt)....773 b
Spinal tenderness, back abnormalities (DDx)
Đau cột sống, các bất thường ở lưng (Chẩn đoán phân biệt)....755 b
Spirillum minus (rat bite fever)
Spirillum minus....379 b
Spirochetes
Spirochetes
aerobic
Ái khí....379 b
blood
Trong máu....419
Splenomegaly, abdominal abnormalities (DDx)
Lách to, các bất thường trong ổ bụng (Chẩn đoán phân biệt)....758 b
Spontaneous bacterial peritonitis (SBP)
Viêm phúc mạc nhiễm trùng tiên phát (SBP)....180
Sporanox....963
Sporothrix schenckii
Sporothrix schenckii
Chronic septic arthritis
viêm khớp nhiễm khuẩn mạn tính....224
cutaneous sporotrichosis
bệnh do sporothrix trên da....485
fungal arthritis
viêm khớp do nấm....220
pulmonary sporotrichosis

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Serum half-life (normal/ESRD), explanation
thời gian bán thải trong huyết thanh (bình thường /ESRD), giải thích.....816
Serum test abnormalities (DDx)
Các bất thường xét nghiệm huyết thanh (Chẩn đoán phân biệt)
Elevated cold agglutinins
Tăng agglutinin lạnh.....777 b
Elevated ferritin levels, acute/chronic, monoclonal gammopathy
Tăng ferritin, tăng gamma đơn dòng/đa dòng cấp/mạn tính.....777 b
Erythrocyte sedimentation rate (ESR)
Tốc độ lắng hồng cầu (ESR).....776b
Lactate dehydrogenase (LDH), elevated
Tăng Lactate dehydrogenase (LDH) ....777 b
Monoclonal gammopathy
Bệnh Gamma đơn dòng.....776 b
Monospot (false +)
Monospot (dương tính giả) .....777 b
Procalcitonin levels (PCT), elevated
Tăng procalcitonin levels (PCT).....778
SPEP (polyclonal gammopathy)
SPEP (tăng gamma đa dòng).....776b
Serum transaminases (SGOT/SGPT), elevations, liver test abnormalities (DDx)
Tăng transaminases (SGOT/SGPT), Các bất thường về xét nghiệm gan (Chẩn đoán phân biệt) ....779 b
Severe acute respiratory syndrome (SARS)
Hội chứng suy hô hấp cấp nặng (SARS).....110
Sexually transmitted diseases, empiric therapy
Bệnh lây lan qua đường tình dục, Điều trị theo kinh nghiệm.....204
Shigella sp. ..... 376 b
Dysentery
lỵ 163
HIV/AIDS.....555
Travel prophylaxis
dự phòng khi đi du lịch.....605 b
Shingles
Bệnh zona 253
Shin hyperpigmentation, extremity abnormalities (DDx)
Tăng sắc tố da, các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt).....765 b
Shock, general appearance abnormalities (DDx)
Sốc, các bất thường khi thăm khám toàn thân (Chẩn đoán phân biệt).....742 b
Shoulder tenderness, chest abnormalities (DDx)
Căng đau vùng vai, các bất thường ở lồng ngực (Chẩn đoán phân biệt).....753 b
Shunt infections, CNS, acute bacterial meningitis
Nhiễm khuẩn qua shunt, thần kinh trung ương, CNS, viêm màng não mủ cấp tính
Single fever spikes, fever curves (DDx)
Sốt cao 1 đỉnh, đường cong sốt (Chẩn đoán phân biệt).....720 b
Sinusitis
Viêm xoang
Acute bacterial
Nhiễm trùng cấp 57
Chronic bacterial
Nhiễm trùng mạn 58
pediatric
trẻ em 636
Sirturo (Bedaquilin)
Sirturo (thuốc chống lao mới cho lao đa kháng).....94
skin
Da
boils
Nhọt 248
Fungal infections
Nấm 260
Infections, empiric therapy
Điều trị nhiễm khuẩn theo kinh nghiệm 238
Infestations (body lice, head lice, pubic lice, scabies)
Ký sinh (rận cơ thể, chấy đầu rận mu, ghẻ) 265
Other lesions
Các tổn thương khác.....491
Papules/nodules/abscesses
Nốt sần/cục/ápxe.....477
Parasites, fungi, unusual organisms

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Sưng bìu, các bất thường về tiết niệu sinh dục (Chẩn đoán phân biệt) .....761 b
Scrub (chigger/mite-borne) typhus
Sốt ban do Rickettsia (lây truyền qua bọ chét/ve).....486
Seborrheic dermatitis, severe, head abnormalities (DDx)
Viêm da tiết bã nhờn nặng, các bất thường ở đầu (Chẩn đoán phân biệt) .....754 b
Selzentry (maraviroc) 981
Sepsis
sepsis 270
Asplenia/hyposplenia
Không có lách/ thiểu năng lách.....274
candidemia
Nấm Candida máu 268
Intraabdominal/pelvic source
Nguồn gốc từ ổ bụng/ tiểu khung 277
IV line
Đường truyền tĩnh mạch 276
Lung source
Nguồn gốc phổi 275
Miliary BCG
BCG dạng kê 274
Miliary TB
Lao kê.....274
Overwhelming, with purpura
Tình trạng bệnh bùng phát toàn thân, với ban xuất huyết.....274
Steroids, chronic
Steroid, ở người dùng kéo dài.....74
unknown source
Không rõ nguồn gốc.....274
urosepsis
sepsis do nhiễm khuẩn tiết niệu.....277
sepsis abortion
Sảy thai do nhiễm trùng 202
Septic arthritis
Viêm khớp nhiễm khuẩn 217
acute
cấp 217
animal bite
động vật cắn.....219
fungal
nấm 220
pediatric
trẻ em 661
TB
Lao 220
Septic pelvic thrombophlebitis (SPT)
Viêm tắc tĩnh mạch vùng khung chậu nhiễm khuẩn huyết (SPT).....181
Septic pulmonary emboli, cavitary infiltrates (thick-walled)
Tắc động mạch phổi nhiễm trùng, xâm nhiễm dạng hang (thành dày).....728
Septic shock
Sốc nhiễm khuẩn.....268
Septic thrombophlebitis
Viêm tĩnh mạch huyết khối nhiễm khuẩn.....148
Septra 1071
Sequestered lung, cavitary infiltrates (thin-walled)
Bệnh phổi cô lập, xâm nhiễm dạng hang (thành mỏng) 747
Seromycin 909
Serpiginous lesions, subcutaneous
Tổn thương vằn vèo dưới da (ecpet) 475
Serratia marcescens
Serratia marcescens..... 375 b
Acute bacterial meningitis
viêm màng não mủ cấp tính.....35
endocarditis
viêm nội tâm mạc 136
pneumonia
viêm phổi 125
sepsis
sepsis 268
urosepsis
sepsis do nhiễm khuẩn tiết niệu.....199
usual/unusual susceptibility patterns
mô hình nhạy cảm thông thường/bất thường ..... 12 b

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

bệnh do sporothix ở phổi.....438
Sporotrichosis
Bệnh do Sporothrix
Cavitary infiltrates (thick-walled)
xâm nhiễm dạng hang (thành dày).....736
Cavitary infiltrates (thin-walled)
xâm nhiễm dạng hang (thành mỏng).....735
cutaneous
trên da.....438
sputum Gram stain, clinical use
Nhuộm Gram đờm, ứng dụng lâm sang.....399 b
Squamous cell carcinoma, cavitary infiltrates (thick-walled)
Ung thư biểu mô tế bào vảy, xâm nhiễm dạng hang (thành dày).....732
SQV (saquinavir).....1043
St. Louis encephalitis (St.LE)
Viêm não St. Louis (St LE).....47
Staphylococci, usual/unusual susceptibility patterns
Tụ cầu, mô hình nhạy cảm thông thường/bất thường.....12 b
Staphylococcus aureus
Tụ cầu vàng.....342
Acute bacterial meningitis
viêm màng não mủ cấp tính.....34
animal bite wounds
Động vật cắn.....668
Bone marrow transplant infections
nhiễm khuẩn trong ghép tủy.....283
brain abscess
ápxe não.....48
burn wounds
vết thương do bỏng.....256
CAPD-associated peritonitis
Viêm phúc mạc do lọc màng bụng CAPD.....180
Cavitary infiltrates (thick-walled)
xâm nhiễm dạng hang (thành dày).....716
complicated skin/skin structure tissue infections
nhiễm khuẩn da/cấu trúc da phức tạp.....236
decubitis ulcers
loét do tì đè.....243
diabetic foot ulcers
loét bàn chân đo đái tháo đường.....244
endocarditis
viêm nội tâm mạc.....138
acute bacterial (ABE)
Nhiễm trùng cấp (ABE).....138
Prosthetic valve (PVE)
Sau thay van (PVE).....139
endophthalmitis
viêm nội nhãn cầu.....65
infected joint prosthesis
Nhiễm trùng khớp giả.....229
Ischemic foot ulcers
loét bàn chân thiếu máu cục bộ.....247
IV line (CVC) infections
Nhiễm trùng đường truyền tĩnh mạch.....147
Keratitis
viêm giác mạc.....59
lung abscess/empyema
ápxe phổi/mủ màng phổi.....173
mastoiditis
viêm xương chũm.....72
osteomyelitis
viêm tủy xương.....231
pacemaker infections
Nhiễm trùng sau đặt máy tạo nhịp tim.....144
Pericarditis
Viêm màng ngoài tim.....142
Renal abscess
Ápxe thận.....194
sepsis
sepsis.....268
septic arthritis
viêm khớp nhiễm trùng.....217
skin abscesses/infected cysts
ápxe da/nhiễm khuẩn nang da.....248
solid organ transplant
ghép tạng đặc.....284

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

suppurative parotitis
viêm tuyến mang tai mưng mủ 72
surgical prophylaxis
dự phòng trong phẫu thuật ....579 b
toxic sock syndrome
hội chứng sốc nhiễm độc....299
transplant infections
nhiễm trùng ở người được ghép tạng 283
vascular graft infections
nhiễm trùng cầu nối mạch máu 149
Staphylococcus epidermidis (CoNS)
Staphylococcus epidermidis (CoNS)....342
Brain abscess
viêm màng não mủ cấp tính.... 32
CAPD-associated peritonitis
ápxe não 51
CNS shunt infection
Viêm phúc mạc do lọc màng bụng....180
endocarditis
viêm nội tâm mạc 138
infected joint prosthesis
Nhiễm trùng nhân tạo....299
Pacemaker infection
nhiễm trùng liên quan đặt máy tạo nhịp.... 144
sepsis
sepsis 268
surgical prophylaxis
dự phòng trong phẫu thuật ....579 b
Staphylococcus lugdunensis
Staphylococcus lugdunensis....344
Staphylococcus saprophyticus
Staphylococcus saprophyticus....345
cystitis
Viêm bàng quang 184
Dysuria-pyuria syndrome
Hội chứng đái khó-đái mủ 183
Stavudine (d4T)....1045
Stenotrophomonas maltophilia
Stenotrophomonas maltophilia....376 b
Community-acquired pneumonia
viêm phổi mắc phải ở cộng đồng....120
usual/unusual susceptibility patterns
mô hình nhạy cảm thông thường/bất thường .... 12 b
Sternal tenderness, chest abnormalities (DDx)
Đau xương ức, các bất thường ở lồng ngực (Chẩn đoán phân biệt)....753 b
Steroid therapy, chronic, pneumonia
Điều trị steroid dài ngày, viêm phổi 122
Stomach, upper small bowel surgery, surgical prophylaxis
Phẫu thuật dạ dày, đoạn trên ruột non, dự phòng trong phẫu thuật....560 b
Stomatitis
Viêm miệng 81
Stool, parasites, fungi, unusual organisms in
Phân, kí sinh trùng, nấm, căn nguyên bất thường trong 453
Streptobacillus moniliformis
Streptobacillus moniliformis....376 b
Septic arthritis
viêm khớp nhiễm khuẩn....219
Streptococcus anginosus (S.milleri) group (S.intermedius, S.anginosus, S.constellatus)...325
Streptococcus (bovis)
Streptococcus (bovis)
galloyticus
galloyticus 325
endocarditis
viêm nội tâm mạc....135
Streptococci. See Group A streptococci; Group B streptococci, Groups C, F, G streptococci; Nutritionally-variant streptococci (NVS)
Streptococci. Xem Liên cầu nhóm A , B , C, F, G, liên cầu phụ thuộc vào chất dinh dưỡng để phát triển (NVS)
deep neck infections
Nhiễm trùng vùng sâu của cổ 83
dental infections
nhiễm trùng răng 84
endophthalmitis
viêm nội nhãn cầu 65
Streptococcus pneumoniae

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Phế cầu 352
acute bacterial exacerbation of chronic bronchitis
Đợt cấp viêm phế quản mạn 87
acute bacterial meningitis
viêm màng não cấp tính 32
acute otitis media
viêm tai giữa cấp 69
adult immunization
tiêm chủng người lớn ..... 614 b
brain abscess
ápxe não 51
chronic medical prophylaxis
dự phòng nội khoa mạn tính ..... 595 b
CLSI susceptibility breakpoints
điểm breakpoint theo CLSI ..... 14 b
community-acquired pneumonia
viêm phổi mắc phải ở cộng đồng 89
conjunctivitis
viêm kết mạc 61
epiglottitis
viêm nắp thanh quản 86
HIV infection
Nhiễm HIV 500
prophylaxis
dự phòng 527
intraabdominal or pelvic peritonitis/abscess
Nhiễm trùng trong ổ bụng/ápxe. 181
keratitis
viêm giác mạc 59
lung abscess/empyema
ápxe phổi/mủ màng phổi 123
mastoiditis
viêm xương chũm 72
pericarditis
Viêm màng ngoài tim 142
prophylaxis of opportunistic infections
dự phòng nhiễm trùng cơ hội ..... 597 b
sepsis
sepsis 268
susceptibility breakpoints
điểm đánh giá độ nhạy 14
unilateral focal segmental/lobar infiltrate without effusion
xâm nhiễm khu trú thùy phổi một bên không có tràn dịch 689
usual/unusual susceptibility patterns
mô hình nhạy cảm thông thường/bất thường ..... 12 b
Streptomycin 1047
Stribild [elvitegravir (EVG) + combicistat (COBI) + emtricitabine (FTC) + tenofovir (TDF)] 827
Strongyloides, bilateral infiltrates wittth effusion
Nhiễm giun lươn, xâm nhiễm hai phổi có tràn dịch 722
Strongyloides stercoralis
Strongyloides stercoralis 459
Transplant infections
nhiễm trùng ở người được ghép tạng 283
Strongyloidiasis
Bệnh giun lươn 459
Subacute bacterial endocarditis (SBE)
Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng bán cấp (SBE) 129
Subconjunctival hemorrhage, eye abnormalities (DDx)
Viêm kết mạc xuất huyết (Chẩn đoán phân biệt) ..... 746 b
Subcutaneous serpiginous lesions
Tổn thương vằn vèo dưới da 475
Subdural empyema
Ổ mủ dưới màng cứng 51
Superior vena cava syndrome, neck abnormalities (DDx)
Hội chứng tĩnh mạch chủ trên, các bất thường ở cổ (Chẩn đoán phân biệt) ..... 753 b
Suppurating inguinal adenopathy
Hạch bẹn mưng mủ 210
Suppurative parotitis
Viêm tuyến mang tai mưng mủ 72
Supurative pericarditis
Viêm màng ngoài tim 142
Supraclavicular adenopathy, lymph node abnormalities (DDx)
Hạch thượng đòn, các bất thường

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

hạch bạch huyết (Chẩn đoán phân biệt) 759b
Suprax 697
Surgical prophylaxis
Dự phòng trong phẫu thuật
arthroscopy
nội soi khớp .....582 b
biliary tract surgery
Phẫu thuật đường mật .....580 b
Cardiac valve replacement surgery
Phẫu thuật thay van tim .....579 b
CNS shunt (VP/VA) placement, craniotomy, open CNS trauma
Đặt dẫn lưu vào TKTW (VP/VA), mở sọ trong chấn thương sọ hở .....579 b
Coronary artery bypass graft (CABG) surgery
Phẫu thuật cầu nối động mạch vành (CABG) .....580 b
Distal small bowel, colon surgery
Phẫu thuật ruột non đoạn xa, đại tràng ...580 b
Factors affecting efficacy of
Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả ....577 b
Hepatic surgery
Phẫu thuật gan .....580 b
Orthopedic prosthetic implant surgery (total hip/knee replacement)
Phẫu thuật ghép bộ phận giả trong chấn thương chỉnh hình (thay toàn bộ gối/háng) .....582 b
Orthopedic surgery (open fracture)
Phẫu thuật chỉnh hình (Gãy xương hở) ....582 b
Pelvic (OB/GYN) surgery
Phẫu thuật khung chậu (sản/phụ khoa)..571 b
Stomach, upper small bowel surgery
Phẫu thuật dạ dày, hỗng tràng .....580 b
Thoracic (non-cardiac) surgery
Phẫu thuật ngực (không tính tim).....579 b
TURP, cytoscopy
TURP, soi bàng quang .....583 b
Urological implant surgery
Phẫu thuật cấy ghép bộ vào hệ tiết niệu....582 b
Surgical therapy, inadequate, antibiotics and
Ngoại khoa, không thỏa đáng, kháng sinh 26
Susceptibility patterns for MDROs and ESBL
Đặc điểm nhạy cảm cho các căn nguyên đa kháng và sinh ESBL
organisms
Căn nguyên.....13 b
unusual
không thường gặp.....12 b
Susceptibility testing microbiology and in vitro vs. in vivo activity
Test độ nhạy của vi khuẩn invitro và invivo.....10
Sustiva (Efavirenz).....925
Swimmers ear
"bệnh tai của người đi bơi" 68
Swimming pool granuloma
Bệnh u hạt bể bơi 473
Swine influenza (H1N1)
Cúm lợn (H1N 1) 114
Community-acquired pneumonia
viêm phổi mắc phải ở cộng đồng.....92
Post-exposure prophylaxis
dự phòng sau phơi nhiễm.....585 b
Symmetrel 831
Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone (SIADH), encephalitis
Hội chứng tăng tiết ADH không thích hợp (SIADH), Viêm não 49
Synercid 1029
Synergistic gangrene
Hoại thư mô mềm 239
Syphilis
Giang mai.....213
Latent
tiềm ẩn 215
neurosyphilis
giang mai thần kinh 216
primary
tiên phát 214
secondary
thứ phát..... 214
tertiary
tam cấp 215

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Systemic lupus erythematosus (SLE) bilateral infiltrates with effusion
Lupus ban đỏ hệ thống (SLE), xâm nhiễm hai phổi có tràn dịch 723
Unilateral ill-defined infiltrates without effusion
Xâm nhiễm ranh giới không rõ một bên không có tràn dịch màng phổi 706

T

Tachycardia, heart abnormalities (DDx)
Nhịp tim nhanh, các bất thường ở tim (Chẩn đoán phân biệt) ..... 755 b
Taenia multiceps, cerebral coenurosis
Taenia multiceps, sán dây não 426
Taenia saginata, beef tapeworm
Taenia saginata, sán dây bò 461
Taenia solium, neurocysticercosis
Taenia solium, nang sán thần kinh 426
Taenia solium, pork tapeworm
Taenia solium, Sán dây lợn 461
Tamiflu 699
Tapeworms, intestinal
Sán dây đường tiêu hóa 461
Target cells, RBC abnormalities (DDx)
Hồng cầu hình bia, Các bất thường của hồng cầu ..... 773 b
Tazicef 884
Tazídime
Tazidim 884
Tazocin 1019
TB osteomyelitis
viêm tủy xương do lao 232
TDF (tenofovir) 1055
Teflaro 882
Telaprevir 1049
Telavancin 1050
Pearls & pitfalls
Điểm nhấn và các sai lầm cần tránh 811
Telbivudine
Telbivudin 1052
Telithromycin 1053
Temporal muscle wasting, head abnormalities (DDx)
Teo cơ vùng thái dương, các bất thường ở đầu (Chẩn đoán phân biệt) ..... 744 b
Tenofovir disoproxil fumarate
Tenofovir disoproxil fumarat 929
Tenosynovitis, extremity abnormality (DDx)
Sưng vùng cổ tay, các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt) ..... 763 b
Terbinafine
Terbinafin 1056
Tetanus
Uốn ván 301
adult immunization
tiêm chủng ở người lớn ..... 609 b
traval prophylaxis
dự phòng khi đi du lịch ..... 612 b
Tetanus prophylaxis in routine wound management
Dự phòng uốn ván trong xử trí thường quy các vết thương ..... 612 b
More than/equal to 3 doses
nhiều hơn/ Tối thiểu 3 liều ..... 612 b
Unknown or less than 3 doses
không nhớ hoặc ít hơn 3 liều ..... 612 b
Tetracyclines
Tetracyclin 1057
Pearls & pitfalls
Điểm nhấn và các sai lầm cần tránh 798
susceptibility profiles
các thông tin về độ nhạy cảm của vi sinh vật với kháng sinh ..... 324 b
Thigh tenderness (bilateral), extremity abnormality (DDx)
Căng đau đùi (hai bên), các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt) ..... 764 b
Thoracic surgery, surgical rophylaxis
Phẫu thuật ngực, dự phòng trong phẫu thuật ..... 579 b
3TC (lamivudine) 967

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

3TC/ZDV (Combivir) 969
Thrombocytopenia, platelet abnormalities (DDx)
Giảm tiểu cầu, các bất thường về tiểu cầu (Chẩn đoán phân biệt) .....775 b
Thrombocytosis, platelet abnormalities (DDx)
Tăng tiểu cầu, các bất thường tiểu cầu (Chẩn đoán phân biệt).....775 b
Thrombophlebitis, extremity abnormality (DDx)
Viêm tắc tĩnh mạch, các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt).....764 b
Intracranial suppurative
Viêm tắc tĩnh mạch mủ trong sọ.....51
Septic pelvic
Nhiễm khuẩn huyết từ khung chậu.....180
Thrush
Nấm Candida 77
HIV/AIDS.....552
Ticar 1058
Ticarcillin 1058
pediatric dose
liều dùng cho trẻ em.....693
tivicay (dolutegranir) 920
Ticarcillin/clavulanate
Ticarcillin/clavulanat.....1059
pediatric dose
liều dùng cho trẻ em.....683
Tichophyton mentagrophytes, tinea corporis
Tichophyton mentagrophytes, nấm da thân 260, 262
Tick-borne relapsing fever (TBRF)
Sốt hồi quy do ve (TBRF) 417
Tick typhus fevers
Sốt ban do ve 417
Tigecycline
Tigecyclin 1061
Pearls & pitfalls
Điểm nhấn và các sai lầm cần tránh.....809
Time-dependent kinetics, antibiotics with
Dược động học kháng sinh phụ thuộc thời gian...3
Tinea capitis (scalp ringworm)
Nấm da đầu (ecpet mảng tròn da đầu).....263
Tinea corporis (body ringworm)
Nấm da thân (ecpet mảng tròn thân mình).....262
Tinea cruris (jock itch)
Nấm da vùng đùi (ngứa khớp) 263
Tinea pedis
Nấm da vùng bàn chân.....263
Tinea versicolor (pityriasis)
Lang ben (pityriasis) 264
Tinidazole, pediatric dose
Tinidazol, liều dùng cho trẻ em.....683
Tipranavir (TPV).....1066
Tissue penetration, antibiotic selection and
Thẩm thấu kháng sinh vào mô, lựa chọn kháng sinh 3
TMP 1070
TMP-SMX 1071
Pearls & pitfalls
Điểm nhấn và các sai lầm cần tránh.....803
Tobramycin 1068
pediatric dose
liều dùng cho trẻ em.....683
Tongue tenderness, mouth abnormalities (DDx)
Đau lưỡi, các bất thường ở miệng (Chẩn đoán phân biệt).....752
Tongue ulcers, mouth abnormalities (DDx)
Loét lưỡi, các bất thường ở miệng (Chẩn đoán phân biệt) .....752 b
Tonsillar membranes, mouth abnormalities (DDx)
Màng amiđan, các bất thường ở miệng (Chẩn đoán phân biệt) .....752 b
Tonsillar ulcers, mouth abnormalities (DDx)
Viêm amiđan, các bất thường ở miệng (Chẩn đoán phân biệt) .....752 b
Toxic shock syndrome (TSS)
Hội chứng sốc nhiễm độc tố.....299
Toxin-mediated infectious diseases
Các bệnh nhiễm trùng sinh độc tố 299
botulism
bệnh do độc tố botulinum 300
diphtheria
bệnh bạch hầu 301

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

tetanus
bệnh uốn ván 301
toxic shock syndrome (TSS)
hội chứng sốc nhiễm độc tố 299
Toxocariasis, meningitis
Bệnh Toxocara , viêm màng não 32
Toxoplasma gondii
Toxoplasma gondii
Cerebral toxoplasmosis
Nhiễm Toxoplasma não 431
Chorioretinitis
viêm màng mạch võng mạc 63
encephalitis
viêm não 47
HIV/AIDS
HIV/AIDS 544
HIV/AIDS, prophylaxis
HIV/AIDS, dự phòng 526
transplant infections
nhiễm trùng ở người được ghép tạng 283
Toxoplasmosis
Nhiễm toxoplasma
HIV/AIDS, prophylaxis
HIV/AIDS, dự phòng 544
meningitis
viêm màng não 32
prophylaxis of opportunistic infections
dự phòng nhiễm khuẩn cơ hội ..... 597 b
TPV (tipranavir) 1067
Trachipleistophora, microsporidia enteritis
Viêm ruột do Trachipleistophora 551
Trachoma conjunctivitis
viêm kết mạc do virus mắt hột 62
Transplant prophylaxis (BMT/SOT)
Dự phòng sau ghép tạng (ghép tủy xương/ ghép tạng đặc) ..... 598 b
Aspergillus sp 599
Candida sp ..... 599 b
Cytomegalovirus (CMV) ..... 600 b
Herpes simplex (HSV) ..... 598 b
PCP
Pneumocystis (carinii) jiroveci ..... 598 b
toxoplasmosis
Toxoplasma ..... 598 b
varicella zoster virus (VZV)
virus thủy đậu (VZV) ..... 599 b
Transplants. See Organ transplants
Ghép tạng
Transverse myelitis, neurological abnormalities (DDx)
Viêm tủy cắt ngang, các bất thường của hệ thần kinh (Chẩn đoán phân biệt) ..... 769 b
Trapezius tenderness, chest abnormalities (DDx)
Đau cơ thang, các bất thường ở lồng ngực (Chẩn đoán phân biệt) 754
Traveler's diarrhea, travel prophylaxis
Tiêu chảy khi đi du lịch, dự phòng khi đi du lịch ..... 607 b
Travel prophylaxis
Dự phòng khi đi du lịch ..... 605 b
General infectious disease travel precautions
Cảnh báo chung về các bệnh nhiễm khuẩn 605
Hepatitis A (HAV)
viêm gan A (HAV) ..... 608 b
japanese encephalitis (JE)
Viêm não Nhật Bản (JE) ..... 609 b
Meningococcal meningitis
viêm màng não do não mô cầu ..... 608 b
rabies
Bệnh dại ..... 590 b
Tetanus, diphtheria, pertussis
uốn ván, bạch cầu, Ho gà ..... 609 b
traveler's diarrhea
Tiêu chảy khi đi du lịch ..... 607 b
Typhoid fever
Sốt thương hàn ..... 608 b
Yellow fever
sốt vàng ..... 609 b
travel vaccines, HIV/AIDS
Tiêm phòng vaccin khi đi du lịch, HIV/AID 530
Trecator 941

Dr Quy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Trematodes (flukes/flatworms), intestinal
Sán lá đường tiêu hóa 463
Treponema pallidum
Treponema pallidum
meningitis
viêm màng não 40
primary syphilis
giang mai tiên phát 209
syphilis
giang mai 213, 214
Trichinella spiralis, trichinosis
Trichinella spiralis, nhiễm giun xoắn 493
Trichinosis
Bệnh nhiễm giun xoắn 493
Trichomonas vaginalis, urethritis/cervicitis
Viêm niệu đạo/ viêm cổ tử cung do trichomonas 204
Trichophyton mentagrophytes, onychomycosis
Trichophyton mentagrophytes, bệnh nấm móng 261
Trichophyton rubrum
Trichophyton rubrum
onychomycosis
bệnh nấm móng 261
tinea corporis
nấm da thân 262
Trichosporon beigelii, trichosporon
Trichosporon beigelii, trichosporon 482
Trichostrongyliasis
Trichostrongyliasis 459
Trichostrongylus orientalis
Trichostrongylus orientalis 459
Trichuris trichiura
Trichuris trichiura, nhiễm giun xoắn 493
Trimethoprim
Trimethoprim 1071
Trimethoprim- sulfamethoxazole
Trimethoprim- sulfamethoxazol 1071
Trimox 835
Trimpex 1071
Trismus, mouth abnormalities (DDx)
Cứng hàm, các bất thường ở miệng (Chẩn đoán phân biệt) ..... 751 b
Trizivir [abacavir (ABC) + lamivudine (3TC) + zidovudine (ZDV)] 827
Trobicin 1045
Tropheryma whippelli, Whipple's disease
Tropheryma whippelli, bệnh Whipple 464
Truvada [emtricitabine (FTC) + tenofovir (TDF)] 929
Trypanosoma brucei
Trypanosoma brucei
cruzi
cruzi 412,413
gambiense
gambiense 413,314
rhodesiense
rhodesiense 413,414
Trypanosoma brucei cruzi, Chagas' disease
Trypanosoma brucei cruzi, Bệnh Chagas 447
Trypanosomes in blood
Có Trypanosoma trong máu 412
Trypanosomiasis
Bệnh doTrypanosoma
American
châu Mỹ 414
East African
Đông Phi 412
West African
Tây Phi 412
Tsutsugamushi fever
Sốt Tsutsugamushi 489
Tuberculosis. See Mycobaterium tuberculosis
Lao. Xem Mycobacterium Tuberculosis
Tuberculosis endophthalmitis
Viêm nội nhãn cầu do lao 67
Tuboovarian abscess
Áp xe buồng trứng/ống dẫn trứng 202
Tularemia pneumonia
viêm phổi do bệnh Tularemia 303
bioterrorist
khủng bố sinh học 307
unilateral focal segmental/lobar infiltrate

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

with effusion
xâm nhiễm khu trú thùy phổi một bên có tràn dịch 696
TURP, surgical prophylaxis
Phẫu thuật cắt u tuyến tiền liệt qua đường niệu đạo (TURP), dự phòng trong phẫu thuật ....583 b
Tygacil 1061
Typhoid fever
Sốt thương hàn 154
travel prophylaxis
dự phòng khi đi du lịch ....608 b
Typhus infections
Nhiễm trùng do Rickettsia
epidemic
thành dịch 486
flying squirrel
ở sóc bay 486
murine
ở chuột 486
scrub
bụi cây 486
tick typhus fevers
sốt rickettsia do ve truyền 486
tyzeka
Tyzeka 1052
T20 (enfuvirtide) 934

U

Ulcer-node syndromes, lymph node abnormalities (DDx)
Hội chứng loét-nổi hạch, các bất thường hạch bạch huyết (Chẩn đoán phân biệt) ....760 b
Ulcers
Loét
Buruli
Buruli 469
foot/leg
bàn chân/cẳng chân ....764 b
frenal
hãm môi ....752 b
genital
sinh dục 208
mouth
khoang miệng 79
oral
qua đường miệng ....752 b
peptic
ổ loét dạ dày 153
perirectal
quanh trực tràng ....761 b
skin
da 243
tongue
lưỡi ....751 b
tonsillar
amiđan ....752 b
ultra 95
ultracef 86
unasyn 47
Unipen 996
Unsafe water (fecally-contaminated), infectious disease travel precautions
Khuyến cáo về các bệnh nhiễm trùng do uống nước nhiễm bẩn khi đi du lịch ....605 b
Urethritis/cervicitis
viêm niệu đạo/viêm cổ tử cung 204
Urethritis
Viêm niệu đạo
gonoccocal
do lậu cầu 204
non-gonococcal
Không do lậu cầu 204
Urex 985
Urinary abnormalities (DDx)
Các bất thường của nước tiểu (Chẩn đoán phân biệt)
chyluria
đái dưỡng chấp ....783 b
eosinophiluria
tăng bạch cầu ái toan trong nước tiểu ....783 b
hematuria, gross/microscopic

Dr Hay Thing
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Đái máu, đại thể/vi thể ..... 72 b
leukocyte esterase
esterase bạch cầu ..... 783 b
myoglobinuria (2° to rhabdomyolysis)
myoglobin niệu
(thứ phát sau tiêu cơ vân) ..... 783 b
nitrite positive
nitrite (+) ..... 783 b
proteinuria
protein niệu ..... 783 b
pyuria
đái mủ 783
specific gravity, decreased
Tỷ trọng nước tiểu, giảm 783b
urinary pH, alkaline/acidic
pH niệu, nhiễm kiềm, nhiễm toan ..... 783 b
Urinary pH, alkaline/acidic, uriary abnormalities (DDx)
pH niệu, nhiễm kiềm, nhiễm toan, các bất thường của nước tiểu (Chẩn đoán phân biệt) ..... 783 b
Urinary tract infections (UTIs), chronic medical prophylaxis
Nhiễm trùng đường tiết niệu, Dự phòng nội khoa mạn tính ..... 595 b
Urine Gram stain, clinical use
Nhuộm Gram bệnh phẩm nước tiểu, ứng dụng lâm sàng ..... 400 b
Urological implant surgery, surgical prophylaxis
Phẫu thuật cấy ghép thiết bị nhân tạo vào hệ tiết niệu, dự phòng trong phẫu thuật ..... 582 b
Urosepsis
sepsis do nhiễm khuẩn tiết niệu 198
community-acquired
mắc phải ở cộng đồng 198
urologic procedure
do thủ thuật đường tiết niệu 199
Urticaria, general appearance abnormalities (DDx)
Mày đay, các bất thường khi thăm khám toàn thân (Chẩn đoán phân biệt) ..... 743 b
USFDA use-in-pregnancy letter code
USFDA (mã về độ an toàn của thuốc dùng ở phụ nữ có thai) ..... 821 b
Usual dose, explanation
Liều thông thường, giải thích 816
Uveitis, eye abnormalities (DDx)
Viêm màng bồ đào, các bất thường ở mắt (Chẩn đoán phân biệt) ..... 748 b
Uvular edema, mouth abnormalities (DDx)
Phù lưỡi gà, các bất thường ở miệng (Chẩn đoán phân biệt) ..... 752 b

V

Vaccinations. See Adult immunizations; Immunizations
Tiêm chủng. Xem Tiêm chủng người lớn; Tiêm chủng
Vaginosis
Nhiễm trùng âm đạo 207
Vaginitis
Viêm âm đạo 207
Vaginitis, Candida, in HIV/AIDS
Viêm âm đạo, Candida, ở bệnh nhân HIV/AIDS 556
Valacyclovir 1074
Valcyte
Valcyte 1075
Valganciclovir 1075
Valtrex 1073
Vancocin 1077
Vancomycin 1077
Pearls & pitfalls
Điểm nhấn và các sai lầm cần tránh 805
pediatric dose
liều dùng cho trẻ em 684
Vancomycin-resistant enterococci (VRE)
Cầu khuẩn ruột kháng lại Vancomycin .....
Vantin 880
Varicella (VZV) chickenpox, adult immunization
Varicella (VZV) thủy đậu,
tiêm chủng ở người lớn ..... 588 b
Post-exposure prophylaxis
dự phòng sau phơi nhiễm ..... 525 b
Varicella zoster virus (VZV). See also Herpes zoster

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Varicella zoster virus (VZV). xem thêm Herpes zoster
chickenpox
thủy đậu 252
Herpes zoster
Herpes zoster 253
HIV/AIDS
HIV/AIDS 525
Variola virus, post-exposure prophylaxis
Variola virus, dự phòng sau phơi nhiễm ..... 592 b
smallpox
đậu mùa 308
vascular graft infections
Các nhiễm trùng cầu nối mạch 149
Venezuelan equine encephalitis (VEE)
Viêm não ngựa Venezuala (VEE) 47
Ventilator-associated pneumonia (VAP)
Viêm phổi liên quan với máy thở 125
Verrucous foot/leg lesions, extremity abnormalities (DDx)
Tổn thương mụn cơm ở chân/bàn chân, các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt) ..... 763 b
Verrucous hand/arm lesions, extremity abnormalities (DDx)
Tổn thương dạng mụn cơm tay/bàn tay, các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt) ..... 763 b
Vesicles, skin
Mụn nước/phỏng nước trên da 475
Vfend 1080
Vibativ 1050
Vibramycin 923
Vibra-tabs 923
Vibrio alginolyticus
Vibrio alginolyticus ..... 377 b
Vibrio cholerae
Vibrio cholerae hay phẩy khuẩn tả ..... 377 b
Travel prophylaxis
dự phòng khi đi du lịch ..... 607 b
Vibrio parahaemolyticus
Vibrio parahaemolyticus ..... 232 b
Vibrio sp. saltwater wounds
Vibrio sp. Vết thương do nước mặn 256
Vibrio vulnificus
Vibrio vulnificus ..... 377 b
Saltwater wounds
Vết thương do tiếp xúc với nước mặn 256
Victrelis 862
Videx (didanosine) 918
Vincent's angina
Viêm họng kiểu Vincent 80
Viracept (nelfinavi) 997
Viral conjunctivitis
Viêm kết mạc do virus 61
Viral esophagitis
Viêm thực quản do virus 151
Viral hemorrhagic fever, post-exposure prophylaxis
Sốt xuất huyết do virus, dự phòng sau phơi nhiễm ..... 592 b
Viral hepatitis
Viêm gan virus 147
Viral influenza (human seasonal), post-exposure prophylaxis
Cúm mùa (người), dự phòng sau phơi nhiễm ..... 529 b
Viral pharyngitis
Viêm họng do virus 76
Viramune (nevirapine) 999
Viread (tenofovir) 1054
Viridans streptococci endocarditis prosthetic, subacute (SBE)
Viêm nội tâm mạc, bán cấp trên van nhân tạo do nhiễm liên cầu Viridans 129
Viridans
Liên cầu Viridans
Prosthetic valve endocarditis (PVE)
Viêm nội tâm mạc sau thay van 139
streptococci
liên cầu 333
bone marrow transplant infection
nhiễm khuẩn trong ghép tủy 283
usual/unusual susceptibility patterns
kiểu nhạy cảm thường gặp/ không thường gặp của vi sinh vật ..... 12 b

Dr Hải Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Visceral leishmaniasis (Kala-azar)
Nhiễm leishmania nội tạng (Kala-azar).....441
Vistide 896
Vitiligo, general appearance abnormalities (DDx)
Bạch tạng, các bất thường khi thăm khám toàn thân (Chẩn đoán phân biệt) .....743 b
Volume of distribution, explanation
Thể tích phân bố, giải thích 817
Voriconazole 1080
VRE. See Vancomycin-resistant enterococci (VRE)
Cầu khuẩn ruột kháng lại vancomycin (VRE). Xem enterococci kháng Vancomycin (VRE)
VZV
Virus thủy đậu (VZV)
Bilateral infiltrates without effusion
Xâm nhiễm hai phổi không có tràn dịch màng phổi.....713
community-acquired pneumonia
viêm phổi mắc phải ở cộng đồng 93
conjunctivitis
viêm kết mạc..... 62
encephalitis
viêm não.....47
HIV/AIDS, prophylaxis
HIV/AIDS, dự phòng.....526
meningitis
viêm màng não.....40
ophthalmicus
zona mắt.....62
prophylaxis of opportunistic infections
dự phòng các nhiễm trùng cơ hội.....597 b

W

Warts, genital/perianal
Hạt cơm, sinh dục/quanh hậu môn.....212
Watery eyes, eye abnormalities (DDx)
Mắt chảy nước (mắt ướt), các bất thường ở mắt (Chẩn đoán phân biệt).....748 b
WBC abnormalities (DDx)
Các bất thường của bạch cầu (Chẩn đoán phân biệt)
Atypical lymphocytes
Bạch cầu lympho không điển hình.....771 b
basophilia
bạch cầu ái kiềm .....772 b
eosinophilia
bạch cầu ái toan .....772 b
immunoblasts
nguyên bào miễn dịch.....771 b
leukocytosis
tăng bạch cầu đa nhân.....770b
leukopenia
giảm bạch cầu đa nhân.....770 b
lymphocytosis
tăng bạch cầu lympho .....770 b
monocytosis
tăng bạch cầu mono .....771 b
relative lymphocytosis,
tăng tương đối bạch cầu lympho.....770 b
relative lymphopenia
giảm tương đối bạch cầu lympho.....770 b
WBC inclusions
Thể vùi trong bạch cầu .....772 b
WBC inclusions, WBC abnormalities (DDx)
Thể vùi bạch cầu, Các bất thường của bạch cầu (Chẩn đoán phân biệt).....772 b
WBCs (per mm), pleural effusion profiles in various diseases (DDx)
Số lượng bạch cầu (trong mm^3), đặc điểm dịch màng phổi trong các bệnh lý khác nhau (Chẩn đoán phân biệt).....785 b
WBC type/glucose, clinical use
Loại bạch cầu và glucose, ứng dụng lâm sàng..... 397b
Wegener's granulomatosis
U hạt Wegener
bilateral infiltrates with effusion
Xâm nhiễm hai phổi có tràn dịch màng phổi 724
bilateral infiltrates without effusion
xâm nhiễm hai phổi không có tràn dịch màng phổi.....717
caviary infiltrates (thick-walled)

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

xâm nhiễm dạng hang (thành dày) 732
West African trypanosomiasis
Bệnh trypanosoma Tây Phi 412
Western equine encephalitis (WEE)
Viêm não ngựa vùng miền Tây Hoa kỳ 47
West Nile encephalitis (WNE)
Viêm não vùng miền Tây sông Nil 47
meningitis
viêm màng não 39
Wheezing, diffuse, chest abnormalities (DDx)
Tiếng thở rít lan tỏa, các bất thường ở lồng ngực (Chẩn đoán phân biệt) 754b
Whipple's disease
Bệnh Whipple 464
Whipworm
Giun tóc 447
Wound infections
Nhiễm trùng vết thương 254
animal bite
động vật cắn 254
burns
bỏng 256
cat scratch disease (CSD)
bệnh do mèo cào 257
freshwater
nước ngọt 256
saltwater
nước biển 256
Wrist swelling, extremity abnormality (DDx)
Sưng cổ tay, các bất thường ở chi (Chẩn đoán phân biệt) .....763 b
Wuchereria bancrofti
Wuchereria bancrofti 409
Wymox 835

Y

Yeasts/fungi, clinical significance, pending susceptibility testing
Nấm/nấm men, ứng dụng lâm sàng khi chưa có xét nghiệm độ nhạy kháng sinh .....390 b
Yellow fever
Sốt vàng 310
travel prophylaxis
dự phòng khi đi du lịch 608
Yellow/whitish pleural fluid abnormalities (DDx)
vàng/hơi trắng, các bất thường của dịch màng phổi (Chẩn đoán phân biệt) 784b
Yersinia
Yersinia
infectious diarrhea
Ia chảy nhiễm khuẩn 154
travel prophylaxis
dự phòng khi đi du lịch .....607 b
Yersinia enterocolitica
Yersinia enterocolitica .....378 b
Yersinia pestis (plague)

Z

Zalcitabine (ddc) 1084
ZDV (zidovudine) 1085
Zerit (stavudine) 1045
Ziagen (ABC) 824
Zidovudine (ZDV)
Zidovudin 1085
Zinacef 892
Zithromax 857
Zoonotic atypical pneumonias
Viêm phổi không điển hình lây từ động vật sang người 107
diagnostic features
đặc điểm chẩn đoán 108
Zoonotic diseases, post-exposure prophylaxis
Các bệnh lây từ động vật sang người, dự phòng sau phơi nhiễm 590
Zosyn 1019
Zovirax 828
Zygomycosis, cutaneous
Zygomyces ngoài da 483
Zyvox 975

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

Địa chỉ: Số 352 - Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội
Email: xuatbanyhoc@ftp.com.vn
Số điện thoại: 04.37625934 - Fax: 04.37625923

HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM

Chịu trách nhiệm xuất bản
Tổng Giám đốc
Chu Hùng Cường

Chịu trách nhiệm nội dung
Phó tổng biên tập
BSCKI. Nguyễn Tiến Dũng

Hiệu đính:
PGS.TS Nguyễn Đạt Anh
Trịnh Tráng

Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần in Sách Việt Nam

Biên tập:
BS. Vũ Thị Bình

Sửa bản in:
Ích Phạm

Thiết kế & chế bản:
Hoàng Hà - Demac Print Design

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

In 1.000 cuốn, khổ 16 x 24 cm tại Công ty Cổ phần in sách Việt Nam.
Địa chỉ: Số 22B Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giấy phép xuất bản số: 685-2016/CXBIPH/7-31/YH
Quyết định xuất bản số: 149/QĐ-XBYH cấp ngày 25/4/2016
Mã số ISBN: 978-604-66-1886-7. In xong và nộp lưu chiểu năm 2016.

HƯỚNG DẪN

ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TỦ SÁCH A9 - BỆNH VIỆN BẠCH MAI

ISBN: 978 604 66 1886 7